Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2)

W9271 World Organization of National Colleges, Academies, and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2) / Elaborada pelo Comitê Internacional de Classificação da WONCA (Associações Nacionais, Academias e Associações Acadêmicas de Clínicos Gerais/Médicos de Família, mais conhecida como Organização Mundial de Médicos de Família) ; Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição, Gustavo Diniz Ferreira Gusso. – 2. ed. – Florianópolis : Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 2009.

200 p. ; 23 cm + CD-ROM

Tradução de: ICPC-2-R (Revised Second Edition): International Classification of Primary Care. ISBN 978-85-63010-00-1

1. Nosologia. 2. Atenção primária à saúde (Medicina) – Classificação. I. Título. II. WONCA. III. Organização Mundial de Médicos de Família. IV. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.

CDU 616.001.4

Catalogação na publicação: Júlia Angst Coelho – CRB 10/1712

Segunda edição

Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP 2)

Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição:
Gustavo Gusso
Presidente da SBMFC

2010

Elaborada pelo Comitê Internacional de Classificação da Organização Mundial de Associações Nacionais, Academias e Associações Acadêmicas de Clínicos Gerais/ Médicos de Família (WONCA), mais conhecida como Organização Mundial de Médicos de Família.
Sob permissão da Organização Mundial de Associações Nacionais, Academias e Associações Acadêmicas de Clínicos Gerais/ Médicos de Família/ Organização Mundial dos Médicos de Família (WONCA) para a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC)

Florianópolis, 2009

© Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, 2009

Capa
Henrique Caravantes

Projeto e editoração
Armazém Digital® Editoração Eletrônica – Roberto Carlos Moreira Vieira

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade
Rodovia SC 401 km 4, 3854 – Saco Grande – Florianópolis/Santa Catarina.
CEP: 88032-005

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da SBMFC.

IMPRESSO NO BRASIL
PRINTED IN BRAZIL

DIRETORIA DA SBMFC (2010 – 2012)

Gustavo Diniz Ferreira Gusso	Presidente
Luiz Felipe Cunha Mattos	Vice-Presidente
Zeliete Zambon	Secretária Geral
Aline de Avila Ramos	Diretora Financeira
Ruth Borges Dias	Diretora Científica
Daniel Knupp	Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação *Lato Sensu*
Thiago Gomes da Trindade	Diretor de Graduação e Pós-Graduação *Strictu sensu*
Oscarino Barreto dos Santos Júnior	Diretor de Comunicação
Emílio Rossetti Pacheco	Diretor de Titulação
Cleo Borges	Diretor de Exercício Profissional
Nilson Massakazu Ando	Diretor de Medicina Rural
Bruno Souza Benevides	Diretor Residente

CONSELHO DIRETOR DA SBMFC

Marcelus Antônio Motta Prado de Negreiros	Acre
Ana Cláudia Soares da Silva	Alagoas
Ricardo César Garcia Amaral Filho	Amazonas
Caroline Lopez Fidalgo	Bahia
Marco Tulio Aguiar Mourão Ribeiro	Ceará
Sergio Leuzzi	Distrito Federal
Marcello Dala Bernardina Dalla	Espírito Santo
Sandro Rogério Rodrigues Batista	Goiás
Fabiano Gonçalves Guimarães	Minas Gerais
Ivo Alves de Freitas	Mato Grosso do Sul
Fernando Antonio Santos e Silva	Mato Grosso
Yuji Magalhães Ikuta	Pará
Verônica Galvão Freires Cisneiros	Pernambuco
Marcelo Garcia Kolling	Paraná
Cristiane Coelho Cabral	Rio de Janeiro
Thiago Gomes da Trindade	Rio Grande do Norte
José Mauro Ceratti Lopes	Rio Grande do Sul
Robinson Cardoso Machado	Rondônia
Marcela Dohms	Santa Catarina
Denise Santos do Nascimento	Sergipe
Fernanda Plessmann de Carvalho	São Paulo
Raimundo Célio Pedreira	Tocantins

PREFÁCIO 1

A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), com o apoio do Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde, disponibiliza para uso livre, por meio desta publicação, o mais adequado sistema de classificação para ser utilizado na atenção primária à saúde. Não se trata de uma alternativa a Classificação Internacional de Doenças (CID), que continua importante para ser usada em morbi-mortalidade, mas de uma poderosa ferramenta que permite classificar não só os problemas diagnosticados pelos profissionais da saúde, mas principalmente os motivos da consulta e as intervenções acordadas seguindo a sistematização SOAP (subjetivo, objetivo, avaliação e plano) concebida por Lawrence Weed na década de 60 do século passado. Tem o potencial de avaliar as razões pelas quais os pacientes procuram o serviço de saúde, as probabilidades pré-teste dos problemas de saúde (por exemplo, porcentagem de pacientes com queixa de febre que recebe o diagnóstico de infecção de vias aéreas superiores) e as comorbidades. Acima de tudo, potencializa a prevenção quaternária como concebida por Marc Jamoulle, evitando diagnósticos precipitados e intervenções inadequadas – em especial quando há um sofrimento ou uma enfermidade, mas não uma doença que seja detectável em exame laboratorial ou de imagem.

Em atenção primária, frequentemente o diagnóstico etiológico não é o mais importante, e a Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) tem como principal critério de sistematização a pessoa incluindo o contexto social (capítulo Z), e não a doença. A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido responsável pela reestruturação da atenção primária no Brasil, e o uso da CIAP permitirá conhecer melhor a demanda dos pacientes e o trabalho realizado. Desta forma, ajudará no planejamento das ações nas unidades de saúde e também das atividades voltadas para o desenvolvimento profissional contínuo. Enfim, o objetivo é transformar cada unidade de saúde em um potente campo de avaliação da própria prática, qualificando cada vez mais a atenção primária brasileira.

Este projeto nasceu em 2006, quando o Brasil passou a ter um representante no Comitê Internacional de Classificação da WONCA (WICC). Alguns pesquisadores utilizavam a versão de Portugal, mas não era suficiente para

o uso sistematizado em prontuários eletrônicos ou para classificar todos os encontros entre profissionais de atenção primária e os pacientes. O Ministério da Saúde assinou então um convênio com a SBMFC, que permitiu o pagamento dos *royalities* para a WONCA e o livre uso da CIAP no Brasil. Durante os congressos e em discussões com colegas que já utilizavam a CIAP, algumas alterações em relação à versão portuguesa foram decididas. Em primeiro lugar, o próprio nome, que em Portugal era Classificação Internacional de Cuidados Primários; na versão brasileira, substituímos "cuidados" por "atenção", termo mais utilizado por aqui. Foi realizada uma revisão minuciosa dos termos e as adaptações necessárias como a mudança de "cancro" para "câncer". Duas alterações de rubricas efetivadas merecem destaque. O termo A77 passou a ser "Dengue e outras doenças virais NE" em vez de "Outras doenças virais NE" onde se incluía a dengue e o A78 "Hanseníase e outras doenças infecciosas NE" em vez de apenas "Outras doenças infecciosas NE" que incluía a hanseníase. Esta foi uma maneira de dar destaque para estes problemas de saúde que não estavam explicitados na rubrica nas versões inglesa e portuguesa, mas apenas nos critérios de inclusão por causa da importância dessas doenças no contexto nacional. A CIAP é feita com base na prevalência dos problemas de saúde, e o principal critério de inclusão é ser mais prevalente que 1:1.000. A inclusão de mais doenças infecciosas tem sido debatida no WICC para a próxima versão da CIAP, que será mapeada para a CID 11, ainda sem data de lançamento.

Esta publicação vem acompanhada de duas tabelas em excel prontas para serem utilizadas. A primeira ("CIAP_CID") sistematiza a CIAP com os critério de inclusão, exclusão, definições e o mapeamento para a CID. A coluna "CID mais frequente" é na verdade uma forma de mapeamento rápido "um para um" elaborado pelo Erik Falkoe da Dinamarca, e pode ser utilizada quando não há tempo de se escolher o código da CID que melhor se enquadra na CIAP selecionada. Este código CID é o mais utilizado dentre os possíveis. A segunda tabela ("Tesauro") é uma compilação de termos já mapeada para a CIAP e a CID, desenvolvida pelo grupo de belgas que fazem parte do Comitê Internacional de Classificação da WONCA sob encomenda do Ministério da Saúde da Bélgica. Trata-se de um *tesauro* extenso, com muito mais termos que o capítulo 12 deste livro, e, como qualquer outro trabalho desta magnitude, não está (nem nunca estará) completo – sempre haverá novos termos a serem incluídos, e outros a serem modificados ou até mesmo excluídos. Pedimos que as sugestões sejam enviadas para o *e-mail* ciapbrasil@gmail.com, para que o tesauro não seja modificado sem padronização, o que prejudicaria a comparabilidade.

Este árduo trabalho não teria sido possível sem a colaboração de muitas pessoas que citarei brevemente porque não há como descrever aqui a dimensão da doação de cada uma. Em primeiro lugar, a SBMFC deve muito a Luis Pisco e Ana Pisco, que, dentre incontáveis colaborações, cederam a tradução

portuguesa da CIAP (ou Classificação Internacional de Cuidados Primários em Portugal), a qual serviu como ponto de partida para este trabalho. Nada disso teria sido possível sem a doação dos secretários Rogério Machado e Lucas Córdoba. Agradecemos também a Juan Gervas, por toda a contribuição que tem dado no campo conceitual da medicina de família e atenção primária; ao Marc Jamoulle pela concepção da prevenção quaternária, tão necessária para compreender o nosso trabalho; ao Luis Fernando Rolim Sampaio e a Claunara Mendonça por terem trazido o apoio necessário do Ministério da Saúde desde o início deste projeto; ao Ministério da Saúde Belga, Marc Verbeke e Michel de Jonghe e demais desenvolvedores do Tesauro pela disponibilização sem custos deste material; ao Daniel Knupp, Henrique Lira e Érica Figueiredo por terem revisado termo por termo do Tesauro; a Elisabeth Wartchov por ter mediado a difusão da CIAP no Ministério da Saúde; e finalmente a Cassia Buchalla e Ruy Laurenti por todo trabalho de décadas à frente do Centro Brasileiro de Classificação de Doenças zelando pela família de classificações da qual a CIAP faz parte. Agradeço aos colegas diretores e conselheiros da SBMFC que têm feito um excepcional trabalho nas suas diretorias e estados ajudando a transformar a medicina de família e comunidade em uma especialidade cada vez mais reconhecida. É um trabalho apaixonado, e a motivação é verificar que o país está caminhando na direção de um sistema de saúde cada vez mais qualificado e equânime e que corresponde às reais necessidades das pessoas, ajudando-as a se desenvolverem de forma integral e plena sem rotular todos meramente como doentes.

Gustavo Gusso
Presidente da SBMFC
Membro do Comitê Internacional de Classificações da WONCA
Médico de Família e Comunidade – PSF Florianópolis
gustavo.gusso@ig.com.br
Outono de 2009
Gustavo Gusso

PREFÁCIO 2

No trabalho clínico, o profissional de atenção primária utiliza sempre alguma classificação, por mais que seja intuitiva. Quiçá, o primeiro e mais importante momento seja o da atribuição da enfermidade por meio da queixa do paciente (o motivo da consulta). Este distinguir entre saudável e enfermo é chave porque uma das missões da atenção primária é evitar as desnecessárias cascatas diagnósticas e terapêuticas que a falsa rotulação de doente desencadeia. Perante a dicotomia saudável/ doente, o profissional de atenção primária habitualmente se sai bem e descarta como não-enfermos os que convém proteger do processo diagnóstico e terapêutico. Por exemplo, sabemos que o médico geral/ de família e comunidade seleciona melhor os saudáveis que os especialistas. Estes em geral se saem melhor que os generalistas quando se deparam com pacientes de sua especialidade, mas apenas para selecionar os doentes. Daí vem a vantajosa concatenação do trabalho sanitário, do primeiro contato com uma atenção primária que faz o papel de filtro em relação à atenção especializada. A atenção primária seleciona os saudáveis que não passam pelo filtro, e a atenção especializada seleciona os doentes entre os que são referenciados (que passaram pelo filtro).

Porém, nem tudo é saúde e doença, nem tudo é simples dicotomia. Tomemos como exemplo o agente comunitário de saúde que vai ao domicílio de um paciente terminal e estabelece uma conversa com o cuidador principal que conta sobre a dificuldade de morrer, chegando à eutanásia como resposta para a mesma. Como classificar a conversa sobre eutanásia que diz muito do cuidador e dos cuidados no futuro? O agente de saúde não terá nenhuma dificuldade para registrar apropriadamente o "motivo da consulta" porque a Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) conta com uma rubrica específica. No mesmo exemplo pode ser expressado o medo da morte, por parte do paciente ou do cuidador, e, novamente, é possível classificar, a partir da CIAP, sem dificuldade, esta questão, uma vez que há uma rubrica específica para tal.

É característico do trabalho em atenção primária o enfrentamento das enfermidades no seu aspecto mais complexo, desde o começo até o final, e em suas múltiplas manifestações. Assim, o trabalhador social pode assinalar

os problemas que geram a pobreza em uma família, o agente comunitário de saúde registrar as carências de sua habitação; a enfermeira fazer constar o retardo de crescimento de um dos filhos dessa família, o médico atender a mãe por dependência ao tabaco e DPOC, o farmacêutico anotar as dificuldades para o seguimento do tratamento medicamentoso. O conjunto de problemas de saúde mencionado pode ser tabulado com a CIAP, tanto do ponto de vista do paciente (motivo da consulta) quanto do ponto de vista do profissional (problema atendido).

A CIAP permite inclusive a classificação do processo de atenção (aquilo que faz e manda fazer o profissional de saúde). Ficam fora da CIAP apenas a classificação dos resultados da exploração clínica (dor à palpação profunda do hipocôndrio esquerdo, por exemplo).

O emprego da CIAP exige certo grau de treinamento porque o profissional de saúde tende a pensar apenas em doenças claramente estabelecidas. Habituam-se a ignorar o ponto de vista do paciente (o motivo da consulta) e inclusive a própria definição dos problemas com que se deparam. Por exemplo, não se costuma registrar como problema atendido "febre" no lugar de "quadro gripal". Contudo, o científico, o clinicamente apropriado, é registrar e classificar um problema no estado de conhecimento que se tem quando se atende. Além disso, na atenção primária a metade dos problemas é seguida corretamente sem que se chegue a um diagnóstico, por isso é imperativo o uso de uma classificação que permita o registro da qualidade do trabalho clinico, e, para isso, a CIAP é imbatível.

Quando se conta com a versão em uma língua própria da CIAP, o desenvolvimento nacional da atenção primária é facilitado. De certa forma, a CIAP inclui uma forma de pensar e uma filosofia que ajuda a impregnar de qualidade e de ciência o trabalho clínico diário. É, por isso, um prazer ler a versão brasileira da CIAP, indicador de um presente e de um futuro de desenvolvimento positivo da atenção primária no Brasil.

De Buitrago del Lozoya (Madri, Espanha) em 4 de abril de 2009

Juan Gérvas
Médico geral rural, Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes y El Cuadrón (Madri, Espanha).
Membro do Comitê Internacional de Classificação da WONCA desde 1984.
jgervasc@meditex.es www.equipocesca.org

SUMÁRIO

Prefácio vii
Membros do Comitê de Classificação da WONCA 15

1 Introdução 18
2 A estrutura da CIAP 26
3 Episódio de cuidados: conceito básico de medicina de família e comunidade 31
4 CIAP como meio de registrar os motivos da consulta 38
5 CIAP como meio de registrar problemas de saúde, procedimentos e intervenções 47
6 Critérios de inclusão da CIAP 53
7 Códigos de gravidade da doença: escala de DUSOI/WONCA 59
8 Avaliação do estado funcional: quadros da COOP/WONCA 65
9 Referências bibliográficas 69
10 Lista tabular 73
11 Códigos de conversão para a CID-10 163

Índice 179

COMITÊ INTERNACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO DA WONCA (WICC)

Alejandro Lopez Osornio (Argentina)
Anders Grimsmo (Noruega)
Chris van Weel (Holanda)
Daniel Wai-sing Chu (Hongkong)
Deborah Saltman AM (Austrália)
Dimitris Kounalakis (Grécia)
Elena Kazakevitch (Russia)
Erik Falkoe (Dinamarca)
Francois Mennerat (França)
Gojimir Zorz – Gojo (Eslovênia)
Graeme Miller (Austrália)
Gustavo Gusso (Brasil)
Helena Britt (Austrália)
Ian Marshall (Austrália)
Inge Okkes (Holanda)
Jan De Maeseneer (Bélgica)
Jean Karl Soler (Malta)
Joachim Szecsenyi (Alemanha)
Juan Gérvas (Espanha)
Kees van Boven (Holanda)
Kristian Ulfves (Finlândia)
Kumara Mendis (Austrália)
Laurent Letrilliart (França)
Marc Jamoulle (Bélgica)
Marc Verbeke (Bélgica)
Marius Marginean (Romênia)
Mårten Kvist (Finlândia)
Martti Virtanen (Suécia)
Maurice Wood (Estados Unidos)
Michel De Jonghe (Bélgica)
Mike Klinkman (Estados Unidos)
Nick Booth (Inglaterra)
Niels Bentzen (Dinamarca)
Nuno Sousa (Portugal)
Philip Sive (Israel)
Ray Simkus (Canadá)
Robert Bernstein (Canadá)
Rubina Shah (Paquistão)
S. Krishna Mohan (Índia)
Sebastian Juncosa (Espanha)
Shinsuke Fujita (Japão)
Takashi Yamada (Japão)
Thorsten Körner (Alemanha)
Tim Gardner (Nova Zelândia)

Contato com o Comitê de Classificação da WONCA no Brasil
E-mail: ciapbrasil@gmail.com



Encontro do *Wonca International Classification Committee* (WICC) em Dunedin, Nova Zelândia. Setembro de 2007.

CIAP 2

Segunda edição

1 INTRODUÇÃO

PERCURSO HISTÓRICO

Até meados dos anos 1970, grande parte dos dados de morbidade em atenção primária foi classificada segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID)1,2. Sendo reconhecida internacionalmente, esta classificação permitia comparar dados de diferentes países. No entanto, isto dificultou a codificação de muitos sintomas e condições não relacionadas a doenças, embora fizessem parte da atenção primária, pois a classificação destinava-se originalmente a estatísticas de morbidade e a sua estrutura baseava-se em doenças.

Visando resolver este problema, o Comitê de Classificação da WONCA criou a Classificação Internacional de Problemas de Saúde em Atenção Primária (CIPS), primeiro publicada em 1975[3], com segunda edição em 1979[4], relacionada à 9ª revisão da CID. Embora já se tivesse previsto uma divisão de classificação de alguns sintomas não-diagnosticados, a classificação obedecia ainda à estrutura da CID, o que era claramente limitador. Na terceira edição de 1983 adicionaram-se critérios para a utilização da maioria das rubricas[5], aumentando a sua confiabilidade, sem, todavia, vencer as deficiências na utilização em atenção primária. Era necessário criar uma nova classificação dos motivos da consulta do paciente e de seus problemas.

Na conferência sobre Atenção Primária à Saúde, realizada em 1978 pela Organização Mundial de Saúde em Alma Ata[6], reconheceu-se que uma boa política de atenção primária constituía o passo principal em direção à "saúde para todos até o ano 2000". Consequentemente, tanto a WONCA como a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceram que só seria possível construir sistemas de cuidados primários adequados, permitindo a avaliação e implementação das respectivas prioridades, se os profissionais de atenção primária tivessem acesso às informações certas. Isto conduziu ao desenvolvimento de novos sistemas de classificação.

Posteriormente, ainda em 1978, a OMS nomeou aquele que passou a ser conhecido por Grupo de Trabalho da OMS, responsável pelo desenvolvimento de uma Classificação Internacional de Motivos da Consulta em Atenção Pri-

mária. Os membros deste grupo, em sua maioria também membros do Comitê de Classificação da WONCA, desenvolveram uma Classificação de Motivos da Consulta (CMC)[7,8,9], mais tarde conhecida como Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP ou *ICPC* do inglês International Classification of Primary Care).

Motivos da consulta (MC) é a expressão adotada para referir-se a toda razão que leva um paciente a aderir ao sistema de cuidados de saúde, como reflexo da necessidade que o indivíduo tem de recorrer a esse tipo de cuidado. Poderá se tratar de sintomas ou queixas (dores de cabeça ou receio de câncer), doenças conhecidas (gripe ou diabetes), pedidos de exames de diagnóstico ou preventivos (fazer um eletrocardiograma ou medir a pressão), pedido de tratamento (passar nova receita), conhecer os resultados de testes, ou por razões administrativas (um atestado médico). Esses motivos têm normalmente um ou vários problemas subjacentes que, ao fim da consulta, o profissional terá identificado e que poderão não corresponder às razões iniciais que levaram o paciente a marcar uma consulta.

As classificações de doenças são estruturadas de forma a permitir aos profissionais de saúde interpretar os problemas do paciente como um mal-estar, uma doença ou uma lesão. A classificação dos Motivos da consulta, por sua vez, centra-se em elementos da perspectiva do paciente[7,10,11]. Encontra-se assim orientada para o paciente, e não para a doença ou para o profissional de saúde. O médico ou profissional de saúde, em geral, deverá clarificar a razão por trás da marcação da consulta ou do pedido de cuidados do paciente, antes de fazer o diagnóstico do problema de saúde ou de tomar uma decisão quanto ao tipo de cuidado a adotar.

A equipe responsável pela classificação de MC já testou várias versões em campo. O primeiro ensaio de campo, visando avaliar se a classificação de MC era completa e confiável foi um estudo piloto realizado na Holanda em 1980[8]. Os resultados obtidos suscitaram a necessidade de testar a sua validade externa em 1983; estes estudos foram realizados em nove países: Austrália, Brasil, Barbados, Hungria, Malásia, Holanda, Noruega, Filipinas e Estados Unidos[9, 12, 13]. A classificação foi traduzida em várias línguas, incluindo francês, húngaro, norueguês, português e russo. Uma classificação mais completa foi desenvolvida a partir da análise de mais de 90.000 motivos da consulta, registrados em mais de 75.000 consultas personalizadas, e da experiência coletiva dos participantes9, 12, 13. Ao testar a viabilidade da classificação, chegou-se à conclusão de que a CMC permitiria ainda, facilmente, classificar os motivos da consulta e ainda dois elementos do cuidado orientado para o problema: o processo de cuidado (procedimentos e intervenções) e os problemas de saúde diagnosticados. E foi assim, neste quadro conceitual, que a Classificação de Motivos da consulta originou a Classificação Internacional de Atenção Primária.

Problemas relacionados à evolução atual da CID-10 impediram a OMS de publicar a CMC. A WONCA, no entanto, desenvolveu a partir dela a CIAP, e publicou sua primeira edição em 1987. Embora a CIAP-1 fosse muito mais indicada para atenção primária do que as classificações anteriores baseadas no quadro da CID, ela não contava com critérios de inclusão para as rubricas ou qualquer tipo de referência cruzada. Era, por essa razão, menos útil do que a publicação que a precedeu, a CIPS-2-definida, apesar de fazer referência a ela como fonte importante de critérios de inclusão.

Em 1985, um projeto em alguns países europeus lançou um novo sistema de classificação, que permitia obter dados de morbidade em medicina geral para os sistemas de informação de saúde nacional, envolvendo a tradução da classificação e estudos comparativos internacionais. Os resultados foram publicados em 1993, e incluíam uma versão atualizada da CIAP[14].

Em 1980, a WONCA foi declarada uma Organização Não-Governamental (ONG) e, em cooperação com a OMS, tem estimulado uma melhor compreensão da necessidade da atenção primária criar seus próprios sistemas de informação e classificação, em meio a todo uma rede de serviços de saúde.

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

A Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP*)[15] abriu novos horizontes no mundo das classificações quando da sua publicação em 1987 pela WONCA (*The World Organisation of Colleges, Academies, and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians*), hoje mais conhecida por Organização Mundial de Médicos de Família. Pela primeira vez, os profissionais de saúde tinham meios de classificar, usando apenas uma classificação, três elementos importantes de uma consulta: os motivos que levaram à marcação da consulta (MC), os diagnósticos ou problemas, e os procedimentos. A ligação entre esses elementos permite a categorização desde o início da consulta (com os MC) até sua conclusão.

A nova classificação teve por base a tradicional Classificação Internacional de Doenças (CID), dividida em capítulos, cujos eixos variam entre sistemas anatômicos (Capítulos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII e XIII), etiologia (Capítulos I, II, XIV, XVII) e outros (Capítulos XI, XV, XVI e XVIII). Com os eixos assim misturados, a classificação torna-se confusa, visto que um conjunto de entidades de diagnóstico poderá encontrar-se classificado em mais de um capítulo; por exemplo, "influenza" poderá encontrar-se no capítulo "Infecções", no capítulo "Respiratório", ou mesmo em ambos. A CIAP não seguiu este formato, classificando todos os capítulos com base nos sistemas anatômicos, partindo do princípio de que a localização (ou a pessoa) tem primazia sobre a etiologia. Os componentes de cada capítulo permitem uma

considerável especificidade para os três elementos da consulta, ao mesmo tempo em que a estrutura simétrica e a enumeração uniformizada de todos os capítulos facilitam o seu manejo até nos sistemas manuais de classificação. A estrutura racional e bastante abrangente da CIAP faz dela um modelo para futuras classificações internacionais.

Desde a data da sua publicação, a CIAP tem recebido reconhecimento progressivamente maior em nível mundial como uma classificação apropriada para medicina de família e comunidade e atenção primária, e vem sendo usada intensamente em algumas partes do mundo, em especial na Europa14 e na Austrália[16].

Mais recentemente, o Comitê de Classificação da WONCA participou do desenvolvimento internacional de mais iniciativas relacionadas a classificações, incluindo medidas de estado funcional, indicadores da gravidade da doença e um glossário internacional de medicina de família e comunidade. Este livro contém mais informações acerca do assunto referido.

CLASSIFICAÇÃO, NOMENCLATURA E TESAURO

A classificação de aspectos da medicina de família e comunidade, tais como motivos da consulta e problemas de saúde, requer que as classificações existentes reflitam as características do quadro da medicina de família e comunidade. As classificações deverão ser selecionadas a partir de uma nomenclatura ou tesauro. A nomenclatura possui todos os termos específicos da medicina, enquanto o tesauro constitui uma espécie de armazém de palavras, enciclopédia ou arquivo com um grande índice e os respectivos sinônimos[17].

Os sistemas de classificação fornecem uma estrutura de organização de elementos em classes de acordo com critérios estabelecidos. Surgem algumas dificuldades quando se pretende utilizá-las como uma nomenclatura, e nem todos os termos se encontram incluídos. Muitas vezes, vários termos são normalmente incluídos em uma única rubrica, de tal modo que uma codificação com base em uma classificação não é suficientemente específica[17].

A CIAP constitui uma classificação que reflete distribuição e conteúdo típicos de atenção primária. Não se trata de uma nomenclatura. A medicina, principalmente no que diz respeito ao paciente individual, é tão rica, que requer uma nomenclatura e um tesauro muito mais exaustivos do que a CIAP, principalmente quando se trata do registro de um pormenor específico que deve constar no registro individual de um paciente. Esta classificação, juntamente com a CID-10 e outros sistemas, tais como a classificação anátomo-terapêutico-química de medicações (CAT), poderá criar a base para uma nomenclatura e um tesauro apropriados; porém, caso seja necessária uma codificação mais completa, esta terá de ser suplementada por sistemas de

codificação ainda mais específicos, e, apenas se esses sistemas se basearem em uma classificação adequada – como, por exemplo, a CIAP para a medicina de família e comunidade —, será possível que sejam obtidos dados coerentes sobre uma população inteira, e não apenas sobre indivíduos[17]. Ao longo dos anos, tem-se assistido a certas tensões entre as classificações de atenção primária já existentes e a CID, devido a problemas conceituais e taxonômicos. A CID-10 fornece uma nomenclatura amplamente reconhecida de doenças e problemas de saúde, própria para atenção primária, mas não é o instrumento mais apropriado para uma classificação de atenção primária[18]. Quando utilizada juntamente com a CIAP, como principio ordenador, a CID-10 constitui o caminho para uma boa base de dados informatizada de cada paciente, tornando possível a troca de dados com especialistas e hospitais[17].

CIAP-2

Esta segunda edição da CIAP foi publicada essencialmente por duas razões: estabelecer uma ligação com a 10ª edição da CID, CID-10, publicada pela OMS em 19922, e adicionar critérios de inclusão e referências cruzadas em grande parte das rubricas – as quais são explicadas no Capítulo 6 e desenvolvidas na lista tabular do Capítulo 10. Como garantia de estabilidade e coerência, foram poucas as alterações introduzidas na classificação, embora muitas das que foram sugeridas continuem a ser objeto de consideração por parte do Comitê de Classificação da WONCA. Quaisquer sugestões dos usuários que nos possam ajudar neste processo são bem-vindas.

Esta segunda edição inclui ainda informações acerca de novos avanços na base conceitual da compreensão de medicina de família e comunidade, que surgiram em grande parte a partir da utilização de uma classificação própria desta área. Esses avanços são referidos nos Capítulos 2-5. O livro se baseia em terminologia padronizada, como definida no glossário internacional publicado pelo Comitê de Classificação da WONCA, em 1995[19].

O livro inclui ainda informação acerca de uma série de novas iniciativas relacionadas à classificação. A Escala de Gravidade de Problemas de Duke/WONCA (DUSOI/WONCA) permite classificar problemas individuais de saúde ou problemas combinados de saúde codificados de acordo com a gravidade (Capítulo 7). Os quadros de avaliação do estado funcional de COOP/WONCA permitem avaliar o estado funcional do paciente, independentemente da razão específica ou do problema de saúde que o tenha levado a marcar uma consulta (Capítulo 8).

O índice alfabético (Capítulo 12) da lista tabular inclui apenas os termos dos títulos das diferentes rubricas e os respectivos termos de inclusão. Não é exaustivo e nem pretende ser.

CIAP E CID

A CIAP sempre esteve ligada à amplamente reconhecida Classificação Internacional de Doenças, publicada pela Organização Mundial de Saúde. A primeira edição incluía uma lista de conversão de códigos para a CID-9. Desde então, já foi editada a CID-10, e a CIAP-2 foi cuidadosamente adaptada a ela, possibilitando assim a utilização de sistemas de conversão (Capítulo 11). Os usuários que necessitarem de uma conversão para a CID-9 poderão requerer um disquete à Comissão de Classificações da WONCA.

As pesquisas empíricas exaustivas confirmaram que a CIAP e a CID se complementam, em vez de competirem entre si. É gratificante poder ter a WONCA e a OMS como patrocinadoras desta nova edição.

TRADUÇÕES

A WONCA é uma organização internacional e tenciona promover a publicação de versões da CIAP em outras línguas, além do inglês – a língua de trabalho da Comissão de Classificações. A CIAP já foi traduzida para 19 línguas, e encontra-se publicada como livro em alguns desses idiomas (Quadro 1.1)[13, 20, 21]. Aqueles que desejam promover, ajudar ou assumir a tradução da CIAP-2, não hesitem em entrar em contato com a comissão.

QUADRO 1.1

LÍNGUAS NAS QUAIS A CIAP SE ENCONTRA DISPONÍVEL

Basco	Húngaro	Dinamarquês*
Italiano	Holandês*	Japonês*
Inglês*	Norueguês*	Finlandês*
Polonês	Francês*	Português*
Alemão	Russo	Grego*
Africânder	Hebraico	Castelhano*
Sueco		

* Edição separada disponível nestas línguas.

POLÍTICA DE DIREITOS AUTORAIS E LICENÇA DE PUBLICAÇÃO

Os direitos autorais da CIAP, tanto da cópia original como da versão eletrônica, pertencem à WONCA. Esta política refere-se à versão eletrônica e tem os seguintes objetivos:

- Permitir à Comissão de Classificações da WONCA promover, distribuir e apoiar a CIAP-2 como a melhor classificação de atenção primária;
- Garantir a comparabilidade internacional entre as diferentes versões da CIAP-2;
- Obter informações e manter o rigor das diferentes experiências internacionais da utilização da CIAP-2;
- Obter o reconhecimento da iniciativa e da experiência da WONCA no domínio de classificações;
- Promover a compreensão das ligações entre a CIAP-2 e outros sistemas de classificação e de codificação, mais especificamente a CID-10;
- Encorajar a utilização da CIAP-2, em vez de inibi-la com restrições;
- Obter apoio financeiro que permita que esses objetivos sejam alcançados, promovendo o desenvolvimento e a continuação do trabalho do Comitê de Classificação da WONCA.

Políticas

A versão eletrônica da CIAP-2 deverá encontrar-se disponível no maior número de países possível.

As versões envolvendo edições, traduções ou alterações deverão obter o consentimento do Comitê de Classificação da WONCA, caso pretendam ser reconhecidas como versões oficiais.

A WONCA deverá nomear organizações específicas, responsáveis pela promoção e distribuição de versões eletrônicas da CIAP-2 por países, regiões e grupos linguísticos.

Estas organizações serão responsáveis pelo recolhimento do pagamento de licenças por parte dos usuários. O valor das cotas será negociado e poderá ser alterado caso a WONCA considere de interesse; por exemplo, visando à contribuição para a pesquisa ou o desenvolvimento.

Os leitores que pretendem obter este livro em forma eletrônica, integrar as versões eletrônicas da CIAP em seus sistemas de informática, ou desenvolver e utilizar uma CIAP sob outras formas, deverão entrar em contato com um representante local do Comitê de Classificação da WONCA pelo *e-mail* ciapbrasil@gmail.com.

Abreviaturas

Tentou-se evitar a utilização de abreviaturas tanto quanto possível nesta publicação. No entanto, foi necessário recorrer a algumas:

anr	anormal
doe	doença
quei	queixa
excl	exclui
incl	inclui
NE	não especificado de outra forma
sin	sintomas
/	ou

FEEDBACK DO USUÁRIO

Visando à continuidade do desenvolvimento da CIAP, o Comitê de Classificação da WONCA deseja obter *feedback* do maior número de usuários possível, com sugestões de esclarecimentos, alterações ou edições. Por favor, entre em contato com o representante local da comissão pelo *e-mail* ciapbrasil@gmail.com.

2

A ESTRUTURA DA CIAP

A Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) baseia-se em uma estrutura simples, fundada em dois eixos: 17 capítulos em um deles, com um código alfa cada, e sete componentes idênticos no outro, com rubricas numeradas com códigos de dois dígitos (Figura 2.1 e Quadro 2.1).

Graças à sua característica mnemônica, a CIAP é facilmente usada pelo profissional de saúde e constitui uma forma simplificada de um registro – manual ou eletrônico – centralizado de dados colhidos em qualquer lugar.

A classificação apresenta-se em forma de lista tabular (Capítulo 10). As rubricas dos componentes 1 e 7 surgem por extenso em cada capítulo. As rubricas dos componentes de 2 a 6 são uniformes para todos os capítulos, sendo mencionadas apenas uma vez. A cada uma delas, é atribuído um número de três dígitos, um título pequeno, e os códigos das respectivas rubricas na CID-10. Em sua maioria, compreende ainda termos de inclusão e exclusão, e de "considerar" (vide Capítulo 6). Tentou-se evitar a utilização exagerada de abreviaturas, e, quando usada, a palavra "múltiplo(a)s" refere-se a três ou mais elementos.

	Capítulos																
Componentes	**A**	**B**	**D**	**F**	**H**	**K**	**L**	**N**	**P**	**R**	**S**	**T**	**U**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	

FIGURA 2.1
Estrutura da CIAP: 17 capítulos e 7 componentes.

QUADRO 2.1

CAPÍTULOS E COMPONENTES DA CIAP*

A	Geral e não-específico
B	Sangue, órgãos hematopoiéticos e linfáticos (baço, medula óssea)
D	Aparelho digestivo
F	Olhos
H	Ouvidos
K	Aparelho circulatório
L	Sistema musculoesquelético
N	Sistema nervoso
P	Psicológico
R	Aparelho respiratório
S	Pele
T	Endócrino, metabólico e nutricional
U	Aparelho urinário
W	Gravidez e planejamento familiar
X	Aparelho genital feminino (incluindo mama)
Y	Aparelho genital masculino
Z	Problemas sociais

Componentes (iguais para todos os capítulos)

1	Componente de queixas e sintomas
2	Componente de procedimentos diagnósticos e preventivos
3	Componente de medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos
4	Componente de resultados de exames
5	Componente administrativo
6	Componente de acompanhamento e outros motivos de consulta
7	Componente de diagnósticos e doenças, incluindo:

- doenças infecciosas
- neoplasias
- lesões
- anomalias congênitas
- outras doenças específicas

* Sempre que possível, foi utilizado um código alfa mnemônico.

O índice alfabético da lista tabular (Capítulo 12) inclui termos dos títulos de todas as rubricas e respectivos termos de inclusão. Não se pretendeu com isso criar uma listagem exaustiva, contemplando apenas os termos mais comuns ou os mais importantes em atenção primária. Um utilizador que busque determinado termo que não conste da relação, poderá procurar a respectiva rubrica no índice da CID-10, e depois a rubrica da CIAP nas tabelas de conversão (Capítulo 11). Alguns usuários já desenvolveram um tesauro mais completo, em formato eletrônico, mas ainda não existe uma versão internacional aprovada.

Embora a CIAP seja suficientemente vasta para permitir a classificação dos principais aspectos da atenção primária, ela ainda possui algumas limitações. As rubricas dos componentes de 2 a 6, referentes ao processo de cuidados, são muito generalizadas e não-específicas. Uma classificação de terapêuticas e medicamentos, descrita no relatório do estudo europeu[14], ainda não foi formalmente incluída. A CIAP não adiciona quaisquer resultados objetivos de exames físicos ou pesquisa. Estes materiais poderão ser objeto de desenvolvimento posterior.

RUBRICAS RESIDUAIS

Ao final de cada seção e subseção, poderão ser encontradas rubricas residuais ("rag-bags"), cuja descrição inclui a palavra "outros". "Não especificado de outra forma" (NE) refere-se a todos os termos dessas rubricas. A utilização eficiente da classificação requer bom conhecimento dos limites de cada seção ou subseção. Em caso de dúvida, consulte o índice alfabético.

UTILIZAÇÃO PRÁTICA DE DADOS DE MORBIDADE/DIAGNÓSTICO

Até muito recentemente, existiam apenas classificações de dados destinadas a estatísticas de saúde e formulações de políticas sociais. O aparecimento de bases de dados informatizadas facilitou a organização e introdução rotineira de informações como parte das consultas. Tais dados são necessários como parte integrante dos prontuários dos pacientes e para a elaboração de estudos estatísticos no campo da saúde. As formas de classificação e codificação diferem de acordo com estes dois objetivos: os prontuários dos pacientes requerem o maior número possível de informações detalhadas, enquanto os estudos estatísticos requerem dados sistematicamente agrupados em categorias, fundamentado na sua frequência e relevância para as políticas sociais. A CIAP foi desenvolvida visando ao segundo objetivo, e deverá assim ser ajustada de forma a permitir a codificação de dados nos registros.

EXPANSÃO HIERÁRQUICA OPCIONAL

É claro que nenhuma classificação internacional conseguirá responder a todas as necessidades de cada usuário. Haverá situações inevitáveis em que os usuários desejarão separar as informações contidas numa única rubrica, o que requer códigos expandidos com base no princípio de hierarquia opcional. A codificação de dados clínicos dos processos de cuidado requer muita expansão.

Recomenda-se que, sempre que possível, tais expansões sejam feitas em conformidade com o método da CID-10, ou que esses códigos sejam utilizados como de expansão, permitindo assim equivalência máxima entre sistemas de informações. Mesmo nestes casos, será necessário incluir um espaço para referências específicas a um paciente, de forma a garantir a especificidade dos prontuários dos pacientes[17].

GRAVIDADE DO PROBLEMA E ESTADO FUNCIONAL

Com a ajuda da CIAP, será possível registrar informações sobre a gravidade do problema e a avaliação do estado funcional do paciente, e ainda classificar estas informações com a ajuda de meios fornecidos por este livro. É possível estabelecer uma ligação entre a Escala de Gravidade do Problema de Duke/WONCA (DUSOI/WONCA) (que poderá aplicar-se a problemas individuais de saúde) e as rubricas da CIAP, e a soma dos valores permitirá avaliar a gravidade do total de problemas de saúde do paciente (Capítulo 7). Os quadros de avaliação do estado funcional da COOP/WONCA (explicados no Capítulo 8) aplicam-se ao paciente independentemente dos seus problemas de saúde.

3

EPISÓDIO DE CUIDADO: UM CONCEITO CENTRAL DA MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Desde a publicação da CIAP, em 1987, as mudanças nas necessidades e na utilização de classificações em atenção primária têm sido contínuas. Na época, pensava-se que a principal função da categorização consistia em recolher dados para pesquisa e adoção de linhas de cuidado. Contudo, hoje, os resultados de pesquisas e a experiência prática proveniente da utilização da CIAP, assim como o aparecimento de novos conceitos na medicina de família e comunidade, têm resultado em novas aplicações da classificação.

Dentre as novas aplicações da CIAP, as mais importantes consistem em descrever episódios de cuidados e em informatizar os prontuários dos pacientes. Essas duas funções encontram-se intimamente ligadas e têm por base a CIAP enquanto princípio classificador de dados obtidos na prática da medicina de família e comunidade, e da atenção primária.

A definição da WONCA para *clínico geral/médico de família* refere-se a um "médico que presta cuidados de saúde personalizados, primários e continuados a indivíduos e famílias"[19]. Esta definição está bastante próxima de outras relativas a atenção primária, como a do Instituto de Medicina (IOM): "Atenção Primária é o conjunto de serviços integrados acessíveis prestados por clínicos, responsáveis pela prestação de uma grande variedade de cuidados, estabelecendo apoio contínuo a pacientes num contexto familiar e comunitário"[22].

EPISÓDIO DE CUIDADOS

A escolha de episódio de cuidados como a unidade de avaliação apropriada garantiu a operacionalidade das definições acima referidas. Tais episódios distinguem-se dos de mal-estar ou de doença em uma população. Ele tem início desde o momento em que o problema de saúde (ou a doença) é

apresentado ao profissional e termina na finalização da última consulta concernente àquelas questões (Figura 3.1)[17].

Os motivos da consulta, os problemas de saúde/diagnósticos, e os procedimentos para o cuidado/intervenções são a base de um episódio de cuidados, constituído por uma ou mais consultas incluindo as alterações ao longo do tempo. Por conseguinte, um episódio de cuidados refere-se a todo tipo de atenção prestada a um determinado indivíduo que apresente um problema de saúde ou uma doença. Quando esses episódios são introduzidos no processo informatizado de um paciente com base na CIAP, é possível avaliar a necessidade de cuidados de saúde, a abrangência, o grau de integração, de acessibilidade e responsabilidade.

O conceito de episódio de cuidados foi demonstrado no estudo europeu usando a $CIAP_{14}$, o qual estabeleceu semelhanças e diferenças epidemiológicas e clínicas entre diferentes localidades. O conceito de motivo da consulta também revelou-se uma forma inovadora e prática de operacionalizar a perspectiva do paciente e o seu pedido de cuidados. A validade do motivo da consulta codificado pelo médico de família e comunidade quando comparado ao ponto de vista do paciente, após a consulta, revelou-se muito consistente.[23]

O novo Glossário Internacional de Atenção Primária define o conteúdo de medicina de família e comunidade, e permite estruturar os episódios com a CIAP, possibilitando a recuperação de padrões epidemiológicos e tornando viável a comparação de dados entre diferentes países[19].

MOTIVO DA CONSULTA

O motivo da consulta (MC) é reconhecido como uma fonte prática de informação sobre o paciente, com um papel igualmente importante na pesquisa

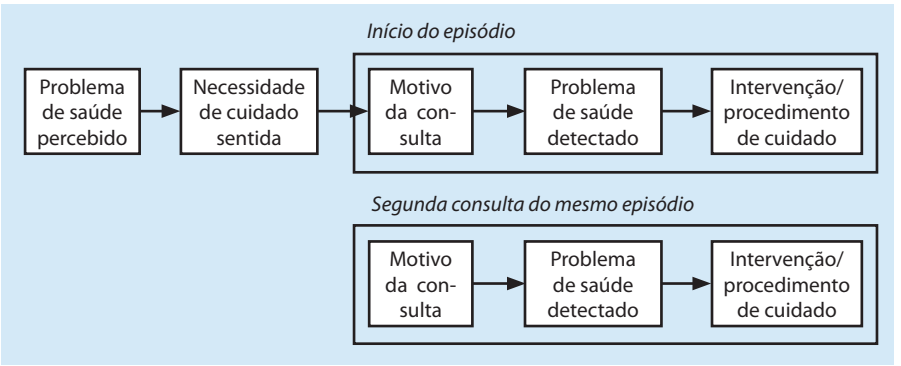


FIGURA 3.1
Um episódio de cuidados

e formação, exemplificado pelo "Transition Project" holandês, cujos dados epidemiológicos encontram-se dispostos na forma de resultado padrão fiel às regras do glossário.[17] Começando por definir o motivo da consulta, o profissional de saúde poderá determinar, por sexo e grupo etário, a probabilidade de se tratar determinado problema de saúde logo no início da consulta ou no acompanhamento do episódio. Os 10 problemas principais relacionados à tosse no início de um episódio revelam diferenças clinicamente significativas entre crianças dos 5 aos 14 anos de idade e homens dos 65 aos 74 (Quadro 3.1). O processo inverso é igualmente relevante sob um ponto de vista clínico: quais os motivos da consulta de cada grupo etário e sexo apresentados no início e durante o acompanhamento de um problema? O episódio de bronquite aguda (Quadro 3.2) ilustra bem esse fato. Os quadros registram as diferenças clínicas com muito mais detalhes do que jamais foi conseguido.

QUADRO 3.1

TÍTULOS DOS 10 EPISÓDIOS PRINCIPAIS QUE COMEÇARAM COM TOSSE (RO5) COMO MOTIVO DA CONSULTA (PROBABILIDADES PRECEDENTES)

MC	R05 Tosse (N = 1267)	N	%
R74	Infecção respiratória superior (constipação nasal)	456	35,6
R78	Bronquite aguda/ bronquiolite	261	20,4
R05	Tosse	159	12,4
R77	Laringite aguda/traqueíte	110	8,6
A77	Outras doenças virais NE	54	4,2
R96	Asma	40	3,1
R81	Pneumonia	33	2,6
R75	Sinusite aguda/crônica	30	2,3
R80	Gripe sem pneumonia	24	1,9
R71	Tosse convulsa	22	1,7
Total 10 mais		**1189**	**92,8**
Total 1281		**100,0**	

Homens com idades entre 65-74 (N = 646)		**N**	**%**
R78	Bronquite aguda/bronquiolite	256	39,1
R74	Infecção respiratória superior (constipação nasal)	155	23,7
R05	Tosse	65	9,9
R77	Laringite aguda/traqueíte	45	6,9
R75	Sinusite aguda/crônica	22	3,4
K77	Deficiência cardíaca	15	2,3
R96	Asma	13	2,0
R91	Bronquite aguda/bronquiectasia	12	1,8
R81	Pneumonia	10	1,5
R95	Enfisema/DPOC	9	1,4
Total 10 mais		**602**	**92,0**
Total 654		**100,0**	

Fonte: "Transition Project", referido em Hofmans-okkes e Lamberts[17]

QUADRO 3.2

DEZ MOTIVOS PRINCIPAIS PARA A CONSULTA NUM EPISÓDIO DE BRONQUITE AGUDA/BRONQUIOLITE (R78)

Crianças com idades entre 5-14 (N = 377)		**N**	**%**
R05	Tosse	321	46,1
A03	Febre	98	14,1
R31	Exame médico/avaliação de saúde/parcial	64	9,2
R02	Dispneia/Fadiga respiratória	43	6,2
R74	Infecção respiratória superior (constipação nasal)	24	3,4
A04	Debilidade/Fadiga/Mal-estar/Cansaço	18	2,6
R03	Respiração ruidosa/sibilante	17	2,4
R64	Episódio novo/antigo iniciado por prestador de CSP	17	2,4
R78	Bronquite aguda/bronquiolite	13	1,9
R21	Sinais/sintomas da garganta	9	1,3
Total 10 mais		**624**	**89,5**
Total 697		**100,0**	

Homens 65-74 (N = 422)		**N**	**%**
R05	Tosse	324	39.4
R02	Dispneia/Fadiga respiratória	133	16.2
R78	Bronquite aguda/bronquiolite	100	12.2
R31	Exame médico/avaliação de saúde parcial	79	9.6
A03	Febre	34	4.1
R25	Expectoração anormal	23	2.8
R64	Episódio novo/antigo iniciado por prestador de CSP	21	2.6
R74	Infecção respiratória superior (constipação nasal)	14	1.7
A04	Debilidade/Fadiga/Mal-estar/cansaço	13	1.6
R01	Dor atribuída ao aparelho respiratório	8	1.0
Total 10 mais		**749**	**91.1**
Total 822		**100.0**	

Fonte: "Transition Project", referido em Hofmans-okkes e Lamberts[17]

PROBLEMA DE SAÚDE/DIAGNÓSTICO

O problema de saúde/diagnóstico, que dá nome ao episódio de cuidados, constitui seu ponto principal. Muitos problemas de saúde são, de fato, diagnósticos médicos, mas em atenção primária muitos são constituídos por outras condições tais como medo de doenças, sintomas, queixas, incapacidades ou necessidade de cuidados (por exemplo, imunização). A CIAP inclui todas essas condições. O problema de saúde poderá ser classificado na consulta com relação ao seu estágio, a certeza que o profissional tem do diagnóstico e a gravidade do problema.

O estágio do episódio numa consulta pode ser especificado como novo tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente; novo para o profissional, embora já possa ter sido tratado em outro serviço; ou antigo para

ambos no caso de consulta de acompanhamento (Figura 3.2 D). Um prontuário informatizado do paciente avisa ao profissional de saúde se o episódio ainda não foi registrado na base de dados, ou se já existe algum com o mesmo nome. Tal dispositivo permite garantir a qualidade do registro diário de informações.

Outro aspecto dos episódios de cuidados consiste em determinar até que ponto o profissional poderá ter a certeza de que o seu diagnóstico está correto (avaliação desde o mais certo até o mais incerto). No entanto, não foi ainda adotado qualquer método formal de avaliação. Ainda assim, os critérios de inclusão de rubricas na CIAP-2 permitirão assegurar que a denominação escolhida para certo episódio seja utilizada com coerência por todos os profissionais de saúde. Menus *pop-up* permitem dispor as opções segundo a ordem do registro de informação na base de dados informatizada.

O terceiro elemento de categorização de um episódio de cuidados, a gravidade, é abordado no Capítulo 7.

São muito frequentes, em atenção primária, os casos de pacientes com múltiplos problemas de saúde e episódios de cuidados. Um bom sistema de dados permitirá estabelecer uma inter-relação entre esses dois campos, e fornecer informações de comorbidade (Quadro 3.3).

INTERVENÇÕES, PROCEDIMENTOS

A especificidade do código de três dígitos do processo da CIAP, que permite a classificação de intervenções imediatas, é limitada, embora adequada. Contudo, a prescrição de medicamentos necessita do código de medicamentos. Devido ao vasto número de fármacos envolvidos e à idiossincrasia dos remédios nacionais, não existe ainda nenhum código internacional. Na Europa, o código de medicamentos da CIAP, compatível com a ATC (*Anatomical Therapeutic Chemical Classification System*), tem sido muito útil e poderá ser adotado em circunstâncias muito mais amplas.[13]

REGISTROS DE PACIENTES

A base de qualquer arquivo informatizado de pacientes usa informações codificadas com a CIAP, as quais independem da língua, encorajando a utilização de dados clínicos, visando à comparação entre países e apoiando o estabelecimento da medicina de família e comunidade como profissão internacionalmente desenvolvida, com base em um quadro referencial empírico e bem definido. A publicação da CIAP em 19 línguas e o crescente número de traduções da CID-10, juntamente com índices alfabéticos, permitirão aos profissionais de saúde de vários países introduzir, no respectivo sistema de

QUADRO 3.3

EPISÓDIOS DE COMORBIDADE EM PACIENTES COM R78, BRONQUITE AGUDA/BRONQUIOLITE

Crianças entre 5 e 14 anos (N=329)		**N**	**%**	**Prev.**
R74	Infecção respiratória superior	90	9,6	274
H71	Otite aguda/meningite	57	6,1	173
R78	Bronquite aguda/bronquiolite	48	5,1	146
R96	Asma	37	3,9	112
A97	Sem doença	32	3,4	97
S03	Verruga	29	3,1	88
A77	Outras doenças virais NE	21	2,2	64
R76	Amigdalite aguda	20	2,1	61
S18	Laceração/ferida aberta	20	2,1	61
D73	Outras infecções presumíveis do aparelho digestivo	17	1,8	52
Total 10 mais		**371**	**39,6**	**1128**
Total 938		**100,0**	**2851**	

Média de episódios de comorbidade = 2,9

Homens com idades entre 65 e 74 (N=350)		**N**	**%**	**Prev**
R78	Bronquite aguda/bronquiolite	72	4,7	206
A97	Sem doença	56	3,7	160
R95	Enfisema/DPOC	47	3,1	134
K86	Hipertensão não-complicada	46	3,0	131
R74	Infecção respiratória superior	46	3,0	131
K77	Insuficiência cardíaca	35	2,3	100
A85	Efeito(s) secundário(s) de fármaco(s)	30	2,0	86
H81	Cerúmen em excesso no ouvido	30	2,0	86
K76	Cardiopatia isquêmica crônica/outras cardiopatias isquêmicas	30	2,0	86
T90	Diabetes mellitus	25	1,6	71
Total 10 mais		**417**	**27,4**	**1191**
Total 1521		**100,0**	**4346**	

Média de episódios de comorbidade = 4,3
Prev. = Número de episódios de comorbidade em cada 1.000 pacientes com R78
Fonte: "Transition Project", em Hofmans-Okkes e Lamberts[17]

saúde, um tesauro especializado e, simultaneamente, com a ajuda da CIAP, estruturar os dados clínicos e a base de dados de forma mais padronizada.

NOVAS EVOLUÇÕES

Aos três elementos básicos de consultas codificados pela CIAP (Figura 3.1) – motivo da consulta, problema de saúde e intervenções ou procedimentos – foram acrescentados mais três, existindo atualmente seis rubricas de dados (A-F) nos prontuários informatizados de pacientes (Figura 3.2)[19]. O

motivo da consulta é registrado em duas componentes: os sintomas e queixas do paciente e o pedido de intervenção por parte dele. Os achados clínicos do médico, enunciados sob a forma de sinais e sintomas, são codificados juntamente com os motivos da consulta. As intervenções são registradas como imediatas (adotadas durante a consulta) ou subsequentes (a serem realizadas após a consulta).

Todo o trabalho realizado com essa estrutura, particularmente nos Países Baixos, confirmou a utilidade do conceito de motivo da consulta, aperfeiçoando-o, bem como aprimorou os demais conceitos de problema de saúde/ diagnóstico e intervenção/ procedimento.[14]

Não restam dúvidas que a identificação dos motivos da consulta permite determinar fatores antecedentes, ainda mais se os incômodos apresentados pelo paciente, tais como tosse, falta de ar, febre, expectoração e chiado no peito (Figura 3.2A) forem diferentes dos dados clínicos observados pelo profissional durante a colheita da história clínica (Figura 3.2C). A CIAP engloba mais de 200 sinais e sintomas, podendo desempenhar bem o papel de classificação de motivos da consulta e de achados clínicos, embora convenha referir que não inclui ainda uma classificação de achados objetivos. Ambas as aplicações podem ser integradas no componente de consulta e episódio do prontuário informatizado do paciente (Figura 3.2A e C). Juntas, permitem um cálculo rigoroso de probabilidades prévias, mantendo a distinção entre um sintoma expresso pelo paciente como motivo da consulta e aquele diagnosticado pelo profissional; se for o caso, as probabilidades poderão ser calculadas separadamente.

Os motivos da consulta sob a forma de sintomas, queixas ou problemas de saúde/diagnóstico deverão ser claramente diferenciados dos pedidos de

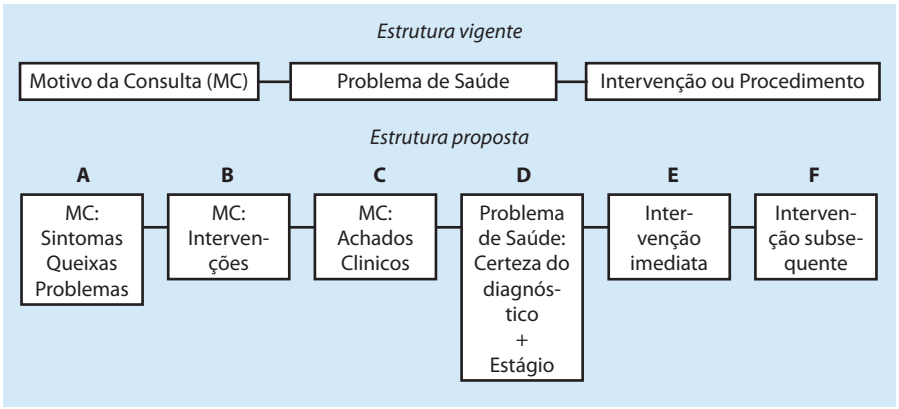


FIGURA 3.2
Nova estrutura proposta para a descrição de consultas[19]

procedimentos, tais como receitas, radiografia, referência ou ensino (Figura 3.2A e B). É frequente um pedido de procedimento ser seguido imediatamente pela própria intervenção: quando um paciente pede determinada medicação ou análise, o médico, normalmente, logo passa a ele a receita ou requisição.[17] Visto que os pacientes influenciam diretamente os cuidados prestados pelos clínicos gerais/médicos de família, convém registrar esta influência de forma a compreender melhor a aderência.

Os sistemas de dados deveriam ser capazes de distinguir entre uma intervenção do tipo diagnóstica e terapêutica durante a consulta ("imediata", Figura 3.2E) e as intervenções seguintes ("subsequentes", Figura 3.2F). A diferenciação entre a intervenção real do profissional durante a consulta e a intervenção posterior esperada facilita a análise dos dados de utilização dos serviços, das variações de profissional para profissional e da aderência. Permite ainda compreender melhor a modificação das probabilidades *a priori* na primeira consulta de um episódio, para probabilidades *a posteriori* durante o acompanhamento.[19]

Para o registro de intervenções subsequentes, será necessária uma classificação de procedimentos mais específica do que a CIAP permite. O trabalho do Comitê de Classificação da WONCA prossegue nesse sentido.

4

USO DA CIAP PARA REGISTRAR O MOTIVO DA CONSULTA

A forma de codificar informações utilizando a CIAP varia conforme o tipo de dado a ser registrado: por exemplo, o motivo da consulta, o problema de saúde ou o procedimento. De forma a promover um registro coerente e uniformizado, e, por conseguinte, melhor comparação de informações entre os centros, sugerimos os padrões abaixo.

MOTIVO DA CONSULTA

O prestador de cuidados primários deverá identificar e clarificar o motivo da consulta (MC) tal como foi expresso pelo paciente, sem fazer quaisquer juízos de valor relativos à veracidade e à exatidão dele. Três princípios orientam esse uso da classificação:

1. O motivo da consulta deverá ficar claro entre o paciente e o profissional e deverá ser reconhecido pelo paciente como uma descrição aceitável.
2. A rubrica da CIAP escolhida deverá ser tão próxima quanto possível das palavras originais utilizadas pelo paciente para apresentar o motivo, e deverá ser mantida ou alterada o menos possível pelo profissional. No entanto, será necessário esclarecer os motivos da consulta apresentados pelo paciente dentro do quadro da CIAP de forma que seja aplicada a rubrica mais apropriada na classificação.
3. A lista de critérios das rubricas para registro de problemas de saúde/diagnósticos NÃO deverá ser usada, haja vista que o motivo da consulta deve ser registrado a partir do ponto de vista do paciente, e totalmente baseado na descrição do motivo feita por ele.

A forma como um paciente exprime os seus motivos da consulta determina o capítulo e o componente a usar (Figura 2.1 e Quadro 2.1). Toda

classificação é aplicável, visto que o paciente pode descrever os seus motivos para procurar os cuidados de saúde sob a forma de sintomas ou queixas, de pedidos de certos serviços ou de problemas de saúde.

ESCOLHER O CÓDIGO DO CAPÍTULO

Para codificar o MC, é necessário, inicialmente, escolher o sistema anatômico ou o capítulo correto, atribuir-lhe o código alfa certo e, em seguida, o código numérico de dois dígitos do componente em questão, como um sintoma ou sinal, um diagnóstico ou um procedimento. O índice alfabético deverá ser utilizado quando houver dúvidas quanto ao capítulo ou ao componente em que a consulta deve ser inserida. O capítulo A é usado para consultas relacionadas aos sistemas anatômicos múltiplos ou não-específicos.

Ao utilizar a CIAP para registrar o MC, aplicam-se quatro regras para o uso dos capítulos e três regras para o uso dos componentes. Essas regras encontram-se enumeradas em seguida, em conjunto com exemplos de sua aplicação prática.

Regra 1

O motivo da consulta deve ser codificado tão especificamente quanto possível, e poderá exigir algum esclarecimento por parte do profissional.

EXEMPLO

As dores no peito poderão ser classificadas como A11 (dores no peito não atribuídas a nenhuma causa específica [NE]), ou como K01 (dores atribuídas ao coração), ou como R01 (dor atribuída ao aparelho respiratório), ou ainda como L04 (sinais/sintomas do tórax). A decisão da escolha não deve ser baseada na opinião do profissional quanto ao tipo de dor no peito, mas sim na forma como o paciente descreve o motivo para ir à consulta quando o profissional lhe pede que especifique.

"É em toda esta área do peito..."	A11
"Meu peito dói quando tusso"	R01
"Meu peito dói... Acho que é do coração"	K01
"Meu peito dói desde que caí da escada"	L04

Regra 2

Quando o paciente for bastante específico, use a terminologia dele.

EXEMPLO

A icterícia, enquanto termo descritivo de um diagnóstico, pode ser encontrada no Capítulo D (digestivo), mas o paciente pode descrever esse sintoma como uma coloração amarelada da pele (Capítulo S). Se o paciente descrever o problema como icterícia, o código da CIAP é D13. Se, pelo contrário, o paciente disser "a minha pele está amarela", o código correto será S08, mesmo se o prestador de cuidados de saúde tiver a certeza de que o diagnóstico é uma forma de hepatite.

Regra 3

Quando o paciente não é capaz de descrever a sua queixa, a razão apresentada pela pessoa que o acompanha pode ser aceita como sendo do paciente (por exemplo, a mãe de uma criança ou o familiar que acompanha um paciente inconsciente).

Regra 4

Qualquer problema apresentado pelo paciente deve ser registrado como motivo da consulta. Se ele apresentar mais de uma razão, impõe-se uma codificação múltipla. Todas as razões devem ser codificadas, independentemente do momento da consulta em que surgem.

"Preciso dos comprimidos para a pressão. Além disso, meus seios estão muito sensíveis e doloridos" – K50, X18. Se, mais tarde, o paciente perguntar: "O que será este volume na pele?", isso também deve ser codificado como um motivo da consulta – S04.

ESCOLHER O CÓDIGO DO COMPONENTE

Sinais e sintomas

Os motivos mais comuns apresentados pelos pacientes para procurar os cuidados de saúde têm a forma de sinais e sintomas[14, 16, 23, 24]. Assim sendo, é natural que o Componente 1 (sinais e sintomas) seja muito utilizado. Os sintomas são específicos para cada capítulo: as náuseas encontram-se no Capítulo Digestivo (D09), enquanto os espirros (R07) estão no Capítulo Respiratório. Embora a maioria das rubricas desse componente sejam sintomas específicos do capítulo a que pertencem, foi introduzida alguma padronização para que a codificação seja mais fácil.

Na maioria dos capítulos, com exceção do psicológico e do social, as primeiras rubricas dizem respeito ao sintoma dor. Exemplos disso são as dores de ouvido (H01) e as dores de cabeça (N01). Existem ainda quatro rubricas padrão do Componente 1 em cada capítulo. São elas:

1. Medo de câncer;
2. Medo de uma doença ou estado;
3. Limitação Funcional / incapacidade;
4. Outros sinais/sintomas.

Os códigos 26 e 27, e, por vezes, alguns outros, são usados quando o paciente manifesta preocupação ou medo de ter câncer ou outra doença. Eis alguns exemplos:

"Tenho medo de ter tuberculose"	A27
"Estou preocupada porque tenho medo de ter câncer de mama"	X26
"Tenho muito medo de ter uma doença venérea"	Y25

Mesmo que o prestador pense que tal receio é totalmente injustificado ou ilógico, ele constitui o motivo da consulta.

A rubrica -28 deve ser usada quando o MC do paciente é expresso em termos de uma incapacidade que afeta suas atividades cotidianas e suas funções sociais.

EXEMPLOS

"Não consigo subir as escadas com o gesso que me puseram na perna por causa da fratura no tornozelo" – L28 (Componente 1) e L76 (Componente 7).

"Não posso ir ao escritório porque as hemorroidas não me deixam ficar sentado por muito tempo" – K28 (Componente 1) e K96 (Componente 7).

Em cada capítulo, o componente 29 serve de "miscelânea" para os sinais/sintomas. Essa rubrica inclui os sintomas menos comuns e as queixas que não têm uma rubrica própria. Serve ainda para os sinais/sintomas que foram descritos de forma pouco clara. Antes de usá-la,é conveniente verificar o índice para ter a certeza de que não há outra que se refira a palavras sinônimas das utilizadas pelo paciente.

DIAGNÓSTICO, RASTREIO E PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS

As razões incluídas neste conceito são aquelas pelas quais o paciente solicita um procedimento específico, como, por exemplo: "Estou aqui para fazer um exame de sangue" (-34). O paciente pode pedir determinado procedimento relativo a uma questão já descrita, ou simplesmente fazer o pedido, como nestes casos:

"Queria que o senhor me examinasse por causa do coração"	(K31)
"Acho que devia fazer um exame de urina"	(-35)
"Vim por causa do resultado da radiografia"	(-60)
"Tenho que tomar uma vacina"	(-44)

O prestador deverá pedir os esclarecimentos que julgue necessários para saber a razão que leva o paciente a querer fazer um exame de urina, por exemplo, para assim poder escolher o código alfa correto. Se for por causa de uma possível infecção da bexiga, será o código U35; se for por diabetes, T35. Se o resultado da radiografia referir-se a um contraste baritado, D60. Um pedido para uma vacina contra a rubéola, A44.

TRATAMENTO, PROCEDIMENTOS E MEDICAÇÃO

Esses motivos englobam os casos em que o paciente solicita um tratamento, ou quando se refere às instruções do profissional para que regressasse após algum tempo por motivos de tratamento, procedimento ou medicação. Por vezes será necessário que o profissional peça mais esclarecimentos para saber qual é o código mais adequado.

EXEMPLOS

"Preciso de uma receita para os meus medicamentos" (-50). Se o paciente descreve a razão pela qual está tomando essa medicação ou se o prestador conhece essa razão, deverá escolher o código alfa correspondente: para uma sinusite, por exemplo, o código seria R50.

"Vim para tirar o gesso" (-54). É claro que, se o paciente sofreu uma fratura no braço esquerdo, o código alfa correto seria o L.

"Me disseram para vir aqui hoje tirar os pontos" (-54). Embora, à primeira vista, possa parecer que toda remoção de suturas deve ser incluída no Capítulo da Pele, o paciente pode ter pontos resultantes de uma cirurgia na pálpebra (F54) ou de uma operação por fimose (Y54).

RESULTADOS DE EXAMES COMPLEMENTARES

Esse componente deve ser escolhido quando o paciente pede, especificamente, os resultados de exames já realizados. O fato de o resultado dos exames ser negativo não afeta em nada a escolha desse componente. Muitas vezes, o paciente, além de querer saber o resultado do exame e as suas consequências, também pede mais informações sobre o problema que levou à sua realização. Nesse caso, não se deve esquecer de utilizar também o código -45 (educação e conselhos para a saúde).

EXEMPLOS

"Queria saber o resultado do meu exame de sangue". Se a análise foi por anemia, o código é B60; se foi para lipídeos, T60; se o paciente não souber especificar, A60.

"Queria saber os resultados do raio-X de estômago que fiz na semana passada" (D60).

"Vim buscar os resultados da minha análise de urina, como combinado, para levá-los ao urologista. Também queria saber que tipo de exames e de tratamento são prováveis que ele me aconselhe" (U60, U45).

MOTIVOS ADMINISTRATIVOS

Os motivos administrativos para uma consulta médica podem incluir exames pedidos por terceiros (alguém que não seja o paciente), formulários de seguros que precisem ser preenchidos, e questões de transferência de registros.

EXEMPLOS

"Preciso preencher este formulário para o seguro" (A62).

"A minha fratura está boa e preciso de uma declaração para voltar a trabalhar" (L62).

REFERÊNCIAS E OUTROS MOTIVOS DA CONSULTA

Se o motivo do paciente para vir à consulta é pedir credenciais para ver outro prestador, -66, -67 e -68 devem ser utilizados. Se o paciente diz que vem porque "o senhor mandou que eu voltasse" ou porque "foi mandado por outro médico", utilize -64 ou -65.

Quando um prestador inicia um novo episódio ou toma a iniciativa de acompanhar um episódio já existente de um problema de saúde como, hipertensão, obesidade, alcoolismo, tabagismo etc., será conveniente codificar o motivo da consulta como -64.

EXEMPLO

Um paciente queixa-se de um ouvido tapado por causa de cera, que é removida. Depois, é medida a sua pressão arterial, que se encontra alta, e, finalmente, são dados a ele alguns conselhos sobre os seus hábitos de fumante. Os motivos da consulta, os problemas e tratamentos a elas relacionados seriam registrados da seguinte forma:

H13 (sensação de ouvido tapado);
H81 (cera no ouvido);
H51 (remoção da cera).
K64 (iniciativa do profissional);
K85 (pressão arterial alta);
K31 (controle da pressão arterial).
P64 (iniciativa do profissional);
P17 (abuso de tabaco);
P45 (conselhos para parar de fumar).

DIAGNÓSTICO/DOENÇA

O componente 7 só deve ser usado quando o paciente descrever o motivo da consulta como um diagnóstico específico ou uma doença. O motivo da consulta de um paciente, o qual sabemos ser diabético, mas que se queixa de fraqueza, não deve ser codificado como diabetes, mas sim como fraqueza (A04). Se, pelo contrário, o paciente veio à consulta por causa da diabetes, então este deve ser registrado como o motivo da consulta (T90).

Se o paciente aponta o motivo da consulta como sendo um diagnóstico que o profissional de saúde sabe não estar correto, o MC "errado" deve ser registrado em vez de o motivo "certo" do profissional. Por exemplo, um paciente que vem à consulta por causa de "enxaquecas", mas que o profissional saiba tratar-se de cefaléias tensionais; ou outro que o profissional saiba que tem pólipos nasais, mas que se queixa de "febre do feno".

EXEMPLOS

"Vim por causa da pressão alta" (K86)

"Venho aqui todos os meses por causa da artrite no quadril" (L89)

REGRAS DOS COMPONENTES

As regras seguintes para o uso de cada componente vêm complementar a descrição dos componentes.

Regra 1

Quando um código for precedido por um traço (-), escolha o código do capítulo (alfa). Use A quando o MC não corresponder a nenhum capítulo específico ou quando se tratar de vários capítulos. Todos os códigos têm de começar por um código alfa para estarem completos.

EXEMPLO

Uma biópsia será codificada como -52: D52 para o sistema digestivo, S52 para a pele. A medicação prescrita será codificada como -50: um paciente que peça medicação para a asma corresponderá a R50.

Regra 2

Podem ser usadas rubricas de mais de um componente ou mais de uma rubrica do mesmo componente para o mesmo atendimento, desde que o paciente aponte mais de um motivo para ir à consulta.

EXEMPLOS

"Tenho dores de barriga desde ontem à noite e já vomitei várias vezes" D01, D10

"Tenho dores de barriga e acho que pode ser apendicite" D06, D88.

5

USO DA CIAP PARA REGISTRAR PROBLEMAS DE SAÚDE E PROCEDIMENTOS

PROBLEMAS DE SAÚDE

A CIAP pode ser usada para registrar a avaliação que o profissional faz dos problemas de saúde do paciente em termos de sinais e sintomas ou diagnósticos e, portanto, deriva dos componentes 1 e 7. Este último baseia-se na lista de doenças, ferimentos e problemas relacionados à saúde da Classificação Internacional de Doenças (CID), mas inclui como rubricas separadas apenas aquelas que são relevantes ou mais comuns nos cuidados primários.

Muitos problemas de saúde tratados em atenção primária não podem ser denominados como doenças ou ferimentos; dentre eles estão sinais e sintomas, os quais encontram-se enumerados no Componente 1. Por vezes, não há qualquer problema de saúde envolvido em um episódio de cuidados, como quando se trata de um pedido de vacina, uma citologia ou um conselho. Esses episódios podem ser registrados como A97 (Sem doença) ou A98 (Medicina preventiva/ manutenção da saúde).

Nos Componentes 1 e 7, os correspondentes nos códigos CID-10 estão listados para cada rubrica. Por vezes, verifica-se uma correspondência exata de um para um, mas, geralmente, há vários códigos CID-10 para uma rubrica CIAP-2, e, outras vezes, vários códigos CIAP-2 para uma só rubrica CID-10. No Capítulo 10, há um quadro de conversão completo.

De forma a garantir a confiabilidade da codificação de problemas de saúde por meio da CIAP-2, muitas rubricas do Componente 7 especificam os critérios de inclusão. Esses são explicados no Capítulo 6.

As rubricas dos Componentes 1 e 7 vêm muitas vezes acompanhadas de informação adicional, que funciona como uma espécie de guia para o uso: listas de sinônimos e descrições alternativas como termos de inclusão; listas

de estados semelhantes, os quais devem ser codificados em outro local como termos de exclusão; e listas de códigos menos específicos, os quais podem ser usados quando o estado do paciente não satisfaz os critérios de inclusão. Essas linhas de orientação não são fornecidas para as rubricas dos Componentes de 2 a 6.

REGRAS GERAIS PARA CODIFICAR OS PROBLEMAS DE SAÚDE

Os usuários deverão registrar, em cada encontro, o leque completo dos problemas de saúde, incluindo os de ordem orgânica, psicológica e social, na forma de episódio(s) de cuidados. O registro deve ser feito com o máximo de precisão diagnóstica por parte do utilizador, e com uma satisfação total dos critérios de inclusão de cada rubrica.

Qualquer sistema de dados deve incluir critérios claros e específicos para a forma como é feito o registro de problemas de saúde ou episódios de cuidados. Esse fato refere-se especificamente à relação entre o estado subjacente e suas manifestações quando ambos constituem rubricas da classificação, e pode ser clarificado com um exemplo. Um paciente com isquemia cardíaca também pode sofrer de fibrilação atrial e da ansiedade daí resultante. Nesse caso, deve-se incluir como episódios de cuidados separados as manifestações que exigem tratamento diferente: a fibrilação atrial e a ansiedade serão registradas como episódios de cuidados adicionais.

Alguns sistemas exigem que os problemas sejam codificados apenas a partir dos Componentes 1 e 7; outros aceitam códigos de componentes diversos, de forma que, por exemplo, se o paciente solicita uma vacina contra o tétano não motivada por nenhum ferimento recente, o problema deve ser codificado como N44.

Na CIAP, a localização nos sistemas anatômicos tem precedência sobre a etiologia, de forma que, ao codificar um estado, o qual, devido à sua etiologia, pode ser encontrado em vários capítulos (por exemplo, um traumatismo), deve ser usado o capítulo apropriado. O capítulo A (geral) só deve ser escolhido se o local não for especificado ou se a doença afetar mais do que dois sistemas do corpo humano. Todos os capítulos incluem rubricas específicas relativas ao órgão ou sistema envolvido na doença e na etiologia. Estados que acompanhem e afetem a gravidez ou o puerpério são normalmente codificadas no Capítulo W, mas um estado não é incluído nesse capítulo porque a paciente está grávida; deve ser codificado na rubrica apropriada do capítulo que representa o sistema em causa. Todos os problemas sociais, quer apresentados como motivo da consulta ou como problema, estão listados no primeiro componente do Capítulo Z.

Regras específicas para codificar problemas de saúde utilizando critérios de inclusão (ver também o Capítulo 6)

1. A codificação do diagnóstico deve ser a mais específica possível nessa consulta.
2. Os critérios de inclusão contêm o número mínimo de normas necessárias para permitir a codificação dentro de determinada rubrica.
3. A consulta dos critérios deve ser feita depois de se ter chegado a um diagnóstico. Eles NÃO são guias de orientação para o diagnóstico NEM para tomar decisões terapêuticas.
4. Se os critérios não forem cumpridos em sua totalidade, deverão ser consultadas outras rubricas menos específicas sugeridas pelo termo "considerar".
5. Em relação às rubricas que não têm critérios de inclusão, consulte a lista de termos de inclusão da rubrica e leve em consideração os termos de exclusão.

PROCEDIMENTOS

A CIAP pode ser usada para classificar os procedimentos realizados durante a prestação de cuidados em saúde com os Componentes 2, 3, 5 e parte do 6. O componente 4 e algumas rubricas do Componente 6 (nomeadamente, -63, -64, -65 e -69), pelo contrário, não podem ser utilizados do mesmo modo.

Essas rubricas de procedimentos são mais gerais e abrangentes. Por exemplo, um exame de sangue (-34), mesmo se ligado a um só sistema anatômico (por exemplo, o circulatório, K34), pode englobar uma grande variedade de análises, como enzimas, lipídios ou eletrólitos.

Os códigos de procedimentos dos Componentes 2, 3 e 5 obedecem aos grandes títulos da classificação mais específica chamada "IC-Process-PC" (Classificação Internacional de Procedimentos em Atenção Primária), desenvolvida pelo Comitê de Classificação da WONCA25. A CIAP e a "IC-Process-PC" são, portanto, mutuamente compatíveis. Os pormenores encontrados na "IC-Process-PC" podem ser aplicados aos códigos de três dígitos da CIAP, ampliando-os para quatro ou cinco dígitos.

Os códigos das rubricas dos Componentes 2, 3, 5 e das rubricas do Componente 6 podem ser usados nos procedimentos e mantêm-se uniformes em todos os capítulos em relação aos dois dígitos. O código alfa do capítulo em questão deve ser acrescentado pelo profissional responsável pela codificação. Um certo número de rubricas do primeiro e do sétimo componentes dos Ca-

pítulos W, X e Y também incluem procedimentos como parto, aborto e planejamento familiar.

O princípio mais importante na codificação do procedimento é compilar todas as intervenções que têm lugar em determinada consulta e que têm uma relação lógica com o episódio de cuidados. Um quarto ou até um quinto dígito pode ser necessário para maior especificidade, como nos exemplos seguintes:

EXEMPLO 1

-54	Reparação/fixação/sutura/gesso/prótese
L54.1	Aplicação de gesso
L54.2	Remoção do gesso

EXEMPLO 2

-40	Endoscopia diagnóstica
D40	Endoscopia diagnóstica do aparelho digestivo
D40.1	Gastroscopia

Pode-se utilizar mais de um código de procedimento para cada consulta, mas é extremamente importante manter a coerência. Por exemplo, a medição da pressão arterial, que é rotineira em casos de hipertensão, pode ser sempre codificada como K31. A coerência deve também ser mantida nos exames de rotina dos sistemas anatômicos no capítulo geral, quer completos, quer parciais. Em seguida, apresentaremos exemplos de definições para exames completos e parciais usados em determinados contextos. Porém, é essencial que cada país desenvolva a sua definição de exame completo – geral e de exame completo – sistema anatômico, e que estas sejam usadas com coerência. Assim, fica assegurada a relação harmônica entre ambos nesse país.

Exame completo

O termo exame completo refere-se a uma análise que inclui elementos de controle, os quais refletem o padrão habitual de cuidados dispensados pelos profissionais de determinada área. Esse exame deverá ser completo quando relativo a um sistema anatômico (por exemplo, os olhos, Capítulo F) ou um exame geral completo (Capítulo A).

Exame parcial

O termo "exame parcial" refere-se, em todos os capítulos, a exames parciais relacionados a determinado sistema ou função. Sempre que um exame limitado ou incompleto incluir mais de dois sistemas, deve ser considerado um exame geral (Capítulo A). A maioria das consultas inclui um exame parcial para avaliar doenças mais ou menos graves ou novas visitas no caso de doenças crônicas. Alguns exemplos:

- Exame completo – completo, *check-up* = A30
- Exame neurológico completo = N30
- Exame parcial – geral, exame limitado a vários sistemas, por exemplo, respiratório e circulatório = A31
- Exame parcial – sistema anatômico, medição da pressão arterial = K31

Os procedimentos seguintes são considerados pelo Comitê de Classificação da WONCA como parte dos exames de rotina, os quais devem ser codificados nas rubricas -30 e -31 e não em códigos específicos:

- inspeção, palpação, percussão, ausculta;
- acuidade visual e fundoscopia;
- otoscopia;
- percepção das vibrações (teste do diapasão);
- função vestibular (excluindo testes calorimétricos);
- toque retal e vaginal;
- exame da vagina com espéculo;
- registro da pressão arterial;
- laringoscopia indireta;
- altura/peso.

Todos os outros exames devem ser incluídos em outras rubricas.

Componente 2 – Procedimentos diagnósticos e preventivos

Os procedimentos diagnósticos e preventivos cobrem um leque vasto de cuidados de saúde, como imunizações, rastreios, avaliação de riscos, educação para a saúde e aconselhamento.

Componente 3 – Medicação, tratamentos, procedimentos terapêuticos

Esse componente compreende os procedimentos feitos no local pelo prestador de atenção primária. Não deve ser usado para registrar procedimentos feitos por profissionais de saúde para os quais o paciente tenha sido referenciado com uma ficha de encaminhamento, situação que exigiria uma lista de procedimentos bem mais extensa. As imunizações estão codificadas no Componente 2.

Componente 4 – Resultados

O Componente 4 não se refere aos procedimentos ou às intervenções.

Componente 5 – Administrativo

Esse componente pretende classificar os casos em que o paciente solicita ao profissional um documento ou certificado escrito, previsto pela lei em vigor, quer esse documento seja para si próprio ou para outrem. Escrever uma carta de referência só é considerado um serviço administrativo se for a única atividade desenvolvida durante o encontro. Caso contrário, deve ser incluída no Componente 6.

Componente 6 – Referências

As referências para outros prestadores de cuidados de saúde primários, médicos, hospitais, clínicas e serviços terapêuticos ou de aconselhamento devem ser codificadas neste componente. As requisições para uma radiografia ou uma análise em laboratório devem ser codificadas no Componente 2.

Para maior especificidade, pode-se adicionar um quarto dígito, por exemplo:

-66	Encaminhamento para outro profissional/enfermeiro/terapeuta/ assistente social.
-66.1	Enfermeiro
-66.2	Fisioterapeuta
-66.3	Assistente social
-67	Especialista
-67.1	Clínico geral
-67.2	Cardiologista
-67.3	Cirurgião

6

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DA CIAP

INTRODUÇÃO

A Comissão de Classificação da WONCA sempre soube que uma lista de rubricas, definida a nível internacional, para classificar os problemas com os quais se deparam os cuidados primários seria incapaz, por si só, de garantir o mais alto nível de comparação estatística. Visando aumentar a coerência da codificação, foram introduzidos critérios de inclusão para o uso de cada rubrica na Classificação Internacional de Problemas de Saúde em Atenção Primária (CIPS-2-Definida), publicada em 1983[5].

Critérios de inclusão não é o mesmo que definições. Devem ser considerados em relação ao seu objetivo (aumentar a coerência da codificação) e não como definições para delinear problemas de saúde. Esforçamo-nos, porém, para que eles sejam compatíveis com as definições aceitas, como as da Nomenclatura Internacional de Doenças (NID).

Nesta publicação, muitos dos critérios de inclusão baseados na ICHPPC foram revistos e estão diretamente ligados às rubricas da CIAP. Outros foram consideravelmente modificados e, em alguns casos, criaram-se critérios de inclusão novos, com base no enquadramento teórico descrito na seção seguinte. Apesar de esta publicação marcar um avanço na taxonomia da Medicina de Família e Comunidade e da Atenção Primária à Saúde, ainda não é a ideal. A CIAP é uma classificação em constante evolução, e a experiência com os critérios de inclusão apresentados neste volume conduzirá certamente a mais aperfeiçoamentos. Todos os comentários e críticas por parte dos usuários serão bem-vindos.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO PARA A ATRIBUIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

O enquadramento teórico utilizado para a atribuição dos critérios de inclusão desta classificação baseia-se na presença de quatro categorias gerais de diagnóstico: entidades etiológicas e patológicas, estados patofisiológicos,

diagnósticos nosológicos (síndromes) e diagnósticos de sintomas. Optamos por aplicar princípios diferentes a cada categoria, dependendo das suas características.

- *etiológicas e patológicas*: o diagnóstico revela etiologia ou patologia; os critérios de inclusão baseiam-se na definição-padrão da doença, com pequenas alterações, quando necessário, para que se adaptem à prática de clínica geral.

  Exemplos: apendicite, infarto agudo do miocárdio.

- *patofisiológica*: o diagnóstico revela um substrato patofisiológico; os critérios de inclusão incluem sinais, sintomas e outros indícios objetivos e característicos.

  Exemplos: presbiacusia, hipertensão.

- *nosológica*: o diagnóstico baseia-se num conjunto de sintomas consensual entre os profissionais da saúde, não existe uma etiologia ou uma base patológica ou patofisiológica, e é muitas vezes chamada síndrome; os critérios de inclusão incluem apenas sintomas e queixas.

  Exemplos: depressão, síndrome do cólon irritável.

- *sintoma*: um sinal ou sintoma é o melhor rótulo para o episódio. Exemplo: fadiga, dor ocular.

OS CRITÉRIOS

O princípio subjacente utilizado foi apresentar *os critérios de inclusão da forma mais concisa possível a fim de minimizar as diferenças de codificação*. Esse princípio levou ao uso de um mínimo de critérios de inclusão para cada rubrica, o que exige uma explicação mais detalhada.

Para a maioria das rubricas, o leitor encontrará um ou mais critérios, os quais devem ser satisfeitos para se codificar um problema sob esse título. Por vezes, há uma alternativa de critérios; em outros casos, é necessário satisfazer os de uma lista. Quando usamos "ou" em uma lista, emprega-se em seu sentido inclusivo, ou seja, significando "e/ou". Por "múltiplo" entende-se três ou mais.

Esforçamo-nos para chegar a um conjunto mínimo de normas necessárias a fim de reduzir a complexidade da codificação e, assim, minimizar os riscos de uma codificação errada.

Além disso, incluímos apenas aqueles critérios que são suficientemente discriminatórios para permitir distinguir uma rubrica de outra com a qual poderia ser confundida. Em alguns casos, os critérios disponíveis podem ser poucos para excluir todos os estados possíveis que poderiam ser codificados erradamente sob determinada rubrica, mas excluirão os mais comuns.

Sempre que possível, as normas de classificação basearam-se em critérios clínicos, em detrimento de resultados de exames complementares ou outras investigações. Tanto quanto possível, são independentes da tecnologia, que não é a mesma em todas as partes do mundo e muda diariamente. Assim, os critérios utilizados são adequados à atenção primária em todo o mundo.

Esta abordagem é muito diferente daquela vista nos livros clássicos, voltados para as doenças, que, normalmente, apresentam uma lista exaustiva de sinais e sintomas, ou todos os critérios potenciais associados a determinado diagnóstico. Acreditamos que, a fim de maximizar a utilidade da codificação de problemas baseada em critérios, na clínica geral e atenção primária a brevidade deve prevalecer sobre a exaustividade.

Por vezes, o título da rubrica é suficientemente específico em si mesmo. Nesses casos, não são apresentados quaisquer critérios de inclusão. Para evitar erros, cada rubrica, assim como os seus critérios de inclusão e exclusão, deve ser lida em sua totalidade.

Não fizemos questão de fornecer critérios para todas as rubricas, sobretudo as residuais, que contêm demasiados diagnósticos díspares para terem alguma utilidade. Nesses casos, o leitor deverá consultar a lista de diagnósticos incluída no título da rubrica e os termos de inclusão, ou buscar a lista mais completa apresentada para as rubricas relevantes no CID-10.

REFERÊNCIAS CRUZADAS

Além dos critérios de inclusão, cada rubrica pode incluir a seguinte informação:

- *inclui*: uma lista de sinônimos e de descrições alternativas incluídas na rubrica;
- *exclui*: uma lista de condições semelhantes que deverão ser codificadas sob outra rubrica, com o respectivo código;
- *considerar*: uma lista de rubricas com os respectivos códigos, geralmente menos específicos, que poderão ser consideradas, se a condição do paciente não satisfizer os critérios de inclusão.

VANTAGENS DESTA ABORDAGEM

Esta abordagem permite o uso de critérios de inclusão claros e consensualmente aceitos para problemas comuns na prática da atenção primária à saúde, que exigem critérios de inclusão para serem codificados de forma coerente.

Outra grande vantagem é que o uso mínimo de critérios de inclusão torna os procedimentos de codificação fáceis de aprender e de utilizar na prática cotidiana. É reduzido, assim, o problema da variação entre codificadores.

USO DOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Os critérios de inclusão NÃO DEVEM ser utilizados ao registrar o motivo do paciente para a consulta, na medida em que estes devem ser codificados com base no que o paciente diz, independentemente de isso ser "correto" ou não.

Os critérios de inclusão DEVEM ser utilizados ao registrar o diagnóstico ou o problema a ser tratado pelo profissional de saúde. Quando a questão tem de ser codificada apenas como sinal/sintoma, pode ser necessária certa orientação para escolher o código mais adequado. Por exemplo, sensação de desmaio (N17) não é codificada sob a mesma rubrica que o desmaio propriamente dito (A06); dores abdominais podem ser generalizadas (D01), epigástricas (D02) ou localizadas em outras áreas (D06). As opções devem estar claras para os usuários empregarem a mais adequada.

APLICAR OS CRITÉRIOS EM FASES DIFERENTES DO PROBLEMA

Os critérios de inclusão destinam-se, em primeiro lugar, a codificar a primeira apresentação de um problema. Se for codificado em uma consulta posterior (após ter sido modificado pelo tempo e pela terapia) a informação anterior deverá ser considerada (por exemplo, a pressão arterial de um paciente com hipertensão pode ser normal numa consulta em que já se verifique o efeito da medicação, mas o estado será sempre codificado como hipertensão).

DESVANTAGENS DO SISTEMA

Naturalmente, esse sistema de critérios de inclusão não é isento de erros. Para assegurar o máximo de precisão e de confiabilidade nas estatísticas na prática da medicina de família e comunidade ou da atenção primária à saúde, tivemos que estabelecer limites bastante rígidos para os conceitos diagnósticos, muitos dos quais têm, na realidade, fronteiras pouco distintas. Embora, para efeito de terapia ou de tratamento, não sejam necessárias fronteiras rígidas, há uma necessidade de dados precisos para fins de pesquisa. Por outro lado, o uso de critérios de inclusão demasiado delimitados pode aumentar o uso de rubricas residuais, menos específicas, mas, no nosso entender, isso é

preferível a transformar na prática a maioria das rubricas em não-específicas. Para codificar problemas que não satisfazem cabalmente os critérios apresentados, sugerimos rubricas alternativas, menos específicas, destacadas por meio do comentário "considerar". Essas sugestões vêm se juntar aos itens listados como "exclusão" em uma rubrica.

POSSÍVEIS CONFUSÕES

É importante que o leitor esteja perfeitamente ciente de um certo número de pontos que os critérios NÃO pretendem cobrir.

Os critérios NÃO servem de guia para o diagnóstico. O objetivo prioritário da classificação é reduzir as possibilidades de uma má codificação depois do diagnóstico, e não eliminar a possibilidade de erro no diagnóstico em si. Se o profissional de saúde já levou em consideração os diagnósticos diferenciais possíveis antes da codificação, na maioria dos casos, uma boa prática clínica e um diagnóstico correto exigem muito mais informação do que aquela que é dada nos critérios de inclusão.

Os critérios não estabelecem nenhum padrão de tratamento. Embora a informação retirada do uso da classificação possa mudar os conceitos médicos e, assim, ter alguma influência nos cuidados, estes critérios de inclusão foram definidos apenas para melhorar a qualidade do registro de dados.

Os critérios não são um guia para a terapia. Os critérios de inclusão ou exclusão para determinada condição não têm necessariamente a ver com aqueles que são aplicados para o uso de determinada terapia. Por exemplo, o clínico pode entender que uma terapia para a enxaqueca está indicada para um paciente que não satisfez totalmente os critérios desse título de diagnóstico, e cuja condição ele codifica como "dor de cabeça".

FONTES

A Comissão não teve receio de inventar novas definições e basear critérios de inclusão em outros já existentes, alcançando, assim, os objetivos acima indicados. De fato, poucas definições satisfaziam nossas exigências porque, em geral, foram desenvolvidas para projetos de pesquisa e não para efeitos de prática clínica; logo, tendiam a ser demasiado incômodas. No entanto, nossos critérios de inclusão são compatíveis com a maioria das definições-padrão das doenças.

Se o trabalho de outros foi usado inadvertidamente sem o seu conhecimento, ficam as nossas sinceras desculpas, mas a imitação é a mais genuína forma de admiração.

7

CODIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO PROBLEMA

DESENVOLVIMENTO DE UM CÓDIGO DE GRAVIDADE DO PROBLEMA

Desde 1993, o Comitê de Classificação da WONCA tem desenvolvido a Escala de Duke de Gravidade do Problema (DUSOI), a ser utilizada internacionalmente. O Estudo de Campo da Gravidade do Problema da WONCA (WONCA-SIFT) foi conduzido visando testar a escala em 16 países[27]. A comissão reconheceu que é necessário estabelecer um método que ajude os profissionais de saúde a codificar não só o nome de cada problema de saúde, como também o respectivo grau de gravidade. O método é aplicável a problemas, quer por episódio de cuidados, quer por consulta (Figura 2.1).

Dentre todos os sistemas de classificação internacionais, a CIAP é a única que permite classificar os problemas de saúde de acordo com o grau de gravidade em cada paciente e com o problema de saúde. O sistema de codificação da gravidade do problema, Escala de Duke de Gravidade do Problema (DUSOI/WONCA), constitui uma extensão que permite ao médico ou profissional de saúde não só classificar o problema e atribuir-lhe um código, mas também atribuir um código de gravidade padronizado, avaliando os pacientes com o mesmo problema de acordo com o grau de maior ou menor gravidade. Visto que os parâmetros e os critérios da escala são gerais e não-específicos de determinado problema de saúde, poderão ser aplicados a quaisquer problemas de saúde, permitindo, assim, estabelecer uma comparação do grau de gravidade entre diferentes problemas de saúde com base em termos de avaliação iguais. A escala, testada em campo por WONCA-SIFT, está pronta para ser utilizada por profissionais de saúde em um contexto clínico[27].

CODIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO PROBLEMA

A escala de codificação da gravidade do problema de DUSOI/WONCA permite à CIAP classificar as questões de saúde em termos de gravidade. O

profissional identifica cada problema no encontro com o paciente e tenta avaliar a gravidade de cada um deles para o paciente em determinado momento, a qual é avaliada de acordo com os seguintes parâmetros gerais:

- sintomas durante a semana precedente;
- complicações durante a semana precedente;
- prognóstico para os seis meses seguintes, caso o problema de saúde não tenha sido tratado;
- "tratabilidade" ou a necessidade de tratamento, e a resposta esperada deste para o paciente.

A Figura 7.1 oferece o exemplo de um prontuário preenchido, em que o profissional de saúde, João da Silva, enumera os problemas identificados durante a consulta da paciente, Maria Joana, em 5 de outubro de 1995. Como exemplo, a gota é referida em todas os prontuários; não é o caso dessa paciente. Se ela tivesse gota, o profissional de saúde teria mencionado gota novamente, e classificado o grau de gravidade de acordo com os seus efeitos sobre a paciente. Na verdade, durante a consulta, a paciente foi diagnosticada com isquemia cardíaca sem angina, diabetes mellitus e bronquite aguda.

ÍNDICES BRUTOS

Os índices brutos possíveis de atingir em cada um dos quatro parâmetros de gravidade vêm indicados no quadro maior, na base do impresso DUSOI/WONCA. No exemplo do caso de doença cardíaca isquêmica sem angina (K76), Figura 4, o grau de gravidade foi pontuado como "2", numa escala de 0 a 4, porque considerou-se que a paciente tinha "sintomas leves" naquele momento. A gravidade, em termos de complicações, foi classificada com "0", por não serem clinicamente evidentes problemas da doença cardíaca isquêmica. Para a pontuação DUSOI/WONCA, define-se complicação como "um problema de saúde, secundário a outro, e que não foi considerado e classificado como um problema separado". Se uma complicação é registrada sob a forma de problema de saúde separado, seus efeitos separadamente não deverão ser incluídos na avaliação de gravidade do problema de origem. Isso evita atribuir uma dupla ponderação à complicação no momento de classificá-la. O prognóstico para a doença cardíaca isquêmica, com angina, (Figura 4) foi pontuada com "4" porque o prestador fez um juízo clínico de que aquela paciente poderia morrer nos 6 meses seguintes à consulta, se não iniciasse tratamento e deixasse que a doença evoluísse como numa paciente não tratada. Se o Dr. Silva tivesse previsto que Maria Joana não morreria sem tratamento, mas em vez disso, teria uma grave incapacidade, então a pontuação de "3" seria a mais adequada. A incapacidade é definida como "qualquer limitação

da capacidade funcional de uma pessoa para o seu dia a dia". Incapacidade grave (índice bruto de "3") é definida como uma "grande restrição da atividade habitual e necessidade de grandes cuidados de terceiros". Incapacidade leve (índice bruto de "1") é definida como "pequena restrição das atividades habituais", e incapacidade moderada (índice bruto de "2") como "uma grande restrição da atividade habitual, mas necessitando poucos cuidados de terceiros". "Tratabilidade" foi pontuada, no exemplo, com "2", porque o prestador decidiu que aquela paciente necessitava de tratamento e seria esperada uma boa resposta.

CODIFICAÇÃO DA GRAVIDADE

A soma dos pontos atribuídos a cada problema de saúde convertida num código de gravidade, com a ajuda do quadro de conversão no fim do impresso, permite determinar o código de gravidade DUSOI/WONCA. No exemplo de doença cardíaca isquêmica, sem angina, na Figura 4, o índice total bruto é 8 (2+0+4+2), e o código de gravidade é 2 (a tabela de conversão revela que os índices brutos de 5 a 8 correspondem a código de gravidade de 2). O código de gravidade 2 indica instantaneamente ao prestador que a doença cardíaca isquêmica nessa paciente, e neste encontro em particular, é de gravidade "intermediária", em uma escala de 0 a 4 (entre "nenhuma" e "máxima" gravidade).

Pode-se juntar ao código do problema de saúde o de gravidade como uma extensão, usando ":" como convenção que distingue a extensão da gravidade de outras extensões possíveis. Assim, o código de doença cardíaca isquêmica, sem angina, na Figura 4 é K76.2.

RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO DA ESCALA DE GRAVIDADE DO PROBLEMA

O estudo internacional foi conduzido ao longo de um período de dois anos (1993-1995), visando testar a confiabilidade, viabilidade e potencial utilidade clínica da escala DUSOI/WONCA. Inicialmente, participaram 47 clínicos gerais e médicos de família de 16 países; destes, 22 médicos de nove países (Bélgica, Alemanha, Hong Kong, Israel, Japão, Países Baixos, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos) completaram a coleta de dados[27].

Os 22 médicos aplicaram os testes DUSOI/WONCA em 1.191 pacientes (59,6% mulheres). A média de idade do grupo-alvo era de 59,2 anos, e somavam um total de 2.488 problemas de saúde. A confiabilidade da escala de DUSOI/WONCA foi estimada com base na avaliação de uma série uniforme de problemas de saúde. O coeficiente de correlação múltipla28 referente à

confiabilidade entre classificadores foi igual a 0,45, e a correspondente confiabilidade entre classificadores variou entre 0,39 relativo a problema social resultante da doença do parceiro (CIAP código Z14), 0,78 por obesidade (CIAP código T82) e 0,68 por ansiedade (CIAP código P74). A viabilidade de uso em prática foi boa, tal como o revela a média de 1,9 minutos necessários para avaliar o índice DUSOI/WONCA de cada paciente (entre 1 e 10 minutos). Os médicos não tiveram qualquer dificuldade em utilizar a escala em 71,1% dos pacientes. Em 14,7% dos casos, consideraram a escala muito útil, em 53,6% de utilidade média, e em 31,7% dos casos sem qualquer utilidade. A utilidade foi tanto mais elevada quanto maior fosse o grau de gravidade do problema.

A pontuação média de gravidade DUSOI/WONCA dos 2.488 problemas de saúde foi de 39,1 (escala=0-100 de mínimo para mais elevado), e os problemas foram distribuídos entre os cinco códigos de gravidade do seguinte modo: Código 0 (sem gravidade) = 1,6%; Código 1 (gravidade leve) = 29,9%, Código 2 (gravidade intermediária) = 45,9%; Código 3 (gravidade moderada) = 19,3%; e Código 4 (gravidade máxima) = 3,3%. Foram registradas variações acentuadas de gravidade entre diferentes diagnósticos e dentro de cada diagnóstico.

Por exemplo, a média de gravidade de problemas respiratórios variava entre 26,4 nos casos de infecção respiratória superior (IVAS, CIAP código R74), e 53,2 nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC, CIAP código R95). Em relação aos de IVAS, a frequência dos códigos de gravidade variavam entre 61,1% no Código 1 e 0% no Código 4, em comparação a DPOC, que variava entre 8,4% do Código 1 e 10,6% do Código 4.

No fim dos estudos de campo e quando questionados acerca da probabilidade de utilização futura da escala DUNSOI/WONCA, 41,2% dos 22 participantes afirmaram ter a intenção de utilizarem deste instrumento nos cuidados prestados aos pacientes; 71,2% tencionavam utilizá-lo na pesquisa, 43,8% na formação e 52,9% na gestão de prática médica.

Concluiu-se que a escala DUSOI/WONCA é viável e potencialmente útil na prática da Clínica Geral/Medicina de Família e Comunidade/Atenção Primária à Saúde[27]. Contudo, os médicos não foram questionados quanto à utilidade para a classificação da gravidade do problema, embora os achados empíricos do estudo de campo indiquem que ela se adapta bem a este objetivo.

FIGURA 7.1
Escala de Duke de Gravidade do Problema/WONCA: DUSOI/WONCA*

LISTA DE DUKE DE GRAVIDADE DO PROBLEMA (DUKE SEVERITY OF ILNESS CHECKLIST – DUSOI)
Paciente: Maria João

Data de Nascimento:	**Sexo:**	**Prestador de Cuidados:**	**Data da Consulta:**
6 Nov, 1925	**Feminino (x) Masculino ( )**	**João da Silva**	**5 Out, 2005**

Problemas de Saúde (abordados durante a consulta)	**Índices Brutos (classificados de 0 a 4) ****				**Índice Total Bruto (0 a 16)**	**Código de Gravidade (0 a 4)*****	**Código CIAP**
	Sintomas	**Complicações**	**Prognóstico**	**Tratabilidade**			
Exemplo: Gota	3	1	3	2	9	3	T92.3
1. D. Cardíaca Isquêmica	2	0	4	2	8	2	K76.2
2. Diabetes Mellitus	0	0	2	2	4	1	T90.1
3. Bronquite aguda	3	0	2	2	7	2	R78.2
4. _____	_	_	_	_	_	_	____
5. _____	_	_	_	_	_	_	____
6. _____	_	_	_	_	_	_	____

Use páginas adicionais se tiver mais de seis problemas de saúde

****ÍNDICES BRUTOS**

	Nenhum	**Questionável**	**Leve**	**Moderado**	**Grave**
1. Sintomas (última semana)	0	1	2	3	4
2. Complicações (última semana)	0	1	2	3	4
	Incapacidade				
	Nenhum	Leve	Moderada	Grave	Risco de Vida
3. Prognóstico (próximos 6 meses sem tratamento)	0	1	2	3	4

	Necessidade de tratamento			**Resposta esperada**		
	Não	**Questionável**	**Se SIM =>**	**Boa**	**Questionável**	**Ruim**
4. Tratabilidade	0	1		2	3	4

*****CÓDIGOS DE GRAVIDADE**

Código de Total Bruto		**Gravidade**	**Gravidade**
0	=	0	Nenhuma
1-4	=	1	Leve
5-8	=	2	Intermediária
9-12	=	3	Moderada
13-16	=	4	Máxima

* *Departamento de Medicina de Família e Comunidade, Centro Médico da Universidade de Duke, Curham, NC, EUA*

8

MEDIÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL: OS QUADROS COOP/WONCA

Em 1987, o Comitê de Classificação da WONCA lançou-se na tarefa de desenvolver um método de classificar e registrar o estado funcional geral do paciente, independentemente do estado de gravidade de seus problemas de saúde[29]. Passados alguns anos, esse trabalho, mais tarde conduzido em cooperação com a Comissão de Investigação da WONCA, resultou na criação dos quadros de medição do estado funcional COOP/WONCA[30,31].

O estado funcional é a medida do bem-estar geral do indivíduo. Constitui um dos elementos do conjunto total de medidas do estado de saúde, que inclui ainda a avaliação do estado clínico e da qualidade de vida. O Glossário Internacional para Medicina de Família e Comunidade define estado funcional como "a capacidade de uma pessoa agir em determinado ambiente ou de ele se adaptar, medida tanto de modo objetivo como subjetivo, durante um determinado período de tempo"[19]. Implícito em qualquer definição de estado funcional está, para além da doença, a importância de outros fatores para a saúde dos pacientes. À medida em que aumenta a complexidade e cronicidade dos problemas de saúde, o profissional depende cada vez mais de indicadores de estado funcional e de saúde para monitorar as suas intervenções e medir os resultados.

O estado funcional refere-se ao paciente e não ao problema de saúde, à doença ou ao episódio de cuidados. Por isso, encontra-se menos diretamente relacionado aos códigos da CIAP do que à gravidade do problema. No entanto, dada a sua importância em medicina de família e comunidade e atenção primária à saúde, é imperativo que seja incluído neste livro.

Os clínicos gerais têm sabido reconhecer toda a importância de promover a saúde e medir o estado funcional nas consultas. Tais avaliações são particularmente importantes em se tratando de idosos ou pacientes crônicos. A soma dos valores do estado funcional aos motivos da consulta, diagnóstico e procedimentos terapêuticos constitui um passo lógico em direção ao processo de classificação em medicina de família e comunidade e atenção primária à saúde.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL

Um dos primeiros instrumentos de medição do estado funcional reconhecido pela WONCA como confiável foi o Quadro Dartmouth COOP[32] de medição do estado funcional de saúde. Esses quadros foram adaptados pelo Comitê de Classificação e postos em prática juntamente com a CIAP, e são conhecidos pelos quadros COOP/WONCA.

Embora especificamente desenvolvidos para a medicina de família e comunidade, os quadros não são os únicos instrumentos existentes para avaliar o estado funcional. Existe uma variedade de indicadores, muitos dos quais têm sido utilizados em contextos de clínica geral e atenção primária à saúde, como exemplo, a *Medical Outcomes Trust Short Form*[36] e derivados desse instrumento. Do mesmo modo, o Perfil de Saúde de Duke tem sido usado com êxito nos Estados Unidos[33]. Na Europa, vários têm sido os instrumentos utilizados. O Perfil do Impacto da Doença e o Perfil de Saúde de Nottingham constituem os instrumentos mais citados. Quando criados, alguns destes instrumentos (por exemplo, o Perfil do Impacto da Doença) destinavam-se à pesquisa e não para fins clínicos.[34]

Até a presente data, os quadros COOP/WONCA têm sido testados mais exaustivamente no contexto da medicina de família e comunidade. A sua validade facial e utilidade clínica em medicina geral é reconhecida internacionalmente. Os clínicos gerais sentem que trabalham facilmente com estes quadros durante as consultas, e que estes lhes são muito úteis como instrumentos de medição do estado global do paciente e dos resultados dos cuidados.

Qualquer medida de estado funcional requer que sejam explorados os aspectos cultural e contextual. Alguns estudos utilizando os quadros têm sugerido que lhes falta uniformidade intercultural. Enquanto instrumento de pesquisa, o teste-reteste de confiabilidade será sempre necessário, visto tratar-se de indicadores globais e influenciados por tantas variáveis. Muitos estudos têm se debruçado sobre esta questão. A uniformização das condições dos testes e a avaliação da confiabilidade entre classificadores poderão ajudar a melhorar os resultados de projetos de investigação.

OS QUADROS COOP/WONCA

Os quadros COOP/WONCA adquiriram a sua forma atual após sucessivos testes realizados no contexto da medicina de família e comunidade e atenção primária à saúde. Existem seis: condição física; sentimentos; atividades cotidianas; atividades sociais; alteração do estado de saúde; e estado de saúde geral. A Figura 8.1 constitui o exemplo de um Quadro de Atividades Cotidianas. Encontram-se atualmente em preparação novos quadros referentes à dor e ao sono.

Atividades Diárias
Durante as duas últimas semanas...
Que dificuldades teve ao fazer as suas atividades ou tarefas diárias, dentro ou fora de casa, devido à sua condição física ou emocional?

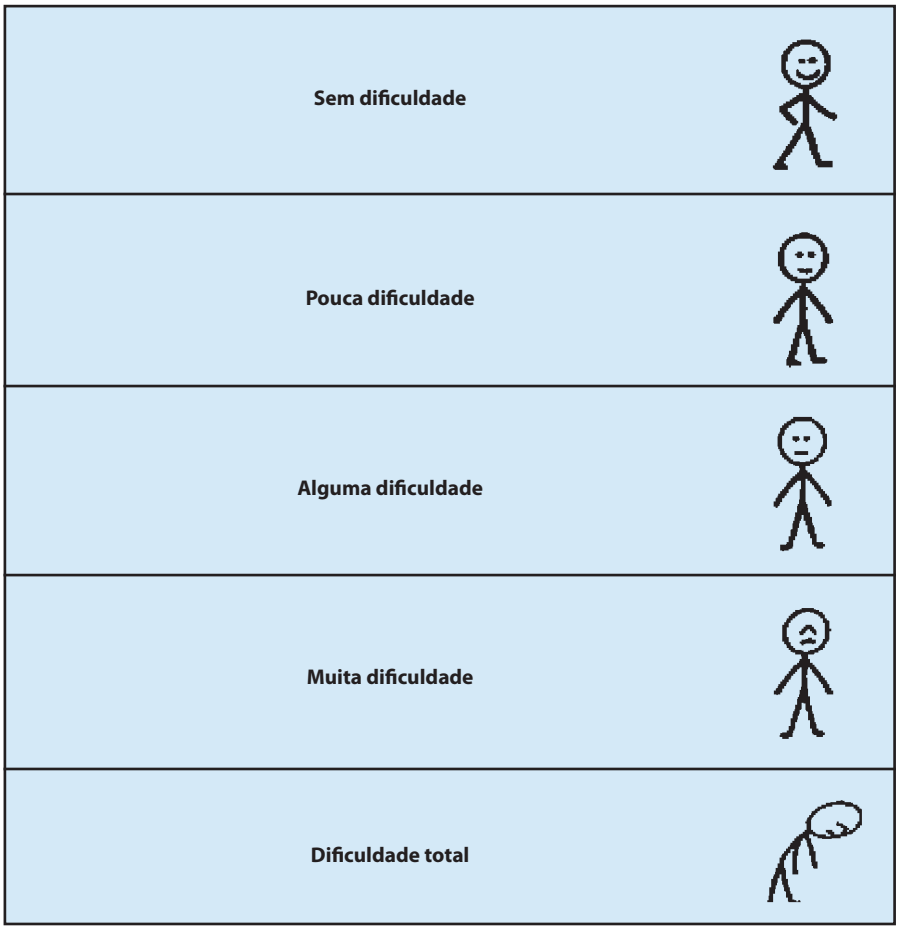


FIGURA 8.1
Quadros COOP/WONCA. Avaliação do Estado Funcional: atividades diárias

Cada quadro é constituído por uma frase introdutória e cinco respostas opcionais. Imagens representativas das cinco opções acompanham o texto. Os desenhos realçam a aplicabilidade dos quadros nos contextos da atenção primária à saúde entre uma população de pacientes com muita variedade nos níveis de escolaridade.

Os quadros encontram-se publicados nas seguintes línguas: chinês, dinamarquês, holandês, alemão, finlandês, francês, hebraico, italiano, japonês, coreano, norueguês, português, catalão, castelhano e galego, eslovaco, sueco e urdu[30].

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO DOS QUADROS

Os quadros podem ser utilizados individualmente ou em grupos. Quando mais de um quadro é usado, aconselha-se a seguinte ordem: condição física; sentimentos; atividades cotidianas; atividades sociais; alteração do estado de saúde; e estado de saúde geral. A autoadministração dos quadros constitui o método preferido. Contudo, há um estudo que revela a correlação entre autoavaliação e avaliação por parte do profissional de saúde. Um quadro leva, em média, menos de cinco minutos para ser preenchido.

Sempre que utilizados em um novo contexto cultural, convém verificar se os conceitos medidos são adequados e adaptados ao contexto. Uma tradução adequada constitui o primeiro passo. O "Manual das tabelas de medição do estado funcional de saúde COOP/WONCA"[30] apresenta informação adicional sobre o aperfeiçoamento e utilização dos quadros, a sua tradução e uma lista de contatos em caso de necessidade de assistência, incluindo os nomes dos responsáveis pelas várias traduções.

RELAÇÃO ENTRE A CIAP E OS QUADROS COOP/WONCA

Os quadros COOP/WONCA, juntamente com a CIAP, permitem explorar a relação entre funcionalidade e problemas de saúde. Por exemplo, a rubrica 28 do Componente 1 (sinais e sintomas) de cada capítulo da CIAP refere-se a incapacidades e funções limitadas. O conceito "estado funcional" poderia ser registrado nesse componente com um código de um dígito adicional. Contudo, tendo em conta que o estado funcional se refere ao paciente como um todo e não apenas ao problema de saúde, torna-se difícil estabelecer uma relação quando nos deparamos com mais de um problema ativo, pois a comorbidade dificulta a interpretação. Por exemplo, tanto um caso de hipertensão como de diabetes em um paciente podem influir sobre o seu estado funcional. No entanto, um registro de rotina não permite determinar a sua importância e efeitos. Mesmo tratando-se de um único problema, as medidas do estado funcional ultrapassam a avaliação do estado do problema, e assim poderá não ser fácil estabelecer uma relação imediata com determinado código da CIAP.

9

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ICHPPC-2 (International Classification of Health Problems in Primary Care). Oxford, Oxford University Press, 1979.
2. International Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revision). Geneva,World Health Organisation,1992.
3. International Classification of Health Problems in Primary Care (ICHPPC). Chicago, World Organization National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)/American Hospital Association (AHA), 1975.
4. ICHPPC-2 (International Classification of Health Problems in Primary Care). Oxford, Oxford University Press, 1979.
5. ICHPPC-2-Defined: International Classification of Health Problems in Primary Care, 3rd edition. Oxford, Oxford University Press, 1983.
6. Report of the International Conference on Primary Care, Alma Ata, USSR, 6-12, September 1978; WHO/Alma Ata/78.10.
7. Meads, S. The WHO Reason for Encounter classification. WHO Chronicle, 1983; 37 (5): 159-162.
8. Lamberts, H, Meads, S, and Wood, M. Classification of reasons why persons seek primary care: pilot study of a new system. Public Health Reports, 1984; 99: 597-605.
9. Lamberts, H, Meads, S, and Wood, M. Results of the international field trial with the Reason for Encounter Classification (RFEC). Med Sociale Preventive,1985; 30: 80-87.
10. Working Party to develop a classification of the 'Reasons for Contact with Primary Health Care Services'. Report to the World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1981.
11. Wood, M. Family medicine classification systems in evolution. J Fam Pract, 1981; 12: 199-200.
12. Lamberts, H, Meads, S, and Wood, M. Results of the field trial with the Reason for Encounter Classification (RFEC). In: Cote RA, Protti AJ, and Scherner JR eds. Role of Informatics in Health Data Coding and Classification Systems. Amsterdam, Elsevier Sci Publ/JFIP-JMIA, 1985.
13. Bentsen BG. International Classification of Primary Care. Scandinavian J Primary Hlth Care 1986;4:43-56
14. Lamberts, H, Wood, M, Hofmans-Okkes, I, eds. The International Classification of Primary Care in the European Community: with Multi-Language Layer. Oxford, Oxford University Press, 1993.

15. Lamberts H, Wood M eds. ICPC: International Classification of Primary Care. Oxford, Oxford University Press, 1987
16. Bridges-Webb, C, Britt, H, Miles, D A, Neary, S, Charles, J, Traynor, V. Morbidity and treatment in general practice in Australia 1990-1991. Med J Aust 1992; 157, Supp.19 Oct: S1-S56.
17. Hofmans-Okkes IM, Lamberts H. The International Classification of Primary Care (ICPC): new applications in research and computer based patient records in family practice. Family Practice 1996; 13: 294-302
18. Wood M, Lamberts H, Meijer JS, Hofmans-Okkes I.M. The conversion between ICPC and CID-10: requirements for a family of classification systems in the next decade. in Lamberts H, Wood M, Hofman-Okkes I, eds. The International Classification of Primary Care in the European Community: with Multi-Language Layer. Oxford, Oxford University Press, 1993:18-24.
19. Bentzen N, ed. An international glossary for general/family practice. Fam Pract 1995; 12: 341-369.
20. Jamoulle M, Roland M. Classification Internationale des Soins Primaires (traduction francaise de l' ICPC). Edition Alexandre Lacassagne, Lyon, 1992.
21. Jamoulle M, Roland M. Approches taxonomiques en medicine de famille, assorties d'une terminologie medicale normalisee et classifiee a usage informatique en soins de sante primaires. CARE Editions, Bruxelles, 2 vol., 1996.
22. Donaldson MS, Yordy KD, Lohr KN, Vanselow NA eds. Primary care: America's health in a new era. Washington DC, National Academy Press, 1996.
23. Hofmans-Okkes IM. An international study into the concept and validity of the 'reason for encounter'. In Lamberts H, Wood M, Hofmans-Okkes IM eds. The International Classification of Primary Care in the European Community. Oxford: Oxford University Press, 1993: 34-44.
24. Nylenna, M. Why do our patients see us? A study of reasons for encounter in general practice. Scand J Prim Health Care, 1985; 3: 155-162.
25. International Classification of Process in Primary Care (IC-Process-PC), Oxford, Oxford University Press, 1986.
26. Parkerson GR Jr, Broadhead WE, Tse C-KJ. The Duke Severity of Ilness Checklist (DUSOI) for measurement of severity and comorbidity. J Clin Epidemiol 1993; 46: 379-393.
27. Parkerson GR Jr, Bridges-Webb C, Gervas J, Hofmans-Okkes I, Lamberts H, Froom J, Fischer G, Meyboom-de Jong B, Klinkman M, & Maeseneer J. Classification of severity of health problems in family/general practice: an international field trial. Fam Pract 1996;13:303-309
28. Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. Psychol Bull, 1979; 86: 420-428.
29. WONCA Classification Committee. Functional status in primary care. New York, Springer, 1990.
30. Scholten JHG, van Weel C. Functional Status Assessment in Family Practice. MEDITekst CIPGegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 1992.
31. van Weel C, Konig-Zahn C, Touw-Otten FWMM, van Duijn NP, Meyboom-de Jong B. Measuring functional health status with the COOP/WONCA Charts: a manual. CIP-Gegevens Koninklijke Bibiliotheek, Den Haag 1995.

32. Nelson EC, Wasson J, Kirk J, et al. Assessment of function in routine clinical practice. Description of the COOP Chart method and preliminary findings. J Chron Dis 1987;40(suppl 1): 55s-64s.

33. Parkerson GR Jr, Broadhead WE, Tse C-KJ. The Duke Health Profile, a 17-item measure of health and dysfunction. Med Care 1990;28:1056-1072.

34. Bergner M, Bobbitt RA, Carter WB, et al. The Sickness Impact Profile. Conceptual formulation and methodology for the development of a health status measure. Int J Health Serv 1976:6:393.

35. Hutchinson A, Bentzen N, Konig-Zahn C (eds.) Cross cultural health outcome assessment: a user,s guide. European Research Group on Health Outcomes (ERGHO), 1997; 1-184.

36. Bentsen B, Natvig B, Winnem M. Assement of own functional capacity. COOP-WONCA charts in clinical work and research (in Norwegian, English summary). Tiddsk. Nor. Laegeforen. 117:1790-93

10

LISTA TABULAR

A lista tabular inclui especificações de todas as rubricas da CIAP. Os componentes de procedimentos (2-6) são iguais em todos os capítulos e estão em primeiro lugar, seguidos dos componentes 1 e 7 com rubricas específicas para cada capítulo.

COMPONENTES DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS DA CIAP: COMPONENTES 2-6

O traço (-) que surge em primeiro lugar deverá ser substituído pelo código alfa de cada capítulo.

Componente 2 – Procedimentos de diagnóstico e prevenção

-30 Exame médico/avaliação de saúde / completo
-31 Exame médico/avaliação de saúde / parcial
-32 Teste de sensibilidade
-33 Teste microbiológico/imunológico
-34 Análise de sangue
-35 Análise de urina
-36 Análise de fezes
-37 Citologia esfoliativa / histologia
-38 Outras análises laboratoriais NE
-39 Teste de função física
-40 Endoscopia diagnóstica
-41 Radiologia/imagiologia diagnóstica
-42 Traçados elétricos
-43 Outros procedimentos diagnósticos
-44 Vacinação/medicação preventiva
-45 Educação em saúde/aconselhamento/dieta
-46 Consulta com profissional de Atenção Primária à Saúde (APS)
-47 Consulta com especialista
-48 Esclarecimento/discussão dos motivos da consulta
-49 Outros procedimentos preventivos

Componente 3 – Medicação, tratamento, procedimentos terapêuticos

-50 Medicação/prescrição/pedido/renovação/injeção
-51 Incisão/drenagem/limpeza/aspiração/remoção de líquidos corporais (excl. cateterização -53)
-52 Excisão/exerese/biópsia/destruição/debridamento/cauterização
-53 Cateterização/intubação/dilatação
-54 Reparação/fixação-sutura/gesso/prótese (aplicação/remoção)
-55 Injeção local/infiltração
-56 Curativo/bandagem/compressão/tamponamento
-57 Medicina física/reabilitação
-58 Aconselhamento terapêutico/escuta terapêutica
-59 Outros processos terapêuticos/pequena cirurgia, NE

Componente 4 – Resultados

-60 Resultados de análises/procedimentos
-61 Contrarreferência de outro prestador – resultado de exames/teste/análise/registros/carta/procedimentos

Componente 5 – Administrativo

-62 Procedimento administrativo

Componente 6 – Encaminhamentos e outros motivos da consulta

-63 Consulta de acompanhamento não-especificada
-64 Consulta/problema iniciado pelo profissional de saúde
-65 Consulta/problema iniciado por outra pessoa que não o paciente/profissional
-66 Referenciado para outro profissional de saúde/enfermeiro/ terapeuta/assistente social (excl. médico)
-67 Referenciado para médico/especialista/clínica/hospital
-68 Outras referenciações NE
-69 Outro motivo da consulta NE

DISPOSIÇÃO DAS RUBRICAS NOS COMPONENTES 1 E 7

As rubricas estão dispostas pela seguinte ordem:

Código **Título**
Código(s) da CID-10
incl: termos incluídos
excl: termos excluídos, com os respectivos códigos da CIAP
critérios: definições da rubrica
considerar: rubricas a serem consideradas caso os critérios não sejam satisfeitos

Exemplo

A73 **MALÁRIA**
de B50 a B54
incl: complicações da malária
excl: profilaxia da malária A44
critérios: febre intermitente com calafrios em uma pessoa que habita ou que tenha visitado recentemente uma região de malária; sinais de formas do parasita da malária no sangue periférico
considerar: febre A03

Resumo das principais alterações aos componentes 1 e 7 da CIAP-1 para a CIAP-2

São referidas apenas as principais alterações: acréscimos, alteração do significado da rubrica, transferência ou supressão de uma rubrica. Muitas outras pequenas alterações nos títulos das rubricas não influenciam o seu significado nem foram incluídas nesta lista.

Código	TÍTULO CIAP-1 *(algumas abreviações)*	TÍTULO CIAP-2
A05	Deterioração geral	Sentir-se doente
A11	(omitido por engano da CIAP)	Dores torácicas NE
A12	Alergia/reação alérgica	(transferido para A92)
A13	Preocupação com a reação tratamento ao medicamento	Preocupação/receio do
A14	Cólicas infantis	(suprimido, incluído em D01)
A15	Choro infantil excessivo	(suprimido, incluído em A16)
A17	Criança com outros sint. gerais	(suprimido, incluído em A16)
A18	(rubrica nova em CIAP-2)	Preocupação com a aparência
A21	(rubrica nova em CIAP-2)	Risco de malignidade
A23	(rubrica nova em CIAP-2)	Fator de risco NE
A92	Toxoplasmose (suprimido, incluído em A78)	Alergia/reações alérgicas ne (transferido de A12)
A98	(nova rubrica em CIAP-2)	Manutenção da saúde/prevenção
B03	Outros sint. gânglios linfáticos	(suprimido, incluído em B02)
B85	Exame de sangue anormal inexplicável	(suprimido, incluído em A91)
B86	Outras alterações hematológicas	(suprimido, incluído em B99)
D07	(rubrica nova em CIAP-2)	Dispepsia/indigestão

Código	TÍTULO CIAP-1 *(algumas abreviações)*	TÍTULO CIAP-2
D22	Vermes/oxiúros/ /outros parasitas	(transferido para D96)
D23	(transferido de D96)	Hepatomegalia
D96	Hepatomegalia	(transferido para D23)
D96	(rubrica alterada na CIAP-2)	Lombrigas/outros parasitas
K22	(rubrica nova na CIAP-2) cardiovascular	Fator de risco de doença
K74	Angina de peito com angina	Doença cardíaca isquêmica
K76	Doença isquêmica crônica e outros	Doença cardíaca isquêmica sem angina
K80	Batimentos ectópicos, todos os tipos	Arritmia cardíaca NE
K81	Sopro cardíaco NE	Sopro cardíaco/arterial NE
K91	Aterosclerose (excl. coração/cérebro)	(incluído em K92 na CIAP-2)
K91	(rubrica alterada na CIAP-2)	Doença cerebrovascular
K92	Outra obstrução arterial Arteriosclerose	Doença vascular periférica
L05	Sinais/sintomas flanco	Sinais/sintomas flanco/axilares
L06	Sinais/sintomas axilares	(suprimido, incluído em L05)
L71	Neoplasias	Neoplasias malignas
L83	Síndromes da coluna cervical	Síndrome do pescoço
L84	Osteoartrose da coluna irradiação	Síndrome da coluna sem
L86	Lesão discal lombar/ dores de coluna	Lesão do disco/dores de coluna com irradiação
L87	Cisto sinovial Articular/tendão	Bursite/tendinite/sinovite NE
L97	Afecção interna Crônica joelho (incluído em L99 na CIAP-2)	Neoplasia benigna/incerta (retirado de L71 na CIAP-2)
N02	Cefaleia de tensão	(transferido para N95)
N08	(rubrica nova na CIAP-2) (retirado de N06)	Movimentos anormais involuntários
N80	Outra lesão da cabeça sem fratura do crânio	Outros ferimentos na cabeça
N95	(rubrica nova na CIAP-2) (transferido de N02)	Cefaleia de tensão
P21	Criança hiperativa, hipercinética	(transferido para P81)
P75	Alterações histéricas/ hipocondríacas	Perturbação somática
P81	(rubrica nova na CIAP-2) (transferido de P21)	Perturbação hipercinética

Código	TÍTULO CIAP-1 *(algumas abreviações)*	TÍTULO CIAP-2
P82	(rubrica nova na CIAP-2) pós-traumático (retirado de P02)	Distúrbio de estresse
P86	(rubrica nova na CIAP-2) (transferido de T06)	Anorexia nervosa, bulimia
R22	Sinais/sintomas das amígdalas	(suprimido, incluído em R21)
R70	Tuberculose	(suprimido, incluído em A70)
R72	Inf estreptocócica orofaringe/escarlatina	Inf estreptocócica orofaringe (escarlatina incluída em A78)
R79	(rubrica nova na CIAP-2) (transferida de R91)	Bronquite crônica
R80	Gripe sem pneumonia	Gripe
R82	Pleurisia (inclui derrame pleural de R93)	Pleurisia/derrame pleural
R91	Bronquite crônica	(transferido para R79)
R92	(nova rubrica na CIAP-2) de natureza incerta	Neoplasia respiratória
R93	Derrame pleural	(suprimido e incluído em R82)
S11	Outra infecção da pele pós-traumática	Ferida infectada, localizada
S79	Outras neoplasias benignas da pele	Neoplasia benigna da pele/incerta
S80	Outras neoplasias da pele NE	Ceratose solar/ queimadura solar
T06	Anorexia nervosa com/sem bulimia	(transferido para P82)
T15	Cisto/massa da tireoide	(suprimido, incluído em T81)
T88	Glicosúria renal	(suprimido, incluído em T99)
T89	(nova rubrica na CIAP-2)	Diabetes insulinodependente
T90	*Diabetes mellitus* dependente	Diabetes não-insulino
U08	(rubrica nova na CIAP-2)	Retenção urinária
W20	Outros sinais/sintomas da mama na gravidez	(suprimido, incluído em W19)
W21	(rubrica nova na CIAP-2) do corpo durante a gravidez	Preocupação com a aparência
W77	Outras condições não-obstétricas	(suprimido)
W85	(rubrica nova na CIAP-2)	Diabetes gestacional
X22	(rubrica nova na CIAP-2) da mama	Preocupação com a aparência
X92	(rubrica nova na CIAP-2)	Infecção genital por clamídia

A – GERAL E NÃO-ESPECÍFICO

Componente 1 – Sinais e sintomas

Nota: Nesta classificação, os termos "geral" ou "múltiplo" referem-se a três ou mais locais ou sistemas corporais. As condições que afetam um ou dois locais deverão ser registradas nas seções indicadas.

A01 DOR GENERALIZADA/MÚLTIPLA ***R52***

incl: dor crônica generalizada, dores múltiplas
excl: dor não-específica A29

A02 ARREPIOS ***R50,R68.8***

incl: calafrios, tremores
excl: febre A03

A03 FEBRE ***R50***

incl: pirexia
excl: febre com exantemas A76, exaustão pelo calor ou golpe de calor A88

A04 DEBILIDADE/CANSAÇO GERAL ***G93.3,R53***

incl: síndrome de fadiga crônica, exaustão, fadiga, lassidão, letargia, fadiga pós-viral
excl: sentir-se paciente, má disposição A05; modorra A29; exaustão pelo calor A88; cansaço por desfasamento de horário (*jetlag*) A88; sonolência P06

A05 SENTIR-SE DOENTE ***R53***

incl: mal-estar
excl: senescência, senilidade P05, caquexia T08, malnutrição T91

A06 DESMAIO/SÍNCOPE ***R55***

incl: perda momentânea da consciência, colapso, crise vasovagal
excl: coma A07; sentir-se tonto/tonturas N17

A07 COMA ***R40***

incl: letargia
excl: síncope A06

A08 INCHAÇO ***R68.8***

incl: alto, massa NE
excl: gânglio linfático B02, edema KO7, articulação L20, mama X19

A09 PROBLEMAS DE SUDORESE ***R61***

incl: hiperidrose, suores noturnos, problemas de transpiração
excl: doença das glândulas sudoríparas S92

A10 SANGRAMENTO, HEMORRAGIA NE ***R58***

A11 DORES TORÁCICAS NE ***R07.3, R07.4***

excl: dor atribuída a causas cardíacas K01, à parede torácica L04, ao sistema respiratório R01

(A12) transferido para A92

A13 RECEIO OU MEDO DO TRATAMENTO ***Z71.1***

incl: receio das consequências da medicação ou de qualquer tipo de tratamento
excl: efeitos adversos da medicação A85, complicações do tratamento médico ou cirúrgico A87

(A14) transferido para D01

(A15) suprimido, incluído em A16

A16 CRIANÇA IRRITAVÉL ***R68.1***

incl: choro excessivo, bebê agitado
excl: cólicas infantis D01; criança ou adulto agitado/irritável P04

(A17) suprimido, incluído em A16

A18 PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA ***R46.8***

incl: preocupação com a aparência física
excl: preocupação com o aspecto das orelhas H15, com a aparência relacionada com a gravidez W21, mama X22

A20 PEDIDO/DISCUSSÃO DA EUTANÁSIA ***Z71.8***

A21 FATOR DE RISCO DE MALIGNIDADE ***Z80,Z85***

incl: história pessoal ou familiar, tratamento anterior ou outros fatores de risco de malignidade

A23 FATOR DE RISCO NE ***Z20, Z23 a Z29, Z72.0 a Z72.5, Z73.2, Z81, Z82.0 a Z82.2, Z82.5 a Z82.8, Z83, Z84, Z86.0 a Z86.6, Z87, Z88, Z91, Z92***

incl: contato com doença infecciosa, história pessoal ou familiar, episódio anterior ou outros fatores de risco de outras doenças
excl: fator de risco de malignidade A21, de doença cardiovascular K22

A25 MEDO DE MORRER/DA MORTE ***Z71.1***

A26 MEDO DE CÂNCER NE ***Z71.1***

excl: se o paciente tem câncer, codifique a doença
critérios: receio de um paciente em ser portador de câncer sem, de fato, o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

A27 MEDO DE OUTRA DOENÇA NE ***Z71.1***

excl: se o paciente tiver a doença, codifique-a
critérios: receio de um paciente ser portador de outra doença sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

A28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE NE ***Z73.6, Z74, Z93.8, Z93.9, Z99.0, Z99.3, Z99.8, Z99.9***

incl: restrição de uma função ou incapacidade que não está relacionada com nenhuma doença inserida em qualquer outro capítulo
excl: quedas A29
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

A29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS GERAIS ***R68.0,R68.8***

incl: inépcia, sonolência, quedas, dor não-especificada

Componente 7 – Diagnóstico/doença

A70 TUBERCULOSE ***A15 a A19, B90, N33.0***

incl: todo tipo de infecções de tuberculose em qualquer parte do corpo, efeitos tardios.
critérios: conversão para um teste positivo de tuberculina; demonstração de *Mycobacterium Tuberculosis* por microscopia ou cultura; manifestação característica na radiografia do tórax; ou manifestação histológica característica por biópsia
considerar: febre A03, tosse R05

A71 SARAMPO ***B05***

incl: complicações de sarampo
critérios: pródromo com injeção das conjuntivas, febre e tosse; manchas brancas em base vermelha nas membranas da mucosa jugal (manchas de Koplik), ou erupção maculopapular confluente em face e corpo, ou exantema atípico em um indivíduo parcialmente imune durante um surto de sarampo ou manifestação serológica de sarampo agudo
considerar: febre A03, doença viral com exantema A76, erupção cutânea S07

A72 VARICELA ***B01***

incl: complicações de varicela
excl: herpes zoster S70
critérios: exantema vesicular, em que as lesões evoluem rapidamente de pápulas superficiais a vesículas e, eventualmente, a crostas
considerar: febre A03, doença viral com exantema A76, erupção cutânea S07

A73 MALÁRIA ***B50 a B54***

incl: complicações de malária
excl: profilaxia da malária A44
critérios: febre intermitente com calafrios e suores frios em um habitante ou visitante recente de uma região com malária; ou demonstração de formas do parasita da malária no sangue periférico
considerar: febre A03

A74 RUBÉOLA ***B06***

incl: complicações da rubéola, rubéola congênita
excl: roséola infantil A76
critérios: exantema agudo com nódulos linfáticos dilatados, normalmente suboccipital e retroauricular, erupção cutânea – primeiro na face, depois no tronco e na região proximal dos membros —; ou evidência serológica de infecção de rubéola
considerar: febre A03, doença viral com exantema A76, erupção cutânea S07

A75 MONONUCLEOSE INFECCIOSA ***B27***

incl: febre glandular
critérios: inflamação das amígdalas ou da faringe, com linfadenopatia não confinada aos nódulos cervicais anteriores e linfócitos atípicos no esfregaço de sangue ou esplenomegalia; ou titulo aumentado de anticorpos heterófilos anormais ou pesquisa positiva de vírus de EB
considerar: febre A03; nódulos linfáticos aumentados B02; infecção aguda do trato respiratório superior R74

A76 OUTRO EXANTEMA VIRAL ***A88.0, B03, B04, B08.0, B08.2 a B08.4, B08.8, B09***

incl: febre com erupção cutânea, quinta doença, roséola infantil
excl: doenças especificadas em A71, A72, A74, A75

A77 DENGUE E OUTRAS DOENÇAS VIRAIS NE ***A82, A90 a A96, A98, A99, B00.7, B25, B33.0, B33.1, B33.3, B33.8, B34, B97***

incl: adenovírus; vacina; doenças por Coxsackie; dengue; doença das mãos, pés e boca; febre de Ross River
excl: exantemas virais A76, gripe R80

A78 HANSENÍASE E OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS NE ***A20 a A28, A30, A31, A32.7 a A32.9, A38, A40 até A44, A48.0, A48.2 a, A48.4, A48.8, A49, A59.8, A59.9, A64,,A68, A69.2, A69.8, A68.9, A70, A74.8, A74.9, A75, A77 a, A79, B37.7 a B37.9, B38 a, B49, B55, B57, B58.8, B58.9, B59, B60, B64, B89, B92, B94.8, B94.9, B95, B96, B99, K77.0***

incl: brucelose; infecções com localização não-especificada; doença de Lyme; infecções meningocócicas; mycoplasma; febre Q; riquetsiose; escarlatina; doença sexualmente transmissível NE; aftas NE; toxoplasmose
excl: meningite meningocócica N71

A79	**CARCINOMATOSE (LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA DESCONHECIDA) NE**	***C38.1 a C38.3, C38.8, C45.7, C45.9, C46.7 a C46.9, C76, C78, C79, C80, C97, D09***

incl: neoplasias secundárias e metastáticas com localização primária desconhecida.
critérios: evidência histológica de malignidade considerar: outra doença generalizada A99

A80	**LESÃO TRAUMÁTICA/ACIDENTE NE**	***S11, S15, S21, S27, S25, S26, S35, S37.9, S38.1, S38.3, S39, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T09, T14.5, T14.7 a T14.9, T28.4, T28.9***

incl: acidente de trânsito
excl: lesão traumática múltipla A81, efeitos tardios de lesão traumática A82

A81	**POLITRAUMATISMOS/FERIMENTOS MÚLTIPLOS**	***S35.0,S35.1,S36.7 a S36.9, S37.7, S37.8, S39, T00 a T05,T06.5 a T06.8, T07, T29, T35***

incl: lesões internas NE
Nota: Nesta classificação, os termos "geral" e "múltiplo" referem-se a três ou mais localizações corporais ou sistemas. As condições que afetam uma ou duas zonas deverão ser codificadas nestas.

A82	**EFEITO SECUNDÁRIO DE UMA LESÃO TRAUMÁTICA**	***T79.0 a T79.2, T79.4, T79.5, T79.7 a T79.9, T90 a T98***

incl: sequelas, cicatrizes resultantes de ferimentos anteriores; amputação anterior
excl: efeitos relacionados com sistemas corporais específicos (codificar no capítulo dos sistemas); efeitos psicológicos P02; reação aguda ao estresse P02; perturbação de estresse pós-traumático P82; ferida infectada S11; cicatriz S99

A84	**INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTO**	***T36 a T50***

incl: *overdose*
excl: abuso de medicação P18; tentativa de suicídio P77; coma insulínico T87
critérios: toxicidade ou incapacidade provocada por *overdose* acidental ou deliberada de um agente com propriedades medicinais quando tomado na dose habitual

A85	**EFEITOS SECUNDÁRIOS DE UM FÁRMACO**	***D61.1, D64.2, G44.4, I95.2, L27.0, L27.1, T88***

incl: efeitos secundários, alergia e anafilaxia devidos à medicação administrada em dose correta
excl: *overdose* ou envenenamento A84; reação à imunização e à transfusão A87; Parkinsonismo N87; dependência ou habituação P18; dermatite de contato S88; coma insulínico T87
critérios: sinais e sintomas atribuídos à ingestão adequada de medicamentos, e não a uma doença ou um ferimento
Nota: É possível ainda codificar a natureza dos efeitos secundários

A86	**EFEITO TÓXICO DE UMA SUBSTÂNCIA NÃO-MEDICINAL**	***D61.2, D64.2, T51 a T65***

incl: monóxido de carbono; efeitos gerais ou locais; materiais industriais; chumbo; animais, insetos, plantas, serpentes venenosas

excl: devido aos agentes medicinais A84, A85, ou ao álcool, tabaco e às drogas P16 a P19; efeitos tóxicos respiratórios R99; queimaduras químicas – internas ou externas S14 —; mordeduras não-tóxicas S12, S13; dermatite de contato S88

A87	**COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO**	***E89, G97, H95, I97, J95, K91, M96, N99, O29, 074, O86.0, O89, O90.0 a O90.2, T80, T81, T86, T87, T88***

incl: choque anestésico; reações a imunização e transfusão; ruptura, infecção, hemorragia de ferida operatória; problemas resultantes de radiação diagnóstica ou terapêutica
excl: medicação em *overdose* A84; efeitos secundários da medicação A85
critérios: perturbações inesperadas resultantes da cirurgia, tratamento com medicamentos, radioterapia ou qualquer outra forma de terapêutica

A88	**EFEITOS SECUNDÁRIOS POR FATORES FÍSICOS**	***T33, T34, T66 a T69, T70.2 a T70.4, T70.8, T70.9, T71, T73,T75, T78.1, T78.8, T78.9***

incl: frio; calafrios; afogamento; calor; *jetlag* (cansaço e distúrbios causados pela diferença de fuso horário); trovoada; movimento; pressão; radiação
excl: efeitos de radiação médica A87; cegueira da neve F79; efeitos do álcool P16; efeitos do tabaco P17; queimaduras de radiação S14; queimadura solar S88

A89	**EFEITOS DE UMA PRÓTESE**	***T82 a T85,Z95 a Z97***

incl: incapacidade, desconforto, deficiência, dor ou limitação da função resultante da utilização de uma prótese corretora de uma deficiência; cateter; prótese dentária; válvula cardíaca; prótese articular; transplante de órgão; marca-passo

A90	**MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS NE/MÚLTIPLAS**	***Q85 a Q87, Q89.3, Q89.4, Q89.7, Q89.9, Q90 a Q93, Q95 a Q99***

incl: síndrome de Down; síndrome de Marfan; outras malformações cromossômicas
excl: malformações relacionadas com sistemas corporais específicos (codificar no capítulo dos sistemas)

A91	**INVESTIGAÇÃO COM RESULTADOS ANORMAIS NE**	***E83, R73, R74, R76 a R79, R83 a R94***

incl: teste ou imagiologia anormal e inexplicável; perturbação eletrolítica
excl: células brancas anormais B84; anomalia hematológica B99; teste de urina anormal U98; esfregaço de pap anormal X86
critérios: resultados anormais que não podem ser atribuídos a doença conhecida

A92	**ALERGIA/REAÇÃO ALÉRGICA NE**	***T78.0, T78.2 a T78.4***

incl: todas as reações alérgicas não especificadas em qualquer outra parte, edema alérgico, choque anafilático, edema angioneurótico
excl: urticária S98, consequência de medicação A85, rinite alérgica R97

A93 RECÉM-NASCIDO PREMATURO ***P07***

critérios: nascido-vivo com menos de 36 semanas de gestação

A94 MORBIDADE PERINATAL, OUTRA ***P00 a P06, P08, P10 a P15, P20 a P29, P35 a P39, P50 a P61, P70 a P72, P74 a P78, P80, P81, P83, P90 a P94, P96***

excl: condições congênitas A90; atraso de crescimento T10
critérios: morbidade até 4 semanas após o parto

A95 MORTALIDADE PERINATAL ***P95, R95***

critérios: morte até 4 semanas após o parto

A96 MORTE ***R95 a R99***

excl: perinatal A95

A97 SEM DOENÇA *Z00*

incl: nenhuma doença ou afecção detectada durante a consulta

A98 MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE ***Z51.8***

A99 DOENÇA GERAL NE ***D15.7, D15.9, D36.7, D36.9, D48.9, R69, Z22, Z90.0, Z90.8, Z94.8, Z94.9, Z98.8***

incl: doença ou condição de natureza ou localização não-especificadas; portador de doença

B – SANGUE, SISTEMA HEMATOPOIÉTICO, LINFÁTICO, BAÇO

Componente 1 – Sinais e sintomas

B02 GÂNGLIO(S) LINFÁTICO(S) DOLORIDOS/COM VOLUME AUMENTADO ***R59***

incl: linfadenopatia com ou sem dor/sensibilidade
excl: linfadenite – aguda B70, crônica B71

(B03) suprimido, incluído em B02

B04 SINAIS/SINTOMAS DO SANGUE ***R68.8***

excl: anemia B82, palidez S08

B25 MEDO DE VIH/ HIV/ SIDA/ AIDS ***Z71.1,Z71.7***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de AIDS/HIV sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

B26 MEDO DE CÂNCER NO SANGUE/ SISTEMA LINFÁTICO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador da doença sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

B27 MEDO DE OUTRAS DOENÇAS DO SANGUE/ VASOS LINFÁTICOS ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de outra doença sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

B28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

incl: incapacidade provocada por problemas de perda de sangue
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

B29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS DO SANGUE/SISTEMA LINFÁTICO/BAÇO NE **R68.8**

excl: esplenomegalia B87

Componente 7 – Diagnóstico/doença

B70 LINFADENITE AGUDA ***L04***

incl: abcesso de gânglio linfático
excl: linfadenite crônica B71; linfadenite mesentérica B71
critérios: um ou mais gânglios linfáticos inflamados ou aumentados, sensíveis ou com dor, na mesma região anatômica, que apareceram recentemente (menos de 6 semanas) e cuja fonte primária de infecção seja desconhecida
considerar: gânglio linfático aumentado B02

B71 LINFADENITE CRÔNICA NÃO-ESPECÍFICA ***I88***

incl: linfadenite mesentérica, aguda ou crônica
excl: linfadenite aguda (exceto mesentérica) B70, linfangite K99
critérios: gânglios linfáticos aumentados, dolorosos, persistindo mais de 6 semanas, ou identificação por cirurgia, ecografia ou linfografia de gânglios linfáticos mesentéricos aumentados e inflamados
considerar: gânglio linfático aumentado BO2

B72 DOENÇA DE HODGKIN/ LINFOMAS ***C81 a C85***

critérios: manifestação histológica característica
considerar: outras neoplasias malignas B74; neoplasias de benignidade ou malignidade não especificada (quando não há dados histológicos disponíveis) B75

B73 LEUCEMIA ***C91 a C95***

incl: todos os tipos de leucemia
critérios: manifestação histológica característica
considerar: neoplasias de benignidade ou malignidade não especificada (quando não há dados histológicos disponíveis) B75

B74 OUTRA NEOPLASIA MALIGNA DO SANGUE ***C46.3, C77, C88, C90, C96***

incl: doença mieloproliferativa, mieloma múltiplo
excl: doença de Hodgkin, linfomas B72

B75 NEOPLASIAS BENIGNAS NE ***D15.0, D36.0, D45, D47***

incl: policitemia vera

B76 ROTURA DO BAÇO ***S36.0***

B77 OUTRAS LESÕES TRAUMÁTICAS DO SANGUE/LINFA/BAÇO ***T14.9***

B78 ANEMIAS HEMOLÍTICAS HEREDITÁRIAS ***D56 a D58***

incl: anemia de células falciformes, característica da célula falciforme, esferocitose, talassemia
critérios: achados característicos com testes clínicos, tais como eletroforese da hemoglobina, esfregaço de sangue ou aumento da fragilidade osmótica dos eritrócitos
considerar: outras malformações congênitas B79

B79 OUTRA MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO SANGUE/LINFÁTICA ***D61.0, D64.0, D64.5, Q89.0, Q89.8***

incl: anemia congênita
excl: anemia hemolítica hereditária B78, hemofilia B83

B80 ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO ***D50***

incl: anemia decorrente de perda de sangue
excl: deficiência de ferro sem anemia T91
critérios: diminuição da hemoglobina ou do hematócrito, atingindo níveis inferiores aos indicados para idade e sexo; e ainda evidência de perda de sangue, ou índices ou aparência de eritrócitos hipocrômicos microcíticos na ausência de talassemia, ou diminuição do nível de ferro no soro e aumento da capacidade de fixação do ferro, ou nível reduzido de ferritina no soro ou de hemossiderina na medula óssea, ou boa resposta à administração de ferro
considerar: anemia não-especificada B82

B81 ANEMIA PERNICIOSA / DEFICIÊNCIA DE FOLATOS ***D51,D52***

incl: anemia macrocítica, anemia megaloblástica, anemia perniciosa
excl: deficiência de vitamina B12 sem anemia T91
critérios: anemia macrocítica por índices ou esfregaço; e ainda nível baixo de vitamina B12 e ácido fólico, ou teste de Schilling positivo

B82 OUTRAS ANEMIAS NÃO-ESPECIFICADAS ***D46, D53, D55, D59 a D60, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63, D64.1, D64.3, D64.8, D64.9***

incl: anemia aplástica, anemia hemolítica adquirida, anemia por deficiência de proteínas
excl: anemia por deficiência de ferro B80; anemia por deficiência de vit. B12/ácido fólico B81; anemia da gravidez W84

B83 PÚRPURA/DEFEITOS DE COAGULAÇÃO ***D65 a D69***

incl: plaquetas anormais, hemofilia, trombocitopenia

B84 GLÓBULOS BRANCOS ANORMAIS ***D70 a D72, R72***

incl: agranulocitose; eosinofilia; leucocitose; linfocitose; neutropenia
excl: leucemia B73

(B85) suprimido, incluído em A91

(B86) suprimido, incluído em B99

B87 ESPLENOMEGALIA ***R16.1,R16.2***

excl: hiperesplenismo B99

B90 INFECÇÃO PELO VIH/ HIV/ SIDA/ AIDS ***B20 a B24,R75,Z21***

B99 OUTRA DOENÇA DO SANGUE/ VASOS LINFÁTICOS/BAÇO ***D73 a D77,D80 a D84 D86, D89, I89, R70, R71***

incl: doença autoimune do sangue; defeitos do complemento; hiperesplenismo; imunodeficiência; outra malformação hematológica ou não-especificada; VS elevada; malformação dos eritrócitos; sarcoidose; policitemia secundária
excl: linfadenite B70, B71; policitemia primária B75; doença do vírus da imunodeficiência humana (HIV) B90; linfoedema K99

D – APARELHO DIGESTIVO

Componente 1 – Sinais e sintomas

D01 DOR ABDOMINAL GENERALIZADA/CÓLICAS ***R10.0, R10.4***

incl: cólicas abdominais, desconforto, dor NE; cólicas infantis
excl: dores de estômago D02, azia D03, dores abdominais localizadas DO6, indigestão D07, dores por gases D08, cólicas biliares D98, cólicas renais U14, dismenorreia X02

D02 DORES ABDOMINAIS, EPIGÁSTRICAS ***R10.1***

incl: desconforto epigástrico, enfartamento; dores de estômago
excl: dispepsia/indigestão D07; flatulência, gases D08

D03 AZIA ***R12***

incl: acidez, pirose
excl: dores epigástricas D02; indigestão D07; esofagite, refluxo D84

D04 DOR ANAL/ RETAL ***K59.4, R10.2, R10.3***

incl: espasmo anal; proctalgia fugaz
excl: fezes duras D12

D05 IRRITAÇÃO PERIANAL ***L29.0,L29.3***

incl: prurido perianal
excl: prurido da vulva X16

D06 OUTRAS DORES ABDOMINAIS LOCALIZADAS ***R10.1 a R10.3***

incl: dores do cólon
excl: dores epigástricas D02

D07 DISPEPSIA/INDIGESTÃO ***K30***

excl: dores epigástricas D02, azia D03, eructação D08

D08 FLATULÊNCIA/GASES/ERUCTAÇÃO ***R14***

incl: estômago inchado; arroto; dores provocadas por gases; distensão gasosa; gases
excl: indigestão NE D07, alteração do volume do abdômen D25

D09 NÁUSEA ***R11***

excl: sensação de ter comido demais D02; vômitos D10; má disposição provocada pelo álcool P16; perda de apetite T03; gravidez WO6
Nota: codificar náuseas e vômitos no modo problemas, como D10

D10 VÔMITOS ***F50.5, R11***

incl: emese, hiperemese, esforço de vômito
excl: hematemese D14; durante a gravidez WO6
Nota: codificar diarreia e vômitos no modo problemas, como D11

D11 DIARREIA ***K52.9, K59.1***

incl: evacuação intestinal frequente; fezes líquidas
excl: melenas D15, outras alterações do trânsito intestinal D18

D12 OBSTIPAÇÃO ***K56.4,K59.0***

incl: fezes duras
excl: íleo D99

D13 ICTERÍCIA ***R17***

incl: ictérico

D14 HEMATEMESE/VÔMITO DE SANGUE ***K92.0***

excl: hemoptise R24

D15 MELENA ***K92.1***

incl: fezes escuras ou negras
excl: sangue fresco expelido pelas fezes D16

D16 HEMORRAGIA RETAL ***K62.5***

incl: sangue fresco expelido pelas fezes
excl: melena D15

D17 INCONTINÊNCIA INTESTINAL ***R15***

incl: incontinência fecal
excl: encoprese P13

D18 ALTERAÇÃO NAS FEZES/ MOVIMENTOS INTESTINAIS ***R19.4, R19.5***

excl: diarreia D11, prisão de ventre D12, incontinência D17

D19 SINAIS/SINTOMAS DOS DENTES/GENGIVAS ***K00.7***

incl: problemas com a dentadura, inflamação ou sangramento gengival, dentição, dor de dentes
excl: cáries D82

D20 SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS ***K14,R19.6,R68.2***

incl: mau hálito; língua saburrosa; lábios rachados; salivação; boca seca; halitose; lábios inchados; inflamação da boca
excl: quilose D83; problemas nos dentes e gengivas D19; alteração do gosto N16; desidratação T11

D21 PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO ***R13***

incl: sensação de sufocamento, disfagia

(D22) (transferido para D96)

D23 HEPATOMEGALIA ***R16.0,R16.2***

D24 MASSA ABDOMINAL NE ***R19.0***

incl: relevo no abdômen
excl: esplenomegalia B87, hepatomegalia D23, massa renal U29

D25 DISTENSÃO ABDOMINAL ***R19.0***

incl: abdômen inchado sem massa
excl: estômago dilatado, gases D08; massa abdominal D24; ascite D29

D26 MEDO DE CÂNCER DO APARELHO DIGESTIVO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de câncer do aparelho digestivo sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

D27 MEDO DE OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO ***Z71.1***

incl: receio de doença do aparelho digestivo diferente de câncer
excl: se o paciente sofre da doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de uma doença do aparelho digestivo sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

D28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6, Z93.1 a Z93.4***

excl: colostomia, gastrostomia A89; perturbações pós-operatórias D99; síndrome do esvaziamento rápido D99
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

D29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS DIGESTIVOS ***R18, R19.1 a R19.3, R19.8***

incl: ascite, ranger de dentes

Componente 7 – Diagnóstico/doença

D70 INFECÇÃO GASTROINTESTINAL **A00 a A08**

incl: infecção gastrointestinal ou disenteria com organismos especificados, incluindo *campylobacter*, giárdia, salmonela, shigella, febre tifoide, cólera
excl: contatos, portadores de doença infecciosa/parasitária A99; infecções não-específicas ou presumidas D73
critérios: paciente sintomático com evidência de bactéria patogênica, vírus ou protozoários por sorologia ou isolamento nas fezes ou em alimentos ingeridos
considerar: presumível infecção de gastrenterite D73

D71 CAXUMBA/PAROTIDITE EPIDÊMICA **B26**

incl: meningite de caxumba, orquite de caxumba, pancreatite de caxumba
critérios: inflamação aguda não-supurativa, não-eritematosa, difusa, dolorosa de uma ou mais glândulas salivares ou infecção aguda de caxumba diagnosticada por cultura ou sorologia; ou orquite em uma pessoa exposta ao vírus da caxumba, após o período de incubação
considerar: massa ou inchaço localizado A08

D72 HEPATITE VIRAL ***B15 a B19,K77.0***

incl: todo tipo de hepatite de origem supostamente viral; hepatite crônica ativa
excl: hepatite NE D97
critérios: evidência de infecção viral hepática com inflamação, com ou sem icterícia; ou evidência sorológica de uma infecção com um vírus da hepatite
considerar: icterícia D13, hepatomegalia D96

D73 GASTRENTERITE, PRESUMÍVEL INFECÇÃO ***A09***

incl: diarreia ou vômitos presumivelmente infecciosos; disenteria NE; intoxicação alimentar; gripe gástrica
excl: perturbações digestivas funcionais D93; enterite e gastrenterite não-infecciosas D94, D99

D74 NEOPLASIA MALIGNA DO ESTÔMAGO ***C16***

incl: carcinoma do estômago
critérios: aparência histológica característica
considerar: outras neoplasias malignas (quando a localização primária é desconhecida) D77; neoplasias de benignidade ou malignidade desconhecida (quando a histologia não se encontra disponível) D78

D75 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON/RETO ***C18 a C21***

critérios: aparência histológica característica
considerar: outras neoplasias malignas (quando a localização primária é desconhecida) D77; neoplasias de benignidade ou malignidade desconhecida (quando a histologia não se encontra disponível) D78

D76 NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS ***C25***

incl: carcinoma do pâncreas
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasias de benignidade ou malignidade desconhecida (quando a histologia não se encontra disponível) D78

D77 OUTRA NEOPLASIA MALIGNA DO APARELHO DIGESTIVO NE ***C00 a C08, C14.8,DO15, C17, C22 a C24, C26, C45.1, C46.2, C48***

incl: todo o tipo de malignidade primária do aparelho digestivo excetuando D74 a D76; câncer da vesícula; câncer do fígado
excl: malignidade secundária de localização conhecida (codificar de acordo com a localização); localização desconhecida A79

D78 NEOPLASIA DO APARELHO DIGESTIVO BENIGNA/INCERTA ***D00, D01, D10 aD13, D20, D37, D48.3, D48.4, K62.0, K62.1***

incl: pólipos do estômago, duodeno, cólon, reto

D79 CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO ***T18***

incl: corpo estranho no tubo digestivo, incluindo boca, esôfago e reto
excl: corpo estranho na laringe R87, inalado R87

D80 OUTRAS LESÕES TRAUMÁTICAS **S00.5, S01.5, S02.5, S03.2, S36.1a S36.6, *T28.0 a T28.2, T28.5 a T28.7***

incl: traumatismos dos órgãos abdominais, dentes e língua
excl: traumatismos de múltiplos órgãos A81, órgãos pélvicos X82, Y80

D81 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO APARELHO DIGESTIVO ***Q18,Q35 a Q45***

incl: malformações biliares; lábio e palato leporinos; divertículo de Meckel; megacólon, doença de Hirschprung; atresia esofágica; estenose pilórica; língua presa
excl: hemangioma, linfangioma B79; alterações congênitas do metabolismo T80

D82 DOENÇAS DOS DENTES/GENGIVAS ***K00.1 a K00.6, K00.8, K00.9, K01 a K10***

incl: cáries; abcessos; gengivite; maloclusão; perturbação da articulação temporomandibular; angina de Vincent
excl: dentição D19; problemas com a dentadura D19; traumatismo dos dentes e gengivas D80

D83 DOENÇAS DA BOCA/LINGUA/LÁBIO ***A69.0, A69.1, B00.2, B37.0, K11 a K13***

incl: úlcera aftosa; quilose; glossite; mucocele; parotite; cálculo salivar; estomatite; aftas
excl: caxumba D71; traumatismos D80; herpes simples S71

D84 DOENÇA DO ESÔFAGO ***K20 a K23***

incl: acalasia, divertículo, síndrome de Mallory-Weiss, esofagite, refluxo, ulceração
excl: câncer do esôfago D77; hérnia do hiato D90; varizes esofágicas K99

D85 ÚLCERA DO DUODENO ***K26***

incl: hemorragia, obstrução, perfuração
critérios: achados imagiológicos característicos; sinais endoscópicos característicos; ou sintomas exacerbados em paciente com história clínica de úlcera no duodeno
considerar: azia D03; indigestão D07

D86 ÚLCERA PÉPTICA, OUTRAS ***K25, K27, K28***

incl: gástrica, gastrojejunal, marginal; erosões agudas; úlcera péptica NE
excl: úlcera esofágica D84; úlcera duodenal D85
critérios: sinais imagiológicos característicos; sinais endoscópicos característicos; ou sintomas exacerbados em um paciente com história prévia de úlcera
considerar: azia D03; indigestão D07

D87 ALTERAÇÕES FUNCIONAIS DO ESTÔMAGO ***K29***

incl: dilatação aguda do estômago; duodenite; gastrite (incl alcoólica)
excl: gastrite ou enterite infecciosa D70,D73
critérios: resultados de investigação indicando mau funcionamento do estômago
considerar: dores abdominais D01, D06; dores epigástricas D02; azia D03; indigestão/dispepsia D07; gases intestinais D08; náusea D09; esofagite D84; vômitos D10

D88 APENDICITE ***K35 a K37***

incl: abcesso do apêndice, perfuração
critérios: evidência objetiva de apêndice inflamado, detectado por intervenção cirúrgica ou exame histológico
considerar: dores abdominais D01, D06; vômitos D10

D89 HÉRNIA INGUINAL ***K40***

excl: hérnia femural D91
critérios: inchaço da região inguinal e impulso transmitido pela tosse; aumento de volume por compressão; ou redutível ao abdômen; ou obstrução intestinal
considerar: inchaço do abdômen D24

D90 HÉRNIA DO HIATO/DIAFRAGMÁTICA ***K44***

incl: hérnia diafragmática
excl: esofagite, refluxo D84
critérios: sinais característicos por imagiologia, endoscopia, estudos de pressão intraluminal; ou durante intervenção cirúrgica
considerar: dores epigástricas D02; azia D03; indigestão D07

D91 HÉRNIA ABDOMINAL, OUTRAS ***K41 a K43, K45, K46***

incl: femural, incisional, umbilical, ventral
excl: hérnia do hiato D90
critérios: identificação por intervenção cirúrgica; inchaço na zona especificada e impulso transmitido pela tosse; ou aumento de volume por compressão, ou redutível ao abdômen, ou obstrução intestinal
considerar: inchaço abdominal D24

D92 DOENÇA DIVERTICULAR INTESTINAL **K57**

incl: diverticulite; diverticulose do intestino
excl: divertículo de Meckel D81; divertículo esofágico D84
critérios: sinais imagiológicos de divertículo; demonstração de divertículo na cirurgia; ou dores abdominais agudas com febre e palpação dolorosa do cólon descendente ou da sigmoide
considerar: dores abdominais D01, D06

D93 SÍNDROME DO CÓLON IRRITÁVEL ***K58***

incl: colite mucosa, colite espástica
excl: doença intestinal de origem infecciosa D70, D73; enterite regional D94; gastrenterite e colite alérgicas, dietéticas e tóxicas D99; insuficiência vascular do intestino D99; diarreia psicogênica P75
critérios: dores abdominais contínuas ou intermitentes e alteração do trânsito intestinal ao longo de determinado período de tempo; e gases intestinais, ou cólon palpável e sensível, ou história clínica de fezes com muco sem sangue
considerar: dores abdominais D01, D06; flatulência D08; diarreia D11; prisão de ventre D12

D94 ENTERITE CRÔNICA/COLITE ULCEROSA ***K50, K51, K52.0***

incl: doença de Crohn, enterite regional, colite ulcerosa
critérios: manifestações características endoscópicas, imagiológicas ou histológicas
considerar: dores abdominais D01, D06; diarreia D11; colite mucosa D93

D95 FISSURA ANAL/ABCESSO PERIANAL ***K60,K61***

incl: fístula anal, abcesso isquiorretal
excl: abcesso pilonidal S85

D96 LOMBRIGAS/OUTROS PARASITAS ***B65 a B83***

incl: cestoides; parasitas intestinais não-especificados; triquiníase; doença hidática
critérios: manifestações de helmintas em forma adulta, larva ou ova; exames dermatológicos positivos; ou sorologia positiva

D97 DOENÇA DO FÍGADO/NE ***B58.1, B94.2, K70 a K76, K77.8***

incl: hepatite alcoólica, cirrose, fígado gordo, hepatite NE, insuficiência hepática, hipertensão portal
excl: hepatite viral D72, doença hidática D96

D98	COLECISTITE, COLELITÍASE	*K80 a K83,K87.0*

incl: cólicas biliares, colangite, cálculos
critérios: colecistite – evidência de patologia típica por ecografia ou intervenção cirúrgica —; quadrante superior direito doloroso e icterícia ou febre ou história clínica de cálculos; colelitíase – demonstração imagiológica ou cirúrgica de cálculos —; cólica biliar aguda – dores abdominais agudas do quadrante superior direito sem febre – e icterícia ou quadrante superior direito doloroso, ou história clínica de cálculos na vesícula
considerar: dores abdominais localizadas D06

D99	OUTRA DOENÇA DO SISTEMA DIGESTIVO	*K31, K38, K52.1, K52.2, K52.8, K55, K56.0 a K56.3, K56.5 a K56.7, K59.2, K59.3, K59.8, K59.9, K62.2 a K62.4, K62.6 a K62.9, K63 a K67, K85 a K86, K87.1, K90, K91, K92.2, K92.8, K92.9, K93, Z90.3, Z90.4, Z94.4, Z98.0*

incl: aderências abdominais; doença celíaca; síndrome do esvaziamento rápido; intolerância alimentar; gastroenteropatia alérgica, toxica e diabética; íleo; obstrução intestinal; intuscepção; síndrome de má absorção; doença vascular mesentérica; doenças pancreáticas; peritonite; megacólon secundário; espru; e outras doenças do sistema digestivo NE
excl: colite associada a antibióticos A85, doença maligna D74-D77

F – OLHO

Componente 1 – Sinais e sintomas

F01	DOR NO OLHO	*H57.1*

excl: sensações anormais no olho F13

F02	OLHO VERMELHO	*H57.8*

incl: olhos congestionados, inflamados

F03	SECREÇÃO OCULAR	*H04.2*

incl: lacrimejo, secreção purulenta

F04	MOSCAS VOLANTES/PONTOS LUMINOSOS/MANCHAS	*H53.8*

incl: pontos fixos ou flutuantes no campo visual
excl: perda de visão F94

F05	OUTRAS PERTURBAÇÕES VISUAIS	*H53.1 a H53.3, H53.9, H54.7*

incl: visão turva; dificuldade em ler; diplopia; vista esforçada; escotoma e ofuscamento em caso de sintomas confinados à vista; cegueira temporária NE; perda de visão; vista cansada
excl: fotofobia F13, cegueira da neve F79, erros de refração F91, cegueira permanente F94, daltonismo F99, cegueira noturna F99

F13 SENSAÇÕES OCULARES ANORMAIS ***H57.8***

incl: ardor nos olhos; olhos secos; prurido nos olhos; fotofobia
excl: dor no olho F01

F14 MOVIMENTOS OCULARES ANORMAIS ***H55***

incl: pestanejar anormal, ambliopia, nistagmo, contração espasmódica
excl: estrabismo F95; tiques dos olhos P10

F15 APARÊNCIA ANORMAL DOS OLHOS ***H57.8***

incl: alteração da cor dos olhos; olhos inchados
excl: olho vermelho F02

F16 SINAIS/SINTOMAS DAS PÁLPEBRAS ***H02.2 a H02.7***

incl: ptose palpebral
excl: pálpebras inflamadas F72

F17 SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AOS ÓCULOS ***Z46.0***

incl: problemas com os óculos, afetando a estrutura, função ou sensações dos olhos
excl: problemas com lentes de contato F18

F18 SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS ÀS LENTES DE CONTATO ***Z46.0***

incl: problemas com as lentes de contato, afetando a estrutura, função ou sensações dos olhos

F27 MEDO DE DOENÇA OCULAR ***Z71.1***

incl: medo de cegueira
excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de uma doença ocular sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

F28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***H54.4 a H54.6, Z73.6***

incl: cegueira de um olho; incapacidade relacionada ao olho ou a problemas de visão
excl: cegueira F94
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

F29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS OCULARES ***H57.9***

Componente 7 – Diagnóstico/doença

F70 CONJUNTIVITE INFECCIOSA ***B30, G31.1, H10.0, H10.2 a H10.5, H10.8, H10.9, H13***

incl: bacteriana e viral; NE
excl: alérgica com e sem rinorreia F71, queimadura por clarão F79, tracoma F86
critérios: inflamação das conjuntivas sem as condições referidas em exclusão

F71 CONJUNTIVITE ALÉRGICA ***H10.1***

incl: alérgica com ou sem rinorreia
excl: conjuntivite bacteriana e viral F70, queimadura por clarão F79, tracoma F86
critérios: hiperemia das conjuntivas, lacrimejo excessivo, prurido e possível edema da conjuntiva sem as condições referidas em exclusão

F72 BLEFARITE/HORDÉOLO/CALÁZIO ***H00, H01***

incl: dermatite; dermatose das pálpebras; hordéolo; infecção; cisto de Meibomius; cisto társico
excl: dacriocistite F73
critérios: inflamação generalizada ou localizada e/ou pálpebras inchadas, incluindo as glândulas társicas

F73 OUTRAS INFECÇÕES/INFLAMAÇÕES OCULARES ***B00.5, B58.0, H03, H04.3, H04.4, H16.1 a H16.4, H16.8, H16.9, H19.0, H19.2, H20 a H22, H30, H32***

incl: dacriocistite; herpes simples sem úlcera da córnea; herpes zoster oftálmico; irite; iridociclite; queratite
excl: úlcera da córnea (herpes) F85, tracoma F86

F74 NEOPLASIA DO OLHO/ANEXOS ***C69, D31, D48.7***

incl: benignas e malignas

F75 CONTUSÃO/HEMORRAGIA OCULAR ***H11.3, S00.1, S05.1***

incl: olho negro; hifema; hemorragia subconjuntival
excl: úlcera da córnea F85

F76 CORPO ESTRANHO OCULAR ***T15***

excl: escoriação da córnea F79

F79 OUTRAS LESÕES TRAUMÁTICAS OCULARES ***H44.6, H44.7, S00.2, S01.1, S05.0, S05.2 a S05.9, T26***

incl: escoriação da córnea, queimadura por clarão, cegueira provocada pela neve
excl: contusão/hemorragia F75, corpo estranho F76

F80 OBSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL DA CRIANÇA ***Q10.5***

excl: dacriocistite F73, em pessoas idosas F99
critérios: corrimento de lágrimas sem choro com início antes dos três meses de idade

F81 OUTRAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO OLHO ***Q10.0 a Q10.4, Q10.6, Q10.7, Q11 a Q15***

F82 DESCOLAMENTO DA RETINA ***H33***

F83 RETINOPATIA ***H35.0 a H35.2, H35.4, H36***

incl: diabética, hipertensiva ou outras

F84 DEGENERAÇÃO MACULAR ***H35.3***

excl: retinopatia F83

F85 ÚLCERA DA CÓRNEA ***H16.0,H19.1***

incl: úlcera dendrítica; queratite viral
excl: escoriação da córnea F75, outros traumatismos F79

F86 TRACOMA ***A71,B94.0***

critérios: evidência de infecção com *Chlamydia trachomatis* ou características clínicas típicas, incluindo inflamação e hipertrofia da conjuntiva com formação de grânulos amarelados ou acinzentados
considerar: olho vermelho F02, corrimento do saco lacrimal F03

F91 ERRO DE REFRAÇÃO ***H52***

incl: astigmatismo; hipermetropia; visão longa; miopia; presbiopia; visão curta
excl: cegueira e acuidade visual reduzida NE F94
critérios: déficit visual corrigível com lentes apropriadas

F92 CATARATAS ***H25,H26***

excl: congênitas F81
critérios: opacidade total ou parcial da lente óptica, reduzindo ou enfraquecendo a visão

F93 GLAUCOMA ***H40,H42***

incl: aumento da pressão intraocular
excl: congênito F81

F94 CEGUEIRA ***H54.0 a H54.3***

incl: cegueira parcial ou total dos dois olhos
excl: visão turva F05; cegueira temporária F05; cegueira de uma vista F28; cegueira provocada pela neve F79; erros de refração F91; daltonismo F99; cegueira noturna F99

F95 ESTRABISMO ***H49 a H51***

incl: olhos cruzados, olhos tortos
critérios: falta de paralelismo do eixo visual dos olhos diagnosticado durante exame médico
considerar: movimentos oculares anormais F15

F99	**OUTRAS DOENÇAS OCULARES/ANEXOS**	***H02.0, H02.1, H02.8, H02.9, H04.0, H04.1, H04.5 a H04.9, H05.2 a H05.5, H05.8, H05.9, H06, H11.0 aH11.2, H11.4, H11.8, H11.9, H15, H17, H18, H19.3, H19.8, H27, H28, H31, H34, H35.5 a H35.9, H43, H44.0 a H44.5, H44.8, H44.9, H45 a H48, H53.4 a H53.6, H57.0, H57.8, H58, H59, Z94.7***

incl: arco senil; ambliopia; daltonismo; opacidade da córnea; ectrópio; entrópio; episclerite; pestana encravada; irite; cegueira noturna; papiledema; pterígio; esclerite; e outras doenças oculares NE

H – OUVIDO

Componente 1 – Sinais e sintomas

H01	**DORES DE OUVIDOS**	***H92.0***

H02	**PROBLEMAS DE AUDIÇÃO**	***H93.2***

excl: surdez de um ouvido H28, ambos ouvidos H86

H03	**ACUFENO, ZUMBIDO, RUÍDO, ASSOBIO**	***H93.1***

incl: eco nos ouvidos, tinido
excl: ouvidos a estalar H29

H04	**SECREÇÃO DO OUVIDO**	***H92.1***

excl: sangue H05

H05	**HEMORRAGIA DO OUVIDO**	***H92.2***

incl: sangue dentro dos ouvidos/expelido pelos ouvidos

H13	**SENSAÇÃO DE OUVIDO TAPADO**	***H93.8***

incl: ouvidos obstruídos
excl: cera nos ouvidos H81

H15	**PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA DAS ORELHAS**	***R46.8***

excl: orelhas de abano H80, malformações congênitas H80

H27	**MEDO DE DOENÇA DO OUVIDO**	***Z71.1***

incl: medo de surdez
excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de uma doença auditiva ou surdez sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

H28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

incl: surdez de um ouvido, surdez temporária
excl: surdez H84-86; tonturas, vertigens N17
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

H29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS DOS OUVIDOS ***H93.9***

incl: ouvidos estalando; coceira nos ouvidos
excl: tonturas ou vertigens N17, perda de equilíbrio N17

Componente 7 – Diagnóstico/doença

H70 OTITE EXTERNA **H60,H62**

incl: eczema externo do meato auditivo; furúnculo ou abcesso do meato auditivo externo; ouvido de nadador
critérios: inflamação ou descamação do canal auditivo externo

H71 OTITE MÉDIA AGUDA/MIRINGITE ***H66.0, H66.4, H66.9, H67, H73.0***

incl: otite média supurativa aguda, otite média NE, timpanite
excl: otite serosa média H72, otite média crônica H74
critérios: perfuração recente da membrana do tímpano, provocando uma secreção de pus; tímpano inflamado e abaulado; um tímpano mais congestionado do que o outro; tímpano congestionado, provocando dores de ouvidos; ou bolha no tímpano
considerar: dores de ouvidos H01, secreção dos ouvidos H04

H72 OTITE MÉDIA SEROSA ***H65***

incl: "ouvido de cola"; otite média com efusão (OME)
excl: otite média aguda H71, otite média crônica H74
critérios: líquido acumulado por trás do tímpano, sem inflamação; macicez do tímpano com retração ou abaulamento; macicez do tímpano com consequente diminuição da capacidade auditiva
considerar: sensação de ouvido obstruído H13, salpingite eustaquiana ou bloqueio H73

H73 INFECÇÃO DA TROMPA DE EUSTÁQUIO ***H68,H69***

incl: bloqueio eustaquiano/catarro/disfunção/salpingite
excl: otite serosa média H72
critérios: diminuição aguda da capacidade auditiva, ou sensação de desconforto no ouvido, com membrana do tímpano normal
considerar: sensação de ouvido obstruído H13

H74 OTITE MÉDIA CRÔNICA ***H66.1 a H66.3, H70, H71, H73.1***

incl: colesteatoma, otite média supurativa crônica, mastoidite
excl: otite média com efusão H72

H75 NEOPLASIA DO OUVIDO ***C30.1,D48.9,H74.4***

incl: benigna e maligna; pólipo
excl: neuroma acústico N75

H76 CORPO ESTRANHO NO OUVIDO *T16*

H77 PERFURAÇÃO DO TÍMPANO *H72*

excl: com infecção H71, H74; rotura traumática ou por pressão do tímpano H79

H78 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO OUVIDO *S00.4*

incl: meato externo, pavilhão auricular
excl: do tímpano H79

H79 OUTROS TRAUMATISMOS DO OUVIDO *S01.3,S09.2,T70.0*

incl: rotura traumática ou por pressão do tímpano

H80 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO OUVIDO *Q16,Q17*

incl: orelha acessória, orelhas de abano
excl: surdez congênita H86

H81 CERÚMEN EM EXCESSO NO OUVIDO *H61.2*

critérios: sinais/sintomas decorrentes de cera no canal auditivo

H82 SÍNDROMES VERTIGINOSAS *A88.1, H81, H82, H83.0*

incl: vertigem paroxística e posicional benigna; labirintite; doença de Meniére; neuronite vestibular
critérios: vertigem giratória verdadeira
considerar: vertigens, tonturas N17

H83 OTOESCLEROSE *H80*

H84 PRESBIACUSIA *H91.1*

excl: surdez não-especificada H86
critérios: desenvolvimento progressivo de surdez simétrica bilateral a partir do envelhecimento, principalmente na percepção de sons de alta frequência
considerar: diminuição da capacidade auditiva H28

H85 LESÃO ACÚSTICA *H83.3*

incl: surdez por ruído
excl: tímpano perfurado H77
critérios: surdez para sons de alta frequência, com história de exposição a ruído elevado
considerar: surdez não-especificada H86

H86 SURDEZ *H91.9*

incl: surdez congênita; surdez parcial ou total dos dois ouvidos
excl: surdez temporária H28, surdez de um ouvido H28, otoesclerose H83, presbiacusia H84, surdez de ruído H85

H99	OUTRA DOENÇA DO OUVIDO/MASTOIDE	*H61.0, H61.1, H61.3 a H61.9, H73.8, H73.9, H74.0 a H74.3, H74.8, H74.9, H75, H83.1, H83.2, H83.8, H83.9, H93.0, H93.3, H93.8, H94*

excl: mastoidite H74

K – APARELHO CIRCULATÓRIO

Componente 1 – Sinais e sintomas

K01	DOR ATRIBUÍDA AO CORAÇÃO	*R07.2*

incl: dores atribuídas pelo paciente ao coração
excl: dores torácicas NE A11; medo de ataque cardíaco K24; angina de peito K74; sensação de aperto torácico R29

K02	SENSAÇÃO DE PRESSÃO/APERTO ATRIBUÍDO AO CORAÇÃO	*R07.2*

incl: sensação de peso no coração, segundo a descrição do paciente
excl: dores torácicas NE A11; medo de ataque cardíaco K24; angina de peito K74; falta de ar, dispneia R02

K03	DORES ATRIBUÍDAS AO APARELHO CIRCULATÓRIO NE	*R09.8*

excl: dores atribuídas ao coração K01; claudicação K92, enxaquecas N89

K04	PALPITAÇÕES/PERCEPÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS	*R00.0 a R00.2*

incl: taquicardia
excl: taquicardia paroxística K79

K05	OUTRAS IRREGULARIDADES DOS BATIMENTOS CARDÍACOS	*R00.8*

excl: palpitações K04

K06	VEIAS PROEMINENTES	*I78.1,I87.8*

incl: quaisquer veias habitualmente dilatadas, aranhas vasculares
excl: veias varicosas K95, hemangioma S81

K07 T	TORNOZELOS INCHADOS/EDEMA	*R60*

incl: hidropsia, retenção de líquidos, pés e pernas inchadas
excl: sintomas nos tornozelos L16, inchaço localizado S04

K22	FATOR DE RISCO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR	*Z82.3,Z82.4,Z86.7*

incl: história pessoal ou familiar, episódio anterior, ou outro fator de risco de doença cardiovascular

K24 MEDO DE DOENÇA CARDÍACA ***Z71.1***

incl: medo de ataque cardíaco
excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de uma doença cardíaca sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

K25 MEDO DE HIPERTENSÃO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser hipertenso sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

K27 MEDO DE OUTRA DOENÇA CARDIOVASCULAR ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de outra doença do sistema circulatório sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

K28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***R73.6***

excl: medo de doenças K25, K26, K27
critérios: identificação de uma incapacidade que pode ser atribuída a um sintoma e/ou doença do aparelho circulatório
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

K29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS CARDIOVASCULARES ***R03.1,R09.8***

incl: problemas cardíacos, pressão baixa, fraqueza no coração
excl: líquido no peito R93; cianose S08

Componente 7 – Diagnóstico/doenças

K70 DOENÇA INFECCIOSA DO APARELHO CIRCULATÓRIO ***B33.2, B37.6, I30, I32, I33, I38 a I41***

incl: endocardite aguda e subaguda; endocardite bacteriana; miocardite; pericardite (exceto a reumática)
excl: doença cardíaca reumática K71; flebite e tromboflebite K94; arterite K99

K71 FEBRE REUMÁTICA/CARDIOPATIA ***IOO a IO2, IO5 a IO7, I09***

incl: coreia, estenose mitral
critérios: Para a febre reumática aguda – duas manifestações graves, ou uma grave e duas menores, e ainda evidência de infecção estreptocócica anterior. Manifestações graves: poliartrite migratória; cardite; coreia; eritema marginado; aparecimento recente de nódulos subcutâneos. Manifestações menores: febre; artralgia; VS elevada ou proteína C-reativa positiva; intervalo PR prolongado no eletrocardiograma. Para doença cardíaca reumática crônica – tanto sinais físicos correspondentes a lesão valvular cardíaca em um paciente com passado de febre reumática; ou sinais físicos consistentes de estenose mitral, mesmo na ausência de história clínica de febre reumática, mas sem outra causa demonstrável
considerar: doença valvular cardíaca K83, outra doença cardíaca K84

K72 NEOPLASIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO ***C38.0,D48.7***

incl: benigna e maligna
excl: hemangioma S81
Nota: codificar neoplasias secundárias e metastáticas em localização primária

K73 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO ***Q20 a Q28***

incl: malformação septoauricular ou ventricular; tetralogia de Fallot; canal arterial persistente
excl: hemangioma S81

K74 DOENÇA CARDIACA ISQUÊMICA COM ANGINA ***I20,I24.8***

incl: angina provocada pelo esforço, angina de peito, angina com espasmos; dor torácica isquêmica; angina instável
excl: doença cardíaca isquêmica sem angina K76
critérios: história e sinais eletrocardiográficos ou imagiológicos de antigos enfartes do miocárdio; sinais de isquemia do miocárdio no ECG em repouso ou de esforço; ou detecção por investigação de estenose da artéria coronária ou aneurisma ventricular
considerar: dor atribuída ao coração KO1

K75 INFARTO OU ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO ***I21 a I23,I24.1***

incl: enfarte do miocárdio especificado como tendo sido agudo, ou 4 semanas (28 dias) após o começo
excl: enfarte do miocárdio antigo ou tratado K74,K76
critérios: dores torácicas características de isquemia miocárdica, com duração superior a 15 minutos, e/ou alterações anormais do ST-T ou ondas Q novas no eletrocardiograma ou aumento das enzimas cardíacas no sangue
considerar: dor atribuída ao coração KO1, angina de peito K74, doença cardíaca isquêmica crônica K76
Nota: possível código duplo K74 ou K76

K76 DOENÇA CARDÍACA ISQUÊMICA SEM ANGINA ***I24.0,I24.1,I25***

incl: aneurisma cardíaco, doença cardíaca arteriosclerótica ou aterosclerótica, doença coronária, cardiomiopatia isquêmica, enfarte do miocárdio antigo, isquemia miocárdica silenciosa
excl: doença cardíaca isquêmica com angina K74
critérios: história mais ECG, ou manifestações imagiológicas de um enfarte do miocárdio antigo; evidência no ECG em repouso ou de esforço de isquemia do miocárdio; evidência, por investigação, de estenose da artéria coronária; ou aneurisma ventricular

K77 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ***I5O***

incl: asma cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca NE, insuficiência do ventrículo esquerdo, edema pulmonar, insuficiência do ventrículo direito
excl: *cor pulmonale* K82
critérios: sinais múltiplos, incluindo edema dependente, pressão venosa jugular aumentada, hepatomegalia sem a presença de doença hepática, congestão pulmonar, derrame pleural, coração aumentado de tamanho.

K78 FIBRILAÇÃO/*FLUTTER* AURICULAR/ ATRIAL ***I48***

excl: taquicardia paroxística K79
critérios: manifestações características no eletrocardiograma; ritmo cardíaco irregular com déficit do pulso
considerar: palpitações KO4, batimentos cardíacos irregulares anormais KO5

K79 TAQUICARDIA PAROXÍSTICA ***I47***

incl: supraventricular ou ventricular
excl: taquicardia NE K04, fibrilação auricular K78
critérios: história clínica de episódios sucessivos de acelerações cardíacas (superior a 140/min) que surgem e terminam abruptamente
considerar: palpitações KO4, ritmo cardíaco irregular anormal KO5

K80 ARRITMIA CARDÍACA NE ***I49***

incl: auricular, batimentos cardíacos prematuros juncionais, ventriculares e auriculares; bradicardia; bigeminismo; batimentos ectópicos; extrassístoles; batimentos prematuros; síndrome do seio paciente; fibrilação ventricular e *flutter*
excl: taquicardia paroxística K79
critérios: um ou mais batimentos cardíacos que surgem fora do ritmo cardíaco regular
considerar: palpitações KO4, ritmo cardíaco irregular K05

K81 SOPRO CARDÍACO/ARTERIAL NE ***R01***

incl: sopro cardíaco, sopro carotídeo, sopro inocente infantil, ruído da artéria renal
excl: doença reumática cardíaca K71, doença valvular K83, frêmito venoso K84, doença cerebrovascular K90

K82 DOENÇA CARDIOPULMONAR ***I27,I28***

incl: *cor pulmonale* crônico, doenças dos vasos pulmonares, hipertensão pulmonar primária
critérios: presença de doença pulmonar crônica, ou troca dos gases respiratórios; e ainda aumento do tamanho do ventrículo direito ou insuficiência cardíaca direita
considerar: insuficiência cardíaca direita K77

K83 DOENÇA VALVULAR CARDÍACA NE ***I08,I34 a I37***

incl: endocardite crônica; prolapso da válvula mitral; insuficiência da válvula tricúspide, mitral, pulmonar, aórtica não-reumática
excl: doença valvular reumática K71
critérios: ausência de critérios da doença cardíaca reumática crônica K71 e manifestação de disfunção valvular quer por sopro cardíaco característico quer por sinais imagiológicos ou ecocardiográficos do funcionamento valvular anormal
considerar: doença cardíaca hipertensiva K87, sopros cardíacos não-especificados K81

K84 OUTRAS DOENÇAS CARDÍACAS ***I31,I42 a I46, I51, I52, O90.3***

incl: bloqueio de ramo; parada cardíaca; cardiomegalia; doença do pericárdio; cardiomiopatia; bloqueio cardíaco; bloqueio do ramo esquerdo; outros distúrbios da condução; outras doenças cardíacas não-especificadas
excl: arritmias cardíacas K80

K85 PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA ***RO3.0***

incl: pressão arterial elevada não correspondendo aos critérios estabelecidos em K86 e K87; hipertensão transitória ou instável

K86 HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES ***I10***

incl: hipertensão essencial; hipertensão NE; hipertensão idiopática; hipertensão instável
excl: hipertensão com complicações K87, durante a gravidez W81
critérios: duas ou mais leituras em cada consulta, ao longo de duas ou mais consultas, com pressão arterial média superior a 95 mmHg diastólica ou superior a 160 mmHg sistólica (em pacientes adultos); duas ou mais leituras em uma consulta em que o paciente apresenta uma pressão arterial diastólica média igual ou superior a 120 mmHg; sem sinais de envolvimento secundário do coração, rim, olho ou cérebro
considerar: pressão sanguínea elevada K85
Notas: 1 – Tratando-se de uma criança, consultar as tabelas de pressão arterial para crianças.
2 – Em caso de hipertensão secundária, codifique a causa subjacente

K87 HIPERTENSÃO COM COMPLICAÇÕES ***I11 a I13,I15,I67.4***

incl: hipertensão maligna
excl: hipertensão sem complicações K86
critérios: níveis de pressão arterial correspondentes aos definidos em K86, e alterações cardíacas (hipertrofia, insuficiência), renais (albuminúria, azotemia), oculares ou cerebrais devido a hipertensão

K88 HIPOTENSÃO POSTURAL ***I95.0,I95.1,I95.8,I95.9***

incl: hipotensão idiopática, ortostática
excl: devido à medicação A85
critérios: sinais ou sintomas de insuficiência cerebrovascular (tonturas, síncope) ao passar repentinamente da posição supina para a posição vertical; e diminuição da pressão arterial em 15 mmHg em duas ou mais circunstâncias ao passar de uma posição supina para uma posição vertical
considerar: pressão arterial baixa K29

K89 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITÓRIA ***G45***

incl: insuficiência basilar; "ataques de queda"; acidentes isquêmicos transitórios (AIT); amnésia geral transitória
excl: acidente cerebrocardiovascular K90, enxaqueca N89, sopro carotídeo K81
critérios: sintomas de hipofunção cerebral temporária (menos de 24 horas), aparecimento repentino, de origem presumivelmente vascular, sem sequelas; com exclusão de enxaqueca, enxaqueca equivalente ou epilepsia
Nota: código duplo com K91
considerar: desmaios, síncope A06

K90 TROMBOSE/ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ***G46,I60 a I64***

incl: apoplexia; embolia cerebral; enfarte cerebral; trombose cerebral; acidente vascular cerebral (AVC), oclusão ou estenose; hemorragia cerebral; hemorragia subaracnóidea
excl: isquemia cerebral transitória K89
critérios: sinais e sintomas de uma perturbação da função cerebral, presumivelmente de origem vascular, com duração superior a 24 horas ou provocando a morte em quatro semanas (28 dias) após o aparecimento
Nota: código duplo com K91

K91 DOENÇA VASCULAR CEREBRAL ***I65, I66, I67.0 a I67.3, I67.5 a I67.9, I68, I69***

incl: aneurisma cerebral, sequelas de trombose
critérios: isquemia cerebral transitória ou trombose precedentes; ou resultados de investigação evidenciando doença vascular cerebral

K92 ATEROSCLEROSE/DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA ***D15.1, D15.2, I70, I73, I74***

incl: arteriosclerose; embolia arterial, trombose ou estenose; ateroma; endoarterite; gangrena; claudicação intermitente; isquemia dos membros; síndrome de Renaud; vasoespasmo
excl: mesentérica D99, oftálmica F99, da retina F99, coronária de K74 a K76, pulmonar K82, cerebral K89,K90, aneurisma K99, renal U99; como complicação de aborto, gravidez, parto W77 ou puerpério W96

K93 EMBOLIA PULMONAR ***I26***

incl: enfarte pulmonar (arterial ou venoso), tromboembolia, trombose
excl: como complicação de aborto, gravidez, parto W77, ou puerpério W96
critérios: aparecimento súbito de dispneia ou taquipneia, e provas clínicas ou imagiológicas de enfarte pulmonar, ou sinais ECG de sobrecarga ventricular direita aguda
considerar: dispneia R02

K94 FLEBITE E TROMBOFLEBITE ***I80 a I82***

incl: trombose venosa superficial ou profunda; flebotrombose; trombose portal
excl: trombose cerebral K89 K90; tromboflebite na gravidez W77 ou no puerpério W96

K95 VEIAS VARICOSAS DA PERNA ***I83.1,I83.9***

incl: eczema varicoso; insuficiência venosa; estase venosa
excl: úlcera varicosa S97
critérios: presença de veias superficiais dilatadas nas extremidades inferiores; ou demonstração de incompetência valvular
considerar: veias proeminentes K06

K96 HEMORROIDAS ***I84***

incl: hemorroidas internas com ou sem complicações, hematoma perianal; pólipo cutâneo hemorroidal residual; hemorroidas externas trombosadas; veias varicosas do ânus ou reto
critérios: visualização de varicosidades do plexo venoso do ânus; ou edema de início agudo, doloroso e azulado, localizado na zona perianal
considerar: dores anais D04, hemorragia retal D16, tumor anal D29

K99 OUTRA DOENÇA DO APARELHO CIRCULATÓRIO ***C45.2, I71, I72, I77, I78.0, I78.8, I78.9, I79, I85, I86, I87.1, I87.2, I98 a I99, M30, M31, R02, R57, T06.3, Z94.1, Z94.3***

incl: aneurisma da aorta; arterite; fístula arteriovenosa; linfoedema; varizes esofágicas; outro aneurisma; poliarterite nodosa; vasculite; veias varicosas em outras partes do corpo para além das extremidades inferiores
excl: linfadenite B71, aneurisma cerebral K91, gangrena K92

Componente 1 – Sinais e sintomas

L01 SINAIS E SINTOMAS DO PESCOÇO *M54.0.M54.2*

incl: dor atribuída à coluna cervical ou ao sistema musculoesquelético
excl: dor de cabeça, cabeça ou face dolorida NE N01

L02 SINAIS/SINTOMAS DA REGIÃO DORSAL *M54.0, M54.6, M54.8, M54.9*

incl: dorsalgia NE; dores torácicas dorsais
excl: dores na região lombar L03

L03 SINAIS/SINTOMAS DA REGIÃO LOMBAR *M53.3, M54.0, M54.5*

incl: dores nas costas (lombares ou sacroilíacas); coccidinia; lumbago, lombalgia
excl: dor torácica dorsal L02, ciática L86

L04 SINAIS/SINTOMAS DO TÓRAX *R29.8*

incl: dores torácicas atribuídas ao sistema musculoesquelético
excl: dores torácicas NE A11; dor precordial K01; dores provocadas pela respiração, dores pleuríticas, pleurodinia R01

L05 SINAIS/SINTOMAS DO FLANCO/AXILA *R29.8*

incl: dores no flanco
excl: sintomas renais U14

(L06) suprimido, incluído em L05

L07 SINAIS/SINTOMAS DA MANDÍBULA *M25.5,R29.8*

incl: sintomas da articulação temporomandibular
excl: sinais/sintomas dos dentes e gengivas D19

L08 SINAIS/SINTOMAS DOS OMBROS *M25.4,M25.5,M25.6*

L09 SINAIS/SINTOMAS DOS BRAÇOS *M79.6,R29.8*

excl: dores musculares, mialgia L18

L10 SINAIS/SINTOMAS DOS COTOVELOS *M25.4,M25.5,M25.6*

L11 SINAIS/SINTOMAS DOS PUNHOS *M25.4,M25.5,M25.6*

L12 SINAIS/SINTOMAS DAS MÃOS E DEDOS *M25.4, M25.5, M25.6, R29.8*

L13 SINAIS/SINTOMAS DO QUADRIL *M25.4, M25.5, M25.6, R29.4*

L14 SINAIS/SINTOMAS DA PERNA/COXA ***R25.2,R29.8***

incl: cãibras nas pernas
excl: dores musculares, mialgia L18; pernas inquietas N04

L15 SINTOMAS/QUEIXAS DO JOELHO ***M25.4,M25.5,R25.6***

L16 SINAIS/SINTOMAS DO TORNOZELO ***M25.4,M25.5,R25.6***

L17 SINAIS/SINTOMAS DO PÉ/DEDOS DO PÉ ***M25.4, M25.5, M25. R29.8***

incl: metatarsalgia

L18 DORES MUSCULARES ***M60.1, M60.2, M60.8, M60.9, M79.0, M79.1, M79.3, M79.6***

incl: fibrosite, fibromialgia, mialgia, reumatismo NE
excl: dores de coluna L01, L02, L03; cãibras na perna L14

L19 SINAIS/SINTOMAS MUSCULARES NE ***M62.6,M79.9***

incl: rigidez muscular; atrofia, perda muscular; distensão muscular; cansaço muscular
excl: dores de coluna L01, L02, L03; cãibras na perna L14; "dores de crescimento" na criança L29; síndrome das pernas inquietas N04

L20 SINAIS/SINTOMAS DAS ARTICULAÇÕES NE **M25.4, M25.5, M25.6, M25.8, M25.9**

incl: artralgia, derrame articular, dores articulares, articulações rígidas, inchadas, enfraquecidas
excl: articulações especificadas, L07,L08,L10-13,L15-17

L26 MEDO DE CÂNCER DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de câncer do sistema musculoesquelético sem o ser ou até o diagnóstico ser confirmado

L27 MEDO DE DOENÇA DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO, OUTRA ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: receio de um paciente ser portador de doença do aparelho musculoesquelético sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

L28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

excl: quedas A29; mancar N29; dificuldades em andar N29; problemas com a forma de andar N29
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

L29 OUTROS SINAIS/SINTOMAS DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO ***R29.3,R29.8***

incl: "dores de crescimento" na criança; outros sinais, sintomas e condições mal-definidas do sistema musculoesquelético
excl: unhas em baqueta S22

Componente 7 – Diagnóstico/doença

L70 INFECÇÕES DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO ***M00, M01, M46.2 a M46.5, M60.0, M65.0, M65.1, M71.0, M71.1, M86***

incl: Tenossinovite infecciosa; osteomielite; artrite piogênica
excl: doença de Reiter L99, efeitos tardios de poliomielite N70
critérios: infecções localizadas do aparelho musculoesquelético

L71 NEOPLASIA MALIGNA ***C40,C41,C49***

incl: fibrosarcoma; osteossarcoma
excl: neoplasias secundárias (codificar segundo localização primária), neoplasias benignas/não-especificadas L97
critérios: aparência histológica característica

L72 FRATURA: RÁDIO/CÚBITO ***S52***

incl: fratura de Colles
excl: fratura patológica L95, L99; não-união L99
critérios: sinais imagiológicos de fratura, ou traumatismo e deformação visível ou palpável ou crepitação óssea
considerar: sintomas no braço L09; outros traumatismos L81

L73 FRATURA: TÍBIA/PERÔNIO ***S82.1 a S82.9***

incl: fratura de Pott
excl: fratura da rótula L76, fratura patológica L95, L99; não-união L99
critérios: evidência imagiológica de fratura ou trauma, e deformação visível ou palpável, ou crepitação óssea
considerar: sintomas da perna L14, sintomas do tornozelo L16, outros traumatismos L81

L74 FRATURA: OSSO DA MÃO/PÉ ***S62,S92***

incl: carpo, metacarpo; falange da mão; falange do pé; tarso, metatarso
excl: fratura patológica L95,L99; não-consolidação L99
critérios: evidência imagiológica de fratura; traumatismo e deformação visível ou palpável, ou crepitação óssea
considerar: sintomas do braço L09 ou perna L14; outros traumatismos L81

L75 FRATURA: FÊMUR ***S72***

incl: fratura colo do fêmur
excl: fraturas patológicas L95, L99; não-consolidação L99
critérios: evidência imagiológica de fratura; traumatismo e deformação visível ou palpável, ou crepitação óssea
considerar: sintomas da perna L14; outros traumatismos L81

L76 OUTRAS FRATURAS ***S02.0 a S02.4, S02.6 a S02.9, S12, S22, S32, S42, S82.0, T08, T10, T12, T14.2***

incl: todas as fraturas não-especificadas em L72 a L75, N80
excl: fratura patológica L95,L99; não-consolidação L99; fratura craniana N80
critérios: evidência imagiológica de fratura, ou traumatismo e deslocamento visível ou palpável da superfície óssea
considerar: sintomas no Componente 1

L77 TORÇÕES E DISTENSÕES DO TORNOZELO ***S93.4***

critérios: torção traumática da parte afetada e dor agravada pela distensão ou tensão da estrutura afetada
considerar: sintomas do tornozelo L16

L78 TORÇÕES E DISTENSÕES DO JOELHO ***S83.4,S83.6***

excl: lesão aguda do menisco/ligamento interno do joelho L96
critérios: estiramento traumático da parte afetada e dor agravada por distensão ou tensão da estrutura afetada

L79 TORÇÕES E DISTENSÕES DAS ARTICULAÇÕES, NE ***S03.4,S03.5,S13, S23.3 a S23.5,S33.6, S43.4 a S43.7, S53.2 a S53.4, S63.3 a S63.7, S73.1, S93.2, S93.5, S93.6, T14.3***

incl: quaisquer torções e distensões das articulações e ligamentos, exceto tornozelo, joelho e coluna vertebral
excl: tornozelo L77; joelho L78; coluna cervical, traumatismo em chicotada L83; distensão de coluna L84
critérios: estiramento traumático da parte afetada e ainda dores agravadas pela distensão ou tensão da estrutura afetada
considerar: sintomas no Componente 1

L80 LUXAÇÃO E SUBLUXAÇÃO ***M22.0, M22.1, S03.0, S03.3, S13, S23.1, S23.2, S33.1 a S33.3, S43.0 a S43.3, S53.0, S53.1, S63.0 a S63.2, S73.0, S83.0, S83.1, S93.0, S93.1, S93.3, T14.3***

incl: quaisquer luxações e subluxações, incluindo as da coluna vertebral
critérios: lesão da articulação e evidência imagiológica de uma luxação ou subluxação, ou deformação palpável ou visível provocada por luxação
considerar: sintomas na Componente 1
Nota: codificar luxações por fratura em "fraturas"

L81 TRAUMATISMOS DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO NE — ***M79.5, S09.1, S16 a S19, S23.0, S28, S29, S33.0, S33.4, S39, S46 a S49, S56 a S59, S66 a S69, S76 a S79, S86 a S89, S96 a S99, T06.4, T11, T13, T14.6***

incl: corpo estranho profundo; hemartrose; amputação traumática
excl: traumatismo interno torácico, abdominal e da pélvis A81; traumatismo múltiplo A81; efeitos tardios de traumatismo: deformações, incapacidades, cicatrização A82; traumatismos dos dentes D80, e do tímpano H77; não-consolidação, artropatia traumática L91; má consolidação da fratura L99; traumatismo da cabeça, concussão, traumatismo intracraniano, fratura craniana N80; laceração e outros ferimentos dos nervos N81; picada ou mordedura de inseto S12; mordedura de animal S13; equimose, contusão S16; laceração, ferida aberta S18

L82 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS — ***Q65 a Q79***

incl: *genu varum*; pé boto (talipe); luxação congênita do quadril; *genu recurvatum*; malformações do crânio e da face; outras deformações congênitas do pé
excl: escoliose L85; pé chato (adquirido) L98; espinha bífida N85

L83 SÍNDROME DA COLUNA CERVICAL — ***M43.3, M43.4, M43.6, M47.8, M47.9, M48, M50, M53.0, M53.1***

incl: síndromes com ou sem irradiação de dor: lesão do disco cervical; síndrome cervicobraquial; osteoartrite; síndrome radicular dos membros superiores; espondilose; torções e distensões; torcicolo; traumatismo em chicotada

L84 SÍNDROMES DA COLUNA SEM IRRADIAÇÃO DE DOR — ***M43.5, M43.0, M43.1, M46.0, M46.1, M46.8, M46.9, M47.0, M47.8, M47.9, M48, M51, M53.2 a M53.9, S33.5, S33.7***

incl: estiramento da coluna; esmagamento da vértebra NE; degeneração das superfícies articulares; osteoartrose, osteoartrite da coluna; espondilose; espondilolistese
excl: coccidinia L03; síndromes relacionadas com o pescoço L83; dores de coluna com irradiação L86; ciática L86; dores psicogênicas da coluna P75
critérios: dores de coluna sem irradiação com limitação de movimentos, confirmado por exame médico
considerar: sinais/sintomas da coluna L02; lombares L03

L85 DEFORMAÇÃO ADQUIRIDA DA COLUNA — ***M40, M41, M43.8, M43.9***

incl: cifoscoliose; cifose; lordose; escoliose
excl: malformações congênitas L82; espondilite anquilosante L88; espondilolistese L84

L86 SÍNDROME VERTEBRAL COM IRRADIAÇÃO DE DORES ***M47.1, M47.2, M51, M54.3, M54.4***

incl: prolapso ou degeneração do disco; ciática
excl: lesão do disco cervical L83; espondilolistese L84; distensão recente da coluna L84
critérios: dores na região lombar ou torácica da coluna, juntamente com dores irradiadas para uma área específica ou déficit neurológico; ou ciática, uma dor irradiada pela parte de trás da perna, agravada pela tosse, movimentos ou posição; ou identificação de prolapso do disco lombar ou torácico através de técnicas imagiológicas apropriadas ou durante intervenção cirúrgica
Nota: excluir referência a dores vagas
considerar: dores de coluna L02, L03

L87 BURSITE/TENDINITE/SINOVITE NE ***M65.2 a M65.4, M65.8, M65.9, M67.3, M67.4, M70, M71.2 a M71.9, M76, M77.0, M77.2 a M77.9***

incl: esporão ósseo, tendão calcificado, contração de Dupuytren, fasceíte, gânglio ou cisto sinovial, tenossinovite, dedo em gatilho
excl: do ombro L92; cotovelo de tenista, epicondilite externa L93

L88 ARTRITE REUMATOIDE ***M05,M06,M08,M45***

incl: condições associadas: espondilite anquilosante; artrite juvenil
excl: artropatia psoriática S91

L89 OSTEOARTROSE DO QUADRIL ***M16***

incl: osteoartrite; secundária a displasia, traumatismo
critérios: manifestação imagiológica característica; ou perturbações articulares com duração mínima de três meses, sem sintomas constitucionais, e três ou mais das seguintes manifestações: edema intermitente; crepitação; rigidez ou limitação dos movimentos; VS, testes reumatoides, e ácido úrico normais; idade superior a 40 anos
considerar: sintomas nas articulações L20; artrite NE L91

L90 OSTEOARTROSE DO JOELHO ***M17***

incl: osteoartrite, secundária a traumatismo
critérios: manifestação imagiológica característica; ou perturbações das articulações com duração mínima de três meses, sem sintomas constitucionais, e três ou mais das seguintes manifestações: edema intermitente; crepitação; rigidez ou limitação dos movimentos; VS, testes reumatoides e ácido úrico normais; idade superior a 40 anos
considerar: sintomas das articulações L20; artrite NE L91

L91 OUTRAS OSTEOARTROSES ***M13,M15,M18,M19***

incl: artrite NE; nódulos de Heberden; osteoartrite; artropatia traumática
excl: do pescoço L83; da coluna L84; do quadril L89; do joelho L90; do ombro L92
critérios: sinais imagiológicos característicos; ou nódulos de Heberden; ou perturbações das articulações com duração mínima de três meses, sem sintomas constitucionais e três ou mais das seguintes manifestações: edema intermitente; crepitação; rigidez ou limitação dos movimentos; VS, testes reumatoides e ácido úrico normais
considerar: sintomas das articulações L20; artrite NE L91

L92 SÍNDROME DO OMBRO DOLOROSO ***M75***

incl: bursite do ombro; ombro congelado; osteoartrose; síndrome do manguito rotador; sinovite do ombro; tendinite abarticular do ombro
critérios: dor nos ombros, com limitação dos movimentos ou sensibilidade local, crepitação; ou sinais imagiológicos de calcificação periarticular

L93 COTOVELO DE TENISTA ***M77.1***

incl: epicondilite lateral
excl: outras tendinites L87

L94 OSTEOCONDROSE ***M42,M91,M92,M93***

incl: doença de Legg-Calve-Perthes; doença de Osgood/Schlatter; osteocondrite dissecante; doença de Scheuermann; epífise femural deslocada

L95 OSTEOPOROSE ***M80,M81,M82***

incl: fraturas patológicas decorrentes de osteoporose
critérios: sinais imagiológicos característicos

L96 LESÃO INTERNA AGUDA DO JOELHO ***S83.2, S83.3, S83.5, S83.7***

incl: lesão aguda do menisco ou ligamentos cruzados
excl: lesão aguda dos ligamentos colaterais L78, deslocamento do joelho L80, lesão interna crônica do joelho L99
critérios: traumatismo inicial que ocorreu há menos de um mês, e identificação por cirurgia, artroscopia ou imagiologia de rotura do ligamento ou menisco; ou por bloqueio reversível, dor e edema do joelho
considerar: sintomas do joelho L15; torção do joelho L78

L97	NEOPLASIAS BENIGNAS/INCERTAS	*D16,D21,D48.0,D48.1*

incl: neoplasias benignas e não-especificadas do aparelho musculoesquelético
excl: neoplasias malignas L71

L98	MALFORMAÇÃO ADQUIRIDA DE UM MEMBRO	M20,M21

incl: joanete, joelho valgo/varo; *hálux valgo/varo*; dedo em martelo: pés chatos
excl: deformações e malformações congênitas A90,L82

L99	OUTRA DOENÇA DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO	*M02, M03, M07, M09, M11, M12, M14, M22.2 a M22.9, M23, M24, M25.0 a M25.3, M25.7 aM25.9,M32 a M36, M43.2, M49, M54.1, M61, M62.0 a M62.5, M62.8, M62.9, M63, M66, M67.0 a M67.2, M67.8, M67.9, M68, M72, M73, M79.4, M79.8, M84, M85, M87 a M90, M94, M95, M99, T79.6, Z89, Z94.6, Z98.1*

incl: artrodese; perturbação interna crônica do joelho; contraturas; costocondrite; dermatomiosite; perturbações da rótula; má união ou não-união da fratura; miosite; doença óssea de Paget; paniculite; fratura patológica NE; polimialgia reumática; artrite psoriática; doença de Reiter; esclerodermia; síndrome de Sjögren; ruptura espontânea do tendão; lúpus eritematoso sistêmico
excl: hiperuricemia A91; fratura patológica devido a osteoporose L95; paralisia pós-poliomielite N70; paralisia pós-AVC N81; gota T92; pseudogota e artropatia por cristais T99; osteomalacia T99

N – SISTEMA NEUROLÓGICO

Componente 1 – Sinais e sintomas

N01	CEFALEIA	*G44.3,G44.8,R51*

incl: dor de cabeça, dor de cabeça pós-traumática
excl: dores na face N03; enxaqueca N89; cefaleias em cluster N90; cefaleia de tensão N95; nevralgia facial atípica N99; dores dos seios perinasais R09; dor pós-herpética S70

(N02) transferido para N95

N03	DORES DA FACE	*G50.1,R51*

excl: dor de dentes D19, cefaleia N01, enxaqueca N89, nevralgia do trigêmeo N92, dores dos seios perinasais R09, dor pós-herpética S70

N04	SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS	*G25.8*

N05 FORMIGAMENTO/ PARESTESIA NOS DEDOS/MÃOS/PÉS ***R20.2***

incl: sensação de ardor, sensação de picada
excl: dores, sensibilidade da pele S01

N06 OUTRAS ALTERAÇÕES DA SENSIBILIDADE ***R20.0, R20.l, R20.3,R20.8***

incl: anestesia, dormência, parestesia
excl: formigamento N05; dores, sensibilidade da pele S01

N07 CONVULSÕES/ATAQUES ***R56***

incl: convulsões febris, ataques
excl: desmaios A06, acidente isquêmico temporário K89

N08 MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS ANORMAIS ***G25.0 a G25.5, G25.8,G25.9, R25.0, R25.1, R25.3, R25.8***

incl: distonia, crispação (contratura), mioclonia, tremores, espasmos
excl: coreia K71; câibras L12,L14,L17,L18; pernas inquietas N04; convulsões N07; tique doloroso N92; tiques orgânicos N99; tique psicogênico P10

N16 ALTERAÇÕES DO OLFATO/PALADAR ***R43***

incl: anosmia
excl: halitose D20

N17 VERTIGENS/TONTURAS ***R42***

incl: tonturas, sensação de desmaio, sensação de cabeça leve, perda de equilíbrio, estado de aparente embriaguez
excl: síncope A06; perda temporária de consciência A06; enjoo devido ao movimento A88; síndromes vertiginosas específicas H82

N18 PARALISIA/FRAQUEZA ***G98***

incl: paresia
excl: fraqueza geral A04

N19 PERTURBAÇÕES DA FALA ***R47***

incl: afasia, disfasia, disartria, fala enrolada
excl: tartamudez, gagueira P10; atraso da fala P22; rouquidão R23

N26 MEDO DE CÂNCER DO SISTEMA NEUROLÓGICO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de um câncer sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

N27 MEDO DE OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: receio de um paciente ser portador de outra doença neurológica sem o ser ou até o diagnóstico ser confirmado

N28	**LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE**	***Z73.6***

incl: incapacidade decorrente de doenças e perturbações neurológicas
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

N29	**SINAIS/SINTOMAS DO SISTEMA NERVOSO, OUTROS**	***M79.2, R26, R27, R29.0 a R29.2, R29.8***

incl: marcha anormal; claudicação; ataxia; meningismo

Componente 7 – Diagnóstico/doença

N70	**POLIOMIELITE**	***A80,A85.0,B91***

incl: efeitos tardios, síndrome pós-poliomielite, outras infecções enterovirais

N71	**MENINGITE/ENCEFALITE**	***A32.1, A39, A83, A84, A85.1, A85.2, A85.8, A86, A87, B00.3, B00.4, B37.5, B58.2, B94.1, G00, G01 a G05***

excl: encefalomielite miálgica A04
critérios: uma doença febril aguda com resultados anormais do líquido cerebroespinal.
considerar: febre A03, meningismo N29

N72	**TÉTANO**	***A33 a A35***

excl: tetania N08
critérios: rigidez, contrações hipertônicas ou espasmos tetânicos e história de ferimentos anteriores

N73	**OUTRA INFECÇÃO NEUROLÓGICA**	***A81, A88.8, A89, G06 a G09***

incl: abcesso cerebral, infecções por vírus lentos
excl: poliomielite N70; meningite/encefalite N71; polinevrite aguda N94

N74	**NEOPLASIA MALIGNA DO SISTEMA NEUROLÓGICO**	***C47,C70 a C72***

critérios: aspecto histológico característico
considerar: neoplasia não-especificada N76

N75	**NEOPLASIA BENIGNA DO SISTEMA NEUROLÓGICO**	***D32,D33,D36.2***

incl: neurinoma do acústico, meningioma

N76	**NEOPLASIA DO SISTEMA NEUROLÓGICO DE NATUREZA INCERTA**	***D42, D43,D48.2***

excl: neurofibromatose A90

N79	**CONCUSSÃO**	***S06.0***

incl: efeitos tardios
excl: efeitos psicológicos P02
critérios: traumatismo craniano com perda de consciência temporária, frequentemente acompanhada de amnésia, sem contusão cerebral grave
considerar: outras lesões cranianas N80

N80 OUTRAS LESÕES CRANIANAS ***S02.0, S02.1, S06.1 a S06.9, S07, S08, S09.0, S09.7, S09.8***

incl: lesão cerebral com ou sem fratura craniana; contusão cerebral; hemorragia intracerebral traumática; hematoma extradural; hematoma subdural
excl: concussão N79
critérios: traumatismo craniano, com complicações de danos cerebrais

N81 OUTRA LESÃO DO SISTEMA NEUROLÓGICO ***S04, S09.9, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, T06.0 a T06.2, T14.4***

incl: lesão de nervo, lesão da coluna vertebral

N85 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS ***Q00 a Q07***

incl: hidrocefalia, espinha bífida

N86 ESCLEROSE MÚLTIPLA ***G35***

incl: esclerose disseminada
critérios: exacerbações e remissões de manifestação neurológica múltipla com déficits/perturbações distribuídas no tempo e espaço (qualquer combinação de sinais e sintomas neurológicos é possível)
considerar: outros sintomas neurológicos N29

N87 PARKINSONISMO ***G20,G21,G22***

incl: induzido pela medicação; paralisia agitante; doença de Parkinson
critérios: pobreza e lentidão dos movimentos voluntários, tremores em repouso que melhoram com movimentos ativos e rigidez muscular
considerar: movimentos involuntários anormais N08, perturbação da fala N19

N88 EPILEPSIA ***G40,G41***

incl: todos os tipos de epilepsia, crises focais, crises generalizadas, grande mal, pequeno mal, estado epiléptico
critérios: episódios recorrentes de alteração súbita da consciência, com ou sem crises/movimentos tônicos ou clônicos e testemunho ocular da crise, ou alteração característica do eletroencefalograma (EEG)
considerar: convulsões N07, outros sintomas neurológicos N29

N89 ENXAQUECA ***G43,G44.1***

incl: dor de cabeça vascular
excl: cefaleias em cluster N90, cefaleia de tensão N95
critérios: episódios recorrentes de cefaleias unilaterais, náusea ou vômitos, aura, outros sintomas neurológicos, história familiar de enxaqueca
considerar: cefaleia N01

N90 CEFALEIA DE CLUSTER ***G44.0***

excl: enxaqueca N89
critérios: crises de dores severas, frequentemente lancinantes, unilaterais, periorbitárias e/ou temporais, repetindo-se até 8 vezes por dia, por vezes associadas a injeção conjuntival, lacrimejo, congestão nasal, rinorreia, suores, miose, ptose, ou edema da pálpebra. As crises surgem em salva que se prolongam por semanas ou meses, interrompidas por períodos de remissão de meses ou até anos.

N91 PARALISIA FACIAL/PARALISIA DE BELL ***G51***

critérios: paralisia unilateral aguda dos músculos de expressão facial sem perda sensorial
considerar: paralisia, fraqueza N18

N92 NEVRALGIA DO TRIGÊMEO ***G50.0, G50.8, G50.9***

incl: tique doloroso
excl: nevralgia pós-herpética S70
Critérios: paroxismos unilaterais de dor ardente facial, agravada ao palpar pontos gatilho, assoar o nariz ou bocejar, sem paralisia sensorial ou motora
considerar: nevralgia NE N99

N93 SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO ***G56.0***

critérios: perda ou enfraquecimento do tato, afetando o polegar, indicador e dedo do meio, podendo atingir o dedo anelar ou não. Disestesia e dores que se intensificam normalmente durante a noite e podem irradiar ao antebraço.
considerar: perturbações sensoriais N06

N94 NEURITE/NEVRITE/NEUROPATIA PERIFÉRICA ***G54, G55, G56.1 a G56.4, G56.8, G56.9, G57 a G64***

incl: polineuropatia infecciosa aguda, neuropatia diabética, síndrome de Guillain-Barré, lesão do nervo, neuropatia
excl: pós-herpética S70
critérios: alterações sensoriais, reflexivas e motoras, cingidas ao espaço dos nervos individuais, por vezes sem causa aparente, por vezes secundárias a uma doença específica, por exemplo diabetes

N95 CEFALEIA TENSIONAL ***G44.2***

excl: enxaqueca N89; cefaleia de cluster N90
critérios: dor de cabeça latejante, generalizada, associada ao estresse e à tensão muscular com ou sem a sensibilidade aumentada dos músculos pericranianos
considerar: cefaleia N01

N99 DOENÇAS DO SISTEMA NEUROLÓGICO, OUTRAS ***E51.2, G10 a G13,G23, G24, G26, G31.0, G31.8, G31.9, G32, G36, G37, G52, G53.1 a G53.3, G53.8, G70 a G73,G80 a G83, G90 a G92, G93.0 a G93.2, G93.4 to G93.9, G94 a G96, G98, G99, M79.2, Z98.2***

incl: paralisia cerebral, doença do neurônio motor, miastenia gravis, nevralgia NE, membro-fantasma
excl: apneia do sono P06

P – PSICOLÓGICO

Componente 1 – Sinais e sintomas

P01 SENSAÇÃO DE ANSIEDADE/NERVOSISMO/TENSÃO ***R45.0***

incl: ansiedade NE, sentir-se ameaçado
excl: perturbação de ansiedade P74
critérios: sentimentos relatados pelo paciente como uma experiência emocional ou psicológica não atribuída a uma perturbação mental. Verifica-se uma transição gradual de sentimentos indesejáveis – porém, mais ou menos normais – em relação a sentimentos tão perturbadores para o paciente, que o levam a procurar ajuda de um profissional

P02 REAÇÃO AGUDA AO ESTRESSE ***F43.0, F43.2, F43.8, F43.9, F50.4***

incl: choque de adaptação, choque cultural, estresse, pesar, saudade, estresse pós-traumático imediato, choque (psíquico)
excl: depressão P03, perturbação depressiva P76, perturbação depressiva pós-traumática P82
critérios: reação a um acontecimento que provoca estresse ou a uma mudança significativa de vida que exige uma adaptação considerável, quer como uma reação esperada ao acontecimento ou como uma reação de má adaptação que interfere com a vida quotidiana e resulta num mau funcionamento social, com recuperação dentro de um período de tempo limitado.

P03 TRISTEZA/ SENSAÇÃO DE DEPRESSÃO ***R45.2,R45.3***

incl: sentir-se pouco à vontade, só, infeliz, preocupado
excl: perturbação depressiva P76
critérios: sentimentos relatados pelo paciente como uma experiência emocional ou psicológica não atribuída a uma perturbação mental. Verifica-se uma transição gradual de sentimentos indesejáveis – porém mais ou menos normais – em relação a sentimentos que são tão perturbadores para o paciente, que o levam a procurar ajuda de um profissional.

P04 SENTIR-SE/COMPORTAR-SE DE FORMA IRRITÁVEL/ZANGADA ***R45.1, R45.4, R45.5, R45.6***

incl: agitação NE, desassossego NE
excl: criança hiperativa P21, irritabilidade de um elemento da família Z13
critérios: sentimentos relatados pelo paciente como uma experiência emocional ou psicológica não atribuída a uma perturbação mental. Verifica-se uma transição gradual de sentimentos indesejáveis – porém mais ou menos normais – em relação a sentimentos que são tão perturbadores para o paciente, que o levam a procurar ajuda de um profissional.

P05 SENSAÇÃO/COMPORTAMENTO SENIL ***R54***

incl: preocupação com o envelhecimento, senescência
critérios: sentimentos relatados pelo paciente como uma experiência emocional ou psicológica não atribuída a uma perturbação mental. Verifica-se uma transição gradual de sentimentos indesejáveis – porém mais ou menos normais – em relação a sentimentos que são tão perturbadores para o paciente, que o levam a procurar ajuda de um profissional.

P06 PERTURBAÇÃO DO SONO ***F51,G47***

incl: insônia, pesadelos, apneia do sono, sonambulismo, sonolência
excl: cansaço provocado pelas viagens e diferença de fuso horário A88
critérios: a perturbação do sono como diagnóstico requer que o problema de sono seja uma queixa importante que, segundo o paciente e o profissional, não seja causada por outra perturbação, mas seja antes um problema em si mesmo. A insônia requer uma deficiência qualitativa ou quantitativa do sono, o qual é considerado pelo paciente como insatisfatório, ao longo de um período de tempo significativo. A hipersônia caracteriza-se por uma sonolência exagerada durante o dia e ataques de sono que perturbam o desempenho do paciente.

P07 DIMINUIÇÃO DO DESEJO SEXUAL ***F52.0***

incl: frigidez, diminuição da libido
excl: impotência P08, não satisfação sexual P08, preocupação sobre a preferência sexual P09
critérios: problemas sexuais relativos ao desejo, não atribuíveis a qualquer perturbação ou doença orgânica, mas um reflexo da incapacidade do paciente de participar na relação sexual por falta de desejo, não-funcionamento ou ausência de resposta genital.

P08 DIMINUIÇÃO DA SATISFAÇÃO SEXUAL ***F52.9***

incl: impotência não-orgânica ou dispareunia, ejaculação precoce, vaginismo de origem psicogénica
excl: problemas de desejo sexual P07, preocupação com a preferência sexual P09, impotência orgânica e problemas sexuais Y07, vaginismo NE X04
critérios: problemas sexuais relativos à satisfação, não atribuíveis a qualquer perturbação ou doença orgânica, mas a um reflexo da incapacidade do paciente de participar na relação sexual, que o próprio deseja, por insuficiência de funcionamento ou de resposta genital, ou problemas com o desenvolvimento sexual

P09 PREOCUPAÇÃO COM A PREFERÊNCIA SEXUAL ***F64 a F66***

excl: problemas de desejo sexual P07 ou de satisfação sexual P08
critérios: problemas sexuais relativos à preferência, não causados por qualquer perturbação ou doença orgânica, mas um reflexo da incapacidade do paciente de participar da relação sexual, que ele próprio deseja, por problemas com a orientação, a preferência ou a identidade sexual

P10 GAGUEJAR, BALBUCIAR, TIQUES ***F95, F98.4, F98.5, F98.6***

excl: tique doloroso N92
critérios: gagueira e balbuciar: perturbação da fala caracterizada por repetições frequentes ou prolongamentos de sons, ou por hesitações constantes que tornam o discurso pouco fluente

P11 PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA ***F98.2,F98.3***

incl: problemas de alimentação, problemas com o comportamento alimentar das crianças
excl: anorexia nervosa P86, problemas de alimentação dos adultos T05
Nota: Problemas relacionados com o comportamento das crianças são especialmente difíceis de classificar, por isso estão distribuídos por quatro capítulos da CIAP. O fato de os pais apresentarem ou não estes problemas ao clínico geral reflete a sua opinião acerca do que é um comportamento normal – embora incômodo – e um comportamento considerado preocupante ou "patológico".

P12 URINAR NA CAMA, ENURESE ***F98.0***

excl: devido a perturbações orgânicas U04
critérios: emissão involuntária de urina durante o dia ou durante a noite e não atribuível a qualquer causa orgânica.
Nota: Problemas relacionados com o comportamento das crianças são especialmente difíceis de serem classificados, por isso estão distribuídos por quatro capítulos da CIAP. O fato de os pais apresentarem ou não esses problemas ao clínico geral reflete a sua opinião acerca do que é um comportamento normal – embora incômodo – e um comportamento considerado preocupante ou "patológico"

P13 ENCOPRESE/OUTROS PROBLEMAS DE INCONTINÊNCIA FECAL ***F98.1***

critérios: a encoprese requer uma emissão frequente de fezes moldadas em locais impróprios, considerada anormal para a idade, e não causada por obstipação, dificuldades de controle do esfíncter ou outra doença

P15 ABUSO CRÔNICO DO ÁLCOOL ***F10.1 a F10.9***

incl: alcoolismo, síndromes alcoólicas do cérebro, psicose alcoólica, *delirium tremens*
critérios: perturbação devida ao consumo do álcool e que resulta em um ou mais episódios clínicos de grave prejuízo para a saúde, dependência, estado de privação ou distúrbios psicóticos

P16 ABUSO AGUDO DO ÁLCOOL ***F10.0***

incl: embriaguez
critérios: perturbação devida ao consumo de álcool que leva a intoxicações agudas, com ou sem uma história de abuso crônico

P17 ABUSO DO TABACO ***F17***

incl: problemas de tabagismo
critérios: perturbação devida ao consumo de tabaco que leva a uma ou mais intoxicações agudas, uso com prejuízo clinicamente grave para a saúde, dependência ou estado de privação
considerar: fatores de risco NE A23
Nota: Abuso de substâncias
As definições de abuso de substâncias devem levar em conta as diferenças de país para país e de cultura para cultura. Um paciente alcoólatra ou um tóxico-dependente precisa de atenção por profissional da saúde, mas as definições de "abuso de tabaco" são controversas. O profissional pode decidir chamar um episódio de "abuso de tabaco" sem a concordância do paciente e, consequentemente, sem a sua predisposição para concordar com qualquer intervenção

P18 ABUSO DE MEDICAÇÃO ***F13,F19,F55***

incl: qualquer droga prescrita
Nota: Abuso de substâncias
As definições de abuso de substâncias devem levar em conta as diferenças de país para país e de cultura para cultura. Um paciente alcoólatra ou um tóxico-dependente precisa de atenção por profissional da saúde, mas alguns pacientes pedem e tomam tranquilizantes, comprimidos para dormir, anoréticos e laxativos inadequadamente e por muito tempo. Nesses casos, o profissional pode chamar o episódio de "abuso de medicação" sem o acordo do paciente e, consequentemente, sem a sua predisposição para concordar com qualquer intervenção

P19 ABUSO DE DROGAS ***F11 a F16,F18,F19***

incl: dependência de drogas, privação de drogas
critérios: perturbação devida ao abuso de substâncias psicoativas que provocam dependência e que leva a uma ou mais das situações seguintes:

- intoxicação aguda
- uso abusivo com prejuízo clinicamente grave para a saúde
- dependência
- estado de privação
- distúrbios psicóticos

Nota: Abuso de substâncias

As definições de abuso de substâncias devem levar em conta as diferenças de país para país e de cultura para cultura. Um paciente alcoólatra ou um tóxico-dependente precisa de atenção por profissional da saúde, mas as definições de "abuso de haxixe" são controversas. Alguns pacientes pedem e tomam tranquilizantes, comprimidos para dormir, anoréticos e laxativos inadequadamente e por muito tempo. Nesses casos, o profissional pode chamar o episódio de "abuso de drogas" sem o acordo do paciente e, consequentemente, sem a sua predisposição para concordar com qualquer intervenção

P20 ALTERAÇÕES DA MEMÓRIA ***R41***

incl: amnésia; dificuldade de concentração; desorientação

P22 SINAIS/SINTOMAS DO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA ***F91 a F94, F98.8, F98.9***

incl: atraso de uma etapa do desenvolvimento; ciúme; criança excessivamente ativa; atraso da fala; crise de ira
excl: adolescente P23; adulto P80; preocupação com o desenvolvimento físico T10; atraso de crescimento T10

P23 SINAIS/SINTOMAS DO COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE ***F91, F92, F94, F98.8,F98.9***

incl: delinquência
excl: criança P22, P81; adulto P80

P24 DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM ***F80 a F83,R48***

incl: dislexia
excl: dificuldades em manter a atenção P81, atraso mental P85
critérios: dificuldades de aprendizagem da fala ou da linguagem, com início na infância, juntamente com deficiências de funcionamento ligadas à maturação biológica do sistema nervoso central, e um estado estável ao longo do tempo sem remissões ou recaídas espontâneas, embora as dificuldades possam diminuir à medida que a criança cresce.

P25 PROBLEMAS EM UMA FASE DA VIDA DE UM ADULTO ***Z60.0***

incl: Síndrome do "ninho vazio", crise da meia-idade, problemas decorrentes de inovações e mudanças
excl: senilidade, sentir-se/comportar-se como velho P05; menopausa X11

P27 MEDO DE PERTURBAÇÕES MENTAIS ***Z71.1***

incl: preocupação com doenças mentais, medo de tentativa de suicídio
excl: se o paciente tem essa doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de doenças mentais sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

P28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

incl: limitação funcional/incapacidade como resultado de perturbações psicológicas
excl: autoestima fraca P03
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

P29 SINAIS/SINTOMAS PSICOLÓGICOS, OUTROS ***F50.8, F50.9, F98.8, F98.9, R44, R45.7, R45.8, R46, Z64.2, Z64.3, Z73.0, Z73.1***

incl: delírios, problemas alimentares NE, alucinações, sinais/sintomas psicológicos múltiplos, falta de higiene, comportamentos estranhos, desconfiança
excl: cefaleia de tensão N95

Componente 7 – Diagnóstico/doença

Nota: Um distúrbio mental é uma síndrome psicológica ou padrão clinicamente significativo, quer esteja associado ou não a fatores de estresse (como incapacidades, aumento de riscos ou uma perda importante), que não pode ser considerado uma reação esperada a determinado acontecimento, mas antes uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica

P70 DEMÊNCIA ***F00 a F03, G30***

incl: doença de Alzheimer, demência senil
critérios: síndrome decorrente de uma doença do cérebro, geralmente de natureza crônica e/ou progressiva, com perturbações clinicamente significativas das funções do córtex superior (memória, pensamento, orientação, compreensão), mas sem afetar a consciência.
considerar: senilidade P05, outros sintomas psicológicos P29

P71 OUTRAS PSICOSES ORGÂNICAS NE ***F04 a F07, F09***

incl: *delirium*
excl: origem alcoólica P15, psicose não-especificada P98
critérios: distúrbios psiquiátricos orgânicos como diagnóstico exigem síndromes psicológicos ou comportamentos devidos a uma doença orgânica.

P72 ESQUIZOFRENIA ***F20 a F25,F28,F29***

incl: todos os tipos de esquizofrenia, paranoia
critérios: distorções fundamentais e características do pensamento, percepção e afetos que são inadequados ou enevoados (por exemplo, pensamento-eco, inserção, retirada, percepções delirantes, vozes alucinatórias, delírios de controle), mas com perfeita consciência e sem alteração da capacidade intelectual
considerar: psicose não-especificada P98

P73 PSICOSE AFETIVA ***F30,F31,F34.0***

incl: distúrbio bipolar, hipomania, mania, depressão maníaca
excl: depressão P76
critérios: distúrbio fundamental dos afetos e do humor, alternadamente excitado e deprimido (associado ou não a ansiedade). Na perturbação maníaca, a energia e a atividade estão simultaneamente estimuladas. Na doença bipolar, observam-se pelo menos dois períodos de perturbação do humor variando do excitado ao deprimido
considerar: psicose não-especificada P98

P74 DISTÚRBIO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE ***F41.0, F41.1, F41.3 a F41.9***

incl: neurose ansiosa, pânico
excl: ansiedade com depressão P76, ansiedade NE P01
critérios: ansiedade clinicamente significativa que não se restringe a nenhum ambiente ou situação específica. Manifesta-se como episódios de pânico (ataques recorrentes de extrema ansiedade não limitada a nenhuma situação, com ou sem sintomas físicos) ou como uma ansiedade generalizada e persistente, não associada a nenhuma situação específica e com sintomas físicos variáveis
considerar: ansiedade, nervosismo, tensão P01

P75 SOMATIZAÇÃO ***F44,F45***

incl: distúrbios de conversão, hipocondria, histeria, pseudociese
critérios: a somatização caracteriza-se por uma preocupação com a apresentação repetida de sintomas e queixas físicas, assim como pedidos insistentes de exames médicos, apesar de vários resultados negativos e garantias por parte dos médicos. Esta requer a apresentação ao médico de família e comunidade ou profissional da saúde de sintomas físicos múltiplos, recorrentes e sempre diferentes durante um período de pelo menos um ano. A hipocondria requer uma preocupação persistente com a aparência física ou com a possibilidade de uma doença grave, além de queixas somáticas constantes durante um período de pelo menos um ano, apesar de vários resultados negativos e garantias por parte dos profissionais.
Notas: A somatização é a apresentação repetida de sintomas físicos e de queixas sugestivas de distúrbios físicos não confirmados por resultados orgânicos visíveis ou mecanismos fisiológicos, e para os quais existe evidência positiva de ligação a fatores psicológicos, não sentindo o paciente uma sensação de controle na produção desses sintomas ao lidar com os fatores psicológicos.
Sinais e sintomas físicos que incluam dor e sejam apresentados como se fossem devidos a perturbações físicas de um sistema/órgão sob controle do sistema nervoso autônomo, ou que consistam em uma dor contínua e incômoda/grave não explicável por perturbações/processos psicológicos, são codificados como um diagnóstico de sinais/sintomas representativos da vertente física e, se possível, com um código que represente o problema emocional ou psicológico com o qual estão associados.
A definição de somatização no CID-10 (mínimo 2 anos) é demasiado rígida para ser usada na atenção primária à saúde.

P76 PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS ***F32, F33, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F39, F41.2, F53.0***

incl: psicose afetiva NE; neurose depressiva; psicose depressiva; misto de ansiedade e depressão; depressão reativa; depressão pós-natal/puerperal
excl: reação aguda ao estresse P02
critérios: distúrbio importante do estado de espírito no sentido da depressão. O estado de espírito, a energia e a atividade diminuem, assim como diminui a alegria, o interesse e a concentração. O sono e o apetite são normalmente alterados e a autoestima e a confiança diminuem
considerar: sensação de depressão P03

P77 SUICÍDIO/TENTATIVA DE SUICÍDIO ***F99***

incl: gesto suicida; tentativa sucedida (código duplo com A96)
excl: medo de tentativa de suicídio P27

P78 NEURASTENIA, SURMENAGE ***F48.0***

critérios: fadiga crescente com associações desagradáveis, dificuldades de concentração e um decréscimo constante do desempenho e da eficiência; a sensação de cansaço físico e de exaustão depois de um esforço mental ou um esforço físico mínimo é muitas vezes acompanhada de dores musculares e de uma incapacidade de relaxar
considerar: fadiga A04, fadiga pós-viral A04, fadiga crônica A04

P79 FOBIA, PERTURBAÇÃO COMPULSIVA ***F40, F42, F48.1, F48.8, F48.9***

incl: Fobias, perturbações obsessivo-compulsivas
critérios: a ansiedade fóbica exige a expressão dessa ansiedade em voz alta, feita apenas em situações bem definidas e não consideradas perigosas: o paciente tenta evitar estas situações ou suporta-as com terror.
A perturbação obsessivo-compulsiva requer pensamentos obsessivos recorrentes e perturbantes ou atos reconhecidos pelo paciente como sendo seus; comportamentos compulsivos estereotipados repetem-se sucessivamente a fim de evitar um acontecimento não desejável, embora o próprio paciente reconheça que eles são infrutíferos e pouco eficazes.

P80 ALTERAÇÕES DA PERSONALIDADE ***F60 a F63, F68, F69, Z76.5***

incl: psicopatia, neurose de compensação, síndrome de Munchausen, perturbações de comportamento em um adulto
critérios: estados e padrões de comportamento clinicamente relevantes do estilo de vida de um indivíduo e da sua forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros, refletindo desvios significativos ou graves da forma como a maioria dos indivíduos dessa cultura percebe, sente e se comporta. Este padrão está profundamente incorporado e é de longa duração.

P81 PERTURBAÇÃO HIPERCINÉTICA ***F90***

incl: falta de atenção, hiperatividade
excl: início na adolescência P23, problemas de aprendizagem P24
critérios: falta de persistência, de início precoce, ao realizar atividades que exigem envolvimento cognitivo, com tendência em saltar de uma atividade para outra sem completar nenhuma, com comportamento desorganizado e débil e atividade excessiva.
considerar: criança hiperativa P22

P82 ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO ***F43.1***

incl: perturbação persistente da adaptação
critérios: um acontecimento estressante seguido de estados de perturbação e de angústia graves, com uma reação diferida ou prolongada, *flashbacks*, pesadelos, embotamento emocional, anedonia interferindo com o desempenho e o funcionamento social, e incluindo estados depressivos, ansiedade, preocupação e um sentimento de incapacidade em lidar com a situação que persiste ao longo do tempo.
considerar: reação de estresse aguda P02, ansiedade P01, depressão P03

P85 RETARDO/ ATRASO MENTAL ***F70 a F79***

excl: devido a malformações congênitas A90
critérios: interrupção do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do pensamento com impedimento de certas competências durante o período de desenvolvimento, fraco nível de inteligência, com ou sem perturbações comportamentais.

P86 ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA ***F50.0, F50.2, F50.3, F50.4***

critérios: Anorexia Nervosa: perda de peso provocada e mantida deliberadamente pelo paciente, associada a um medo exagerado e supervalorizado da gordura e da flacidez.
Bulimia: ataques repetidos de fome em que se come demais e uma preocupação excessiva com o peso, o que leva a um comportamento padrão de excesso de comida seguido de vômitos provocados ou recurso a purgativos.
considerar: distúrbios alimentares, recusa em comer P11, P29; dificuldades em comer T04,T05

P98 OUTRAS PSICOSES NE ***F23,F53.1***

incl: psicose reativa, psicose puerperal

P99 OUTRAS PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS ***F53.8, F53.9, F54, F59, F84, F88, F89, F99***

incl: autismo; doença mental não-especificada; neurose NE

R – APARELHO RESPIRATÓRIO

Componente 1 – Sinais e sintomas

R01 DOR ATRIBUÍDA AO APARELHO RESPIRATÓRIO ***R07.1***

incl: respiração com dores, dores pleuríticas, pleurodinia
excl: dor no tórax A11, dor no tórax (musculoesquelético) LO4, dores nasais RO8, dor nos seios perinasais RO9, garganta irritada R21, pleurisia R82, sensação de tórax apertado R29

R02 DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA ***R06.0***

incl: ortopneia
excl: respiração ruidosa RO3, estridor R04, hiperventilação R98

R03 RESPIRAÇÃO RUIDOSA ***R06.2***

incl: inspiração ruidosa ou estridor
excl: dispneia R02, estridor R04, hiperventilação R98

R04 OUTROS PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS ***R06.1, R06.3, R06.5, R06.8***

incl: respiração anormal, apneia, interrupção da respiração, dificuldades respiratórias, ressonar, estridor, taquipneia
excl: apneia do sono P06, dores respiratórias R01, dispneia R02, respiração ruidosa R03, tosse R05, hiperventilação R98

R05 TOSSE ***R05***

incl: tosse (seca ou úmida)
excl: expectoração ou muco R25

R06 HEMORRAGIA NASAL/EPISTAXE ***R04.0***

R07 ESPIRRO/CONGESTÃO NASAL ***R06.7***

incl: nariz tapado, rinorreia, corrimento nasal

R08 OUTROS SINAIS/SINTOMAS NASAIS ***J34.8***

incl: dores nasais, gotejamento pós-nasal, nariz inchado, nariz vermelho
excl: anosmia N16, epistaxe R06, nariz tapado R07, espirros R07, queixas dos seios perinasais R09, rinofima S99

R09 SINAIS/SINTOMAS DOS SEIOS PERINASAIS ***J34.8***

incl: seios perinasais obstruídos, seios perinasais congestionados, dor ou pressão nos seios perinasais
excl: cefaleias N01, dores na face N03, congestão nasal R07

R21 SINAIS/SINTOMAS DA GARGANTA ***R07.0,R09.8***

incl: garganta seca, garganta inflamada, amígdalas dilatadas, sensação de aperto na garganta, vermelhidão da garganta, garganta irritada, dor nas amígdalas
excl: sintomas relativos à voz R23, hipertrofia das amígdalas R90

(R22) suprimido, incluído no R21

R23 SINAIS/SINTOMAS DA VOZ ***R49***

incl: disfonia, afonia, rouquidão
excl: perturbações neurológicas da fala N19, gagueira/tiques P10, garganta irritada R21

R24 HEMOPTISE ***R04.2***

incl: tosse com sangue

R25 EXPECTORAÇÃO/MUCOSIDADE ANORMAL ***R09.3***

excl: tosse com expectoração R05, hemoptise R24

R26 MEDO DE CÂNCER DO APARELHO RESPIRATÓRIO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de câncer do aparelho respiratório sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

R27 MEDO DE OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: um medo excessivo de outras doenças respiratórias em um paciente que não é portador de uma, ou até o diagnóstico ser confirmado

R28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6,Z93.0,Z99.1***

incl: incapacidade devido a hipóxia, hipercapnia, funcionamento reduzido dos pulmões, doenças respiratórias, ou devido a problemas nasais, da laringe ou da garganta
excl: dispneia R02, espirros R03
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

R29 SINAIS/SINTOMAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO, OUTROS ***R04.1, R04.8, R04.9, R06.6, R09.0, R09.2, R09.8***

incl: sensação de tórax apertado, fluidos nos pulmões, soluços, congestão dos pulmões, outros sintomas ou queixas do aparelho respiratório
excl: dor R01, problemas respiratórios R02/R03/R04, tosse R05, sintomas do nariz ou dos seios perinasais R06/R07/R08/R09, sintomas da garganta R21/R22/R23, expectoração anormal R24/R25

Componente 7 – Diagnóstico/doença

(R70) suprimido, incluído no A70

R71 TOSSE CONVULSA/ PERTUSSIS ***A37***

incl: parapertussis, pertussis
excl: crupe R77
critérios: infecção respiratória com tosse paroxística entrecortada característica, terminando com uma contração inspiratória de som agudo, ou infecção respiratória com tosse durante pelo menos três semanas em contato com tosse convulsa conhecida, ou demonstração de Pertussis bordetella ou parapertussis
considerar: tosse R05, infecção do aparelho respiratório superior R74

R72 INFECÇÃO ESTREPTOCÓCICA DA OROFARINGE ***J02.0,J03.0***

incl: tonsilite ou faringite estreptocócica confirmadas
excl: escarlatina A78; erisipela, infecção estreptocócica da pele S76
critérios: inflamação aguda da garganta, além de prova de estreptococos beta-hemolíticos
considerar: tonsilite R76

R73 ABCESSO NO NARIZ, FURÚNCULO NO NARIZ ***J34.0***

incl: infecção localizada no nariz
excl: sinusite aguda A75

R74 INFECÇÃO AGUDA DO APARELHO RESPIRATÓRIO SUPERIOR (IVAS) ***B00.2, B08.5, J00, J02.8, J02.9, J06***

incl: rinite aguda, coriza, resfriado, nasofaringite, faringite, infecção do trato respiratório inferior, infecção do trato respiratório superior
excl: sarampo A71, mononucleose infecciosa A75, faringoconjuntivite viral F70, sinusite R75, amigdalite R76, esquinência R76, laringite R77, crupe R77, gripe R80, rinite alérgica R97, faringite crônica R99
critérios: evidência de inflamação aguda nasal ou da mucosa faríngea com ausência de critérios que permitam a definição específica de uma infecção respiratória aguda, classificada nesta seção.

R75 SINUSITE CRÔNICA/AGUDA ***J01,J32***

incl: sinusite que afete qualquer seio perinasal
critérios: secreção nasal ou pós-nasal purulenta, ou episódios anteriores de sinusite medicamente tratada, além de sensibilidade na zona de um ou mais seios perinasais, ou dores faciais profundas agravadas com a cabeça pendente, ou opacidade à transiluminação; evidência imagiológica de sinusite; ou pus proveniente dos seios perinasais
considerar: cefaleia N01, dores faciais N03, infecção do aparelho respiratório superior R74

R76 AMIGDALITE AGUDA ***J03.8,J03.9,J36***

incl: abcesso peritonsilar, esquinência
excl: mononucleose infecciosa A75, infecção estreptocócica da garganta R72, difteria R83, hipertrofia ou infecção crônica das amígdalas R90
critérios: garganta inflamada ou febre com hiperemia das amígdalas mais do que da parede posterior da faringe, e pus na(s) amígdala(s) dilatadas ou gânglios regionais aumentados e sensíveis
considerar: infecção aguda do aparelho respiratório superior R74

R77 LARINGITE/TRAQUEÍTE AGUDA ***J04, J05***

incl: crupe
excl: laringotraqueíte R78, epiglotite R83
critérios: rouquidão ou estridor com ou sem dificuldade respiratória, ou tosse seca e profunda que provoca dor, "tosse de cachorro" nas crianças, não apresentando o tórax qualquer sinal anormal
considerar: infecção do aparelho respiratório superior R74

R78 BRONQUITE/BRONQUIOLITE AGUDA ***J20 a J22, J40***

incl: infecção aguda do aparelho respiratório inferior NE; bronquite NE; infecção do tórax NE; laringotraqueobronquite; traqueobronquite
excl: gripe R80, bronquite crônica R91, bronquite alérgica R96
critérios: em crianças e adultos, tosse e febre com sinais do tórax anormais, em parte ou em geral – respiração ruidosa, estertor rouco e úmido, roncos. Em crianças pequenas (bronquiolite) dispneia e hiperinsuflação
considerar: respiração ruidosa R03, tosse R05, infecção respiratória superior R74

R79 BRONQUITE CRÔNICA ***J41,J42***

excl: enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica (pulmão, vias respiratórias) R95; bronquiectasias R99
critérios: tosse com expectoração quase diária durante pelo menos 3 meses/ano durante pelo menos 2 anos; estridor ou roncos na auscultação do tórax durante esses episódios
considerar: tosse R05; expectoração/mucosidade anormais R25; bronquite NE R78,

R80 GRIPE ***J10.1, J10.8, J11.1, J11.8***

incl: doença do tipo da influenza, parainfluenza
excl: gripe gástrica D70, gripe pneumônica R81
critérios: mialgia e tosse sem outros sinais físicos respiratórios anormais que não a inflamação da membrana da mucosa nasal e da garganta, além de três ou mais dos seguintes fenômenos: início repentino (12 horas ou menos), tremores, arrepios ou febre, prostração e fraqueza, contatos próximos com gripe ou epidemia de gripe; ou cultura viral ou evidência serológica de infecção pelo vírus da gripe
considerar: febre A03; infecção viral NE A77; infecção do aparelho respiratório superior R74

R81 PNEUMONIA ***A48.1, J10.0, J11.0, J12 a J18***

incl: pneumonia bacteriana e viral; broncopneumonia; pneumonia da gripe; doença dos legionários, pneumonite
excl: pneumonia de aspiração R99,
critérios: evidência de consolidação pulmonar
considerar: tosse R05; bronquite NE R78

R82 PLEURITE/DERRAME PLEURAL ***J90, J91, J94, R09.1***

incl: exsudado inflamatório pleural, pleurite
excl: tuberculose R70, pneumonia R81, derrame maligno (codificar na origem da malignidade)
critérios: evidência clínica de exsudado pleural; ou dor pleurítica acompanhada de atrito de fricção pleural; ou evidência de exsudado inflamatório pleural
considerar: dores pleuríticas R01

R83 OUTRA INFECÇÃO RESPIRATÓRIA ***A36, B37.1, B44, B58.3, J31, J37, J85, J86***

incl: nasofaringite crônica; faringite crônica; rinite crônica NE; infecções respiratórias por fungos; infecções por protozoários (sem pneumonia); abcesso no pulmão; difteria; epiglotite; empiema
excl: fibrose quística T99

R84 NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS/PULMÃO ***C33,C34***

incl: malignidade na traqueia, brônquios, pulmão ou pleura
excl: localização não identificada A79; malignidade secundária de origem identificada (codificar no respectivo local)
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia de natureza incerta R92

R85 OUTRA NEOPLASIA RESPIRATÓRIA MALIGNA ***C09 a C13, C14.0 a C14.2, C30.0, C31, C32, C38.4, C39, C45.0***

incl: malignidade na laringe, mediastino, nariz, faringe, seios perinasais; mesotelioma
excl: doença de Hodgkin B72, malignidade da traqueia, dos brônquios, da pleura ou do pulmão R84
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia de natureza incerta R92

R86 NEOPLASIA BENIGNA RESPIRATÓRIA ***D14,D19***

incl: neoplasias benignas do aparelho respiratório
excl: neoplasia de natureza incerta R92, pólipo nasal R99
critérios: aparência clínica ou histológica característica
considerar: neoplasias de natureza incerta R92

R87 CORPO ESTRANHO NO NARIZ/LARINGE/BRÔNQUIOS ***T17***

incl: corpo estranho nos brônquios, laringe, pulmão ou nariz
excl: afogamento A88, corpo estranho alojado no esôfago D79, corpo estranho no ouvido H76, pneumonia de aspiração R99
critérios: visualização do corpo estranho de forma direta, endoscópica ou imagiológica
considerar: outras queixas do sistema respiratório R29

R88 OUTRA LESÃO RESPIRATÓRIA ***S00.3, S03.1, S27, T27, T70.1***

incl: todas as lesões e traumatismos do nariz (exceto fratura) e do aparelho respiratório; enfisema cirúrgico
excl: afogamento A88, fratura do nariz L76, corpo estranho R87

R89 MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO APARELHO RESPIRATÓRIO ***Q30 a Q34***

incl: malformação congênita do nariz, faringe, traqueia, laringe, brônquios, pulmões ou pleura
excl: fissura no lábio ou palato D81, fibrose cística T99

R90 HIPERTROFIA DAS AMÍGDALAS/ADENOIDES ***J35***

incl: amigdalite crônica
excl: amigdalite aguda R76, rinite alérgica R97

(R91) alterado para R79

R92 NEOPLASIA RESPIRATÓRIA DE NATUREZA DESCONHECIDA ***D02,D38***

incl: incerteza quanto à malignidade ou à benignidade
excl: neoplasia secundária de localização desconhecida A79; neoplasias malignas R84,R85; neoplasia benigna R86

(R93) suprimido, incluído no R82

R95 DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA ***J43,J44***

incl: enfisema; obstrução crônica das vias respiratórias, do pulmão, doença pulmonar; limitação crônica das vias respiratórias
excl: bronquite crônica R79, asma R96, bronquiectasias R99, fibrose cística T99
critérios: evidências objetivas de obstrução das vias respiratórias, não aliviada ou apenas parcialmente aliviada pelos broncodilatores
considerar: outros problemas respiratórios R04

R96 ASMA ***J45,J46***

incl: bronquite ruidosa, hiperreatividade brônquica
excl: bronquiolite R78, bronquite crônica R91, enfisema R95
critérios: episódios recorrentes de obstrução aguda e reversível dos brônquios com ruído e/ou tosse seca; ou testes diagnósticos que satisfaçam os critérios de asma
considerar: respiração ruidosa R03, tosse R05

R97 RINITE ALÉRGICA ***J30***

incl: febre do feno, alergia nasal, rinite vasomotora
excl: infecção respiratória superior R74, rinite NE R83

R98 SINDROME DE HIPERVENTILAÇÃO ***R06.4***

critérios: sintomas relacionados à hiperventilação e aliviados quando se respira novamente o ar expirado
considerar: problemas respiratórios R04

R99 OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS ***J33, J34.1 a J34.3, J34.8, J38, J39, J47, J60 a J70, J80 a J82, J84, J92, J93, J96, J98, J99, Z90.2, Z94.2, Z94.3***

incl: pneumonia de aspiração; bronquietasias; desvio do septo nasal; complicações pulmonares de outras doenças; doença do mediastino; pólipo nasal; outras doenças da laringe; pneumoconiose; pneumotorax; pneumonite alérgica, químicos, pó, fumos, fungos; colapso pulmonar; insuficiência respiratória; e outras doenças do aparelho respiratório NE

S – PELE

Componente 1 – Sinais e sintomas

S01 DOR, SENSIBILIDADE DOLOROSA DA PELE ***R20.8,R52***

incl: sensação de ardor, lesão ou erupção cutânea dolorosa, dor
excl: formigamento, distúrbios de sensação N05,N06

S02 PRURIDO ***L29.8,L29.9***

incl: irritação da pele
excl: anogenital D05, dermatite artefacta S99, da vulva X16, dos mamilos X20

S03 VERRUGAS ***B07***

incl: verrugas vulgares
excl: molusco contagioso S95, verruga genital X91, Y76

S04 TUMOR/MASSA LOCALIZADA DA PELE ***R22***

incl: pápula
excl: picada de inseto S12; nódulo na mama X19

S05 INCHAÇOS GENERALIZADOS ***R21***

incl: pápulas, tumores ou inchaços em vários locais
excl: tornozelos inchados/edema K07

S06 ERUPÇÃO CUTÂNEA LOCALIZADA ***L53.9,R21***

incl: máculas, eritema, vermelhidão
excl: inchaços S05

S07 ERUPÇÃO CUTÂNEA GENERALIZADA ***L53.9,R21***

incl: máculas, eritema, vermelhidão em vários locais
excl: erupção cutânea com febre A76, inchaços S06

S08 ALTERAÇÕES DA COR DA PELE ***L81.1, L81.2, L81.3, R23.0, R23.1, R23.2***

incl: "olheiras", cianose, rubor, sardas, palidez, pigmentação
excl: contusão S16, vitiligo S99

S09 INFECÇÃO DOS DEDOS DAS MÃOS/PÉS ***L03.0***

incl: peroníquia
excl: pós-traumática S11; tinea S74; monília, cândida S75

S10 FURÚNCULO/ANTRAZ ***L02***

incl: abcesso; furúnculo; foliculite
excl: linfadenite B70; perianal D95; no meato auditivo externo H70; no interior do nariz R73; no dedo da mão ou do pé infectado, S09; ferida infectada S11; erisipela S76; abcesso pilonidal S85; hidradenite S92; nos genitais externos femininos X99; nos genitais externos masculinos Y99

S11 INFECÇÃO PÓS-TRAUMÁTICA DA PEL-E ***T79.3***

incl: infecção pós-traumática de uma ferida ou mordedura
excl: infecção de uma ferida cirúrgica A87; erisipela S76; piodermia S76; impetigo S84

S12 PICADA OU MORDEDURA DE INSETO ***T14.0***

excl: efeitos tóxicos A86; infecção de picada S11; escabiose S72; pediculose S73

S13 MORDEDURA ANIMAL/HUMANA ***T14.1***

excl: efeitos tóxicos A86; infecção da mordedura S11

S14 QUEIMADURA/ESCALDAMENTO ***T20 a T25, T30, T31, T32***

incl: todos os graus; queimaduras químicas
excl: queimaduras solares S80

S15 CORPO ESTRANHO NA PELE ***T14.0,T14.1***

incl: corpo estranho sob a unha

S16 TRAUMATISMO/CONTUSÃO ***S00.0, S00.7 a S00.9, S10,S20, S30.0, S30.1, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0***

incl: hematoma, equimose
excl: com corte na pele S17
critérios: superfície cutânea intacta

S17 ABRASÃO/ARRANHÃO/BOLHAS ***S00.0, S00.7 a S00.9, S10, S20, S30.7 a S30.9, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0***

incl: contusão se houver solução de continuidade; esfoladela

S18 LACERAÇÃO/CORTE ***S00, S00.7 a S00.9, S01.0, S01.2, S01.4, S01.7 a S01.9, S11, S21, S31.0, S31.1, S31.8, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T14.1***

incl: pele, tecidos subcutâneos
excl: mordedura S13

S19 OUTRA LESÃO CUTÂNEA ***S00.0, S00.7 a S00.9, S10, S20, S30.7 a S30.9, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T14.0***

incl: avulsão da unha, picada com uma agulha, punctura
excl: mordedura S13

S20 CALOS/CALOSIDADES ***L84***

excl: hiperceratose S80

S21 SINAIS/SINTOMAS DA TEXTURA DA PELE ***R23.4***

incl: pele seca, descamação, rugas
excl: problemas de transpiração A09, queixas do couro cabeludo S24, problemas das glândulas sudoríparas S92, ictiose S99, queixas da vulva X10

S22 SINAIS/SINTOMAS DAS UNHAS ***L60.1, L60.4, L60.5, L60.9, L62, R68.3***

incl: dilatação das extremidades dos dedos
excl: peroníquia S09, unha encravada S94

S23 QUEDA DE CABELO/CALVÍCIE ***L63 a L66***

incl: alopecia

S24 SINAIS/SINTOMAS DO CABELO/ COURO CABELUDO ***L67,L68***

incl: couro cabeludo seco, hirsutismo
excl: tricotilomania P29, foliculite S10, queda de cabelo/calvície S23, caspa S86

S26 MEDO DE CÂNCER DE PELE ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de câncer de pele sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

S27 MEDO DE OUTRA DOENÇA DA PELE ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de outra doença cutânea sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

S28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

incl: incapacidade decorrente do estado da pele
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

S29 SINAIS/SINTOMAS DA PELE, OUTROS ***R23.3,R23.8***

incl: pele sangrando, celulite, petéquias, problemas do umbigo, lesão da pele, ferimento(s)
excl: cicatriz S99

Componente 7 – Diagnóstico/doença

S70 HERPES ZOSTER ***B02,G53.0***

incl: nevralgia pós-herpética, zona
excl: herpes zoster oftálmico F73
critérios: conjunto de erupções vesiculares, distribuição unilateral na área de um único dermatoma
considerar: dor cutânea S01, erupção cutânea S06

S71 HERPES SIMPLES ***B00.0, B00.1, B00.8, B00.9***

incl: herpes simples
excl: olho F85; infecções genitais X90,Y72
critérios: vesículas com base eritematosa em uma área localizada; além de história de lesões semelhantes ou evidências virológicas ou serológicas
considerar: erupções cutâneas S06

S72 ESCABIOSE E OUTRAS ACARÍASES ***B86,B88.0,B88.2***

critérios: lesões cutâneas com prurido intenso, além de uma série de galerias nas palmas, dedos, pênis ou dobras da pele, ou evidência de parasitas ou ovos nas lesões
considerar: prurido S02

S73 PEDICULOSE/OUTRAS INFESTAÇÕES DA PELE ***B85, B87, B88.1, B88.3, B88.8, B88.9***

incl: pulgas, piolhos, ácaros, carrapatos/carraças
excl: mordeduras de insetos S12, mordeduras de insetos infectadas S11
critérios: evidência de lêndeas no cabelo ou de insetos na pele ou na roupa
considerar: prurido S02, erupções cutâneas S06

S74 DERMATOFITOSE ***B35,B36***

incl: infecção cutânea a fungos, onicomicose, pitiríase versicolor, tinha
excl: monília, cândida S75
critérios: lesões escamosas e pruriginosas mais claras no centro e pequenas vesículas à volta; ou evidência de fungo

S75 MONILÍASE/CANDIDÍASE DA PELE ***B37.2***

incl: lesões que envolvem as unhas, região perianal, pele; intertrigo monilial
excl: aftas orais D83, infecções genitais X72,Y75

S76 OUTRAS INFECÇÕES DA PELE ***A46, L03.1 a L03.3, L03.8, L03.9, L08***

incl: celulite, erisipela, piodermia
excl: furúnculo, antraz, outra infecção cutânea localizada S11; impetigo S84; molusco contagioso S95; acne S96

S77 NEOPLASIAS MALIGNAS DA PELE ***43,C44,C46.0,C46.1***

incl: carcinoma de células basais (basalioma), doença de Bowen, melanoma maligno, "ulcus rodens", carcinoma de células escamosas (espinocelular)
excl: lesões pré-malignas S79
critérios: aparência histológica característica
considerar: outras neoplasias malignas (quando a localização primária é incerta) A79; neoplasias não-especificadas quer benignas quer malignas S79 (quando não há dados histológicos disponíveis)

S78 LIPOMA ***D17***

S79 NEOPLASIA CUTÂNEA BENIGNA/INCERTA ***D03,D04,D23***

incl: cisto dermoide, lesões pré-malignas
excl: pólipos cutâneos hemorroidais residuais K96; hiperqueratoses S80; queratoses solares S80; hemangioma S81; mancha na pele S82; nevo pigmentado S82; queloide S99; verrugas seborreicas ou senis S99

S80 QUERATOSE SOLAR/QUEIMADURA SOLAR ***D48.5,L55 a L59***

incl: hiperqueratose, fotossensiblidade, lesões cutâneas provocadas pelas radiações, queratose senil, erupção polimórfica leve
excl: lesões cutâneas devido a radiações criadas pelo homem A87 ou A88

S81 HEMANGIOMA/LINFANGIOMA ***D18***

incl: marca de nascimento angiomatosa, mancha cor "vinho do Porto"
critérios: tumor vascular ou linfático, que se eleva acima da pele e diminui sob pressão
considerar: inchaço localizado S04

S82 NEVUS/SINAIS DA PELE ***D22***

S83 LESÕES DA PELE CONGÊNITAS, OUTRAS ***Q80 a Q82,Q84***

incl: marca de nascença; ictiose
excl: hemangioma, linfangioma S81

S84 IMPETIGO ***L00,L01***

incl: impetigo secundário a outras dermatoses
critérios: lesão cutânea crescente, consistindo em máculas, vesículas, pústulas ou crosta com uma área circundante em carne viva
considerar: outras lesões cutâneas localizadas S11

S85 CISTO PILONIDAL/FÍSTULA ***L05***

incl: abcesso pilonidal
excl: cisto dermoide S79

S86 DERMATITE SEBORREICA *L21*

incl: crosta láctea, caspa
excl: verrugas seborreicas S99
critérios: lesões oleosas e escamosas com eritema subjacente em uma ou mais áreas do couro cabeludo, face, esterno, zonas interescapulares, em volta do umbigo e nas pregas da pele, não atribuíveis a outras doenças cutâneas
considerar: erupções cutâneas localizadas S06, erupções cutâneas generalizadas S07

S87 DERMATITE, ECZEMA ATÓPICO *L20*

incl: eczema infantil, dermatite flexural
excl: afetando apenas o meato auditivo externo H70, dermatite alérgica S88, eritema das fraldas S89
critérios: lesões exsudativas pruriginosas com ou sem liquenificação na face e no pescoço, pulsos e mãos, tórax, região poplítea e sangradouro
Considerar: erupções cutâneas S06,S07; prurido S02

S88 DERMATITE DE CONTATO/ALÉRGICA *L23 a L25, L27.2, L27.8, L27.9, L30.0, L30.3, L30.4, L30.8, L30.9, L30.9*

incl: dermatite alérgica, dermatite química, dermatite NE, eczema NE, intertrigo, picadela por planta, alergia cutânea
excl: alergia não-especificada, reação alérgica não-especificada A92; dermatite de contato e outras dermatites das pálpebras F71; meato auditivo externo H70; eczema atópico S87; eritema das fraldas S89; dermatite artefacta S99; urticária S98; neurodermatite S99
critérios: lesões eritematosas pruriginosas ligadas a uma exposição a substâncias químicas
considerar: prurido S02; erupções cutâneas S06,S07

S89 ERITEMA DAS FRALDAS *L22*

incl: erupção cutânea provocada pelas fraldas
critérios: dermatite, principalmente na zona das fraldas e das pregas, em bebês

S90 PITIRÍASE ROSADA *L42*

critérios: erupções ovais e escamosas ao longo das linhas de clivagem da pele do tronco, com história de uma única lesão maior que precede a erupção atual
considerar: erupções cutâneas S06,S07

S91 PSORÍASE *L40*

critérios: manchas descamativas prateadas nos joelhos, cotovelos ou couro cabeludo e/ou picotado ungueal
Nota: codifique duplamente a artrite psoriática L99

S92 DOENÇA DAS GLÂNDULAS SUDORÍPARAS *L30.1,L73.2,L74,L75*

incl: desidrose; erupção provocada pelo calor; hidradenite; miliária; calor pruriginoso; erupção provocada pelo suor; ponfólige
excl: hiperidrose A09

S93	**CISTO SEBÁCEO**	***L72.1***

S94	**UNHA ENCRAVADA**	***L60.0***

excl: peroníquia S09

S95	**MOLUSCO CONTAGIOSO**	***B08.1***

S96	**ACNE**	***L70***

incl: pontos negros, cravos, espinhas
excl: provocado por medicação A85

S97	**ÚLCERA CRÔNICA DA PELE**	***I83.0, I83.2, L89, L97, L98.7***

incl: úlcera de decúbito, úlcera de pressão, úlcera varicosa
excl: gangrena K92

S98	**URTICÁRIA**	***L50***

incl: erupções da pele,vergões
excl: alergia a drogas A85; angioedema, edema alérgico A92

S99	**DOENÇAS DA PELE, OUTRAS**	***L10 a L14, L26, L28, L30.2, L30.5, L41, L43 a L45, L51, L52, L53.0 a L53.3, L53.8, L54, L60.2, L60.3, L60.8, L71, L72.0, L72.2, L72.8, L72.9, L73.0, L73.1, L73.9, L80, L81.4 a L81.9, L82, L83, L85 a L88, L90 a L95, L98.1 a L98.3, L98.5 a L98.9, L99, Z94.5***

incl: dermatite artefacta; lúpus eritematoso discoide; eritema multiforme; eritema nodoso; granuloma; granuloma anular; queloide; queratoacantoma; líquen plano; neurodermatite; onicogrifose; rosácea; rinofima; cicatriz; verrugas seborreicas ou senis; estrias atróficas; vitiligo e outras doenças da pele NE

T – ENDÓCRINO, METABÓLICO E NUTRICIONAL

Componente – Sinais e sintomas

T01	**SEDE EXCESSIVA**	***R63.1***

incl: polidipsia

T02	**APETITE EXCESSIVO**	***R63.2***

incl: comer de forma exagerada, polifagia
excl: bulimia P86

T03	**PERDA DE APETITE**	***R63.0***

incl: anorexia
excl: anorexia nervosa P86

T04 PROBLEMAS ALIMENTARES DO LACTENTE/CRIANÇA ***R63.3***

incl: problemas para comer (o que e como)
excl: alergia a alimentos A98; causas psicológicas P11; perturbações alimentares P11; intolerância à comida T99

T05 PROBLEMAS ALIMENTARES DO ADULTO ***R63.3***

incl: problemas para comer (o que e como)
excl: alergia a alimentos A98; disfagia D21; perturbações alimentares de ordem psicológica, recusa alimentar P29; anorexia/bulimia nervosa P86; perda de apetite T03; intolerância à comida T99

(T06) suprimido, transferido para o P86

T07 AUMENTO DE PESO ***R63.5***

excl: obesidade T82, excesso de peso T83

T08 PERDA DE PESO ***R63.4,R64***

incl: caquexia
excl: anorexia nervosa P86

T10 ATRASO DE CRESCIMENTO ***E34.3,R62***

incl: criança que não cresce, atraso psicológico
excl: atraso de crescimento P22; dificuldades de aprendizagem P24; atraso mental P85; puberdade atrasada T99

T11 DESIDRATAÇÃO ***E86***

incl: depleção hídrica
excl: depleção de sal T94, alterações electrolíticas T94

(T15) suprimido, incluído no T81

T26 MEDO DE CÂNCER DO SISTEMA ENDÓCRINO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de câncer do sistema endócrino sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

T27 MEDO DE OUTRA DOENÇA ENDÓCRINA/METABÓLICA ***Z71.1***

incl: medo de ser diabético
excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: receio de ser portador de outra doença endócrina, metabólica ou nutricional e não o ser ou até o diagnóstico ser confirmado

T28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

incl: limitação funcional/incapacidade relacionada com o sistema endócrino ou com fatores metabólicos ou nutricionais.
Nota: As tabelas da COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

T29 SINAIS/SINTOMAS ENDÓCRINOS, METABÓLICOS/NUTRICIONAIS, OUTROS ***R63.8***

incl: desejo de certo alimento, pica, peso inferior ao normal
excl: hiperglicemia A91; retenção de fluidos K07

Componente 7 – Diagnóstico/doença

T70 INFECÇÃO ENDÓCRINA ***E06.0***

excl: tireoidite T99

T71 NEOPLASIA MALIGNA DA TIREOIDE ***C73***

critérios: aparência histológica característica
considerar: bócio T81, neoplasia não-especificada T73

T72 NEOPLASIA BENIGNA DA TIREOIDE ***D34***

excl: bócio T81, neoplasia não-especificada T73

T73 OUTRA NEOPLASIA ENDÓCRINA NÃO-ESPECIFICADA ***C74,C75,D35,D44***

T78 CISTO DO CANAL TIREOGLOSSO ***Q89.2***

excl: bócio T81

T80 MALFORMAÇÃO ENDÓCRINA/METABÓLICA CONGÊNITA ***Q89.1,Q89.2***

incl: nanismo, cretinismo
excl: canal tireoglosso (cisto) T78

T81 BÓCIO ***E04***

incl: nódulo da tireoide, bócio não-tóxico
excl: neoplasia da glândula tireoide T71-T73, bócio tóxico T85, hipotireoidismo T86

T82 OBESIDADE ***E66***

excl: excesso de peso T83
critérios: índice de massa corporal superior a 30

T83 EXCESSO DE PESO ***E66***

excl: obesidade T82
critérios: índice de massa corporal superior a 25, mas inferior a 30

T85 HIPERTIREOIDISMO/TIREOTOXICOSE ***E05***

incl: doença de Graves, bócio tóxico
excl: bócio não-tóxico T81
critérios: evidências laboratoriais de excesso de hormônios da tireoide; ou nódulo da tireoide; ou bócio e tremor, perda de peso, e pulsação muito rápida (superior a 100/min em descanso) ou sinais dos olhos (exoftalmia, pálpebras que se movem mais lentamente do que normal ou oftalmoplegia)

T86 HIPOTIREOIDISMO/MIXEDEMA ***E00 a E03***

excl: cretinismo T80
critérios: evidências laboratoriais de diminuição da atividade hormonal da tireoide e excesso do hormônio estimulante da tireoide; ou quatro ou mais dos seguintes: fraqueza, cansaço, alterações mentais – apatia, memória fraca, lentidão —; alterações da voz – mais rouca, discurso mais lento —; sensibilidade anormal ao frio; obstipação; face opaca; pele seca, pele amarelada, diminuição do suor; edema periférico
considerar: outras queixas do metabolismo T29

T87 HIPOGLICEMIA ***E15,E16***

incl: hiperinsulinismo, coma insulínico
critérios: hipoglicemia provada por testes bioquímicos, ou sintomas característicos de um paciente diabético aliviados pela ingestão ou injeção de açúcar

(T88) suprimido, incluído no T99

T89 DIABETES, INSULINODEPENDENTE ***E10, O24.0***

incl: diabetes juvenil, diabetes do tipo 1
critérios: paciente que necessita de tratamento regular com insulina após um diagnóstico confirmado por um dos seguintes meios:

a) sintomas clássicos de diabetes, como poliúria, polidipsia e perda rápida de peso, juntamente com aumento inequívoco da glicose plasmática
b) níveis de glicose sanguínea em jejum de 8mmol/l (l40mg/dl) ou superior em duas ou mais ocasiões
c) níveis de glicose sanguínea sem ser em jejum de 11mmol/l (200mg/dl) ou superior em duas ou mais ocasiões
d) um teste de tolerância à glicose oral (75mg glicose) com um valor de glicose plasmática entre uma a duas horas de 11mmol/l (200mg/dl) ou mais, e glicose plasmática em duas horas de 11mol/l (200mg/dl) ou mais

considerar: hiperglicemia A91; diabetes, não-insulinodependente T90

T90 DIABETES NÃO-INSULINODEPENDENTE ***E11 a E14, O24.1 a O23.3, O23.9***

incl: diabetes NE, diabetes com início tardio, diabetes de tipo 2
excl: hiperglicemia provocada por medicação A85, hiperglicemia como achado isolado A91
critérios: paciente que não necessita de tratamento regular com insulina após um diagnóstico confirmado por um dos meios seguintes:

a) sintomas clássicos de diabetes, como poliúria, polidipsia, perda rápida de peso, juntamente com aumento inequívoco da glicose plasmática
b) níveis de glicose sanguínea em jejum de 8mmol/l (l40mg/dl) ou superior em duas ou mais ocasiões
c) níveis de glicose sanguínea sem ser em jejum de 11mmol/l (200mg/dl) ou superior em duas ou mais ocasiões
d) um teste de tolerância à glicose oral (75mg glicose) com um valor de glicose plasmática entre uma a duas horas de 11mmol/l (200mg/dl) ou mais, e glicose plasmática em duas horas de 11mol/l (200mg/dl) ou mais

considerar: hiperglicemia A91; diabetes insulinodependente T89

T91	**DEFICIÊNCIA VITAMÍNICA/NUTRICIONAL**	***E40 a E46, E50, E51.1, E51.8, E51.9, E52 a E56, E58 a E61, E63, E64***

incl: beribéri; dieta deficiente de minerais; deficiência de ferro sem anemia; malnutrição; marasmo; escorbuto
excl: anemia por falta de ferro B80; anemia; anemia megaloblástica (perniciosa) B81; sindrome de malabsorção, espru, psilose D99

T92	**GOTA**	***M10***

excl: gota provocada por drogas A85; ácido úrico elevado A91; pseudogota e outras artropatias por cristais T99

T93	**ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LIPÍDEOS**	***E78***

incl: hiperlipidemia; níveis anormais de lipoproteínas; níveis elevados de colesterol e triglicerídeos; xantoma

T99	**DOENÇAS ENDÓCRINAS/ METABÓLICAS/ NUTRICIONAIS, OUTRAS**	***E06.1 a E06.5, E06.9,E07, E20 a E32, E34.0 a E34.2, E34.4 a E34.9, E35, E65, E67, E68, E70 a E77, E79, E80, E84, E85, E87 a E90, M83, O90.5***

incl: acromegalia; amiloidose; perturbações metabólicas congênitas; artropatia a cristais; síndrome de Cushing; fibrose cística; diabetes insípida; síndrome de Gilberts; hiperaldosteronismo; intolerância à lactose; osteomalacia; disfunção adrenal/ovária/ /pituitária/paratiroide/testicular ou outra endócrina; porfiria; puberdade precoce ou tardia; pseudogota; glicosúria renal; tireoidite
excl: alergia a alimentos A98; intolerância a alimentos D99; osteoporose L95

U – APARELHO URINÁRIO

Componente 1 – Sinais e sintomas

U01	**DISÚRIA/MICÇÃO DOLOROSA**	***R30***

incl: micção com ardor
excl: micção frequente/urgente U02, síndrome uretral U72

U02	**MICÇÃO FREQUENTE/URGENTE/POLACIÚRIA**	***R35***

incl: noctúria, poliúria

U04	**INCONTINÊNCIA URINÁRIA**	***N39.3,N39.4,R32***

incl: enurese de origem orgânica, micção involuntária, incontinência provocada pelo *stress*
excl: de origem psicológica P12

U05	**OUTROS PROBLEMAS COM A MICÇÃO**	***R34,R39.1***

incl: anúria, oligúria, urina em gotas
excl: retenção urinária U08

U06 HEMATÚRIA ***N02,R31***

incl: sangue na urina, análises macroscópicas, microscópicas ou químicas positivas

U07 OUTROS SINAIS DA URINA ***R39.8***

incl: urina com mau odor, urina escura
excl: análises anormais da urina U98

U08 RETENÇÃO URINÁRIA ***R33***

U13 SINAIS/SINTOMAS DA BEXIGA, OUTROS ***R39.0,R39.8***

incl: bexiga irritável

U14 SINAIS/SINTOMAS DOS RINS ***N23***

incl: dores nos rins, problemas com os rins, cólicas renais
excl: dores lombares L05

U26 MEDO DE CÂNCER DO APARELHO URINÁRIO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de um câncer do aparelho urinário sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

U27 MEDO DE OUTRA DOENÇA URINÁRIA ***Z71.1***

excl: medo de câncer do aparelho urinário U26; se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de outra doença do aparelho urinário sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

U28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6, Z93.5, Z93.6, Z99.2***

incl: transplante renal, fluxo reduzido
excl: incontinência urinária U04
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

U29 SINAIS/SINTOMAS DO APARELHO URINÁRIO, OUTROS ***R39.8***

excl: bexiga irritável, dores na bexiga U13; problemas dos rins U14

Componente 7 – Diagnóstico/doença

U70 PIELONEFRITE ***N10 a N12, N15.1, N15.9***

incl: infecção dos rins; abcesso renal e perirrenal
critérios: dois entre os seguintes: dor na região lombar, sensibilidade renal ou evidência de lesões crônicas renais; além de evidência clínica ou laboratorial de infecção do aparelho urinário
considerar: cistite/outra infecção urinária U71

U71 CISTITE/OUTRA INFECÇÃO URINÁRIA ***N30,N39.0***

incl: bacteriúria assintomática, cistite aguda e crônica (não-venérea), infecção do aparelho urinário inferior, infecção do aparelho urinário NE
excl: pielonefrite U70, uretrite U72; vaginite X84; balanite Y75;
Nota: em caso de gravidez codifique também W84

U72 URETRITE ***B37.4,N34***

incl: uretrite por chlamydia, uretrite não específica, síndrome uretral, meatite
excl: uretrite gonocócica feminina X71; uretrite tricomonal feminina X73; uretrite gonocócica masculina Y71
critérios: secreção uretral com frequência, ardor, dor ou urgência durante a micção sem bacteriúria ao microscópio ou cultura; ou inflamação do meato urinário externo
considerar: micção dolorosa U01; micção frequente/urgente U02; bexiga irritável U13; secreção uretral X29,Y03

U75 NEOPLASIA MALIGNA DO RIM ***C64,C65***

critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia do aparelho urinário NE U79 (quando não há dados histológicos disponíveis)

U76 NEOPLASIA MALIGNA DA BEXIGA ***C67***

critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia do aparelho urinário NE U79 (quando não há dados histológicos disponíveis)

U77 NEOPLASIA MALIGNA DO APARELHO URINÁRIO, OUTRA ***C66,C68***

incl: neoplasia maligna do ureter, neoplasia maligna da uretra
excl: neoplasia maligna da próstata Y77
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia do aparelho urinário NE U79 (quando não há dados histológicos disponíveis)

U78 NEOPLASIA BENIGNA DO APARELHO URINÁRIO ***D30***

incl: papiloma da bexiga; pólipo do aparelho urinário
excl: hipertrofia prostática Y85
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia do aparelho urinário NE U79 (quando não há dados histológicos disponíveis)

U79 NEOPLASIA DO APARELHO URINÁRIO NE ***D41***

incl: neoplasia da bexiga/rim/ureter/uretra NE
excl: neoplasias do aparelho urinário histologicamente comprovadas U75, U76, U77, U78

U80 LESÕES TRAUMÁTICAS DO APARELHO URINÁRIO ***S37.0 a S37.3, T19.0, T19.1, T28.3, T28.8***

incl: contusão do rim, corpo estranho no aparelho urinário

U85 MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO APARELHO URINÁRIO ***Q60 a Q64***

incl: duplicação de rim/ureter, rim policístico (congênito)

U88	GLOMERULONEFRITE/ SINDROME NEFRÓTICA	*N00, N01, N03, N04, N05, N07, N08, N14, N15.0, N15.8, N16*

incl: glomerulonefrite aguda, nefropatia por analgésicos, glomerulonefrite crônica, nefrite, nefropatia, nefrosclerose, síndrome nefrótica
excl: insuficiência renal U99
critérios: três ou mais dos seguintes: hematúria, proteinúria, retenção renal de água e sal, diminuição do funcionamento renal, anomalias persistentes do sedimento urinário frequentes; ou evidência por biópsia renal
considerar: análises de urina anormais U98, queixa do rim U14

U90	ALBUMINÚRIA/PROTEINÚRIA ORTOSTÁTICA	*N39.2*

incl: proteinúria postural
critérios: albuminúria de esforço, sem albuminúria após repouso no leito e sem sinais de doença renal
considerar: proteinúria NE U98

U95	CÁLCULO URINÁRIO	*N20, N21, N22, N28, N29*

incl: cálculo ou pedra da bexiga, rim, ureter; urolitíase
critérios: dores tipo cólica e hematúria ou história de cálculo urinário; ou emissão de cálculo; ou evidência imagiológica de cálculo
considerar: sangue na urina U06, cólicas renais U14, outros sintomas urinários U29, resultados anormais de análise de urina U98

U98	ANÁLISES ANORMAIS DE URINA NE	*N39.1,R80 a R82*

incl: glicosúria, proteinúria, pus na urina, piúria
excl: hematúria/sangue na urina U06; albuminúria/proteinúria ortostática U90

U99	OUTRA DOENÇA URINÁRIA	*N06, N13, N17 a N19, N25 a N27, N31, N32, N33.8, N35 a N37, N39.8, N39.9, R39.2, T19.8, T19.9, Z90.5, Z90.6, Z94.0*

incl: divertículo da bexiga; hidronefrose; rim hipertrófico; obstrução do colo vesical; insuficiência renal; carúnculo uretral; aperto uretral; refluxo uretérico; uremia; e outras doenças do aparelho urinário NE

W – GRAVIDEZ, PARTO, PLANEJAMENTO FAMILIAR

Componente 1 – Sinais e sintomas

W01	QUESTÃO SOBRE GRAVIDEZ	*Z32.0*

incl: menstruação em atraso ou sintomas que indiciem uma gravidez
excl: receio de gravidez W02, gravidez confirmada W78,W79

W02	MEDO DE ESTAR GRÁVIDA	*Z71.1*

incl: preocupação com a possibilidade de uma gravidez indesejada
excl: preocupação ou medo em uma gravidez não-desejada confirmada W79

W03 HEMORRAGIA ANTES DO PARTO ***O20,O46***

incl: hemorragia vaginal durante a gravidez
excl: hemorragia intraparto W17

W05 VÔMITOS/NÁUSEAS DURANTE A GRAVIDEZ ***O21***

incl: hiperemese, enjoos matinais no caso de gravidez confirmada

W10 CONTRACEPÇÃO PÓS-COITAL ***Z30.3***

incl: "pílula do dia seguinte"

W11 CONTRACEPÇÃO ORAL ***Z30.4***

incl: planejamento familiar por terapia hormonal

W12 CONTRACEPÇÃO INTRAUTERINA/ DISPOSITIVO INTRAUTERINO/ DIU ***T83,Z30.1,Z30.5***

incl: planejamento familiar por DIU

W13 ESTERILIZAÇÃO ***Z30.2***

incl: planejamento familiar por esterilização feminina

W14 CONTRACEPÇÃO, OUTROS ***Z30.0, Z30.8, Z30.9***

incl: contracepção NE, planejamento familiar NE, aconselhamento genético
excl: contracepção oral W11, DIU W12, esterilização W13

W15 INFERTILIDADE/SUBFERTILIDADE ***N97,Z31***

incl: esterilidade
critérios: incapacidade de engravidar após 2 anos de tentativas
considerar: sinais/sintomas da gravidez W29

W17 HEMORRAGIA PÓS-PARTO ***O72***

incl: sangramento pós-parto
critérios: hemorragia franca no, durante ou até 6 semanas após o parto
considerar: sinais/sintomas do pós-parto W18

W18 SINAIS/SINTOMAS DO PÓS-PARTO ***O90.9***

incl: queixas no parto e durante as 6 semanas pós-parto
excl: depressão puerperal P76, hemorragia W17, queixas sobre o aleitamento W19, complicações W96

W19 SINAIS/SINTOMAS DA MAMA/LACTAÇÃO ***092.5 a 092.7***

incl: galactorreia, ablactação, desmame
excl: mastite puerperal W94, mamilos rachados W95

(W20) suprimido, incluído no W19

W21 PREOCUPAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL DURANTE A GRAVIDEZ ***R46.8***

W27 MEDO DE COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ ***Z71.1***

incl: receio de malformações congênitas no bebê
excl: se a paciente tem complicações, codifique-as
critérios: paciente que receia complicações sem as ter ou até o diagnóstico ser confirmado

W28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6***

incl: incapacidade devida ou relacionada a gravidez ou a instabilidade pélvica
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional da paciente (ver Capítulo 8).

W29 SINAIS/SINTOMAS DA GRAVIDEZ, OUTROS ***R68.8***

incl: sinal/sintoma sobre o planejamento familiar

Componente 7 – Diagnóstico

W70 SÉPSIS/INFECÇÃO PUERPERAL ***O85,O86.1,O86.3***

critérios: infecção do canal de nascimento ou dos órgãos reprodutores até 6 semanas pós-parto

(W77) suprimido

W71 INFECÇÕES QUE COMPLICAM A GRAVIDEZ ***O41.1, O75.2, O75.3, O86.2, O86.4, O86.8, O98***

incl: infecções maternas que complicam a gravidez ou o puerpério
excl: infecção puerperal W70

W72 NEOPLASIA MALIGNA RELACIONADA À GRAVIDEZ ***C58***

incl: corioepitelioma, coriocarcinoma

W73 NEOPLASIA BENIGNA/INCERTA RELACIONADA À GRAVIDEZ **O01, O90.8**

incl: mola hidatiforme

W75 LESÕES TRAUMÁTICAS QUE COMPLICAM A GRAVIDEZ ***T14.9***

incl: consequências de traumatismos que interferem com a gravidez
excl: novo traumatismo causado pelo parto W92,W93

W76 MALFORMAÇÃO CONGÊNITA QUE COMPLICA A GRAVIDEZ ***O99***

incl: malformações maternas que podem afetar a gravidez ou o parto

W78 GRAVIDEZ ***Z32.1,Z33,Z34***

incl: gravidez confirmada
excl: gravidez não desejada W79, gravidez ectópica W80, gravidez de alto risco W84

W79 GRAVIDEZ NÃO DESEJADA ***Z32.1***

W80 GRAVIDEZ ECTÓPICA ***O00***

critérios: confirmação por ecografia, laparoscopia, culdoscopia ou cirurgia
considerar: hemorragia pré-parto W03, outros sintomas durante a gravidez W29

W81 TOXEMIA GRAVÍDICA/ DHEG ***O10,O12 a O16***

incl: eclampsia; hipertensão, edema, proteinúria durante a gravidez; pré-eclampsia
critérios: tensão arterial diastólica >90 mmHg em pelo menos duas ocasiões ou subidas de 15mmHg ou mais; ou edema; ou proteinúria; ou convulsões com hipertensão ou edema ou proteinúria
considerar: outros sinais ou sintomas durante a gravidez W29

W82 ABORTO ESPONTÂNEO ***O02,O03,O05,O06***

incl: aborto – ameaça, completo, incompleto, retido, habitual
excl: aborto provocado W83, hemorragia pré-parto W03, contrações prematuras depois da 28ª semana de gravidez W92,W93, morte fetal, nascido morto após a 28ª semana de gravidez W93

W83 ABORTO PROVOCADO ***O04,Z30.3***

incl: interrupção da gravidez, todo tipo de complicações

W84 GRAVIDEZ DE ALTO RISCO ***O23, O25, O30 a O36, O40, O43, O44, O99, Z35***

incl: primípara idosa; anemia da gravidez; diabetes ou outra doença crônica anterior que afete a gravidez; incompatibilidade feto-pélvica; hidrâmnio; má posição do feto; gravidez múltipla; placenta prévia; cesariana anterior; trabalhos de parto prematuros; atraso de crescimento intrauterino (ACIU)
excl: infecções que complicam a gravidez W71, gravidez ectópica W80, toxemia da gravidez W81, diabetes gestacional W85

W85 DIABETES GESTACIONAL ***O24.4***

incl: diabetes manifestada durante a gravidez
excl: diabetes anterior T89 ou T90
critérios: glicose plasmática em jejum acima de 5.5mmol/L e/ou nível de glicose plasmática superior a 8.0mmol/L (140mg/dl) duas horas depois de um teste de tolerância à glicose oral (75g)
considerar: hiperglicemia A91

W90 PARTO DE NASCIDO VIVO SEM COMPLICAÇÕES ***O80,Z37.0,Z37.9,Z38***

incl: trabalho de parto, parto normal NE

W91 PARTO DE NATIMORTO SEM COMPLICAÇÕES ***Z37.1,Z37.9***

incl: trabalho de parto

W92 PARTO DE NASCIDO VIVO COM COMPLICAÇÕES ***O42, O45, O60 a O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4 a O75.9,O81 a O84,Z37.2, Z37.5,Z37.9,Z38***

incl: parto assistido; parto pélvico; cesariana; distocia; parto induzido; lesões causadas pelo parto; placenta prévia durante o parto; versão
excl: hemorragia W17, eclampsia W81

W93 PARTO DE NATIMORTO COM COMPLICAÇÕES ***O42, O45, O60 a O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4 a O75.9, O81 a O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9***

incl: parto assistido; parto pélvico; cesariana; distocia; parto induzido; lesões causadas pelo parto; placenta prévia durante o parto; versão
excl: hemorragia W17, eclampsia W81

W94 MASTITE PUERPERAL ***O91***

incl: abcesso na mama
critérios: dor, inflamação da mama nas 6 semanas após o parto ou durante o aleitamento
considerar: problemas da lactação W19

W95 OUTROS PROBLEMAS DA MAMA DURANTE A GRAVIDEZ/PUERPÉRIO ***O92.0, O92.1, O92.3, O92.4***

incl: problemas da mama durante o puerpério, mamilo rachado
excl: problemas da lactação W19; mastite W94; problema não relacionado com a gravidez ou a lactação X21

W96 OUTRAS COMPLICAÇÕES DO PUERPÉRIO ***O87,O90.9***

excl: depressão puerperal P76, infecção puerperal W70, toxemia W81, problemas da mama W95

W99 OUTROS PROBLEMAS DA GRAVIDEZ/PARTO ***O07, O08, O22, O26, O41.0, O41.8, O41.9, O47, O48, O88, O95 a O97***

excl: pseudociese P75

X- APARELHO GENITAL FEMININO (INCLUINDO A MAMA)

Componente 1 – Sinais e sintomas

X01 DOR GENITAL ***R52***

incl: dor pélvica, dor vulvar
excl: dores menstruais X02, dispareunia X04, dor na mama X18

X02 DORES MENSTRUAIS ***N94.4 a N94.6***

incl: dismenorreia

X03 DORES INTERMENSTRUAIS ***N94.0***

incl: *mittelschmerz*, dores durante a ovulação

X04 RELAÇÃO SEXUAL DOLOROSA ***N94.1,N94.2***

incl: dispareunia, vaginismo NE
excl: problemas sexuais psicogênicos P07,P08

X05 MENSTRUAÇÃO ESCASSA/AUSENTE ***N91***

incl: amenorreia, atraso menstrual, oligomenorreia
excl: questão sobre a gravidez W01, medo de gravidez W02

X06 MENSTRUAÇÃO EXCESSIVA ***N92.0,N92.2,N92.4***

incl: menorragia

X07 MENSTRUAÇÃO IRREGULAR/FREQUENTE ***N92.1,N92.5,N92.6***

incl: polimenorreia
excl: menorragia X06, hemorragia pubertária X08

X08 HEMORRAGIA INTERMENSTRUAL ***N92.3,N93.8,N93.9***

incl: hemorragia uterina disfuncional, metrorragia, hemorragia durante a ovulação, hemorragia pubertária, *spotting*
excl: hemorragia pós-menopausa X12, hemorragia pós-coito X13

X09 SINAIS/SINTOMAS PRÉ-MENSTRUAIS ***N94.9***

incl: qualquer sintoma relacionado com o período pré-menstrual
excl: síndrome de tensão pré-menstrual X89

X10 DESEJO DE ALTERAR A DATA DA MENSTRUAÇÃO ***Z30.9***

critérios: adiamento da menstruação graças a um tratamento hormonal

X11 SINAIS/SINTOMAS DA MENOPAUSA/ CLIMATÉRIO ***N95.1 a N95.3, N95.8, N95.9***

incl: sintomas relacionados com a menopausa, síndrome da menopausa, vaginite atrófica, vaginite senil
excl: hemorragia pós-menopausa X12

X12 HEMORRAGIA PÓS-MENOPAUSA ***N95.0***

critérios: hemorragia vaginal após pelo menos 6 meses de amenorreia ou confirmação de menopausa por análise laboratorial
considerar: menstruação irregular X07

X13 HEMORRAGIA PÓS-COITO ***N93.0***

incl: hemorragia de contato

X14 SECREÇÃO VAGINAL ***N89.8***

incl: corrimento vaginal, leucorreia
excl: hemorragia X06 a X08, vaginite atrófica X11, gonorreia X71, candidíase urogenital X72, tricomoníase urogenital X73, chlamydia X92

X15 SINAIS/SINTOMAS DA VAGINA, OUTROS ***N89.9***

incl: ressecamento
excl: dores genitais X01, vaginismo orgânico X04, vaginite atrófica X11

X16 SINAIS/SINTOMAS DA VULVA ***L29.2,N90.9***

incl: prurido, ressecamento
excl: dor vulvar X01, abcesso na vulva X99

X17 SINAIS/SINTOMAS DA PÉLVIS FEMININA ***N94.9***

excl: dores genitais X01

X18 DOR NA MAMA ***N64.4***

incl: mastodinia
excl: durante a gravidez ou lactação W19

X19 TUMOR/NÓDULO DA MAMA FEMININA ***N63***

incl: mamas inchadas

X20 SINAIS/SINTOMAS DO MAMILO FEMININO ***N64.0,N64.5***

incl: secreção dos mamilos, fissura, dor, prurido, retração
excl: durante a gravidez ou lactação W19

X21 SINAIS/SINTOMAS DA MAMA FEMININA, OUTROS ***N62,N64.5,N64.9***

incl: mastite (não-puerperal), mastopatia, galactorreia
excl: mastite (puerperal) W94

X22 PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA DA MAMA FEMININA ***R46.8***

X23 MEDO DE DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL ***Z71.1***

excl: se a paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de uma doença sexualmente transmissível sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

X24 MEDO DE DISFUNÇÃO SEXUAL ***Z70,Z71.1***

excl: se a paciente tiver disfunção sexual P07 ou P08
critérios: paciente que receia uma disfunção sexual sem a ter, ou até o diagnóstico ser confirmado

X25 MEDO DE CÂNCER GENITAL ***Z71.1***

excl: se a paciente tiver a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de um câncer do aparelho genital sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

X26 MEDO DE CÂNCER DA MAMA ***Z71.1***

excl: se paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de um câncer da mama sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

X27 MEDO DE OUTRA DOENÇA GENITAL/DA MAMA ***Z71.1***

excl: se a paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente que receia ser portador de outra doença genital/da mama sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

X28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6,Z90.7***

excl: disfunção sexual P07,P08; relações sexuais dolorosas X04, vaginismo X04
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional da paciente (ver Capítulo 8).

X29 SINAIS/SINTOMAS DO APARELHO GENITAL, OUTROS ***N94.8,R36***

incl: secreção uretral na mulher

Componente 7 – Diagnóstico/doença

X70 SÍFILIS FEMININA ***A51 to A53,A65***

incl: sífilis em qualquer localização
critérios: evidência de *Treponema pallidum* ao microscópio, ou teste sorológico positivo para a sífilis

X71 GONORREIA FEMININA ***A54***

incl: gonorreia em qualquer localização
critérios: corrimento purulento uretral ou vaginal, em um contato com um caso demonstrado; ou diplococos intracelulares gram-negativos encontrados no corrimento; ou cultura de *Neisseria gonorrheae*
considerar: uretrite U72; secreção uretral X29

X72 CANDIDÍASE GENITAL ***B37.3,B37.4***

incl: infecção monilial da vagina ou do colo; aftas
critérios: mucosa urogenital inflamada ou pele com exsudado branco aderente, característico, ou evidência de cândida
considerar: secreção vaginal X14; vaginite X84

X73 TRICOMONÍASE GENITAL ***A59.0***

critérios: corrimento com mau odor característico ou evidência de tricomonas ao microscópio
considerar: secreção vaginal X14; vaginite X84

X74 DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA ***N70,N71,N73,N74***

incl: endometrite; ooforite; salpingite
excl: doenças venéreas X70-X73; infecção por *chlamydia* X92
critérios: dores no abdômen inferior, sendo o útero ou anexos sensíveis à palpação, além de outros sinais de inflamação
considerar: síndrome de congestão pélvica X99

X75 NEOPLASIA MALIGNA DO COLO ***C53,D06***

excl: carcinoma *in-situ* X81; neoplasia cervical intraepitelial (CIN) grau 3 X81; esfregaço de pap anormal X86; CIN graus 1 e 2 X86
critérios: aparência histológica característica
considerar: outras neoplasias malignas (quando o local primário é incerto) X77; neoplasias quando não há dados histológicos disponíveis X81

X76 NEOPLASIAS MALIGNAS DA MAMA ***C50,D05***

incl: carcinoma *in-situ*, carcinoma intraductal
critérios: aparência histológica característica
considerar: nódulo na mama X19

X77 NEOPLASIA MALIGNA GENITAL, OUTRAS ***C51,C52,C54 a C57, D07***

incl: malignidade nos ovários, útero, vagina, vulva ou zonas adjacentes
excl: carcinoma *in-situ* X81
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia genital X80 quando não há dados histológicos disponíveis

X78 FIBROMIOMA UTERINO ***D25***

incl: útero fibromiomatoso, fibromioma do colo; mioma
excl: pólipo cervical (adenomatoso) X80, pólipo cervical mucoso X85
critérios: aumento do útero não devido a gravidez ou a malignidade, com um ou mais tumores sólidos do útero

X79 NEOPLASIA BENIGNA DA MAMA FEMININA/ FIBROADENOMA ***D24***

incl: fibroadenoma
excl: doença fibrocística da mama X88
critérios: aparência histológica característica
considerar: nódulo na mama X19

X80 NEOPLASIA BENIGNA GENITAL ***D26 a D28***

excl: pólipo do colo X85; cisto funcional do ovário X99

X81 NEOPLASIA GENITAL DE NATUREZA INCERTA ***D07.0 a D07.3, D39, D48.6***

incl: carcinoma *in-situ*, neoplasia cervical intraepitelial (CIN) de grau 3 confirmada por biópsia, pólipo endometrial

X82 LESÃO TRAUMÁTICA GENITAL ***S30.2, S31.4, S31.5, S37.4 a S37.6, S38.0, S38.2, T19.2, T19.3, T28.3, T28.8***

incl: corpo estranho na vagina, circuncisão feminina
excl: causada pelo parto W92, W93

X83 MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS GENITAIS ***Q50 a Q52,Q56,Q83***

incl: hermafroditismo, hímen não-perfurado
excl: outros síndromes genéticos A90

X84 VAGINITE/VULVITE NE ***N76,N77***

incl: vaginose por gardnerella
excl: candidíase genital X72; tricomoníase genital X73; vaginite atrófica X11

X85 DOENÇA DO COLO NE ***N72,N84.1,N86,N88***

incl: displasia cervical; erosão cervical; leucoplasia cervical; cervicite; pólipo cervical mucoso; laceração antiga
excl: anomalias do colo durante a gravidez, parto e puerpério W77; pólipo adenomatoso X78; esfregaço de pap anormal NE X86

X86 ESFREGAÇO DE PAPANICOLAU/ COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA ANORMAL ***N87***

incl: neoplasia cervical intraepitelial (NIC) graus I e II; NIC grau III não demonstrada por biópsia; displasia
excl: neoplasia cervical intraepitelial (NIC) de grau III confirmada por biópsia X81, carcinoma in-situ confirmado por biópsia X81

X87 PROLAPSO UTEROVAGINAL ***N81***

incl: cistocele; retocele; procidência
excl: incontinência de esforço U04

X88 DOENÇA FIBROCÍSTICA DA MAMA ***N60***

incl: doença fibrocística crônica da mama, fibroadenose cística, displasia, cisto da mama

X89 SÍNDROME DE TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL ***N94.3***

critérios: ocorrência regular no ciclo menstrual de pelo menos dois dos seguintes: edema, mama sensível ou inchada, dor de cabeça, irritabilidade, alterações de humor
considerar: sintoma pré-menstrual X09

X90 HERPES GENITAL ***A60***

incl: herpes simples ano-genital

X91 CONDILOMA ACUMINADO ***A63.0***

incl: verrugas venéreas, infecção pelo vírus papiloma humano

X92 INFECÇÃO GENITAL POR CLAMÍDIA ***A56***

X99 OUTRA DOENÇA GENITAL ***A55, A57, A58, A63.8, N61, N64.1 a N64.3, N64.8, N75, N80, N82, N83, N84.0, N84.2, N84.3, N84.8, N84.9, N85, N89.0 a N89.7, N90.0 a, N90.8, N94.9, N96, N98, Z90.1, Z90.7***

incl: cisto ou abcesso de Bartholin; endometriose; fístula do aparelho genital; síndrome de congestão pélvica; cisto funcional do ovário
excl: doença sexualmente transmissível NE A78

Y – APARELHO GENITAL MASCULINO

Componente 1 – Sinais e sintomas

Y01 DOR NO PÊNIS ***N48.9,R52***

excl: priapismo, ereção dolorosa Y08

Y02 DOR NO ESCROTO/TESTÍCULOS ***R10.2,N50.9,R52***

incl: períneo, pélvis

Y03 SECREÇÃO URETRAL ***R36***

Y04 SINAIS/SINTOMAS DO PÊNIS ***N48.9***

incl: sinais/sintomas do prepúcio
excl: priapismo Y08

Y05 SINAIS/SINTOMAS DO ESCROTO/TESTÍCULOS ***L29.1,N50.9***

incl: nódulo no testículo, testículo retrátil

Y06 SINAIS/SINTOMAS DA PRÓSTATA ***N42.9***

incl: prostatismo
excl: retenção urinária U08

Y07 IMPOTÊNCIA NE ***N48.4***

incl: impotência de origem orgânica
excl: diminuição do desejo sexual P07, diminuição da satisfação sexual P08, impotência psicogênica P08

Y08 SINAIS/SINTOMAS DA FUNÇÃO SEXUAL MASCULINA ***N48.3,N48.9***

incl: priapismo
excl: diminuição do desejo sexual P07, diminuição da satisfação sexual P08, impotência psicogênica P08

Y10 INFERTILIDADE/SUBFERTILIDADE MASCULINA ***N46***

critérios: incapacidade de engravidar após dois anos de tentativas

Y13 ESTERILIZAÇÃO MASCULINA ***Z30.2***

incl: planejamento familiar envolvendo esterilização masculina, vasectomia

Y14 PLANEJAMENTO FAMILIAR/OUTROS **Z30.0,Z30.8,Z30.9**

incl: contracepção NE, planejamento familiar NE, aconselhamento genético

Y16 SINAIS/SINTOMAS DA MAMA MASCULINA ***N63***

incl: nódulo na mama masculina, ginecomastia
excl: doença da mama masculina Y99

Y24 MEDO DE DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente preocupado com uma disfunção sexual sem a ter

Y25 MEDO DE DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL ***Z71.1***

excl: medo de HIV ou AIDS B25; se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente preocupado com uma doença venérea sem a ter, ou até o diagnóstico ser confirmado

Y26 MEDO DE CÂNCER GENITAL MASCULINO ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente preocupado com a possibilidade de ser portador de câncer sem o ser, ou até o diagnóstico ser confirmado

Y27 MEDO DE OUTRA DOENÇA GENITAL MASCULINA ***Z71.1***

excl: se o paciente tem a doença, codifique-a
critérios: paciente preocupado com outra doença genital sem ser portador dela, ou até o diagnóstico ser confirmado

Y28 LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE ***Z73.6,Z90.7***

excl: disfunção sexual P07,P08
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

Y29 SINAIS/SINTOMAS, OUTROS ***N50.9***

Componente 7 – Diagnóstico/doença

Y70 SÍFILIS MASCULINA ***A50 a A53,A65***

incl: sífilis qualquer que seja a sua localização
critérios: evidência de *Treponema pallidum* ao microscópio, ou teste sorológico positivo para a sífilis

Y71 GONORREIA MASCULINA ***A54***

incl: gonorreia qualquer que seja a sua localização
critérios: corrimento uretral ou retal com demonstração de diplococos intracelulares gram-negativos ou cultura positiva de *Neisseria gonorreia*
considerar: uretrite U72; secreção uretral Y03

Y72 HERPES GENITAL ***A60,N51.8***

incl: herpes anogenital; herpes genital masculino
critérios: pequenas vesículas de aparência e localização características que evoluem para úlceras dolorosas e crostas

Y73 PROSTATITE/VESICULITE SEMINAL ***A59.0, N41, N49.0, N51.0***

critérios: próstata ou vesículas seminais sensíveis à palpação e análises à urina compatíveis com inflamação

Y74 ORQUITE/EPIDIDIMITE ***N45,N51.1***

excl: caxumba D71; tuberculose R70; gonorreia Y71; torção dos testículos Y99
Critérios: edema e sensibilidade dos testículos ou epidídimo e ausência de uma etiologia específica (caxumba, gonorreia, tuberculose, trauma, ou torção)
considerar: sintomas dos testículos Y05

Y75 BALANITE/BALANOPOSTITE ***B37.4,N48.1,N51.2***

incl: candidíase
excl: sífilis Y70, gonorreia Y71, herpes Y72, escabiose S73
critérios: sinais de inflamação do prepúcio ou glande

Y76 CONDILOMA ACUMINADO ***A63.0***

incl: verrugas venéreas; infecção do vírus papiloma humano
critérios: aparência característica de lesões, ou aparência histológica característica

Y77 NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA ***C61***

critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia benigna/incerta (quando não há dados histológicos disponíveis) Y79

Y78 NEOPLASIA MALIGNA GENITAL, OUTRA ***C50, C60, C62, C63***

incl: testículos, seminoma, carcinoma masculino da mama
critérios: aparência histológica característica
considerar: neoplasia benigna/incerta (quando não há dados histológicos disponíveis) Y79

Y79 NEOPLASIA GENITAL MASCULINA BENIGNA/INCERTA ***D07.4 a D07.6, D24, D29, D40, D48.6***

incl: neoplasia genital benigna, neoplasia genital não-especificada como benigna ou maligna ou quando a histologia não está disponível, neoplasia benigna na mama masculina, carcinoma *in-situ*
excl: hipertrofia prostática Y85

Y80 OUTRO TRAUMATISMO GENITAL MASCULINO ***S30.2, S31.2, S31.3, S31.5, S38.0, S38.2, T28.3, T28.8***

incl: circuncisão

Y81 FIMOSE/PREPÚCIO REDUNDANTE ***N47***

incl: parafimose
critérios: prepúcio redundante: comprimento excessivo do prepúcio, com incapacidade de retração sobre a glande;
fimose: prepúcio apertado, impedindo a retração sobre a glande

Y82 HIPOSPÁDIAS ***Q54***

Y83 TESTÍCULO NÃO-DESCIDO/CRIPTORQUIDIA/TESTÍCULO ECTÓPICO ***Q53***

incl: criptorquidia
excl: testículo retrátil Y05
critérios: o testículo nunca foi observado no escroto, o testículo não é palpável no escroto

Y84 MALFORMAÇÃO GENITAL CONGÊNITA ***Q55,Q56,Q83***

incl: hermafroditismo

Y85 HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA ***N40***

incl: fibroma; hiperplasia; barra mediana prostática; obstrução da próstata; prostatomegalia
critérios: próstata aumentada, lisa, dura, revelada por palpação, cistoscopia, ou imagiologia, sem sinais de carcinoma prostático
considerar: sintomas, sinais da micção U01 a U05; retenção da urina U08

Y86 HIDROCELE ***N43.0 a N43.3***

critérios: tumefação flutuante não-dolorosa, na zona dos testículos ou do cordão espermático com transiluminação da tumefação ou evidência imagiológica
considerar: sinais/sintomas do escroto ou dos testículos U05

Y99 OUTRA DOENÇA GENITAL ***A55, A57, A58, A63.8, N42.0 a N42.2, N42.8, N42.9, N43.4, N44, N48.0, N48.2, N48.5, N48.6, N48.8, N49.1, N49.2, N49.8, N49.9, N50.0, N50.1, N50.8, N50.9, N51.8, N64.8, Z90.7***

incl: doença da mama masculina; cisto epididimal; espermatocele; torção do testículo; outra doença dos genitais masculinos NE
excl: doença sexualmente transmissível NE A78; ginecomastia Y16; carcinoma da mama masculina Y78

Z – PROBLEMAS SOCIAIS

Componente 1 – Sinais e sintomas

Z01 POBREZA/PROBLEMAS ECONÔMICOS ***Z59.5, Z59.6, Z59.7 a Z59.9***

Nota: Problemas com as condições de vida exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de vida objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z02 PROBLEMAS RELACIONADOS À ÁGUA E À ALIMENTAÇÃO ***Z58.6,Z59.4***

Nota: Problemas com as condições de vida exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de vida objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z03 PROBLEMAS DE HABITAÇÃO/VIZINHANÇA ***Z59.0 a Z59.3, Z59.8, Z59.9***

Nota: Problemas com as condições de vida exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de vida objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z04 PROBLEMA SOCIOCULTURAL ***Z60.1 a Z60.9***

incl: gravidez ilegítima
excl: gravidez indesejada W79
Nota: Problemas com as condições de vida exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de vida objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z05 PROBLEMAS COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ***Z56.1 a Z56.7,Z57***

Nota: Problemas com as condições de vida exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de vida objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z06 PROBLEMA DE DESEMPREGO ***Z56.0***

excl: problemas decorrentes de inovações e mudanças P25
Nota: Problemas relacionados com o desemprego exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de emprego/desemprego objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z07 PROBLEMA RELACIONADO COM A EDUCAÇÃO ***Z55***

incl: analfabetismo
Nota: Problemas relacionados com a educação exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as qualificações do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z08 PROBLEMA RELACIONADO COM O SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL ***Z59.7***

Nota: Problemas com o sistema de segurança social exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições de segurança social objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z09 PROBLEMA LEGAL ***Z65.0 a Z65.3***

Nota: Problemas legais ou jurídicos exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as questões legais objetivas do paciente, este pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z10 PROBLEMA RELACIONADO COM O SISTEMA DE SAÚDE ***Z64.4,Z75***

Nota: Problemas com o sistema de saúde exigem a manifestação de preocupação por parte do paciente, assim como o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda. Quaisquer que sejam as condições do sistema de saúde objetivas, o paciente pode considerá-las um problema. Classificar esses problemas exige uma percepção clara das diferenças além de um bom julgamento do indivíduo.

Z11 PROBLEMA COM O ESTAR PACIENTE ***Z75***

incl: má aceitação
Nota: O diagnóstico de problemas sociais decorrentes do fato de se estar doente requer o reconhecimento por parte do paciente da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z12 PROBLEMA RELACIONAL COM O PARCEIRO ***T74.0, T74.3, Z63.0***

incl: abuso emocional
excl: abuso físico Z25
Nota: O diagnóstico de problemas relacionais entre parceiros requer o reconhecimento por parte do paciente da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z13 PROBLEMA COMPORTAMENTAL DO PARCEIRO ***Z63.0***

incl: infidelidade, abuso físico
Nota: O diagnóstico de problemas decorrentes do comportamento do parceiro requer o reconhecimento por parte do paciente da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z14 PROBLEMA POR DOENÇA DO PARCEIRO ***Z63.6***

Nota: O diagnóstico de problemas decorrentes de doença de um ou ambos os parceiros requer o reconhecimento por parte do paciente da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z15 PERDA OU FALECIMENTO DO PARCEIRO ***Z63.4,Z63.5***

incl: falecimento, divórcio, separação
Nota: O diagnóstico de problemas sociais decorrentes da perda ou falecimento do parceiro requer o reconhecimento por parte do paciente da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z16 PROBLEMA DE RELACIONAMENTO COM UMA CRIANÇA ***T74.0, T74.3, Z61, Z62, Z63.8***

incl: abuso emocional
excl: abuso físico Z25
Nota: O diagnóstico de problemas relacionais entre um adulto e uma criança requer o reconhecimento por parte do paciente da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z18 PROBLEMA COM UMA CRIANÇA DOENTE ***Z63.6***

O diagnóstico de problemas sociais decorrentes do fato de uma criança estar doente requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z19 PERDA OU FALECIMENTO DE UMA CRIANÇA ***Z63.4***

Nota: O diagnóstico de problemas decorrentes da perda ou morte de uma criança da família requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z20 PROBLEMA DE RELACIONAMENTO COM FAMILIARES ***T74.0,Z63.1,Z63.8***

incl: pais, irmão(s) adulto(s), outros elementos da família
excl: parceiro Z12, criança Z16, amigo Z24
Nota: O diagnóstico de problemas relacionais entre familiares requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z21 PROBLEMA COMPORTAMENTAL DE FAMILIAR ***Z63.1,Z63.9***

excl: comportamento da criança P22, adolescente P23, parceiro Z13
Nota: O diagnóstico de problemas decorrentes do comportamento de um elemento da família requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z22 PROBLEMA POR DOENÇA DE FAMILIAR ***Z63.6,Z63.7***

excl: parceiro doente Z14
Nota: O diagnóstico de problemas decorrentes da doença de um elemento da família requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z23 PERDA/FALECIMENTO DE FAMILIAR ***Z63.4***

excl: perda de uma criança Z19, perda do parceiro Z15
Nota: O diagnóstico de problemas decorrentes da perda ou do falecimento de um elemento da família requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z24 PROBLEMA DE RELACIONAMENTO COM AMIGOS ***Z63.9***

excl: familiares Z20
Nota: O diagnóstico de problemas relacionais entre amigos requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z25 ATO/ACONTECIMENTO VIOLENTO ***T74.1, T74.2, T74.8, T74.9, Z65.4, Z65.5***

incl: abuso físico de criança ou parceiro, violação, assédio sexual
excl: problemas físicos têm rubricas específicas em outros capítulos; problemas psicológicos ver Capítulo P
Nota: O diagnóstico de problemas sociais decorrentes de ataques ou outro acontecimento violento requer o reconhecimento da existência do problema e um desejo de ajuda.

Z27 MEDO DE PROBLEMA SOCIAL ***Z71.1***

incl: preocupação com o fato de vir a ter problemas sociais
excl: se o paciente tem o problema, codifique-o
critérios: paciente preocupado com problemas de ordem social sem os ter, ou enquanto o problema não está confirmado

Z28	**LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE**	***Z73.4,Z73.6***

incl: isolamento social, viver sozinho
Nota: Os quadros COOP/WONCA permitem codificar o estado funcional do paciente (ver Capítulo 8).

Z29	**PROBLEMA SOCIAL NE**	***Z58.0 a Z58.5, Z58.8, Z58.9, Z63.2, Z63.3, Z63.7, Z63.8, Z63.9, Z64.0, Z64.1, z65.8, z65.9, Z72.6, Z72.8, Z72.9, Z73.2, Z73.5, Z73.8, Z73.9, Z76.1***

incl: problemas com o ambiente no qual se está inserido, simulação de doença, poluição

11

CÓDIGOS DE CONVERSÃO PARA A CID-10

A relação entre a CIAP e a CID-10 é complexa. Cada uma tem conceitos para os quais não existe correspondente exato na outra[18]. Contudo, grande parte das rubricas de uma das classificações corresponde a uma ou mais rubricas da outra. Neste livro, foi possível estabelecer esta equivalência em ambos os sentidos.

Dada a complexidade da questão, a conversão de um código de uma classificação para a outra e a reconversão de novo para a primeira classificação muitas vezes não conduz ao código original, pois em cada um dos sentidos poderá haver vários códigos para escolher. A escolha exata só poderá ser feita se o título de uma condição é utilizado com a ajuda de um tesauro. O código de conversões deste livro permite apenas indicar os pontos em que os conteúdos das rubricas de cada classificação se sobrepõem.

CONVERSÃO DA CIAP-2 PARA A CID-10

Na lista tabular de rubricas da CIAP-2 (Capítulo 10), cada rubrica inclui todas as rubricas da CID-10 correspondentes. Sempre que corresponder a todo o código de três dígitos da CID-10,este é indicado. Quando corresponder apenas parcialmente ao código de três dígitos da CID-10, todos os códigos de quatro dígitos da CID-10 são indicados. Contudo, isso não significa que os códigos da CID-10 listados se relacionem apenas com a rubrica da CIAP-2, dado que algumas rubricas da CID-10 se relacionam com mais de uma rubrica da CIAP-2 conforme se pode verificar ao usar a lista de conversão contida neste capítulo.

CONVERSÃO DA CID-10 PARA A CIAP-2

Neste capítulo, são fornecidos os códigos de conversão de todos os códigos de três dígitos da CID-10. Contudo, sempre que o código de três dígitos

não corresponder ao mesmo código da CIAP-2, são fornecidas as conversões de todos os códigos de quatro dígitos da CID-10. Por outro lado, as rubricas com asterisco na CID-10, que denotam manifestações das doenças, não são incluídas, pois nunca são usadas como diagnósticos principais; nem o são igualmente as rubricas do capitulo XX da CID-10, correspondente a causas externas de morbidade e mortalidade, dado que a CIAP não se baseia na etiologia. A exclusão dessas rubricas da CID-10 ajuda a evitar a confusão e salienta que essas conversões são mais indicadoras que exatas.

CID-10	CIAP-2
A00	D70
A01	D70
A02	D70
A03	D70
A04	D70
A05	D70
A06	D70
A07	D70
A08	D70
A09	D73
A15	A70
A16	A70
A17	A70
A18	A70
A19	A70
A20	A78
A21	A78
A22	A78
A23	A78
A24	A78
A25	A78
A26	A78
A27	A78
A28	A78
A30	A78
A31	A78
A32.1	N71
A32.0	S76
A32.7	A78
A32.8	A78
A32.9	A78
A33	N72
A34	N72
A35	N72
A36	R83
A37	R71
A38	A78
A39.0	N71
A39.1	A78

CID-10	CIAP-2
A39.2	A78
A39.3	A78
A39.8	A78
A39.9	A78
A40	A78
A41	A78
A42	A78
A43	A78
A44	A78
A46	S76
A48.0	A78
A48.1	R81
A48.2	A78
A48.3	A78
A48.4	A78
A48.8	A78
A49	A78
A50	X70
A50	Y70
A51	X70
A51	Y70
A52	X70
A52	Y70
A53	X70
A53	Y70
A54	X71
A54	Y71
A55	X99
A55	Y99
A56	X92
A57	X99
A57	Y99
A58	X99
A58	Y99
A59.0	X73
A59.0	Y73
A59.8	A78
A59.9	A78
A60	X90

CID-10	CIAP-2
A60	Y72
A63.0	X91
A63.0	Y76
A63.8	X99
A63.8	Y99
A64	A78
A65	X70
A65	Y70
A66	S76
A67	S76
A68	A78
A69.0	D83
A69.1	D83
A69.2	A78
A69.8	A78
A69.9	A78
A70	A78
A71	F86
A74.0	F70
A74.8	A78
A74.9	A78
A75	A78
A77	A78
A78	A78
A79	A78
A80	N70
A81	N73
A82	A77
A83	N71
A84	N71
A85.0	N70
A85.1	N71
A85.2	N71
A85.8	N71
A86	N71
A87	N71
A88.0	A76
A88.1	H82
A88.8	N73

CID-10	CIAP-2
A89	N73
A90	A77
A91	A77
A92	A77
A93	A77
A94	A77
A95	A77
A96	A77
A98	A77
A99	A77
B00.0	S71
B00.1	S71
B00.2	D83
B00.2	R74
B00.3	N71
B00.4	N71
B00.5	F73
B00.7	A77
B00.8	S71
B00.9	S71
B01	A72
B02	S70
B03	A76
B04	A76
B05	A71
B06	A74
B07	S03
B08.0	A76
B08.1	S95
B08.2	A76
B08.3	A76
B08.4	A76
B08.5	R74
B08.8	A76
B09	A76
B09	D72
B15	D72
B16	D72
B17	D72

CID-10	CIAP-2
B18	D72
B19	D72
B20	B90
B21	B90
B22	B90
B23	B90
B24	B90
B25	A77
B26	D71
B27	A75
B30	F70
B33.0	A77
B33.1	A77
B33.2	K70
B33.3	A77
B33.8	A77
B34	A77
B35	S74
B36	S74
B37.0	D83
B37.1	B83
B37.2	S75
B37.3	X72
B37.4	U72
B37.4	X72
B37.4	Y75
B37.5	N71
B37.6	K70
B37.7	A78
B37.8	A78
B37.9	A78
B38	A78
B39	A78
B40	A78
B41	A78
B42	A78
B43	A78
B44	R83
B45	A78
B46	A78
B47	A78
B48	A78
B49	A78
B50	A73
B51	A73
B52	A73
B53	A73
B54	A73
B55	A78
B56	A78
B57	A78
B58.0	F73
B58.1	D97
B58.2	N71
B58.3	R83
B58.8	A78
B58.9	A78
B59	A78
B60	A78
B64	A78
B65	D96
B66	D96
B67	D96
B68	D96
B69	D96
B70	D96
B71	D96
B72	D96
B73	D96
B74	D96
B75	D96
B76	D96
B77	D96
B78	D96
B79	D96
B80	D96
B81	D96
B82	D96
B83	D96
B85	S73
B86	S72
B87	S73
B88.0	S72
B88.1	S73
B88.2	S72
B88.3	S73
B88.8	S73
B88.9	S73
B89	A78
B90	A70
B91	N70
B92	A78
B94.0	F86
B94.1	N71
B94.2	D97
B94.8	A78
B94.9	A78
B95	A78
B96	A78
B97	A77
B99	A78
C00	D77
C01	D77
C02	D77
C03	D77
C04	D77
C05	D77
C06	D77
C07	D77
C08	D77
C09	R85
C10	R85
C11	R85
C12	R85
C13	R85
C14.0	R85
C14.1	R85
C14.2	R85
C14.8	D77
C15	D77
C16	D74
C17	D77
C18	D75
C19	D75
C20	D75
C21	D75
C22	D77
C23	D77
C24	D77
C25	D76
C26	D77
C30.0	R85
C30.1	H75
C31	R85
C32	R85
C33	R84
C34	R84
C37	B74
C38.0	K72
C38.1	A79
C38.2	A79
C38.3	A79
C38.4	R85
C38.8	A79
C39	R85
C40	L71
C41	L71
C43	S77
C44	S77
C45.0	R85
C45.1	D77
C45.2	K72
C45.7	A79
C45.9	A79
C46.0	S77
C46.1	S77
C46.2	D77
C46.3	B74
C46.7	A79
C46.8	A79
C46.9	A79
C47	N74
C48	D77
C49	L71
C50	X76
C50	Y78
C51	X77
C52	X77
C53	X75
C54	X77
C55	X77
C56	X77
C57	X77
C58	W72
C60	Y78
C61	Y77
C62	Y78
C63	Y78
C64	U75
C65	U75
C66	U77
C67	U76
C68	U77
C69	F74
C70	N74
C71	N74
C72	N74
C73	T71
C74	T73
C75	T73
C76	A79
C77	B74
C78	A79
C79	A79
C80	A79
C81	B72
C82	B72
C83	B72
C84	B72
C85	B72
C88	B74
C90	B74
C91	B73
C92	B73

CID-10	CIAP-2
C93	B73
C94	B73
C95	B73
C96	B74
C97	A79
D00	D78
D01	D78
D02	R92
D03	S79
D04	S79
D05	X81
D06	X75
D07.0	X81
D07.1	X81
D07.2	X81
D07.3	X81
D07.4	Y79
D07.5	Y79
D07.6	Y79
D09.0	U79
D09.1	U79
D09.2	F74
D09.3	T73
D09.7	A79
D09.9	A79
D10	D78
D11	D78
D12	D78
D13	D78
D14	R86
D15.0	B75
D15.1	K72
D15.2	K72
D15.7	A99
D15.9	A99
D16	L97
D17	S78
D18	S81
D19	R86
D20	D78
D21	L97
D22	S82
D23	S79
D24	X79
D24	Y79
D25	X78
D26	X80
D27	X80
D28	X80
D29	Y79
D30	U78

CID-10	CIAP-2
D31	F74
D32	N75
D33	N75
D34	T72
D35	T73
D36.0	B75
D36.1	N75
D36.7	A99
D36.9	A99
D37	D78
D38	R92
D39	X81
D40	Y79
D41	U79
D42	N76
D43	N76
D44	T73
D45	B75
D46	B82
D47	B75
D48.0	L97
D48.1	L97
D48.2	N76
D48.3	D78
D48.4	D78
D48.5	S79
D48.6	X81
D48.6	Y79
D48.7	F74
D48.7	K72
D48.8	H75
D48.9	A99
D50	B80
D51	B81
D52	B81
D53	B82
D55	B82
D56	B78
D57	B78
D58	B78
D59	B82
D60	B82
D61.0	B79
D61.1	A85
D61.2	A86
D61.3	B82
D61.8	B82
D61.9	B82
D62	B82
D64.0	B79
D64.1	B82

CID-10	CIAP-2
D64.2	A85
D64.2	A86
D64.3	B82
D64.4	B79
D64.8	B82
D64.9	B82
D65	B83
D66	B83
D67	B83
D68	B83
D69	B83
D70	B84
D71	B84
D72	B84
D73	B99
D74	B99
D75	B99
D76	B99
D80	B99
D81	B99
D82	B99
D83	B99
D84	B99
D86	B99
D89	B99
E00	T80
E01	T86
E02	T86
E03	T86
E04	T81
E05	T85
E06.0	T70
E06.1	T99
E06.2	T99
E06.3	T99
E06.4	T99
E06.5	T99
E06.9	T99
E07	T99
E10	T89
E11	T90
E12	T90
E13	T90
E14	T90
E15	T87
E16	T87
E20	T99
E21	T99
E22	T99
E23	T99
E24	T99

CID-10	CIAP-2
E25	T99
E26	T99
E27	T99
E28	T99
E29	T99
E30	T99
E31	T99
E32	T99
E34.0	T99
E34.1	T99
E34.2	T99
E34.3	T10
E34.4	T99
E34.5	T99
E34.8	T99
E34.9	T99
E40	T91
E41	T91
E42	T91
E43	T91
E44	T91
E45	T91
E46	T91
E50	T91
E51.1	T91
E51.2	N99
E51.8	T91
E51.9	T91
E52	T91
E53	T91
E54	T91
E55	T91
E56	T91
E58	T91
E59	T91
E60	T91
E61	T91
E63	T91
E64	T91
E65	T99
E66	T82
E66	T83
E67	T99
E68	T99
E70	T99
E71	T99
E72	T99
E73	T99
E74	T99
E75	T99
E76	T99

CID-10	CIAP-2
E77	T99
E78	T93
E79	T99
E80	T99
E83	A91
E84	T99
E85	T99
E86	T11
E87	T99
E88	T99
E89	A87
F81	P70
F02	P70
F03	P70
F04	P71
F05	P71
F06	P71
F07	P71
F09	P71
F10.0	P16
F10.1	P15
F10.2	P15
F10.3	P15
F10.4	P15
F10.5	P15
F10.6	P15
F10.7	P15
F10.8	P15
F10.9	P15
F11	P19
F12	P19
F13	P18
F13	P19
F14	P19
F15	P19
F16	P19
F17	P17
F18	P19
F19	P18
F19	P19
F20	P72
F21	P72
F22	P72
F23	P98
F24	P72
F25	P72
F28	P72
F29	P72
F30	P73
F31	P73
F32	P76

CID-10	CIAP-2
F33	P76
F34.0	P73
F34.1	P76
F34.8	P76
F34.9	P76
F38	P76
F39	P76
F40	P79
F41.0	P74
F41.1	P74
F41.2	P76
F41.3	P74
F41.4	P74
F41.5	P74
F41.6	P74
F41.7	P74
F41.8	P74
F41.9	P01
F41.9	P74
F42	P79
F43.0	P02
F43.1	P82
F43.2	P02
F43.8	P02
F43.9	P02
F44	P75
F45.1	P75
F45.2	P75
F45.3	*
F45.4	*
F45.8	*
F45.9	*
F48.0	P78
F48.1	P79
F48.8	P79
F48.9	P79
F50.0	P86
F50.1	P86
F50.2	P86
F50.3	P86
F50.4	P02
F50.4	P86
F50.5	D10
F50.8	P29
F50.9	P29
F51	P06
F52.0	P07
F52.1	P08
F52.2	P08
F52.3	P08
F52.4	P08

CID-10	CIAP-2
F52.5	P08
F52.8	P08
F52.9	P08
F53.0	P76
F53.1	P98
F53.8	P99
F53.9	P99
F54	P99
F55	P18
F59	P99
F60	P80
F61	P80
F62	P80
F63	P80
F63.3	P29
F64	P09
F65	P09
F66	P09
F68	P80
F69	P80
F70	P85
F71	P85
F72	P85
F73	P85
F78	P85
F79	P85
F80	P24
F80.9	P22
F81	P24
F82	P24
F83	P24
F84	P99
F88	P99
F89	P99
F90	P81
F91	P22
F91	P23
F92	P22
F92	P23
F93	P22
F94	P22
F94	P23
F95	P10
F98.0	P12
F98.1	P13
F98.2	P11
F98.3	P11
F98.4	P10
F98.5	P10
F98.6	P10
F98.8	P22

CID-10	CIAP-2
F98.8	P23
F98.8	P29
F98.9	P22
F98.9	P23
F98.9	P29
F99	P77
F99	P99
G00	N71
G03	N71
G04	N71
G06	N73
G08	N73
G09	N73
G10	N99
G11	N99
G12	N99
G20	N87
G21	N87
G23	N99
G24	N99
G25.0	N08
G25.1	N08
G25.2	N08
G25.3	N08
G25.4	N08
G25.5	N08
G25.8	N04
G25.8	N08
G25.9	N08
G30	P70
G31.0	N99
G31.1	N99
G31.2	P15
G31.8	N99
G31.9	N99
G35	N86
G36	N99
G37	N99
G40	N88
G41	N88
G43	N89
G44.0	N90
G44.1	N89
G44.2	N95
G44.3	N01
G44.4	A85
G44.8	N01
G45	K89
G47	P06
G50.0	N92
G50.1	N03

CID-10	CIAP-2
G50.8	N92
G50.9	N92
G51	N91
G52	N99
G54	N94
G56.0	N93
G56.1	N94
G56.2	N94
G56.3	N94
G56.4	N94
G56.8	N94
G56.9	N94
G57	N94
G58	N94
G60	N94
G61	N94
G62	N94
G64	N94
G70	N99
G71	N99
G72	N99
G80	N99
G81	N99
G82	N99
G83	N99
G90	N99
G91	N99
G92	N99
G93.0	N99
G93.1	N99
G93.2	N99
G93.3	A04
G93.4	N99
G93.5	N99
G93.6	N99
G93.7	N99
G93.8	N99
G93.9	N99
G95	N99
G96	N99
G97	A87
G98	N18
G98	N99
H00	F72
H01	F72
H02.0	F99
H02.1	F99
H02.2	F16
H02.3	F16
H02.4	F16
H02.5	F16
H02.6	F16
H02.7	F16
H02.8	F99
H02.9	F99
H04.0	F99
H04.1	F99
H04.2	F03
H04.3	F73
H04.4	F73
H04.5	F99
H04.6	F99
H04.8	F99
H04.9	F99
H05.0	F73
H05.1	F73
H05.2	F99
H05.3	F99
H05.4	F99
H05.5	F99
H05.8	F99
H05.9	F99
H10.0	F70
H10.1	F71
H10.2	F70
H10.3	F70
H10.4	F70
H10.5	F70
H10.8	F70
H10.9	F70
H11.0	F99
H11.1	F99
H11.2	F99
H11.3	F75
H11.4	F99
H11.8	F99
H11.9	F99
H15	F99
H16.0	F85
H16.1	F73
H16.2	F73
H16.3	F73
H16.4	F73
H16.8	F73
H16.9	F73
H17	F99
H18	F99
H20	F73
H21	F73
H25	F92
H26	F92
H27	F99
H30	F73
H31	F99
H33	F82
H34	F99
H35.0	F83
H35.1	F83
H35.2	F83
H35.3	F84
H35.4	F83
H35.5	F99
H35.6	F99
H35.7	F99
H35.8	F99
H35.9	F99
H40	F93
H43	F99
H44.0	F99
H44.1	F99
H44.2	F99
H44.3	F99
H44.4	F99
H44.5	F99
H44.6	F79
H44.7	F79
H44.8	F99
H44.9	F99
H46	F99
H47	F99
H49	F95
H50	F95
H51	F95
H52	F91
H53.0	F99
H53.1	F05
H53.2	F05
H53.3	F05
H53.4	F99
H53.5	F99
H53.6	F99
H53.8	F04
H53.9	F05
H54.0	F94
H54.1	F94
H54.2	F94
H54.3	F94
H54.4	F28
H54.5	F28
H54.6	F28
H54.7	F05
H55	F14
H57.0	F99
H57.1	F01
H57.8	F02
H57.8	F13
H57.8	F15
H57.8	F99
H57.9	F29
H59	F99
L30.0	S88
L30.1	S92
L30.2	S99
L30.3	S88
L30.4	S88
L30.5	S99
L30.8	S88
L30.9	S88
L40	S91
L41	S99
L42	S90
L43	S99
L44	S99
L50	S98
L51	S99
L52	S99
L53.0	S99
L53.1	S99
L53.2	S99
L53.3	S99
L53.8	S99
L53.9	S06
L53.9	S07
L55	S80
L56	S80
L57	S80
L58	S80
L59	S80
L60.0	S94
L60.1	S22
L60.2	S99
L60.3	S99
L60.4	S22
L60.5	S22
L60.8	S99
L60.9	S22
L63	S23
L64	S23
L65	S23
L66	S23
L67	S24
L68	S24
L70	S96
L71	S99

CID-10	CIAP-2
L72.0	S99
L72.1	S93
L72.2	S99
L72.8	S99
L72.9	S99
L73.0	S99
L73.1	S99
L73.2	S92
L73.8	S99
L73.9	S99
L74	S92
L75	S92
L80	S99
L81.0	S08
L81.1	S08
L81.2	S08
L81.3	S08
L81.4	S99
L81.5	S99
L81.6	S99
L81.7	S99
L81.8	S99
L81.9	S99
L82	S99
L83	S99
L84	S20
L85	S99
L87	S99
L88	S99
L89	S97
L90	S99
L91	S99
L92	S99
L93	S99
L94	S99
L95	S99
L97	S99
L98.0	S76
L98.1	S99
L98.2	S99
L98.3	S99
L98.4	S97
L98.5	S99
L98.6	S99
L98.7	S99
L98.8	S99
L98.9	S99
M00	L70
M02	L99
M05	L88
M06	L88

CID-10	CIAP-2
M08	L88
M10	T92
M11	T99
M12	L99
M13	L91
M15	L91
M16	L89
M17	L90
M18	L91
M19	L91
M20	L98
M21	L98
M22.0	L80
M22.1	L80
M22.2	L99
M22.3	L99
M22.4	L99
M22.8	L99
M22.9	L99
M23	L99
M24	L99
M25.0	L99
M25.1	L99
M25.2	L99
M25.3	L99
M25.4	L08
M25.4	L10
M25.4	L11
M25.4	L12
M25.4	L13
M25.4	L15
M25.4	L16
M25.4	L17
M25.4	L20
M25.5	L07
M25.5	L08
M25.5	L10
M25.5	L11
M25.5	L12
M25.5	L13
M25.5	L15
M25.5	L16
M25.5	L17
M25.5	L20
M25.6	L08
M25.6	L10
M25.6	L11
M25.6	L12
M25.6	L13
M25.6	L15
M25.6	L16

CID-10	CIAP-2
M25.6	L17
M25.6	L20
M25.7	L99
M25.8	L20
M25.8	L99
M25.9	L20
M25.9	L99
M30	K99
M31	K99
M32	L99
M33	L99
M34	L99
M35	L99
M40	L85
M41	L85
M42	L94
M43.0	L84
M43.1	L84
M43.2	L99
M43.3	L83
M43.4	L83
M43.5	L84
M43.6	L83
M43.8	L85
M43.9	L85
M45	L88
M46.0	L84
M46.1	L84
M46.2	L70
M46.3	L70
M46.4	L70
M46.5	L70
M46.8	L84
M46.9	L84
M47.0	L84
M47.1	L86
M47.2	L86
M47.8	L83
M74.8	L84
M47.9	L83
M47.9	L84
M48	L83
M48	L84
M50	L83
M51	L84
M51	L86
M53.0	L83
M53.1	L83
M53.2	L84
M53.3	L03
M53.3	L84

CID-10	CIAP-2
M53.8	L84
M53.9	L84
M54.0	L01
M54.0	L02
M54.0	L03
M54.1	L99
M54.2	L01
M54.3	L86
M54.4	L86
M54.5	L03
M54.6	L02
M54.8	L02
M54.9	L02
M60.0	L70
M60.1	L18
M60.2	L18
M60.8	L18
M60.9	L18
M61	L99
M62.0	L99
M62.1	L99
M62.2	L99
M62.3	L99
M62.4	L99
M62.5	L19
M62.6	L19
M62.8	L99
M62.9	L99
M65.0	L70
M65.1	L70
M65.2	L87
M65.3	L87
M65.8	L87
M65.9	L87
M66	L99
M67.0	L99
M67.1	L99
M67.2	L99
M67.3	L87
M67.4	L87
M67.8	L99
M67.9	L99
M70	L87
M71.0	L70
M71.1	L70
M71.2	L87
M71.3	L87
M71.4	L87
M71.5	L87
M71.8	L87
M71.9	L87

CID-10	CIAP-2
M72	L87
M75	L92
M76	L87
M77.0	L87
M77.1	L93
M77.2	L87
M77.3	L87
M77.4	L17
M77.5	L17
M77.8	L87
M77.9	L87
M79.0	L18
M79.1	L18
M79.2	N29
M79.2	N99
M79.3	L99
M79.4	L99
M79.5	L81
M79.6	L09
M79.6	L18
M79.8	L99
M79.9	L19
M80	L95
M81	L95
M83	T99
M84	L99
M86	L70
M87	L99
M88	L99
M89	L99
M91	L94
M92	L94
M93	L94
M94	L99
M95	L99
M96	A87
M99	L99
N00	U88
N01	U88
N02	U06
N03	U88
N04	U88
N05	U88
N06	U99
N07	U88
N10	U70
N11	U70
N12	U70
N13	U99
N14	U88
N15.0	U88

CID-10	CIAP-2
N15.1	U70
N15.8	U88
N15.9	U70
N17	U99
N18	U99
N19	U99
N20	U95
N21	U95
N23	U14
N25	U99
N26	U99
N27	U99
N28	U99
N30	U71
N31	U99
N32	U99
N34	U72
N35	U99
N36	U99
N39.0	U71
N39.2	U90
N39.3	U04
N39.4	U04
N39.8	U99
N39.9	U99
N40	Y06
N40	Y85
N41	Y73
N42.0	Y99
N42.1	Y99
N42.2	Y99
N42.8	Y99
N42.9	Y06
N42.9	Y99
N43.0	Y86
N43.1	Y86
N43.2	Y86
N43.3	Y86
N43.4	Y99
N44	Y99
N45	Y74
N46	Y10
N47	Y81
N48.0	Y99
N48.1	Y75
N48.2	Y99
N48.3	Y08
N48.4	Y07
N48.5	Y99
N48.6	Y99
N48.8	Y99

CID-10	CIAP-2
N48.9	Y01
N48.9	Y04
N48.9	Y08
N49.0	Y73
N49.1	Y99
N49.2	Y99
N49.8	Y99
N49.9	Y99
N50.0	Y99
N50.1	Y99
N50.8	Y99
N50.9	Y02
N50.9	Y05
N50.9	Y29
N60	X88
N61	X21
N61	X99
N62	X21
N62	Y16
N63	X19
N63	Y16
N64.0	X20
N64.1	X99
N64.2	X99
N64.3	X21
N64.4	X18
N64.5	X20
N64.5	X21
N64.8	X99
N64.8	Y99
N64.9	X21
N70	X74
N71	X74
N72	X85
N73	X74
N75	X99
N76	X84
N80	X99
N81	X87
N82	X99
N83	X99
N84.0	X99
N84.1	X85
N84.2	X99
N84.3	X99
N84.8	X99
N84.9	X99
N85	X99
N86	X85
N87	X85
N88	X85

CID-10	CIAP-2
N89.0	X99
N89.1	X99
N89.2	X99
N89.3	X99
N89.4	X99
N89.5	X99
N89.6	X99
N89.7	X99
N89.8	X14
N89.9	X15
N90.0	X99
N90.1	X99
N90.2	X99
N90.3	X99
N90.4	X99
N90.5	X99
N90.6	X99
N90.7	X99
N90.8	X99
N90.9	X16
N91	X05
N92.0	X06
N92.1	X07
N92.2	X06
N92.3	X08
N92.4	X06
N92.5	X07
N92.6	X07
N93.0	X13
N93.8	X08
N93.9	X08
N94.0	X03
N94.1	X04
N94.2	X04
N94.3	X89
N94.4	X02
N94.5	X02
N94.6	X02
N94.8	X99
N94.9	X09
N94.9	X17
N94.9	X29
N94.9	X99
N95.0	X12
N95.1	X11
N95.2	X11
N95.3	X11
N95.8	X11
N95.9	X11
N96	X99
N97	W15

CID-10	CIAP-2
N98	X99
N99	A87
O00	W80
O01	W73
O02	W82
O03	W82
O04	W83
O05	W82
O06	W82
O07	W99
O08	W99
O10	W81
O11	W81
O12	W81
O13	W81
O14	W81
O15	W18
O16	W81
O20	W03
O21	W05
O22	W99
O23	W71
O24.0	W84
O24.1	W84
O24.2	W84
O24.3	W84
O24.4	W85
O24.9	W84
O25	W84
O26	W99
O28	W99
O29	A87
O30	W84
O31	W84
O32	W84
O33	W84
O34	W84
O35	W84
O36	W84
O40	W84
O41.0	W99
O41.1	W71
O41.8	W99
O41.9	W99
O42	W92
O42	W93
O43	W84
O44	W84
O45	W92
O45	W93
O46	W03

CID-10	CIAP-2
O47	W99
O84	W99
O60	W92
O60	W93
O61	W92
O61	W93
O62	W92
O62	W93
O63	W92
O63	W93
O64	W92
O64	W93
O65	W92
O65	W93
O66	W92
O66	W93
O67	W92
O67	W93
O68	W92
O68	W93
O69	W92
O69	W93
O70	W92
O70	W93
O71	W92
O71	W93
O72	W17
O73	W92
O73	W93
O74	A87
O75	W92
O75.0	W92
O75.0	W93
O75.1	W92
O75.1	W93
O75.2	W71
O75.3	W71
O75.4	W99
O75.4	W99
O75.5	W92
O75.5	W93
O75.6	W92
O75.6	W93
O75.7	W92
O75.7	W93
O75.8	W92
O75.8	W93
O75.9	W92
O75.9	W93
O80	W90
O81	W92

CID-10	CIAP-2
O81	W93
O82	W92
O82	W93
O83	W92
O83	W93
O84	W92
O84	W93
O85	W70
O86.0	A87
O86.1	W70
O86.2	W71
O86.3	W70
O86.4	W71
O86.8	W71
O87	W96
O88	W99
O89	A87
O90.0	A87
O90.1	A87
O90.2	A87
O90.3	K84
O90.4	W96
O90.5	W99
O90.8	W96
O90.9	W18
O90.9	W96
O91	W94
O92.0	W95
O92.1	W95
O92.2	W95
O92.3	W95
O92.4	W95
O92.5	W19
O92.6	W19
O92.7	W19
O95	W99
O96	W99
O97	W99
O98	W71
O99	W76
O99	W84
P00	A94
P01	A94
P02	A94
P03	A94
P04	A94
P05	A94
P07	A93
P08	A94
P10	A94
P11	A94

CID-10	CIAP-2
P12	A94
P13	A94
P14	A94
P15	A94
P20	A94
P21	A94
P22	A94
P23	A94
P24	A94
P25	A94
P26	A94
P27	A94
P28	A94
P29	A94
P35	A74
P35	A94
P36	A94
P37	A94
P38	A94
P39	A94
P50	A94
P51	A94
P52	A94
P53	A94
P54	A94
P55	A94
P56	A94
P57	A94
P58	A94
P59	A94
P60	A94
P61	A94
P70	A94
P71	A94
P72	A94
P74	A94
P76	A94
P77	A94
P78	A94
P80	A94
P81	A94
P83	A94
P60	A94
P91	A94
P92	A94
P93	A94
P94	A94
P95	A95
P96	A94
Q00	N85
Q01	N85

CID-10	CIAP-2
Q02	N85
Q03	N85
Q04	N85
Q05	N85
Q06	N85
Q07	N85
Q10.0	F81
Q10.1	F81
Q10.2	F81
Q10.3	F81
Q10.4	F81
Q10.5	F80
Q10.6	F81
Q10.7	F81
Q11	F81
Q12	F81
Q13	F81
Q14	F81
Q15	F81
Q16	H80
Q17	H80
Q18	D81
Q20	K73
Q21	K73
Q22	K73
Q23	K73
Q24	K73
Q25	K73
Q26	K73
Q27	K73
Q28	K73
Q30	R89
Q31	R89
Q32	R89
Q33	R89
Q34	R89
Q35	D81
Q36	D81
Q37	D81
Q38	D81
Q39	D81
Q40	D81
Q41	D81
Q42	D81
Q43	D81
Q44	D81
Q45	D81
Q50	X83
Q51	X83
Q52	X83
Q53	Y83
Q54	Y82
Q55	Y84
Q56	X83
Q56	Y84
Q60	U85
Q61	U85
Q62	U85
Q63	U85
Q64	U85
Q65	L82
Q66	L82
Q67	L82
Q68	L82
Q69	L82
Q70	L82
Q71	L82
Q72	L82
Q73	L82
Q74	L82
Q75	L82
Q76	L82
Q77	L82
Q78	L82
Q79	L82
Q80	S83
Q81	S83
Q82	S83
Q83	X83
Q83	Y84
Q84	S83
Q85	A90
Q86	A90
Q87	A90
Q89.0	B79
Q89.1	T80
Q89.2	T78
Q89.2	T80
Q89.3	A90
Q89.4	A90
Q89.7	A90
Q89.8	B79
Q89.9	A90
Q90	A90
Q91	A90
Q92	A90
Q93	A90
Q95	A90
Q96	A90
Q97	A90
Q98	A90
Q99	A90
R00.0	K04
R00.1	K04
R00.2	K04
R00.8	K05
R01	K81
R02	K92
R03.0	K85
R03.1	K29
R04.0	R06
R04.1	R29
R04.2	R24
R04.8	R29
R04.9	R29
R05	R05
R06.0	R02
R06.1	R04
R06.2	R03
R06.3	R04
R06.4	R98
R06.5	R04
R06.6	R29
R06.7	R07
R06.8	R04
R07.0	R21
R07.1	R01
R07.2	K01
R07.2	K02
R07.3	A11
R07.4	A11
R09.0	R29
R09.1	R82
R09.2	R29
R09.3	R25
R09.8	K03
R09.8	K29
R09.8	R21
R09.8	R29
R10.0	D01
R10.1	D02
R10.1	D06
R10.2	D04
R10.2	D06
R10.2	Y02
R10.3	D04
R10.3	D06
R10.4	D01
R11	D09
R11	D10
R12	D03
R13	D21
R14	D08
R15	D17
R16.0	D23
R16.1	B87
R16.2	N87
R16.2	D23
R17	D13
R18	D29
R19.0	D24
R19.0	D25
R19.1	D29
R19.2	D29
R19.3	D29
R19.4	D18
R19.5	D18
R19.6	D20
R19.8	D29
R20.0	N06
R20.1	N06
R20.2	N05
R20.3	N06
R20.8	N06
R20.8	S01
R21	S05
R21	S06
R21	S07
R22	S04
R23.0	S08
R23.1	S08
R23.2	S08
R23.3	S29
R23.4	S21
R23.8	S29
R25.0	N08
R25.1	N08
R25.2	L14
R25.3	N08
R25.8	N08
R26	N29
R27	N29
R29.0	N08
R29.0	N29
R29.1	N29
R29.1	N29
R29.2	N29
R29.3	L29
R29.4	L13
R29.8	L04
R29.8	L05
R29.8	L07
R29.8	L09
R29.8	L12

CID-10	CIAP-2
R29.8	L14
R29.8	L17
R29.8	L29
R29.8	N29
R30	U01
R31	U06
R32	U04
R33	U08
R34	U05
R35	U02
R36	X29
R36	Y03
R39.0	U13
R39.1	U05
R39.2	U99
R39.8	U07
R39.8	U13
R40	A07
R41	P20
R42	N17
R43	N 16
R44	P29
R45.0	P01
R45.1	P04
R45.2	P03
R45.3	P03
R45.4	P04
R45.5	P04
R45.6	P04
R45.7	P29
R45.8	P29
R46	P29
R46.8	A18
R46.8	H15
R46.8	W21
R46.8	X22
R47	N19
R48	P24
R49	R23
R50	A02
R50	A03
R51	N01
R51	N03
R52	A01
R52	S01
R52	X01
R52	Y01
R52	Y02
R53	A04
R53	A05
R54	P05
R55	A06
R56	N07
R57	K99
R58	A10
R59	B02
R60	K07
R61	A09
R62.0	P22
R62.8	T10
R62.9	T10
R63.0	T03
R63.1	T01
R63.2	T02
R63.3	T04
R63.3	T05
R63.4	T08
R63.5	T07
R63.8	T29
R64	T08
R68.0	A29
R68.1	A16
R68.2	D20
R68.3	S22
R68.8	A02
R68.8	A08
R68.8	A29
R68.8	B04
R68.8	B29
R68.8	W29
R69	A99
R70	B99
R71	B99
R72	B84
R73	A91
R74	A91
R75	B90
R76	A91
R77	A91
R78	A91
R79	A91
R80	U98
R81	U98
R82	U98
R83	A91
R84	A91
R85	A91
R86	A91
R87	A91
R87	X86
R88	A91
R89	A91
R90	A91
R91	A91
R92	A91
R93	A91
R94	A91
R95	A95
R95	A96
R96	A96
R98	A96
R99	A96
S00.0	S16
S00.0	S17
S00.0	S18
S00.0	S19
S00.1	F75
S00.2	F79
S00.3	R88
S00.4	H78
S00.5	D80
S00.7	S16
S00.7	S17
S00.7	S18
S00.7	S19
S00.8	S16
S00.8	S17
S00.8	S18
S00.8	S19
S00.9	S16
S00.9	S17
S00.9	S18
S00.9	S19
S00.9	H78
S01.0	S18
S01.1	F79
S01.2	S18
S01.3	H79
S01.4	S18
S01.5	D80
S01.7	S18
S01.8	S18
S01.9	S18
S02.0	N80
S02.1	N80
S02.2	L76
S02.3	L76
S02.4	L76
S02.5	D80
S02.6	L76
S02.7	L76
S02.8	L76
S02.9	L76
S03.0	L80
S03.1	R88
S03.2	D80
S03.3	L80
S03.4	L79
S03.5	L79
S04	N81
S05.0	F79
S05.1	F75
S05.2	F79
S05.3	F79
S05.4	F79
S05.5	F79
S05.6	F79
S05.7	F79
S05.8	F79
S05.9	F79
S06.0	N79
S06.1	N80
S06.2	N80
S06.3	N80
S06.4	N80
S06.5	N80
S06.6	N80
S06.7	N80
S06.8	N80
S06.9	N80
S07	N80
S08	N80
S09.0	N80
S09.1	L81
S09.2	H79
S09.7	N80
S09.8	N80
S09.9	H78
S09.9	N81
S10	S16
S10	S17
S10	S19
S11	A80
S11	S18
S12	L76
S13.0	L80
S13.1	L80
S13.2	L80
S13.3	L80
S13.4	L83
S13.5	L83
S13.6	L83
S14	N81
S15	A80

CID-10	CIAP-2
S16	L81
S17	L81
S18	L81
S19	L81
S20	S16
S20	S17
S20	S19
S21	A80
S21	S18
S22	L76
S23.0	L81
S23.1	L80
S23.2	L80
S23.3	L79
S23.4	L79
S23.5	L79
S24	N81
S25	A80
S26	A80
S27	A80
S27	R88
S28	L81
S29	L81
S30.0	S16
S30.1	S16
S30.2	X82
S30.2	Y80
S30.7	S17
S30.7	S19
S30.8	S17
S30.8	S19
S30.9	S17
S30.9	S19
S31.0	A80
S31.0	S18
S31.1	A81
S31.1	S18
S31.2	Y80
S31.3	Y80
S31.4	X82
S31.5	X82
S31.5	Y80
S31.7	A81
S31.8	S18
S32	L76
S33.0	L81
S33.1	L80
S33.2	L80
S33.3	L80
S33.4	L81
S33.5	L84
S33.6	L79
S33.7	L84
S34	N81
S35	A80
S36.0	B76
S36.1	D80
S36.2	D80
S36.3	D80
S36.4	D80
S36.5	D80
S36.6	D80
S36.7	A81
S36.8	A81
S36.9	A81
S37.0	U80
S37.1	U80
S37.2	U80
S37.3	U80
S37.4	X82
S37.5	X82
S37.6	X82
S37.7	A81
S37.8	A81
S37.9	A80
S38.0	X82
S38.0	Y80
S38.1	A80
S38.2	X82
S38.2	Y80
S38.3	A80
S39	A80
S39	A81
S39	L81
S40	S16
S40	S17
S40	S19
S41	S18
S42	L76
S43.0	L80
S43.1	L80
S43.2	L80
S43.3	L80
S43.4	L79
S43.5	L79
S43.6	L79
S43.7	L79
S44	N81
S45	A80
S46	L81
S47	L81
S48	L81
S49	L81
S50	S16
S50	S17
S50	S19
S51	S18
S52	L72
S53.0	L80
S53.1	L80
S53.2	L79
S53.3	L79
S53.4	L79
S54	N81
S55	A80
S56	L81
S57	L81
S58	L81
S59	L81
S60	S16
S60	S17
S60	S19
S61	S18
S62	L74
S63.0	L80
S63.1	L80
S63.2	L80
S63.3	L79
S63.4	L79
S63.5	L79
S63.6	L79
S63.7	L79
S64	N81
S65	A80
S66	L81
S67	L81
S68	L81
S69	L81
S70	S16
S70	S17
S70	S19
S71	S18
S72	L75
S73.0	L80
S73.1	L79
S74	N81
S75	A80
S76	L81
S77	L81
S78	L81
S79	L81
S80	S16
S80	S17
S80	S19
S81	S18
S82.0	L76
S82.1	L73
S82.2	L73
S82.3	L73
S82.4	L73
S82.5	L73
S82.6	L73
S82.7	L73
S82.8	L73
S82.9	L73
S83.0	L80
S83.1	L80
S83.2	L96
S83.3	L96
S83.4	L78
S83.5	L96
S83.6	L78
S83.7	L96
S84	N81
S85	A80
S86	L81
S87	L81
S88	L81
S89	L81
S90	L16
S90	S17
S90	S19
S91	S18
S92	L74
S93.0	L80
S93.1	L80
S93.2	L79
S93.3	L80
S93.4	L77
S93.5	L79
S93.6	L79
S94	N81
S95	A80
S96	L81
S97	L81
S98	L81
S99	L81
T00	A81
T01	A81
T02	A81
T03	A81
T04	A81
T05	A81
T06.0	N81

CID-10	CIAP-2
T06.1	N81
T06.2	N81
T06.3	K99
T06.4	L81
T06.5	A81
T06.6	A81
T06.7	A81
T06.8	A81
T07	A81
T08	L76
T09	A80
T10	L76
T11	L81
T12	L76
T13	L81
T14.0	S12
T14.0	S15
T14.0	S16
T14.0	S17
T14.0	S19
T14.1	S13
T14.1	S15
T14.1	S18
T14.2	L76
T14.3	L79
T14.3	L80
T14.4	N81
T14.5	A80
T14.6	L81
T14.7	A80
T14.7	L81
T14.8	A80
T14.9	A80
T14.9	B77
T14.9	W75
T15	F16
T16	H76
T17	R87
T18	D79
T19.0	U80
T19.1	U80
T19.2	X82
T19.3	X82
T19.8	U99
T19.9	U99
T20	S14
T21	S14
T22	S14
T23	S14
T24	S14
T25	S14
T26	F79
T27	R88
T28.0	D80
T28.1	D80
T28.2	D80
T28.3	U80
T28.3	X82
T28.3	Y80
T28.4	A80
T28.5	D80
T28.6	D80
T28.7	D80
T28.8	U80
T28.8	X82
T28.8	Y80
T28.9	A80
T29	A81
T30	S14
T31	S14
T32	S14
T33	A88
T34	A88
T35	A88
T36	A84
T37	A84
T38	A84
T39	A84
T40	A84
T41	A84
T42	A84
T43	A84
T44	A84
T45	A84
T46	A84
T47	A84
T48	A84
T49	A84
T50	A84
T51	A86
T52	A86
T53	A86
T54	A86
T55	A86
T56	A86
T57	A86
T58	A86
T59	A86
T60	A86
T61	A86
T62	A86
T63	A86
T64	A86
T65	A86
T66	A88
T67	A88
T68	A88
T69	A88
T70.0	H79
T70.1	R88
T70.2	A88
T70.3	A88
T70.4	A88
T70.8	A88
T70.9	A88
T71	A88
T73	A88
T74.0	Z12
T74.0	Z16
T74.0	Z20
T74.1	Z25
T74.2	Z25
T74.3	Z12
T74.3	Z16
T74.8	Z25
T74.9	Z25
T75	A88
T78.0	A92
T78.1	A92
T78.2	A92
T78.3	A92
T78.4	A92
T78.8	A88
T78.9	A88
T79.0	A82
T79.1	A82
T79.2	A82
T79.3	S11
T79.4	A82
T79.5	A82
T79.6	L99
T79.7	A82
T79.8	A82
T79.9	A82
T80	A87
T81	A87
T82	A89
T83	A89
T83	W12
T84	A89
T85	A89
T86	A87
T87	A87
T88.0	A85
T88.1	A85
T88.2	A85
T88.3	A85
T88.4	A85
T88.5	A85
T88.6	A87
T88.7	A87
T88.8	A85
T88.9	A85
T90	A82
T91	A82
T92	A82
T93	A82
T94	A82
T95	A82
T96	A82
T97	A82
T98	A82
Z00	-30
Z00	A97
Z01	-31
Z01	-32
Z01	-33
Z01	-34
Z01	-35
Z01	-36
Z01	-37
Z01	-38
Z01	-39
Z01	-40
Z01	-41
Z01	-42
Z01	-43
Z02	-30
Z02	-62
Z03	-45
Z04.0	-34
Z04.1	-31
Z04.2	-31
Z04.3	-31
Z04.4	-31
Z04.5	-31
Z04.6	-31
Z04.8	-31
Z04.9	-31
Z08	-31
Z09	-31
Z10	-30
Z11	-31
Z11	-32

CID-10	CIAP-2
Z11	-33
Z11	-34
Z11	-35
Z11	-36
Z11	-38
Z11	-39
Z12	-31
Z12	-32
Z12	-33
Z12	-34
Z12	-35
Z12	-36
Z12	-37
Z12	-38
Z12	-40
Z12	-41
Z12	-43
Z13	-31
Z13	-34
Z13	-35
Z13	-36
Z13	-38
Z13	-39
Z13	-40
Z13	-41
Z13	-42
Z13	-43
Z20	A23
Z21	B90
Z22	A99
Z23	A23
Z24	A23
Z25	A23
Z26	A23
Z27	A23
Z28	A23
Z29	A23
Z30.0	W14
Z30.0	Y14
Z30.1	W12
Z30.2	W13
Z30.2	Y13
Z30.3	W10
Z30.3	W83
Z30.4	W11
Z30.5	W12
Z30.8	-37
Z30.8	W14
Z30.8	Y14
Z30.9	W14
Z30.9	X10
Z30.9	Y14
Z31	W15
Z32.0	W01
Z32.1	W78
Z32.1	W79
Z33	W78
Z34	W31
Z34	W78
Z35	W84
Z36	-43
Z37.0	W90
Z37.1	W91
Z37.1	W93
Z37.2	W92
Z37.3	W93
Z37.4	W93
Z37.5	W92
Z37.6	W93
Z37.7	W93
Z37.9	W90
Z37.9	W91
Z37.9	W92
Z37.9	W93
Z38	W90
Z38	W92
Z39	W31
Z40	-59
Z41	-69
Z42	-59
Z43	-53
Z43	-54
Z44	-54
Z45	-54
Z46.0	F17
Z46.0	F18
Z46.1	H54
Z46.2	N54
Z46.3	D54
Z46.4	D54
Z46.5	D54
Z46.6	U54
Z46.7	L54
Z46.8	-54
Z46.9	A54
Z47	L54
Z48	-51
Z48	-52
Z48	-54
Z48	-56
Z48	-59
Z49	U51
Z49	U59
Z50	-57
Z51.0	-59
Z51.1	-50
Z51.2	-50
Z51.3	-50
Z51.4	-59
Z51.5	-50
Z51.5	-51
Z51.5	-53
Z51.5	-55
Z51.5	-57
Z51.5	-58
Z51.5	-59
Z51.6	-55
Z51.8	-50
Z51.8	-50
Z51.8	-51
Z51.8	-52
Z51.8	-53
Z51.8	-54
Z51.8	-55
Z51.8	-56
Z51.8	-57
Z51.8	-58
Z51.8	-62
Z51.8	-63
Z51.8	-64
Z51.8	-65
Z51.8	-66
Z51.8	-67
Z51.8	-68
Z51.8	-69
Z51.8	A98
Z51.9	-59
Z51.9	-63
Z51.9	-64
Z51.9	-65
Z51.9	-66
Z51.9	-67
Z51.9	-68
Z51.9	-69
Z52	-69
Z53	-69
Z54	-63
Z54	-69
Z55	Z07
Z56.0	Z06
Z56.1	Z05
Z56.2	Z05
Z56.3	Z05
Z56.4	Z05
Z56.5	Z05
Z56.6	Z05
Z56.7	Z05
Z57	Z05
Z58.0	Z29
Z58.1	Z29
Z58.2	Z29
Z58.3	Z29
Z58.4	Z29
Z58.5	Z29
Z58.6	Z02
Z58.8	Z29
Z58.9	Z29
Z59.0	Z03
Z59.1	Z03
Z59.2	Z03
Z59.3	Z03
Z59.4	Z02
Z59.5	Z01
Z59.6	Z01
Z59.7	Z01
Z59.7	Z08
Z59.8	Z01
Z59.8	Z03
Z59.9	Z01
Z59.9	Z03
Z60	P25
Z60	Z04
Z60	P25
Z61	Z16
Z62	Z16
Z63.0	Z12
Z63.0	Z13
Z63.1	Z20
Z63.1	Z21
Z63.2	Z29
Z63.3	Z29
Z63.4	Z15
Z63.4	Z19
Z63.4	Z23
Z63.5	Z15
Z63.6	Z14
Z63.6	Z18
Z63.6	Z22
Z63.7	Z22
Z63.7	Z29
Z63.8	Z16
Z63.8	Z20
Z63.8	Z29
Z63.9	Z21

CID-10	CIAP-2
Z63.9	Z24
Z63.9	Z29
Z64.0	Z29
Z64.1	Z29
Z64.2	P29
Z64.3	P29
Z64.4	Z10
Z65.0	Z09
Z65.1	Z09
Z65.2	Z09
Z65.3	Z09
Z65.4	Z25
Z65.5	Z25
Z65.8	Z29
Z65.9	Z29
Z70	P58
Z70	X24
Z71.0	-65
Z71.0	-69
Z71.1	-69
Z71.1	A13
Z71.1	A25
Z71.1	A26
Z71.1	A27
Z71.1	B25
Z71.1	B26
Z71.1	B27
Z71.1	D26
Z71.1	D27
Z71.1	F27
Z71.1	H27
Z71.1	K24
Z71.1	K25
Z71.1	K27
Z71.1	L26
Z71.1	L27
Z71.1	N26
Z71.1	N27
Z71.1	P27
Z71.1	R26
Z71.1	R27
Z71.1	S26
Z71.1	S27
Z71.1	T26
Z71.1	T27
Z71.1	U26
Z71.1	U27
Z71.1	W02
Z71.1	W27

CID-10	CIAP-2
Z71.1	X23
Z71.1	X24
Z71.1	X25
Z71.1	X26
Z71.1	X27
Z71.1	Y24
Z71.1	Y25
Z71.1	Y26
Z71.1	Y27
Z71.1	Z27
Z71.2	-60
Z71.2	-61
Z71.3	-45
Z71.4	P58
Z71.5	P58
Z71.6	P58
Z71.7	B58
Z71.8	-58
Z71.8	A20
Z71.9	-45
Z71.9	-58
Z72.0	A23
Z72.1	A23
Z72.2	A23
Z72.3	A23
Z72.4	A23
Z72.5	A23
Z72.6	Z29
Z72.8	Z29
Z72.9	Z29
Z73.0	P29
Z73.1	P29
Z73.2	A23
Z73.2	Z29
Z73.4	Z28
Z73.5	Z29
Z73.6	-28
Z73.6	A28
Z73.6	B28
Z73.6	D28
Z73.6	F28
Z73.6	H28
Z73.6	K28
Z73.6	L28
Z73.6	N28
Z73.6	P28
Z73.6	R28
Z73.6	S28
Z73.6	T28

CID-10	CIAP-2
Z73.6	U28
Z73.6	W28
Z73.6	X28
Z73.6	Y28
Z73.6	Z28
Z73.8	Z29
Z73.9	Z29
Z74	A28
Z75	Z10
Z75	Z11
Z76.0	-50
Z76.1	Z29
Z76.2	-49
Z76.3	-69
Z76.4	-69
Z76.5	P80
Z76.8	-46
Z76.8	-47
Z76.8	-48
Z76.8	-49
Z76.8	-64
Z76.8	-65
Z76.8	-69
Z76.8	A97
Z76.9	-69
Z80	A21
Z81	A23
Z82.0	A23
Z82.1	A23
Z82.2	A23
Z82.3	K22
Z82.4	K22
Z82.5	A23
Z82.6	A23
Z82.7	A23
Z82.8	A23
Z83	A23
Z84	A23
Z85	A21
Z86.0	A23
Z86.1	A23
Z86.2	A23
Z86.3	A23
Z86.4	A23
Z86.5	A23
Z86.6	A23
Z86.7	K22
Z87	A23
Z88	A23

CID-10	CIAP-2
Z89	L99
Z90.0	A99
Z90.1	X99
Z90.2	R99
Z90.3	D99
Z90.4	D99
Z90.5	U99
Z90.6	U99
Z90.7	X28
Z90.7	X99
Z90.7	Y28
Z90.7	Y99
Z90.8	A99
Z91	A23
Z92	A23
Z93.0	R28
Z93.1	D28
Z93.2	D28
Z93.3	D28
Z93.4	D28
Z93.5	U28
Z93.6	U28
Z93.8	A28
Z93.9	A28
Z94.0	U99
Z94.1	K99
Z94.2	R99
Z94.3	K99
Z94.3	R99
Z94.4	D99
Z94.5	S99
Z94.6	L99
Z94.7	F99
Z94.8	A99
Z94.9	-99
Z94.9	A99
Z95	A89
Z96	A89
Z97	A89
Z98.0	D99
Z98.1	L99
Z98.2	N99
Z98.8	A99
Z99.0	A28
Z99.1	R28
Z99.2	U28
Z99.3	A28
Z99.8	A28
Z99.9	A28

ÍNDICE

Este índice não pretende ser exaustivo nem constitui uma nomenclatura (ver Capítulo 1); trata-se apenas de uma lista de títulos de rubricas (em maiúsculas) e de termos de inclusão nas rubricas (em minúsculas). Incluem os sinônimos e termos mais comuns em medicina de família e comunidade e atenção primária à saúde. Caso necessitem de um índice ou nomenclatura mais aprofundada, os usuários serão obrigados a desenvolver a sua própria ou servir-se de outras existentes em países como na Austrália, Canadá, Bélgica e Holanda e em alguns países escandinavos (no CD desta edição há um tesauro disponível desenvolvido pelo Ministério da Saúde belga e traduzido pela SBMFC). Se o usuário decidir desenvolver seu próprio índice, deverá realizar este trabalho juntamente com o Comitê de Classificação da WONCA de forma a garantir uma certa coerência. Esta edição fornece o Tesauro desenvolvido pelo grupo belga e traduzido pela SBMFC.

Este índice não inclui abreviaturas, com a exceção das seguintes:

/ = ou.
NE = não especificado de outra forma.

Abandono, drogas P19
Abcesso cerebral N73
Abcesso cutâneo S10
Abcesso dentário D82
Abcesso isquiorretal D95
ABCESSO NASAL R73
ABCESSO PERIANAL D95
Abcesso perinefrítico U70
Abcesso perirenal U70
Abcesso peritonsilar R76
Abcesso pilonidal S85
Aborto completo W82
ABORTO ESPONTÂNEO W82
Aborto habitual W82
Aborto incompleto W82
ABORTO PROVOCADO W83
Aborto retido W82
Aborto, ameaça de W82
Abrasão da córnea F79
ABUSO Z25
ABUSO AGUDO DE ÁLCOOL P16
ABUSO CRÔNICO DE ÁLCOOL P15
ABUSO DE DROGAS P19
ABUSO DE MEDICAÇÃO P18
ABUSO DE MEDICAMENTOS P18
ABUSO DE TABACO P17
Abuso emocional (infantil) Z16
Abuso emocional do parceiro Z12
Abuso emocional pelo parceiro Z12
Abuso físico (infantil) Z25
Abuso físico do parceiro Z25
Abuso físico Z25
Acalasia D84
Acidente de viação A80
Acidente vascular cerebral K90
Acidez D03

ACNE ... S96
Aconselhamento genético, feminino ... W14
Aconselhamento genético, masculino ... Y14
Acromegalia ... T99
Adenovírus,doença de ... A77
Aderência abdominal ... D99
Afasia ... N19
Afogamento ... A88
Afonia ... R23
Aftas NE ... A78
Aftas, boca ... D83
Aftas, genitais femininos ... X72
Aftas, pele, unha ... S75
Agitação ... P04
Agranulocitose ... B84
AIDS ... B90
AIDS, RECEIO DE ... B25
Albuminúria ... U90
ÁLCOOL ABUSO CRÔNICO DE ... P15
ÁLCOOL, ABUSO AGUDO DE ... P16
Alcoolismo ... P15
Alergia à medicação ... A85
Alergia alimentar ... A92
Alergia cutânea ... S88
Alopecia ... S23
Alteração da cor dos olhos ... F15
ALTERAÇÃO DAS SENSAÇÕES ... N06
Alterações de comportamento, adulto ... P80
ALTERAÇÕES DE PERSONALIDADE ... P80
ALTERAÇÕES DO METABOLISMO LIPÍDIOS ... T93
Alucinações ... P29
Ambliopia ... F99
Amenorreia ... X05
Amígdalas grandes ... R21
Amígdalas, dores ... R21
AMIGDALITE, AGUDA ... R76
Amigdalite, crônica ... R90
Amiloidose ... T99
Amnésia global transitória ... K89
Amnésia ... P20
Amputação antiga ... A82
Amputação traumática recente ... L81
Amputação traumática ... L81
Anafilaxia de medicação ... A85
Analfabetismo ... Z07
ANÁLISES À URINA ANORMAIS ... U98
Anemia da gravidez ... W84
Anemia de células falciformes ... B78
Anemia hemolítica adquirida ... B82
ANEMIA HEMOLÍTICA ... B78
ANEMIA HEREDITÁRIA ... B81
Anemia macrocítica ... B81
Anemia megaloblástica ... B81
Anemia perniciosa ... B81
Anemia por plástica ... B82
ANEMIA, DEFICIÊNCIA DE ÁCIDO FÓLICO ... B81
ANEMIA, DEFICIÊNCIA DE FERRO ... B80
Anemia, deficiência de proteínas ... B82
ANEMIA, DEFICIÊNCIA DE VIT B12 ... B81
ANEMIA, OUTROS/NÃO-ESPECIFICADO ... B82
Anemia, perda de sangue ... B80
Anestesia ... N06
Aneurisma cardíaco ... K76
Aneurisma cerebral ... K91
Aneurisma da aorta ... K99
Aneurisma, outros ... K99
Angina de peito ... K74
Angina de vincent ... D82
Angina instável ... K74
ANOREXIA NERVOSA ... P86
Anorexia ... T03
Anosmia, alterações do olfato ... N16
Ansiedade e depressão ... P76
Ansiedade NE ... P01
Ansiedade ... P01
Anúria ... U05
AP. DIGESTIVO, SINAIS/SINTOMAS DO ... D29
APARÊNCIA ANORMAL DOS OLHOS ... F15
Aparente embriaguez ... N17
APENDICITE ... D88
Aperto no peito ... R29
APETITE EXCESSIVO ... T02
Apneia do sono ... P06
Apneia ... R04
Apoplexia ... K90
Aranhas vasculares ... K06
Arco senil ... F99
Ardor na pele ... S01
Ardor nos olhos ... F13
Ardor nos pés ... N05
ARRANHÃO ... S17
Arrepios ... A02
Arritmia cardíaca ... K80
Arteriosclerose ... K92
Arterite ... K99
Articulação fraca ... L20
ARTICULAÇÃO, SINAIS/SINTOMAS NE ... L20
Articulação, sinais/sintomas ... L07
Artralgia ... L20
Artrite juvenil ... L88
Artrite NE ... L91
Artrite piogênica ... L70
Artrite psoriásica ... L99
Artrite psoriásica ... S91
ARTRITE REUMATOIDE ... L88
Artrite, osteo: ver osteoartrose
artrodese ... L99
Artropatia cristal ... T99
Artropatia traumática ... L91

Artrose, osteo:ver osteoartrose
Ascite D29
Asma cardíaca K77
ASMA R96
Astigmatismo F91
Ataque (convulsão) N07
Ataque epiléptico N88
Ataque generalizado N88
Ataque isquêmico transitório K89
Ataque provocado por calor A88
Ataque vasovagal A06
ATAQUE K90
ATAQUE N07
Ataxia N29
Ateroma K92
ATEROSCLEROSE K92
ATO NOCIVO Z25
Atraso da fala P22
Atraso da menstruação, possibilidade de gravidez W01
Atraso de crescimento P22
Atraso fisiológico T10
ATRASO MENTAL P85
ATRASOS DE CRESCIMENTO T10
Atresia esofágica D81
Atrofia do músculo L19
AUDIÇÃO, QUEIXA H02
AUMENTO DE PESO T07
Aurícula acessória H80
Autismo P99
Avulsão da unha S19
AXILA, SINAIS/SINTOMAS DA L05
AZIA D03
BAÇO, RUPTURA B76
Bacteriúria assintomática U71
Baixa autoestima P28
BALANITE Y75
BALBUCIAR P10
Barra mediana da próstata Y85
Batimento ectópico K80
BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES K05
BENIGNA: ver NEOPLASIA BENIGNA
Beribéri T91
Bexiga irritável U13
BEXIGA, SINAIS/SINTOMAS U13
Bigeminia K80
BLEFARITE F72
Bloqueio cardíaco K84
Bloqueio de ramo K84
Bloqueio do ramo cardíaco direito K84
Bloqueio do ramo cardíaco esquerdo K84
Bloqueio eustaquiano H73
Boca dolorida D20
Boca seca D20
BOCA, SINAIS/SINTOMAS D20
BÓCIO T81
Bócio tóxico T85
Bolhas febris S71
Bolhas S17
BORBULHAS S96
BRAÇO, SINAIS/SINTOMAS DO L09
Bradicardia K80
Broncopneumonia R81
Bronquiectasias R99
BRONQUIOLITE AGUDA R78
BRONQUITE AGUDA R78
BRONQUITE CRÔNICA R79
Bronquite ruidosa R96
Bronquite, NE R78
Brucelose A78
BULIMIA P86
Bursite do ombro L92
BURSITE L87
CABELO, OUTROS SINAIS/SINTOMAS S24
CÃIBRA ABDOMINAL D01
Câibra na perna L14
CALAFRIOS A02
CALÁZIO F72
Cálculo da vesícula D98
Cálculo renal U95
Cálculo salivar D83
Cálculo urinário U95
Calor pruriginoso S92
CALOS S20
CALOSIDADES S20
CALVÍCIE S23
Canal arterial persistente K73
CANAL LACRIMAL OBSTRUÍDO, CRIANÇA F80
Canal lacrimal obstruído, não-infantil F99
Câncer: ver NEOPLASIA MALIGNA
Candidíase do pênis Y75
CANDIDÍASE GENITAL FEMININA X72
CANDIDÍASE NA PELE S75
Candidíase oral D83
Candidíase perianal S75
Cansaço muscular L19
CANSAÇO A04
Caquexia T08
Característica da célula falciforme B78
CARBÚNCULO S10
Carcinoma de células basais S77
Carcinoma de células escamosas S77
Carcinoma in-situ, colo X81
Carcinoma in-situ, mama X81
Carcinoma in-situ: ver neoplasiano classificada/incerto, carcinomatose
Cardiomegalia K84
Cardiomiopatia K84
Cardiopatia isquêmica K76

Cardiovascular ... K22
Cáries ... D82
Carúnculo da uretra ... U99
Caspa ... S86
CATARATAS ... F92
CAXUMBA ... D71
CEFALEIA DE TENSÃO ... N95
Cefaleia vascular ... N89
CEFALEIA, SALVA ... N90
Cefaleias ... N01
Cegueira da neve ... F79
Cegueira de uma vista ... F28
Cegueira noturna ... F99
Cegueira temporária ... F05
CEGUEIRA ... F94
Celíaca, doença ... D99
CÉLULAS BRANCAS ANORMAIS ... B84
Celulite ... S29
Celulite ... S76
CERA EXCESSIVA NOS OUVIDOS ... H81
Cervicite ... X85
Cesariana ... W92/W93
Cestódeos ... D96
Choque anafilático ... A92
Choque anestésico ... A87
Choque cardiovascular ... K99
Choque de adaptação ... P02
Choque de cultura ... P02
Choque psíquico ... P02
Cianose ... S08
Ciática ... L86
Cicatriz ... S99
Cifoscoliose ... L85
Cifose ... L85
Circuncisão feminina ... X82
Circuncisão masculina ... I80
Cirrose ... D97
CISTITE ... U71
Cisto benigno do ovário ... X80
Cisto de Meibomius ... F72
Cisto dermoide ... S79
CISTO DO CANAL TIREOGLOSSO ... T78
Cisto epididimal ... Y99
Cisto fisiológico do ovário ... X99
Cisto ou abcesso de Bartholin ... X99
CISTO PILONIDAL ... S85
CISTO SEBÁCEO ... S93
Cisto sinovial ... L87
Cisto társico ... F72
Cistocele ... X87
Claudicação intermitente ... K92
Coccidínia ... L03
Colangite ... D98
Colapso de vértebra NE ... L84
Colapso do pulmão ... R99
Colapso ... A06
COLECISTITE ... D98
COLELITÍASE ... D98
Cólera ... D70
Colesteatoma ... H74
Colesterol alto/triglicerídeos ... T93
Cólica abdominal ... D01
Cólica biliar ... D98
Cólica infantil ... D01
Cólica renal ... U14
Colite mucosa ... D93
COLITE ULCEROSA ... D94
Cólon espástico ... D93
Colostomia ... A89
Coluna cervical, SINAIS/SINTOMAS DA ... L01
COLUNA LOMBAR, SINAIS/SINTOMAS ... L03
COLUNA, SINAIS/SINTOMAS DA ... L02
Coma insulínico ... T87
COMA ... A07
Complicações da rubéola ... A74
COMPLICAÇÕES DO PUERPÉRIO ... W96
COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO ... A87
Comportamento estranho ... P29
COMPORTAR-SE DE FORMA IRRITÁVEL/ZANGADA ... P04
CONCUSSÃO ... N79
CONDILOMA ACUMINADO FEMININO ... X91
CONDILOMA ACUMINADO MASCULINO ... Y76
Congestão dos seios nasais ... R09
CONGESTÃO NASAL ... R07
Congestão pélvica ... X99
CONJUNTIVITE ALÉRGICA ... F71
CONJUNTIVITE INFECCIOSA ... F70
Consciência, perda momentânea de ... A06
Constipação ... R74
Contato com doença infecciosa ... A23
CONTRACEPÇÃO INTRAUTERINA ... W12
Contracepção masculina ... Y14
CONTRACEPÇÃO NE ... W14
CONTRACEPÇÃO ORAL ... W11
CONTRACEPÇÃO PÓS-COITO ... W10
Contrações ... L99
Contratura de dupuytren ... L87
CONTUSÃO ... S16
Contusão cerebral ... N80
Contusão do rim ... U80
CONTUSÃO OCULAR ... F75
Convulsão febril ... N07
Convulsões ... D10
CONVULSÕES ... N07
Cor pulmonale ... K82
Coração fraco ... K29
CORAÇÃO, SENTIR A PRESENÇA DO ... K04
Coreia ... K71
Coriocarcinoma ... W72

Coriza ... R74
Corpo estranho engolido ... D79
CORPO ESTRANHO INALADO ... R87
Corpo estranho na boca ... D79
CORPO ESTRANHO NA LARINGE ... R87
CORPO ESTRANHO NA PELE ... S15
Corpo estranho na vagina ... X82
Corpo estranho no esôfago ... D79
CORPO ESTRANHO NO NARIZ ... R87
CORPO ESTRANHO NO OLHO ... F76
CORPO ESTRANHO NO OUVIDO ... H76
Corpo estranho no reto ... D79
CORPO ESTRANHO NO SISTEMA DIGESTIVO ... D79
Corpo estranho no trato urinário ... U80
CORPO ESTRANHO NOS BRÔNQUIOS ... R87
Corpo estranho profundo ... L81
Corpo estranho sob a unha ... S15
Corrimento nasal ... R07
Corrimento vaginal ... X14
Costocondrite ... L99
COTOVELO DE TENISTA ... L93
COTOVELO, SINAIS/SINTOMAS DO ... L10
Couro cabeludo seco ... S24
COURO CABELUDO, SINAIS/SINTOMAS ... S24
Coxeio ... N29
CRAVOS ... S96
Cretinismo ... T80
Criança chorona ... A16
Criança ciumenta ... P22
Criança hiperativa ... P22
Criança irrequieta ... A16
CRIANÇA IRRITADIÇA ... A16
Criptorquidia ... Y83
Crise da meia idade ... P25
Crise focal ... N88
Crosta láctea ... S86
Crupe ... R77
Dacriocistite ... F73
Daltonismo ... F99
Dedo em gatilho ... L87
Dedo em martelo ... L98
DEDO, SINAIS/SINTOMAS DO ... L12
Deficiência cromossômica ... A90
DEFICIÊNCIA DA COAGULAÇÃO ... B83
Deficiência de ferro, sem anemia ... T91
Deficiência do complemento ... B99
DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL ... T91
DÉFICIT VITAMÍNICO ... T91
Deformação congênita do pé ... L82
Deformação pós-traumática ... A82
DEGENERAÇÃO MACULAR ... F84
DEGENERESCÊNCIA MACULAR ... F84
Delinquência juvenil ... P23
Delírios ... P29
Delirium tremens ... P15
Delirium ... P71
DEMÊNCIA ... P70
DENTES/GENGIVA, DOENÇA ... D82
DENTES/GENGIVA, SINAIS/SINTOMAS ... D19
Dentição ... D19
Dependência de drogas ... P19
Depleção hídrica ... T11
Depressão pós parto ... P76
Depressão pós-natal ... P76
Depressão puerperal ... P76
Depressão reativa ... P76
DERMATITE ALÉRGICA ... S88
Dermatite artefacta ... S99
DERMATITE DE CONTATO ... S88
Dermatite flexural ... S87
Dermatite NE ... S88
Dermatite química ... S88
DERMATITE SEBORREICA ... S86
DERMATITE, ECZEMA ATÓPICO ... S87
Dermatite, pálpebra ... F72
DERMATOFITOSE ... S74
Dermatomicose ... S74
Dermatomiosite ... L99
Derrame da articulação ... L20
DESCOLAMENTO DA RETINA ... F82
Desconfiança ... P29
Desconforto abdominal ... D01
Desconforto epigástrico ... D02
Desejos de certos alimentos ... T29
DESEMPREGO ... Z06
Desenvolvimento atrasado ... T10
Desgaste da superfície articular ... L84
Desgaste muscular ... L19
DESIDRATAÇÃO ... T11
DESMAIO ... A06
Desmaios, síncope ... A06
Desmame ... W19
Desorientação ... P20
Desproporção ... W84
DIABETES GESTACIONAL ... W85
DIABETES INSULINODEPENDENTE ... T89
Diabetes juvenil ... T89
Diabetes na gravidez ... W84
DIABETES NÃO-INSULINODEPENDENTE ... T90
Diabetes NE ... T90
Diabetes tardia ... T90
Diabetes ... T99
Diabetes, tipo 1 ... T89
Diabetes, tipo 2 ... T90
DIARREIA ... D11
Diarreia presumivelmente infecciosa ... D73
Dieta deficiente ... T91
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, ESPECÍFICA ... P24
Dificuldade de concentração ... P20
Dificuldade em ler ... F05

Dificuldade em manter a atenção ... P81
DIFICULDADE RESPIRATÓRIA ... R02
DIFICULDADES EM RESPIRAR ... R04
Difteria ... R83
Diplopia ... F05
Disartria ... N19
Disenteria de organismo específico ... D70
Disenteria NE ... D73
Disfagia ... D21
Disfasia ... N19
Disfunção adrenal ... T99
Disfunção do ovário ... T99
Disfunção paratireoide ... T99
Disfunção pituitária ... T99
Disidrose ... S92
Dislexia ... P24
Dismenorreia ... X02
Dispareunia não orgânica ... P08
Dispareunia orgânica ... X04
DISPEPSIA ... D07
Displasia da mama ... X88
Displasia do colo ... X85
DISPNEIA ... R02
Distensão gasosa ... D08
Distocia ... W92/w93
Distonia ... N08
Distúrbio bipolar ... P73
Distúrbios de circulação, coração ... K84
Distúrbios de conversão ... P75
DISÚRIA ... U01
Diverticulite intestinal ... D92
Divertículo da bexiga ... U99
Divertículo de Meckel ... D81
Divertículo do esôfago ... D84
Diverticulose intestinal ... D92
Divórcio ... Z15
Doença autoimune do sangue ... B99
Doença cardíaca aterosclerótica ... K76
Doença cardíaca isquêmica sem angina ... K76
DOENÇA CARDÍACA ISQUÊMICA, COM ANGINA ... K74
DOENÇA CARDÍACA ISQUÊMICA, SEM ANGINA ... K76
Doença cardíaca NE ... K84
DOENÇA CARDÍACA REUMÁTICA ... K71
DOENÇA CARDÍACA, OUTROS ... K84
Doença cardíaca,arteriosclerose ... K76
DOENÇA CARDIOPULMONAR ... K82
DOENÇA CARDIOVASCULAR, OUTRA ... K99
DOENÇA CARDIOVASCULAR, OUTROS ... K99
Doença celíaca ... D99
DOENÇA CÍSTICA DA MAMA ... X88
DOENÇA CUTÂNEA, OUTROS ... S99
DOENÇA DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIO ... D83
DOENÇA DA LINFA, OUTROS ... B99
Doença da mama masculina ... Y99
Doença da mão, pé, boca ... A77
DOENÇA DA MASTOIDE ... H99
Doença da válvula aórtica ... K83
Doença da válvula tricúspide ... K83
DOENÇA DAS GLÂNDULAS SUDORÍPARAS ... S92
Doença das vias respiratórias, reativa ... R96
Doença de Alzheimer ... P70
Doença de Bowen ... S77
Doença de Coxsackie ... A77
Doença de Crohn ... D94
Doença de Graves ... T85
Doença de Hirschprung ... D81
DOENÇA DE HODGKIN ... B72
Doença de Legg-Calve-Perthes ... L94
Doença de Lime ... A78
Doença de Menière ... H82
Doença de natureza ou localização não-especificada ... A99
Doença de Osgood-Schlatter ... L94
Doença de Reiter ... L99
Doença de Scheuermann ... L94
DOENÇA DIVERTICULAR ... D92
Doença do adenovírus ... A77
DOENÇA DO AP. DIGESTIVO, OUTROS ... D99
DOENÇA DO AP. URINÁRIO, OUTROS ... U99
DOENÇA DO BAÇO, OUTROS ... B99
DOENÇA DO COLO NE ... X85
DOENÇA DO ESÔFAGO ... D84
DOENÇA DO FÍGADO ... D97
Doença do legionário ... R81
Doença do neurônio motor ... N99
DOENÇA DO OUVIDO, OUTROS ... H99
Doença do pericárdio ... K84
DOENÇA DO SIST. ENDÓCRINO, OUTROS ... T99
DOENÇA DOS OLHOS, OUTROS ... F99
DOENÇA ENDÓCRINA NE ... T99
DOENÇA FIBROCÍSTICA DA MAMA ... X88
DOENÇA GASTROINTESTINAL, OUTROS ... D99
DOENÇA GENITAL FEMININA, OUTROS ... X99
DOENÇA GENITAL MASCULINA, OUTROS ... Y99
Doença geral NE ... A99
DOENÇA GERAL, outros ... A99
Doença hidática ... D96
DOENÇA INFECCIOSA ... A78
Doença infecciosa por contacto ... A23
DOENÇA INFECCIOSA, OUTROS ... A78
Doença inflamatória da pélvis ... X74
Doença linfática, outros ... B99
Doença mental NE ... P99
Doença mieloproliferativa ... B74
DOENÇA MUSCULOESQUELÉTICA, OUTROS ... L99

DOENÇA NEUROLÓGICA, OUTROS N99
DOENÇA NUTRICIONAL, OUTROS T99
Doença óssea de Paget L99
Doença Parkinson N87
DOENÇA PULMONAR R95
Doença renal hipertensiva K87
DOENÇA RESPIRATÓRIA, OUTROS R99
DOENÇA SANGUÍNEA B99
DOENÇA SANGUÍNEA, OUTROS B99
Doença sexualmente transmitida, NE A78
DOENÇA VALVULAR CARDÍACA K83
Doença valvular mitral K83
Doença valvular pulmonar K83
DOENÇA VASCULAR CEREBRAL K91
Doença vascular mesentérica D99
DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA K92
DOENÇA VIRAL, OUTROS A77
DOENÇA VIRAL, OUTROS/NE A77
Doenças pancreáticas D99
DOR AO URINAR U01
Dor de cabeça pós-traumatismo N01
DOR DE CABEÇA N01
Dor de dentes D19
Dor de estômago D02
DOR DE OUVIDO(S) H01
DOR EPIGÁSTRICA D02
DOR GENITAL, FEMININO X01
DOR NA COLUNA, NE L02
DOR NA FACE N03
DOR NA MAMA, FEMININO X18
DOR NO ÂNUS/RETO D04
Dor no nariz R08
DOR NO OLHO F01
DOR NO PÊNIS Y01
Dor nos seios nasais R09
DOR NOS TESTÍCULOS/ESCROTO Y02
DOR/SENSIBILIDADE DOLOROSA NA PELE S01
DORES ABDOMINAIS GERAIS D01
DORES ABDOMINAIS LOCALIZADAS D06
DORES CARDÍACAS K01
DORES CARDIOVASCULARES NE K03
Dores de coluna, lombares L03
Dores de coluna, NE L02
Dores de coluna, torácicas L02
Dores de crescimento numa criança L29
DORES DO AP. RESPIRATÓRIO R01
Dores durante a ovulação X03
DORES GLÂNDULA(S) LINFÁTICA(S) Bo2
DORES INTERMENSTRUAIS X03
Dores lombares L03
Dores lombares L05
DORES MENSTRUAIS X02
Dores múltiplas A01
DORES MUSCULARES L18
Dores nas articulações L20
Dores NE A29
Dores no cólon D06
Dores no peito, musculoesquelético L04
DORES NO PEITO, NE A11
Dores pélvicas, feminino X01
Dores pélvicas, masculino Y02
Dores perineais, masculino Y02
Dores pleuríticas R01
DORES, GERAL A01
Duodenite D87
Eclampsia W81
Eco nos ouvidos H03
Ectrópio F99
ECZEMA ATÓPICO S87
Eczema externo do meato auditivo H70
Eczema infantil S87
Eczema varicoso K95
Eczema, NE S88
Edema alérgico A92
Edema angioneurótico A92
Edema da gravidez W81
Edema pulmonar K77
EDEMA K07
EFEITO DE UMA PRÓTESE A89
Efeito pós-concussão N79
EFEITO SECUNDÁRIO, FÍSICO A88
EFEITO TÓXICO, SUBSTÂNCIA NÃO-MEDICINAL A86
EFEITOS SECUNDÁRIOS DA MEDICAÇÃO A85
Efeitos secundários do tratamento A87
Efeitos secundários, frio A88
Efeitos secundários, pressão A88
Ejaculação precoce P08
Embolia arterial K92
Embolia cerebral K90
EMBOLIA PULMONAR K93
Embriaguez P16
Emese D10
Empiema R83
ENCEFALITE N71
Encefalopatia hipertensiva K87
ENCOPRESE P13
ENCOPRESE/PROBLEMAS DE INCONTINÊNCIA FECAL P13
Endarterite K92
Endocardite aguda/subaguda K70
Endocardite bacteriana K70
Endocardite crônica K83
Endometriose X99
Endometrite X74
ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO K75
Enfarte do miocárdio antigo K76
Enfisema cirúrgico R88
Enfisema R95

Enjoo de movimento ... A88
Enjoos matinais, gravidez ... W05
ENTERITE CRÔNICA ... D94
Enterite por giárdia ... D70
Enterite por salmonela ... D70
Enterite regional ... D94
Entrópio ... F99
Enurese orgânica ... U04
ENURESE ... P12
Envenenamento animal/inseto/planta ... A86
Envenenamento por chumbo ... A86
ENVENENAMENTO POR MEDICAÇÃO ... A84
ENXAQUECA ... N89
Epicondilite lateral ... L93
EPIDIDIMITE ... Y74
Epífise femural deslocada ... L94
Epiglotite ... R83
EPILEPSIA ... N88
Episclerite ... F99
EPISTÁXIS ... R06
Equimose ... S16
Erisipela ... S76
Eritema generalizado ... S07
Eritema localizado ... S06
Eritema multiforme ... S99
Eritema nodoso ... S99
EROSÃO DO COLO ... X85
Erosão gástrica aguda ... D86
ERRO REFRATIVO ... F91
ERUCTAÇÃO ... D08
Erupção ligeira polimorfa ... S80
Erupção provocada pela transpiração ... S92
Erupção provocada pelas fraldas ... S89
Erupção provocada pelo calor ... S92
ERUPÇÃO, FRALDAS ... S89
ERUPÇÃO, GENERALIZADA ... S07
ERUPÇÃO, LOCALIZADA ... S06
ESCABIOSE E OUTRAS ACARÍASES ... S72
ESCALDAMENTO ... S14
Escamação cutânea ... S21
Escaras ... S97
Escarlatina ... A78
Esclerite ... F99
Esclerodermia ... L99
Esclerose disseminada ... N86
ESCLEROSE MÚLTIPLA ... N86
Escoliose ... L85
Escorbuto ... T91
ESCORIAÇÃO ... S17
Escotoma ... F05
ESCROTO, SINAIS/SINTOMAS ... Y05
Esferocitose ... B78
Esfregaço de PAP ANORMAL ... X86
Esfregaço de PAP NORMAL ... X86
Esinofilia ... B84
Esofagite ... D84
Espasmo anal ... D04
Espasmo muscular ... N08
Espasmos ... N08
Espermatocelo ... Y99
Espinha bífida ... N85
ESPIRROS ... R07
ESPLENOMEGALIA ... B87
Espondilite anquilosante ... L88
Espondilolistese ... L84
Espondilose cervical ... L83
Espondilose ... L84
Esporão ósseo ... L87
Esquinência ... R76
ESQUIZOFRENIA ... P72
Estado epiléptico ... N88
Estarei grávida? ... W01
Estase venosa ... K95
Estenose arterial ... K92
Estenose mitral ... K71
Estenose pilórica ... D81
Esterilidade ... W15
ESTERILIZAÇÃO FEMININA ... W13
ESTERILIZAÇÃO MASCULINA ... Y13
Estômago, dilatação aguda do ... D87
Estomatite ... D83
ESTRABISMO ... F95
Estreitamento uretral ... U99
ESTRESSE AGUDO ... P02
ESTRESSE CRÔNICO ... P82
ESTRESSE, PÓS-TRAUMÁTICO ... P82
Estresse pós-traumático, imediato ... P02
Estresse, incontinência provocada por ... U04
Estrias atróficas ... S99
Estridor ... R04
EUTANÁSIA, PEDIDO/DISCUSSÃO DA ... A20
EXANTEMA VIRAL ... A76
Exaustão ... A04
EXCESSO DE PESO ... T83
EXPECTORAÇÃO/FLEUMA ANORMAL ... R25
Extrassístoles ... K80
Fadiga pós-viral ... A04
Fadiga ... A04
Fala enrolada ... N19
Falta de higiene ... P29
Faringite aguda ... R74
Faringite crônica ... R83
Fasciíte ... L87
FATO DE RISCO, DOENÇA CARDIOVASCULAR ... K22
FATO DE RISCO, MALIGNIDADE ... A21
FATO DE RISCO, NE ... A23
FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR ... K22
FEBRE ... A03
Febre com erupção cutânea ... A76
Febre de dengue ... A77
Febre de Ross River ... A77

Febre do feno ... R97
Febre glandular ... A75
Febre Q ... A78
Febre reumática ... K71
Febre tifoide ... D70
Ferimento cerebral ... N80
Ferimento com agulha ... S19
Ferimento da medula ... N81
Ferimento do nervo ... N81
FERIMENTO DO OUVIDO ... H79
Ferimento externo, ouvido ... H78
FERIMENTO GENITAL, FEMININO ... X82
FERIMENTO GENITAL, MASCULINO ... Y80
Ferimento interno ... A81
FERIMENTO MÚLTIPLO ... A81
FERIMENTO NA CABEÇA ... N80
FERIMENTO NE ... A80
FERIMENTO PROFUNDO, OUVIDO ... H79
FERIMENTO QUE COMPLICA A GRAVIDEZ ... W75
FERIMENTO SANGUE/LINFA/BAÇO, OUTROS ... B77
FERIMENTO, AP. DIGESTIVO ... D80
FERIMENTO, APARELHO URINÁRIO ... U80
FERIMENTO, CABEÇA ... N80
Ferimento, dentes ... D80
Ferimento, língua ... D80
FERIMENTO, MUSCULOESQUELÉTICO, NE ... L81
FERIMENTO, olho ... F79
Ferimento, órgão abdominal ... D80
Ferimento, parto ... W92/w93
Ferimento, pavilhão auricular ... H78
FERIMENTO, PELE, OUTROS ... S19
FERIMENTO, RESPIRATÓRIO ... R88
FERIMENTO, SISTEMA NERVOSO, OUTROS ... N81
Feto pequeno para a idade ... W84
Fezes duras ... D12
FEZES, ALTERAÇÃO DAS ... D18
FIBRILAÇÃO AURICULAR ... K78
Fibrilação ventricular ... K80
Fibroadenoma ... X79
Fibroadenose cística ... X88
Fibromialgia ... L18
Fibromioma do colo ... X78
FIBROMIOMA DO ÚTERO ... X78
Fibrose cística ... T99
Fibrosite ... L18
Fibrossarcoma ... L71
Fígado gordo ... D97
FIMOSE ... Y81
Final da gravidez ... W83
Fingir estar paciente ... Z29
FISSURA ANAL ... D95
Fissura do mamilo ... X20
Fístula anal ... D95
Fístula arteriovenosa ... K99
Fístula do aparelho genital ... X99
FISTULA PILONIDAL ... S85
FLANCO, SINAIS/SINTOMAS DO ... L05
FLATULÊNCIA ... D08
FLEBITE ... K94
Flebotrombose ... K94
FLUTTER AURICULAR ... K78
Flutter ventricular ... K80
Fluxo urinário reduzido ... U28
FOBIA ... P79
Foliculite ... S10
FORMIGAMENTO DEDOS MAÕS/PÉS ... N05
Formigamento nas mãos/pés ... N05
Fotofobia ... F13
Fotossensibilidade ... S80
FRAQUEZA GERAL ... A04
FRAQUEZA LOCALIZADA ... N18
Fratura de Colles ... L72
Fratura de Pott ... L73
Fratura devido à osteoporose ... L95
Fratura patológica NE ... L99
Fratura, carpo ... L74
Fratura, colo do fêmur ... L75
FRATURA, CÚBITO ... L72
Fratura, falange ... L74
FRATURA, FÊMUR ... L75
Fratura, má união ou não-união ... L99
Fratura, metatarso ... L74
FRATURA, NE ... L76
FRATURA, OSSO DA MÃO/PÉ ... L74
FRATURA, PERÔNIO ... L73
FRATURA, RÁDIO ... L72
Fratura, tarso ... L74
FRATURA, TÍBIA ... L73
Frieiras ... A88
Frieiras ... S71
Frigidez ... P07
Fumar, problemas ... P17
Função dos pulmões reduzida ... R28
FURÚNCULO DO NARIZ ... R73
FURÚNCULO ... S10
Furúnculo, meato auditivo externo ... H70
GAGUEJAR ... P10
Galactorreia, lactação ... W19
Galactorreia, não lactação ... X21
Gânglio ... L87
Gangrena ... K92
Gardnerella, vaginite por ... X84
Garganta inflamada ... R21
Garganta seca ... R21
Garganta vermelha ... R21
GARGANTA, SINAIS/SINTOMAS ... R21
Gases ... D08
Gastrite (incl. Alcoólica) ... D87
Gastrite alcoólica ... D87

Gastroenteropatia alérgica D99
Gastroenteropatia tóxica D99
GASTROENTRITE, PRESUMÍVEL INFECÇÃO D73
Gazes, dores D08
Gengivite D82
Genu recurvatum L82
Genu valgo/varo L98
Genu varum L82
GERAL, SINAIS/SINTOMAS, OUTROS A29
Ginecomastia Y16
GLÂNDULA(S) LINFÁTICA(S) DILATADA/DOLOROSA B02
GLAUCOMA F93
Glicosúria U98
GLÓBULOS BRANCOS ANORMAIS B84
GLOMERULONEFRITE U88
Glomerulonefrite, aguda U88
Glossite D83
GONORREIA, FEMININA X71
GONORREIA, MASCULINA Y71
Gosto anormal N16
GOTA T92
Gotejamento nasal R08
Gotejamento urina U05
Grande mal N88
Granuloma anular S99
Granuloma S99
GRÁVIDA OU NÃO? W01
GRAVIDEZ W78
GRAVIDEZ DE ALTO RISCO W84
GRAVIDEZ ECTÓPICA W80
Gravidez ilegítima Z04
Gravidez múltipla W84
GRAVIDEZ, INDESEJADA W79
GRAVIDEZ, SINAIS/SINTOMAS W29
GRAVIDEZ, TOXEMIA W81
GRAVIDEZ, VÔMITOS/NÁUSEAS W05
GRAVIDEZ/PARTO, PERTURBAÇÕES W99
Gripe gástrica D73
Halitose D20
Hálux valgo/varo L98
HEMANGIOMA S81
Hemartrose L81
HEMATEMESE D14
Hematoma extradural N80
Hematoma perianal K96
Hematoma subdural N80
Hematoma S16
HEMATÚRIA U06
Hemofilia B83
HEMOPTISE R24
HEMORRAGIA ANTES DO PARTO W03
Hemorragia cerebral traumática N80
Hemorragia cerebral K90
Hemorragia cutânea S29
Hemorragia de contacto do colo X13
HEMORRAGIA DO RETO D16
Hemorragia durante a ovulação X08
HEMORRAGIA INTERMENSTRUAL X08
Hemorragia na gravidez W03
HEMORRAGIA NASAL R06
HEMORRAGIA NE A10
HEMORRAGIA PÓS-COITO X13
Hemorragia pós-operatória A87
Hemorragia pós-parto W17
HEMORRAGIA PRÉ-PARTO W03
Hemorragia pubertal X08
Hemorragia subaracnóidea K90
Hemorragia subconjuntival F75
Hemorragia uterina disfuncional X08
Hemorragia, NE A10
HEMORRAGIA, OLHO F75
HEMORRAGIA, OUVIDO H05
HEMORRAGIA, PÓS-MENOPAUSA X12
HEMORRAGIA, PÓS-PARTO W17
Hemorragia, úlcera do duodeno D85
Hemorroida externa trombosada K96
HEMORROIDAS K96
Hepatite alcoólica D97
Hepatite NE D97
HEPATITE VIRAL D72
Hepatite, ativa crônica D72
HEPATOMEGALIA D23
Hermafroditismo X83
Hermafroditismo Y84
HÉRNIA ABDOMINAL, OUTROS D91
Hérnia diafragmática D90
Hérnia femural D91
Hérnia incisional D91
HÉRNIA INGUINAL D89
Hérnia umbilical D91
Hérnia ventral D91
HÉRNIA, HIATO D90
HERPES GENITAL, FEMININO X90
HERPES GENITAL, MASCULINO Y72
HERPES SIMPLES S71
Herpes simples, olho,sem úlcera da córnea F73
HERPES ZOSTER S70
Herpes zoster, oftálmico F73
Herpes, anogenital, feminino X90
Herpes, anogenital, masculino Y72
Hidradenite S92
Hidrâmnios W84
HIDROCÉFALO N85
Hidrocelo Y86
Hidronefrose U99
Hidropsia K07
Hifema F75
Hímen não perfurado X83
Hiperaldosteronismo T99

Hiperatividade ... P81
Hiperemese da gravidez ... W05
Hiperemese ... D10
Hiperesplenismo ... B99
Hiperhidrose ... A09
Hiperinsulismo ... T87
Hiperlipidemia ... T93
Hipermetropia ... F91
Hiperplasia da próstata ... Y85
Hiperqueratose ... S80
HIPERTENSÃO COM COMPLICAÇÕES ... K87
Hipertensão da gravidez ... W81
Hipertensão essencial ... K86
Hipertensão essencial ... K86
Hipertensão idiopática ... K86
Hipertensão instável ... K85
Hipertensão lábil ... K85
Hipertensão maligna ... K87
Hipertensão portal ... D97
Hipertensão pulmonar ... K82
HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES ... K86
Hipertensão transitória ... K85
HIPERTIREOIDISMO ... T85
HIPERTROFIA, AMÍGDALAS/ADENOIDES ... R90
HIPERTROFIA BENIGNA DA PRÓSTATA ... Y85
Hipertrofia do rim ... U99
HIPERVENTILAÇÃO ... R98
Hipocondria ... P75
HIPOGLICEMIA ... T87
Hipomania ... P73
HIPOSPÁDIAS ... Y82
Hipotensão ortostática ... K88
HIPOTENSÃO POSTURAL ... K88
HIPOTIREOIDISMO ... T86
Hirsutismo ... S24
Histeria ... P75
História de malignidade ... A21
História familiar de doença
história familiar de doença, NE ... A23
História familiar de malignidade ... A21
Hordéolo ... F72
ICTERÍCIA ... D13
Ictiose ... S83
Íleo ... D99
IMPETIGO ... S84
IMPOTÊNCIA ORGÂNICA ... Y07
Impotência psicogênica ... P08
Imunodeficiência ... B99
INCAPACIDADE COMO RESULTANTE
DE PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS ... P28
INCAPACIDADE DA PELE ... S28
INCAPACIDADE DA VISTA ... F28
Incapacidade de aguentar
comida no estômago ... D99
INCAPACIDADE DO AP.
CIRCULATÓRIO ... K28
INCAPACIDADE DO AP.
DIGESTIVO ... D28
INCAPACIDADE DO AP.
MUSCULOESQUELÉTICO ... L28
INCAPACIDADE DO AP. NEUROLÓGICO ... N28
INCAPACIDADE DO AP. RESPIRATÓRIO ... R28
INCAPACIDADE DO OUVIDO ... H28
INCAPACIDADE DO SANGUE/
LINFA/BAÇO ... B28
INCAPACIDADE ENDÓCRINA ... T28
INCAPACIDADE GENITAL FEMININA ... X28
INCAPACIDADE GENITAL MASCULINA ... Y28
INCAPACIDADE GERAL ... A28
INCAPACIDADE METABÓLICA ... T28
INCAPACIDADE URINÁRIA ... U28
INCAPACIDADE, GRAVIDEZ ... W28
INCAPACIDADE, NUTRICIONAL ... T28
Inchaço da articulação ... L20
INCHAÇO GENERALIZADO ... S05
INCHAÇO LOCALIZADO ... S04
INCHAÇO NE ... A08
Inchaço, abdômen ... D24
Inchaço, garganta ... R21
INCHAÇO, MAMA, FEMININO ... X19
Inchaço, mama, masculino ... Y16
Inchaço, NE ... A08
Inchaço, testículos ... Y05
INCHAÇO/MASSA GENERALIZADO ... S05
INCHAÇO/MASSA LOCALIZADO ... S04
Inchaços/massas múltiplos ... S05
Incontinência fecal ... D17
INCONTINÊNCIA INTESTINAL ... D17
INCONTINÊNCIA URINÁRIA ... U04
INDIGESTÃO ... D07
Inépcia ... A29
INFECÇÃO APARELHO RESP.
SUPERIOR ... R74
Infecção com papiloma humano ... X91
INFECÇÃO CUTÂNEA PÓS-TRAUMÁTICA ... S11
INFECÇÃO CUTÂNEA, OUTROS ... S76
Infecção da caixa torácica ... R78
Infecção de ferida pós-traumática ... S11
INFECÇÃO DEDOS MÃOS/PÉS ... S09
INFECÇÃO ENDÓCRINA ... T70
INFECÇÃO ESTREPTOCÓCICA DA
GARGANTA ... R72
Infecção fungos da pele ... S74
INFECÇÃO GASTROINTESTINAL,
ORGANISMO ESPECIFICADO ... D70
INFECÇÃO GENITAL POR CLAMÍDIA,
FEMININA ... X92
Infecção HIV ... B90
Infecção localizada do nariz ... R73
Infecção meningocócica ... A78
INFECÇÃO NEUROLÓGICA, OUTROS ... N73
Infecção pós-operatória ... A87

Infecção pós-traumática mordedura/ferida ... S11
INFECÇÃO PUERPERAL ... W70
INFECÇÃO QUE COMPLICA GRAVIDEZ ... W71
Infecção respiratória por fungos ... R83
INFECÇÃO RESPIRATÓRIA, OUTROS ... R83
INFECÇÃO VIAS RESP. SUPERIORES ... R74
Infecção vírus lento ... N73
INFECÇÃO, APARELHO CIRCULATÓRIO ... K70
Infecção, complicações com o tratamento ... A87
Infecção, fungos da pele ... S74
INFECÇÃO, MUSCULOESQUELÉTICO ... L70
INFECÇÃO, OLHO NE ... F73
Infecção, pálpebra ... F72
Infecção, peito ... R78
Infecção, urinária baixa ... U71
Infecção/hemorragia da ferida pós-operatória ... A87
INFECÇÃO/INFLAMAÇÃO DOS OLHOS, OUTROS ... F73
INFERTILIDADE FEMININA ... W15
INFERTILIDADE MASCULINA ... I10
INFESTAÇÃO CUTÂNEA ... S73
Infestação de ácaros ... S73
Infestação de carrapatos ... S73
Infestação de piolhos ... S73
Infestação por pulgas ... S73
Infidelidade ... Z13
INFLAMAÇÃO OCULAR ... F73
INFLUENZA ... R80
Insônia ... P06
Instabilidade da pélvis ... W28
Insuficiência basilar ... K89
Insuficiência cardíaca congestiva ... K77
Insuficiência cardíaca hipertensiva ... K87
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ... K77
Insuficiência do ventrículo direito ... K77
Insuficiência do ventrículo esquerdo ... K77
Insuficiência hepática ... D97
Insuficiência renal ... U99
Insuficiência venosa ... K95
Interrupção da respiração ... R04
Intertrigo ... S88
Intolerância à lactose ... T99
Intolerância alimentar ... D99
Intoxicação alimentar ... D73
Intuscepção ... D99
INVESTIGAÇÃO IRREGULAR ... A91
Iridociclite ... F73
Irite ... F73
Irrequietude ... P04
IRRITABILIDADE ... P04
Irritação cutânea ... S01
Irritação cutânea ... S02
Irritação na pele ... S29
Irritada, garganta ... R21
Isquemia cerebral ... K90
ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITÓRIA ... K89
ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITÓRIA, AIT ... K89
Isquemia miocárdica ... K76
Isquemia, membro ... K92
Jetlag ... A88
Joanete ... L98
Joelho, lesão aguda do menisco ... L96
Joelho, lesão interna crônica ... L99
JOELHO, SINAIS/SINTOMAS ... L15
Lábio e palato leporino ... D81
Lábio gretado ... D20
Lábio inchado ... D20
Lábio, mucocele ... D83
LÁBIO, SINAIS/SINTOMAS ... D20
Labirintite ... H82
Laceração antiga, colo do útero ... X85
Laceração cutânea ... S18
LACERAÇÃO/CORTE ... S18
Lacrimação ... F03
LACTAÇÃO, SINAIS/SINTOMAS ... W19
LARINGITE AGUDA ... R77
Laringotraqueobronquite ... R78
Lassidão ... A04
LENTE DE CONTACTO, SINAIS/SINTOMAS DA ... F18
LESÃO ... S16
Lesão aguda dos ligamentos ... L96
Lesão cutânea pré-maligna ... S79
Lesão cutânea ... S29
Lesão do disco cervical ... L83
Lesão do nervo ... N94
LESÃO INTERNA AGUDA DO JOELHO ... L96
Lesão interna do joelho, aguda ... L96
Lesão ou erupção dolorosa ... S01
Lesão: ver torção/lesão
Letargia ... A04
Letargia ... A07
LEUCEMIA ... B73
Leucocitose ... B84
Leucoplasia do colo ... X85
Leucorreia ... X14
Limitação crônica das vias respiratórias ... R95
LINFA/BAÇO,OUTROS SINAIS/SINTOMAS ... B29
LINFADENITE AGUDA ... B70
LINFADENITE CRÔNICA NÃO-ESPECÍFICA ... B71
Linfadenite mesentérica ... B71
Linfadenopatia ... Bo2
Linfaedema ... K99
LINFAGIOMA ... S81
Linfocitose ... B84
LINFOMA ... B72
Língua presa ... D81

Língua saburrosa D20
LÍNGUA, SINAIS/SINTOMAS D20
LIPOMA S78
Líquen plano S99
Líquido nos pulmões R29
Lombalgia L03
LOMBRIGAS/OUTROS PARASITAS D96
Lordose L85
Lumbago L03
Lúpus eritematoso discoide S99
Lúpus eritematoso sistêmico L99
Luto: ver PERDA
Luxação congênita do quadril L82
LUXAÇÃO L80
Má aceitação da doença Z11
MÁ DISPOSIÇÃO A05
Mal apresentação W84
MALÁRIA A73
Mal-estar A05
MALFORMAÇÃO ADQUIRIDA DE UM MEMBRO L98
Malformação biliar D81
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA CARDIOVASCULAR K73
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA CUTÂNEA S83
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DA VISTA F81
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DIGESTIVA D81
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO APARELHO URINÁRIO U85
Malformação congênita do nariz R89
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO ÓRGÃO GENITAL FEMININO X83
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO ÓRGÃO GENITAL MASCULINO Y84
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO OUVIDO H80
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA ENDÓCRINA/METABÓLICA T80
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA LINFÁTICA B79
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA MUSCULOESQUELÉTICA L82
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA NE A90
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA NEUROLÓGICA N85
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA QUE COMPLICA A GRAVIDEZ W76
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA RESPIRATÓRIA R89
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA SANGUÍNEA B79
MALFORMAÇÃO CONGÊNITA, MÚLTIPLAS A90
Malformação cromossômica A90
Malformação de eritrócitos B99
Malformação hematológica NE B99
Malformação septal auricular K73
Malformação septal ventricular K73
MALFORMAÇÃO VERTEBRAL ADQUIRIDA L85
Malformações craniofaciais L82
Maligna: ver NEOPLASIA MALIGNA
Malignidade do ovário X77
Malignidade metastática NE A79
MALIGNIDADE NE A79
Malnutrição T91
Maloclusão D82
Malunião de uma fratura L99
MAMILO, SINAIS/SINTOMAS X20
Mamilos gretados durante o puerpério W95
Mancha cor de vinho do porto S81
Manchas generalizadas S07
Manchas localizadas S06
Mania P73
Maníaca, depressão P73
MÃO, SINAIS/SINTOMAS L12
Marasmo T91
Marca de nascimento angiomatosa S81
Marca de nascimento S83
Marcas de estiramento S99
Marcha anormal N29
Massa: ver inchaço mastite (lactação) W94
Mastite (não lactação) X21
MASTITE PUERPERAL W94
Mastodinia X18
Mastoidite H74
Mastopatia X21
Mau hálito D20
MAXILAR, SINAIS/SINTOMAS L07
Meatite U72
Mediastinal, doença R99
MEDICINA PREVENTIVA A98
MEDO DA MORTE/MORRER A25
Medo de ataque cardíaco K24
Medo de câncer P79
MEDO DE CÂNCER DA MAMA FEMININA X26
MEDO DE CÂNCER DA PELE S26
MEDO DE CÂNCER DO APARELHO DIGESTIVO D26
MEDO DE CÂNCER DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO L26
MEDO DE CÂNCER DO APARELHO RESPIRATÓRIO R26
MEDO DE CÂNCER DO APARELHO URINÁRIO U26
MEDO DE CÂNCER DO SISTEMA ENDÓCRINO T26
MEDO DE CÂNCER DO SISTEMA NEUROLÓGICO N26
MEDO DE CÂNCER DO SISTEMA SANGUÍNEO/LINFÁTICO B26
MEDO DE CÂNCER GENITAL FEMININO X25
MEDO DE CÂNCER GENITAL MASCULINO Y26
MEDO DE CÂNCER NE A26

Medo de cegueira F27
MEDO DE COMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ W27
MEDO de diabetes T27
MEDO DE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA X24
MEDO DE DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA Y24
MEDO DE DOENÇA CARDÍACA K24
MEDO DE DOENÇA DA PELE S27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO CARDIOVASCULAR K27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO DIGESTIVO D27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO GENITAL FEMININO X27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO GENITAL MASCULINO Y27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO MUSCULOESQUELÉTICO L27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO RESPIRATÓRIO R27
MEDO DE DOENÇA DO APARELHO URINÁRIO U27
MEDO DE DOENÇA DO SISTEMA ENDÓCRINO T27
MEDO DE DOENÇA DO SISTEMA NEUROLÓGICO N27
MEDO DE DOENÇA DO SISTEMA SANGUÍNEO/LINFÁTICO B27
MEDO DE DOENÇA DOS OLHOS F27
MEDO DE DOENÇA DOS OUVIDOS H27
MEDO DE DOENÇA METABÓLICA T27
MEDO DE DOENÇA NE A27
MEDO DE DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL FEMININA X23
MEDO DE DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL MASCULINA Y25
MEDO DE GRAVIDEZ W02
MEDO DE HIPERTENSÃO K25
MEDO de malformações congênitas do bebê W27
MEDO DE PERTURBAÇÃO MENTAL P27
MEDO DE PROBLEMAS SOCIAIS Z27
MEDO DE SIDA B25
Medo de tentativa de suicídio P27
MEDO DO TRATAMENTO A13
Megacólon secundário D99
Melanoma maligna S77
MELENA D15
Membro fantasma N99
Meningioma N75
Meningismo N29
MENINGITE N71
MENOPAUSA, SINAIS/SINTOMAS X11
Menorragia X06
MENSTRUAÇÃO AUSENTE/ESCASSA X05
MENSTRUAÇÃO EXCESSIVA X06
MENSTRUAÇÃO, ADIAMENTO X10
MENSTRUAÇÃO,IRREGULAR/FREQUENTE X07
Mesotelioma R85
METABÓLICA, DOENÇA, OUTROS T99
METABÓLICO,SINAIS/SINTOMAS,OUTROS T29
Metatarsalgia L17
Metrorragia X08
Mialgia L18
Miastenia grave N99
Micoplasma A78
Mieloma múltiplo B74
Miliaria S92
Miocardite K70
Mioclonia N08
Mioma do útero X78
Miopia F91
Miosite L99
MIRINGITE AGUDA H71
MIXEDEMA T86
Mola hidatidiforme W73
MOLA S82
MOLHAR A CAMA P12
MOLUSCO CONTAGIOSO S95
MONILÍASE: ver CANDIDÍASE
MONONUCLEOSE INFECCIOSA A75
Monóxido de carbono, toxicidade A86
MORBIDADE PERINATAL A94
MORDEDURA DE ANIMAL/HUMANO S13
MORDEDURA DE INSETO S12
MORTALIDADE PERINATAL A95
MORTE DE CRIANÇA Z19
MORTE DE PAI/MÃE Z23
MORTE DE UM FAMILIAR Z23
MORTE DO PARCEIRO Z15
MORTE A96
Moscas volantes F04
MOVIMENTOS ANORMAIS N08
MOVIMENTOS INTESTINAIS ALTERADOS D18
Movimentos oculares anormais F14
MUDANÇA DA COR DA PELE S08
Mudanças, problemas com P25
Músculo fraco L19
MÚSCULO, SINAIS/SINTOMAS L19
MUSCULOESQUELETO,SINAIS/SINTOMAS, OUTROS L29
Nanismo T80
Não-união de uma fratura L99
Nariz obstruído R07
Nariz proeminente R08
Nariz vermelho R08
NARIZ, SINAIS/SINTOMAS OUTROS R08
Nasofaringite aguda R74
Nasofaringite crônica R83
Natimorto W91/w93

Náuseas da gravidez....W05
NÁUSEAS....D09
Nefrite....U88
Nefropatia analgésica....U88
Nefropatia....U88
Nefrosclerose hipertensiva....K87
Nefrosclerose....U88
NEFROSE....U88
Neoplasia benigna da mama masculina....Y79
NEOPLASIA BENIGNA DA MAMA....X79
NEOPLASIA BENIGNA DA TIREOIDE....T72
NEOPLASIA BENIGNA DO APARELHO URINÁRIO....U78
NEOPLASIA BENIGNA DO SISTEMA NERVOSO....N75
NEOPLASIA BENIGNA GENITAL....X80
NEOPLASIA BENIGNA RELACIONADA COM A GRAVIDEZ....W73
NEOPLASIA BENIGNA RESPIRATÓRIA....R86
NEOPLASIA BENIGNA/DESCONHECIDA, DIGESTIVO....D78
NEOPLASIA BENIGNA/DESCONHECIDA, GENITAL MASCULINO....Y79
NEOPLASIA BENIGNA/DESCONHECIDA, MUSCULOESQUELÉTICO....L97
NEOPLASIA BENIGNA/DESCONHECIDA, PELE....S79
NEOPLASIA BENIGNA/DESCONHECIDA, RELACIONADA COM A GRAVIDEZ....W73
NEOPLASIA BENIGNA/DESCONHECIDA, SANGUE/LINFA/BAÇO....B75
NEOPLASIA CARDIOVASCULAR....K72
Neoplasia do colo intraepitelial, grau 1/2....X86
Neoplasia do colo intraepitelial, grau 3....X81
NEOPLASIA ENDÓCRINA,OUTROS/ DESCONHECIDA....T73
NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA FEMININA....X76
Neoplasia maligna da mama masculina....Y78
NEOPLASIA MALIGNA, BEXIGA....U76
NEOPLASIA MALIGNA, BRÔNQUIOS....R84
NEOPLASIA MALIGNA, COLO....X75
NEOPLASIA MALIGNA, CÓLON/RETO....D75
NEOPLASIA MALIGNA, DIGESTIVA, OUTROS....D77
NEOPLASIA MALIGNA, ESTÔMAGO....D74
Neoplasia maligna, fígado....D77
NEOPLASIA MALIGNA, GENITAL FEMININO....X77
NEOPLASIA MALIGNA, GENITAL, MASCULINO....Y78
NEOPLASIA MALIGNA, MUSCULOESQUELÉTICO....L71
NEOPLASIA MALIGNA, PÂNCREAS....D76
NEOPLASIA MALIGNA, PELE....S77
NEOPLASIA MALIGNA, PRÓSTATA....Y77
NEOPLASIA MALIGNA, PULMÃO....R84
NEOPLASIA MALIGNA, RELACIONADA COM A GRAVIDEZ....W72
NEOPLASIA MALIGNA, RIM....U75
NEOPLASIA MALIGNA, SANGUE, OUTROS....B74
NEOPLASIA MALIGNA, TIREOIDE....T71
NEOPLASIA MALIGNA, URINÁRIO, OUTROS....U77
NEOPLASIA MALIGNA,RESPIRATÓRIO, OUTROS....R85
NEOPLASIA MALIGNA,SISTEMA NERVOSO....N74
NEOPLASIA, APARELHO URINÁRIO NE....U79
NEOPLASIA, NATUREZA DESCONHECIDA, GENITAL....X81
NEOPLASIA, NATUREZA DESCONHECIDA, RESPIRATÓRIO....R92
NEOPLASIA, NATUREZA DESCONHECIDA, SISTEMA NERVOSO....N76
NEOPLASIA, OUVIDO....H75
NEOPLASIA, VISTA E ÓRGÃOS ANEXOS....F74
Neuralgia....N99
NEURASTENIA....P78
Neurinoma do acústico....N75
Neurodermatite....S99
NEUROLÓGICO, SINAIS/SINTOMAS OUTROS....N29
Neuronite vestibular....H82
Neuropatia diabética....N94
NEUROPATIA PERIFÉRICA....N94
Neurose ansiosa....P74
Neurose de compensação....P80
Neurose NE....P99
Neutropenia....B84
NEVRALGIA do TRIGÊMEO....N92
Nevralgia pós herpética....S70
NEVRITE PERIFÉRICA....N94
NEVUS SINAIS/SINTOMAS....S22
Nictúria....U02
Nistagmo....F14
Nódulo tiroide....T81
Nódulos de Heberden....L91
NUTRICIONAL,SINAIS/SINTOMAS, OUTROS....T29
OBESIDADE....T82
Obstrução crônica das vias respiratórias....R95
Obstrução do colo da bexiga....U99
Obstrução intestinal....D99
ÓCULOS, SINAIS/SINTOMAS....F17
OLFATO, PERTURBAÇÃO DO....N16
Olfato/gosto....N16
Olheiras....S08
OLHO CONGESTIONADO....F02
Olho inchado....F15

Olho negro ... F75
Olho seco ... F13
OLHO VERMELHO ... F02
Olho vermelho ... F02
Olhos vermelhos ... F02
OLHOS, MOVIMENTOS ANORMAIS DOS ... F14
OLHOS, SENSAÇÕES ANORMAIS DOS ... F13
Oligomenorreia ... X05
Oligúria ... U05
Ombro congelado ... L92
OMBRO, SINAIS/SINTOMAS ... L08
Onicogrifose ... S99
Onicomicose ... S74
Ooforite ... X74
Opacidade da córnea ... F99
Orelha de cola ... H72
Orelhas de morcego ... H80
ORQUITE ... Y74
Ortopneia ... R02
Osteoartrite: ver osteoartrose
OSTEOARTROSE ... L91
Osteoartrose, coluna cervical ... L83
Osteoartrose, coluna ... L84
OSTEOARTROSE, JOELHO ... L90
Osteoartrose, ombro ... L92
OSTEOARTROSE, QUADRIL ... L89
Osteocondrite dissecante ... L94
OSTEOCONDROSE ... L94
Osteomalácia ... T99
Osteomielite ... L70
OSTEOPOROSE ... L95
Osteosarcoma ... L71
OTITE EXTERNA ... H70
OTITE MÉDIA AGUDA ... H71
Otite média com derrame ... H72
OTITE MÉDIA CRÔNICA ... H74
Otite média, NE ... H71
OTITE SEROSA MÉDIA ... H72
OTOSCLEROSE ... H83
OUTROS PROBLEMAS COM A MICÇÃO ... U05
OUTROS PROBLEMAS DA MAMA DURANTE A GRAVIDEZ/PUERPÉRIO ... W95
Ouvido de nadador ... H70
Ouvido estalando ... H29
Ouvido obstruído ... H13
Ouvidos estalando ... H29
Overdose de medicação ... A84
Palidez ... S08
PÁLPEBRA, SINAIS/SINTOMAS DA ... F16
PALPITAÇÕES CARDÍACAS ... K04
Pânico ... P74
Paniculite ... L99
Papiledema ... F99
Papiloma da bexiga ... U78
Pápula ... S04
Pápulas ... S05
Parafimose ... Y81
Paragem cardíaca ... K84
Parainfluenza ... R80
PARALISIA ... N18
Paralisia agitante ... N87
Paralisia cerebral ... N99
PARALISIA DE BELL ... N91
PARALISIA FACIAL ... N91
Paranoia ... P72
Parapertussis ... R71
Parasita intestinal ... D96
Paresia ... N18
Parestesia ... N06
PARKINSONISMO ... N87
Parotidite ... D83
Parto assistido, nado morto ... W93
Parto assistido, nado vivo ... W92
PARTO COM COMPLICAÇÕES, NADO VIVO ... W92
PARTO COM COMPLICAÇÕES, NATIMORTO ... W93
Parto normal ... W90
Parto pélvico, nado morto ... W93
Parto pélvico, nado vivo ... W92
Parto provocado ... W92/w93
PARTO SEM COMPLICAÇÕES, NASCIDO-VIVO ... W90
PARTO SEM COMPLICAÇÕES, NATIMORTO ... W91
Pé chato ... L98
PÉ E DEDOS DO PÉ, SINAIS/SINTOMAS ... L17
Pé torto (talipe) ... L82
Pé/pernas inchadas ... K07
PEDICULOSE ... S73
Pele descamando ... S21
Pele seca ... S21
PELE, SINAIS/SINTOMAS, OUTROS ... S29
PÉLVIS, SINAIS/SINTOMAS, FEMININO ... X17
PÊNIS, SINAIS/SINTOMAS ... Y04
Pequeno mal ... N88
Perda da libido ... P07
PERDA DE APETITE ... T03
Perda de equilíbrio ... N17
PERDA DE PESO ... T08
Perda de visão ... F05
Perda de voz ... R23
PERDA/MORTE DE FAMILIAR ... Z23
PERDA/MORTE DE PAI OU MÃE ... Z23
PERDA/MORTE DE UM FILHO ... Z19
PERDA/MORTE DO PARCEIRO ... Z15
Perfuração da úlcera duodenal ... D85
PERFURAÇÃO DO TÍMPANO ... H77
Pericardite ... K70
Peritonite ... D99
PERNA, SINAIS/SINTOMAS ... L14
PERNAS INQUIETAS ... N04
Peroniquia ... S09

Perspiração, problemas de ... A09
Perturbação da articulação temporomaxilar ... D82
PERTURBAÇÃO DA FALA ... N19
PERTURBAÇÃO DEPRESSIVA ... P76
PERTURBAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ESTÔMAGO ... D87
PERTURBAÇÃO DO GOSTO ... N16
PERTURBAÇÃO DO OLFATO/GOSTO ... N16
PERTURBAÇÃO DO SONO ... P06
Perturbação eletrolítica ... A91
PERTURBAÇÃO HIPERCINÉTICA ... P81
Perturbação interna do joelho ... L99
PERTURBAÇÃO OBSESSIVA-COMPULSIVA ... P79
PERTURBAÇÃO PSICOLÓGICA, OUTROS ... P99
Perturbação respiratória ... R04
PERTURBAÇÃO/ESTADO DE ANSIEDADE ... P74
PERTURBAÇÕES DA MEMÓRIA ... P20
Perturbações da patela ... L99
Perturbações metabólicas congênitas ... T99
PERTURBAÇÕES VISUAIS ... F05
Pertussis ... R71
Pesadelos ... P06
Pesar ... P02
PESCOÇO, SINAIS/SINTOMAS ... L01
PESCOÇO, SÍNDROME ... L83
Pescoço, traumatismo em chicotada ... L83
Peso abaixo do normal ... T29
Pestana encravada ... F99
Petéquia ... S29
PICADA DE INSETO ... S12
Picada de planta ... S88
Picadela de planta ... S88
PIELITE ... U70
PIELONEFRITE ... U70
Pigmentação cutânea ... S08
Pílula do dia seguinte ... W10
PINTAS NO CAMPO VISUAL ... F04
Piodermite ... S76
Pirexia ... A03
PITIRÍASE RÓSEA ... S90
Pitiríase versicolor ... S74
Piúria ... U98
Placenta prévia na gravidez ... W84
Placenta prévia no parto ... W92/W93
Planejamento familiar masculino ... Y14
Planejamento familiar oral ... W11
Planejamento familiar, DIU ... W12
Planejamento familiar, NE ... W14
PLANEJAMENTO FAMILIAR, OUTROS ... Y14
Planejamento familiar, sinais/sintomas ... W29
Plaqueta anormal ... B83
PLEURESIA/DERRAME PLEURAL ... R82
Pleurodinia ... R01
Pneumoconiose ... R99
PNEUMONIA ... R81
Pneumonia alérgica ... R99
Pneumonia infecciosa ... R81
Pneumonia pós-gripe ... R81
Pneumonia química ... R99
Pneumonia, aspiração ... R99
Pneumonia, fungos ... R99
Pneumotórax ... R99
POBREZA ... Z01
Poliartrite nodosa ... K99
Policitemia rubra vera ... B75
Policitemia secundária ... B99
Polidipsia ... T01
Polifagia ... T02
Polimenorreia ... X07
Polimialgia reumática ... L99
POLIOMIELITE ... N70
Pólipo cutâneo hemorroidal, residual ... K96
Pólipo do canal urinário ... U78
Pólipo do cólon ... D78
Pólipo do duodeno ... D78
Pólipo do endométrio ... X99
Pólipo do ouvido ... H75
Pólipo endometrial ... X81
Pólipo mucoso do colo ... X85
Pólipo nasal ... R99
Pólipo retal ... D78
Poliúria ... U02
Poluição ambiental ... Z29
Ponfólige ... S92
Pontos negros ... S96
Porfiria ... T99
Portador da doença ... A99
Prê-eclâmpsia ... W81
PRÉ-MENSTRUAL, SINAIS/SINTOMAS ... X09
PRÉ-MENSTRUAL, TENSÃO ... X89
PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA ... A18
PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA DA MAMA ... X22
PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA DO CORPO RELACIONADA COM A GRAVIDEZ ... W21
Preocupação com a aparência do corpo ... A18
PREOCUPAÇÃO COM A APARÊNCIA DO OUVIDO ... H15
Preocupação com o envelhecimento ... P05
PREOCUPAÇÃO COM O TRATAMENTO ... A13
Preocupação com: ver também RECEIO DE preocupação ... P03
PREPÚCIO REDUNDANTE ... Y81
PRESBIACUSIA ... H84
Presbiopia ... F91

PRESSÃO CARDÍACA K02
Pressão intraocular, aumento da F93
Pressão sanguínea baixa K29
PRESSÃO SANGUÍNEA ELEVADA K85
PRESSÃO/APERTO DO CORAÇÃO K02
Priapismo Y08
Primária desconhecida A79
Primípara idosa W84
PRISÃO DE VENTRE D12
PROBLEMA COM A ÁGUA E A ALIMENTAÇÃO Z02
PROBLEMA COM A VIZINHANÇA Z03
PROBLEMA COM O ESTAR PACIENTE Z11
PROBLEMA COM O TRABALHO Z05
PROBLEMA COM UMA DOENÇA Z11
Problema conjugal Z12
PROBLEMA DE CUIDADOS DE SAÚDE Z10
PROBLEMA DE HABITAÇÃO Z03
PROBLEMA FINANCEIRO Z01
PROBLEMA JURÍDICO Z09
PROBLEMA POR DOENÇA DE FAMILIAR Z22
PROBLEMA POR DOENÇA DE PAIS Z22
PROBLEMA POR DOENÇA DE PARCEIRO Z14
PROBLEMA POR DOENÇA DE UM FILHO Z18
PROBLEMA POR ESTAR PACIENTE Z11
PROBLEMA RELACIONAL, AMIGO Z24
PROBLEMA RELACIONAL, CRIANÇA Z16
PROBLEMA RELACIONAL, PAIS/ FAMILIARES Z20
PROBLEMA RELACIONAL, PARCEIRO Z12
PROBLEMA, SUORES A09
Problemas ambientais Z29
Problemas cardíacos K29
Problemas com a dentadura D19
Problemas com comportamento alimentar das crianças P11
Problemas com o sono P06
PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS, COMPANHEIRO Z13
PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS, FAMILIARES Z21
PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS, PAIS Z21
PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIS P11
Problemas de alimentação NE P29
PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO, ADULTO T05
PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO, BEBÊ T04
PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO, CRIANÇA T04
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO, ADOLESCENTE P23
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO, CRIANÇA P22
PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO FAMILIAR Z20
PROBLEMAS EM ENGOLIR D21
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM P24
PROBLEMAS NUMA FASE DA VIDA DO ADULTO P25
Problemas persistentes de adaptação P82
PROBLEMAS RELACIONAIS COM O PARCEIRO Z12
PROBLEMAS RELATIVOS À EDUCAÇÃO Z07
Procidentia X87
Proctalgia fugaz D04
Prolapso da válvula mitral K83
PROLAPSO UTEROVAGINAL X87
Prolapso/degeneração do disco L86
PRÓSTATA, HIPERTROFIA BENIGNA DA Y85
Próstata, obstrução da Y85
PRÓSTATA, SINAIS/SINTOMAS Y06
Prostatismo Y06
PROSTATITE Y73
Prostatomegalia Y85
Proteinúria U98
Proteinúria na gravidez W81
PROTEINÚRIA ORTOSTÁTICA U90
Prótese dentária, problemas da A89
Prótese valvular cardíaca, problema A89
PRÓTESE, PROBLEMAS A89
PRURIDO S02
Prurido anal D05
Prurido perianal D05
PRURIDO PERIANAL D05
Prurido, mamilo X20
Prurido, olho F13
Prurido, ouvido H29
Prurido, vulva X16
Pseudociese P75
Pseudogota T99
PSICOLÓGICO, SINAIS/SINTOMAS, OUTROS P29
Psicopata P80
Psicose afetiva P73
PSICOSE AFETIVA P76
Psicose alcoólica P15
PSICOSE NE P98
PSICOSE ORGÂNICA P71
Psicose puerperal P98
Psicose reativa P98
PSORÍASE S91
Pterígio F99
Ptose F16
Puberdade precoce T99
Puberdade, atrasada T99
Pulmão, abcesso no R83
Pulmão, congestão do R29
Pulmonar, colapso R99
PULSO, SINAIS/SINTOMAS L11
Punctura cutânea S19
PÚRPURA B83
QUADRIL, SINAIS/SINTOMAS L13
Quedas A29

Queilose ... D83
QUEIMADURA ... S14
Queimadura por clarão ... F79
Queimadura química ... S14
QUEIMADURA SOLAR ... S80
Queloide ... S99
Queratite viral ... F85
Queratite ... F73
Queratoacantoma ... S99
QUERATOSE SOLAR ... S80
Quinta doença ... A76
Radiação, complicações ... A87
Radiação, lesão cutânea ... S80
Ranger de dentes ... D29
Raquitismo ... A78
Reação à imunização ... A87
Reação a transfusão sanguínea ... A87
Reação à transfusão ... A87
Reação alérgica ... A92
Reação vacinal ... A87
Receio de surdez ... H27
RECÉM-NASCIDO PREMATURO ... A93
Refluxo do ureter ... U99
Refluxo ... D84
RELAÇÃO SEXUAL DOLOROSA ... X04
Renal, glicosúria ... T99
Renal, transplante ... U28
Respiração anormal ... R04
Respiração dolorosa ... R01
RESPIRAÇÃO RUIDOSA ... R03
Respiratória, insuficiência ... R99
Respiratória, perturbação ... R04
RESPIRATÓRIOS, SINAIS/SINTOMAS OUTROS ... R29
Ressonar ... R04
Resultados anormais dos testes ... A91
Retenção de líquidos ... K07
Retinopatia diabética ... F83
Retinopatia hipertensiva ... F83
RETINOPATIA ... F83
Retocele ... X87
Retração do mamilo ... X20
Retráteis, testículos ... Y05
Reumatismo ... L18
Rigidez da articulação ... L20
Rigidez do músculo ... L19
Rigidez muscular ... L19
Rim policístico congênito ... U85
RIM, SINAIS/SINTOMAS ... U14
Rim/ureter duplicação ... U85
Rinite aguda ... R74
RINITE ALÉRGICA ... R97
Rinite crônica ... R83
Rinite vasomotora ... R97
Rinofima ... S99
Rinorreia ... R07
Rosácea ... S99
Roséola infantil ... A76
Rouquidão ... R23
RUBÉOLA ... A74
Rubéola congênita ... A74
Rubor ... S08
Rugas ... S21
Ruído carotídeo ... K81
Ruído da artéria renal ... K81
RUÍDO NO OUVIDO ... H03
Ruptura do tímpano ... H79
Ruptura espontânea de tendão ... L99
Salivação ... D20
SALPINGITE EUSTAQUIANA ... H73
Salpingite ... X74
Sangue na urina ... U06
Sangue nas fezes ... D16
Sangue no ouvido ... H05
SANGUE, SINAIS/SINTOMAS DO ... B04
SARAMPO ... A71
Sarcoidose ... B99
Sardas ... S08
Saudades ... P02
Secreção da uretra, feminina ... X29
Secreção da uretra, masculina ... Y03
SECREÇÃO DA VISTA ... F03
Secreção do mamilo ... X20
SECREÇÃO DO OUVIDO ... H04
SECREÇÃO URETRAL ... Y03
SECREÇÃO VAGINAL ... X14
SEDE EXCESSIVA ... T01
SEGURANÇA SOCIAL, PROBLEMA COM ... Z08
Seios nasais obstruídos ... R09
SEIOS NASAIS, SINAIS/SINTOMAS ... R09
SEM DOENÇA ... A97
SEMINAL, VESICULITE ... Y73
Seminoma ... Y78
Senescência ... P05
Senil, demência ... P70
Senil, queratose ... S80
Senil, vaginite ... X11
Senil, verruga ... S99
SENILIDADE ... P05
Sensação de cabeça vazia ... N17
Sensação de desmaio ... N17
Sensação de estômago cheio, ... D02
SENSAÇÃO DE NERVOSISMO ... P01
SENSAÇÃO DE OBSTRUÇÃO DO OUVIDO ... H13
Sensação de sufoco ... D21
SENSAÇÃO DE TENSÃO ... P01
SENTIR-SE ANSIOSO ... P01
Sentir-se assustado/ameaçado ... P01
SENTIR-SE DEPRIMIDO ... P03
Sentir-se desajustado ... P03
SENTIR-SE IRRITÁVEL/ZANGADO ... P04

SENTIR-SE NERVOSO P01
Sentir-se só P03
SENTIR-SE TENSO P01
SENTIR-SE/COMPORTAR-SE COMO UM VELHO P05
Separação do parceiro Z15
SÉPSIS PUERPERAL W70
Septo nasal desviado R99
Sequência de ataques K91
Sexual, ataque Z25
SEXUAL, DIMINUIÇÃO DA SATISFAÇÃO P08
SEXUAL, diminuição do desejo P07
SEXUAL, PREOCUPAÇÃO COM PREFERÊNCIA P09
SEXUAL,FUNÇÃO, SINAIS/SINTOMAS MASCULINO Y08
Shigella enteritis D70
SÍFILIS FEMININA X70
SÍFILIS MASCULINA Y70
SINAIS/SINTOMAS DO OUVIDO, OUTROS H29
SINAIS/SINTOMAS GENITAL, OUTROS FEMININO X29
SINAIS/SINTOMAS GENITAL,OUTROS MASCULINO Y29
SINAIS/SINTOMAS CARDIOVASCULARES K29
SINAIS/SINTOMAS DA MAMA, HOMEM Y16
SINAIS/SINTOMAS DA MAMA, MULHER X21
Sinais/sintomas do prepúcio Y04
SINAIS/SINTOMAS DOS OLHOS, OUTROS F29
SINAIS/SINTOMAS ENDÓCRINOS, OUTROS T29
SINAIS/SINTOMAS PÓS-PARTO W18
SINAIS/SINTOMAS: ver sistema corporal apropriado
SÍNCOPE A06
Síndrome "ninho vazio" P25
Síndrome alcoólica do cérebro P15
Síndrome cerebral crônica P98
Síndrome cervicobraquial L83
Síndrome da coluna cervical L83
SÍNDROME DA COLUNA COM IRRADIAÇÃO DE DORES L86
SÍNDROME DA COLUNA SEM IRRADIAÇÃO DE DORES L84
Síndrome de Cushing T99
Síndrome de Down A90
Síndrome de fadiga crônica A04
Síndrome de Gilberts T99
Síndrome de Guillain-Barré N94
SÍNDROME DE IRRITAÇÃO INTESTINAL D93
Síndrome de malabsorção D99
Síndrome de Mallory-Weiss D84
Síndrome de Marfan A90
Síndrome de Munchhausen P80
Síndrome de Renaud K92
Síndrome de Sjögren L99
Síndrome do esvaziamento D99
Síndrome do manguito rotador L92
SÍNDROME DO OMBRO L92
Síndrome do seio doente K80
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO N93
Síndrome nefrótica U88
Síndrome pós-poliomielite N70
Síndrome radicular dos membros superiores L83
Síndrome uretral U72
SÍNDROME VERTIGINOSO H82
Síndrome: ver título apropriado
Sinovite do ombro L92
SINOVITE L87
SINUSITE AGUDA/CRÔNICA R75
Social, isolamento Z28
SOCIAL, LIMITAÇÃO Z28
SOCIAL, PROBLEMA NE Z29
SOCIOCULTURAL, PROBLEMA Z04
SOLAR, QUERATOSE S80
Soluços R29
SOMATIZAÇÃO P75
Sonambulismo P06
Sonolência A29
Sonolência P06
SOPRO ARTERIAL/CARDÍACO K81
Sopro cardíaco K81
Spotting, vaginal X08
Sprue D99
SUBLUXAÇÃO L80
Substituição da articulação, problema A89
SUICÍDIO/TENTATIVA DE SUICÍDIO P77
Suores noturnos A09
Superaquecimento T02
Supressão da lactação W19
SURDEZ H86
Surdez congênita H86
Surdez de ruído H85
Surdez de um ouvido H28
Talassemia B78
Taquicardia NE K04
TAQUICARDIA PAROXÍSTICA K79
Taquipneia R04
Tendão calcificado L87
Tendão, ruptura espontânea L99
TENDINITE L87
Tendinite, ombro L92
Tenossinovite infecciosa L70
Tenossinovite L87
TERÇOL F72
Teste imagiológico anormal A91
Testicular, disfunção T99
TESTÍCULO NÃO DESCIDO Y83
TESTÍCULOS, SINAIS/SINTOMAS Y05
TÉTANO N72

Tetralogia de Fallot ... K73
TEXTURA DA PELE, SINAIS/SINTOMAS ... S21
Timpanite aguda ... H71
Tinea ... S74
TINIDO NO OUVIDO ... H03
TINIDO NOS OUVIDOS ... H03
TIQUE ... P10
Tique doloroso ... N92
Tique dos olhos ... F14
Tireoidite ... T99
TIREOTOXICOSE ... T85
Tonturas ... N17
TÓRAX, SINAIS/SINTOMAS DO ... L04
Torção dos testículos ... Y99
Torção/lesão, pescoço ... L83
TORÇÃO/luxação, costas ... L84
Torcicolo ... L83
TORÇÕES E LESÕES, TORNOZELO ... L77
TORÇÕES/LESÕES ARTICULAÇÃO, OUTROS ... L79
TORÇÕES/LESÕES, JOELHO ... L78
TORNOZELO INCHADO ... K07
TORNOZELO, SINAL/SINTOMA DO ... L16
Torpor ... N06
TOSSE ... R05
Tosse com sangue ... R24
TOSSE CONVULSA ... R71
TOXEMIA DA GRAVIDEZ ... W81
Toxicidade por mordedura de serpente ... A86
Toxicidade provocada por inseto ... A86
Toxicidade provocada por plantas ... A86
Toxoplasmose ... A78
Trabalho de parto prematuro ... W84
Trabalho de parto ... W90/W91
TRACOMA ... F86
Transplante de um órgão ... A89
TRAQUEÍTE, AGUDA ... R77
Traqueobronquite ... R78
TRAUMATISMO ACÚSTICO ... H85
TRAUMATISMO MÚLTIPLO ... A81
TRAUMATISMO, EFEITO SECUNDÁRIO ... A82
TRAUMATISMO, NE ... A80
Tremores ... N08
TRICOMONÍASE GENITAL ... X73
Triquiníase ... D96
Tristeza ... P03
Trombocitopenia ... B83
TROMBOFLEBITE ... K94
Trombose cerebral ... K90
Trombose portal ... K94
Trombose venosa profunda ... K94
Trombose, veia ... K94
Trovoada ... A88
TUBERCULOSE ... A70
Úlcera aftosa ... D83
Úlcera corrosiva ... S77
ÚLCERA CUTÂNEA CRÔNICA ... S97
ÚLCERA DA CÓRNEA ... F85
Úlcera de decúbito ... S97
Úlcera de pressão ... S97
Úlcera dendrítica ... F85
ÚLCERA DO DUODENO ... D85
Úlcera esofágica ... D84
Úlcera gástrica ... D86
Úlcera gastrojejunal ... D86
Úlcera obstrutiva do duodeno ... D85
ÚLCERA PÉPTICA ... D86
Úlcera péptica marginal ... D86
Úlcera varicosa ... S97
Umbigo, problema do ... S29
UNHA, ENCRAVADA ... S94
Unhas em baqueta ... S22
Uremia ... U99
URETRITE ... U72
Uretrite não específica ... U72
Uretrite POR CHLAMYDIA ... U72
Urina escura ... U07
Urina, gotejamento ... U05
Urina, mau odor da ... U07
URINA, QUEIXA ... U07
URINA, RETENÇÃO ... U08
URINÁRIA FREQUÊNCIA/URGÊNCIA ... U02
Urinária, infecção NE ... U71
URINÁRIO, CÁLCULO ... U95
URINÁRIO, SINAIS/SINTOMAS, OUTROS ... U29
Urolitíase ... U95
URTICÁRIA ... S98
Útero fibroide ... X78
Vacínia ... A77
Vagina seca ... X15
VAGINAL, SECREÇÃO ... X14
VAGINAL, SINAIS/SINTOMAS ... X15
Vaginismo NE ... X04
Vaginismo psicogênico ... P08
Vaginite atrófica ... X11
VAGINITE/VULVITE ... X84
Vaginose ... X84
VARICELA ... A72
Varizes do esôfago ... K99
Vasculite ... K99
Vasectomia ... Y13
Vasospasmo ... K92
VEIA SALIENTE ... K06
Veia varicosa sem ser na perna ... K99
VEIAS VARICOSAS, PERNAS ... K95
Vergões ... S98
Vermelhidão cutânea localizada ... S06
Vermelhidão cutânea múltipla ... S07
Verruga seborreica ... S99
Verruga seborreica/senil ... S99
Verruga venérea, feminino ... X91
Verruga venérea, masculino ... Y76

VERRUGA S03
Verrugas S03
Versão W92/W93
Vertigem paroxística benigna H82
Vertigem posicional H82
VERTIGENS/TONTURAS N17
Vias respiratórias inferiores,
infecção aguda das R78
Vias respiratórias superiores,
infecção aguda das R74
Violação Z25
Visão desfocada F05
Vista aquosa F03
Vista cansada F05
Vista fraca F05
Vista preguiçosa F14
Vitiligo S99
Viver sozinho Z28
VÔMITO DE SANGUE D14
VÔMITOS D10
Vômitos, infecção presumível D73
VOZ, SINAIS/SINTOMAS R23
VS elevada B99
Vulva seca X16
Vulvar, dor X01
VULVAR, SINAIS/SINTOMAS X16
Xantoma T93
Zona, herpes zoster S70